Optimal Untuk Negeri

optimal

Buku Ajar
KEPERAWATAN KOMUNITAS

Eka Mishbahatul Mar'ah Has • Niswa Salamung • Arnindya Kanti Prasasti
Oop Ropei • Aulya Kartini Dg Karra • Lisna Nuryanti • Sherli Mariance Sari

Editor: Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.



BUKU AJAR
KEPERAWATAN KOMUNITAS

Penulis:
Dr. Eka Mishbahatul Mar'ah Has, S.Kep., Ns., M.Kep.
Niswa Salamung, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Arnindya Kanti Prasasti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.K.
Oop Ropei, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom.
Aulya Kartini Dg Karra, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Lisna Nuryanti, M.Kep.
Sherli Mariance Sari, S.Kep., Ners., M.Kes.

Editor:
Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Optimal
Untuk
Negeri

Buku Ajar Keperawatan Komunitas

Penulis:
Dr. Eka Mishbahatul Mar'ah Has, S.Kep., Ns., M.Kep.
Niswa Salamung, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Arnindya Kanti Prasasti, S.Kep., M.Kep., Sp.Kep.K.
Oop Ropei, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom.
Aulya Kartini Dg Karra, S.Kep., Ns., M.Kep.
Ns. Lisna Nuryanti, M.Kep.
Sherli Mariance Sari, S.Kep., Ners., M.Kes.

Editor:
Prof. Ferry Efendi, S.Kep., Ns., M.Sc., Ph.D.

Desain Sampul: Ivan Zumarano
Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7927-74-3
Cetakan Pertama: Agustus, 2026
Hak Cipta 2026
Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
Copyright © 2026
by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri
All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Website : optimaluntuknegeri.com
Instagram : @bimbel.optimal
Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88
RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta
Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga **Buku Ajar Keperawatan Komunitas** ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir sebagai salah satu sumber pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami konsep, pendekatan, serta keterampilan yang dibutuhkan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga di lingkungan komunitas. Materi disusun secara sistematis mulai dari konsep dasar keperawatan keluarga dan siklus kehidupan keluarga, teori sistem keluarga, struktur, peran, fungsi, dan dinamika keluarga, hingga pengkajian keluarga menggunakan genogram dan ecomap. Pembahasan tersebut diharapkan dapat membantu mahasiswa membangun pemahaman yang utuh mengenai keluarga sebagai unit penting dalam pelayanan keperawatan komunitas.

Buku ini juga membahas proses asuhan keperawatan keluarga secara lebih aplikatif, meliputi perumusan diagnosis keperawatan keluarga, perencanaan asuhan, pelaksanaan *home visit*, komunikasi terapeutik, edukasi, negosiasi, keselamatan kunjungan, serta manajemen kasus keluarga dengan penyakit kronik, ketergantungan, dan *caregiver*. Selain itu, pembahasan mengenai evaluasi asuhan keluarga, *continuity of care*, sistem rujukan, serta integrasi berbagai pelayanan kesehatan memberikan gambaran mengenai pentingnya kesinambungan pelayanan dalam keperawatan komunitas. Untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dari aspek pengetahuan hingga keterampilan praktik, buku ini dilengkapi dengan aktivitas *Knows How*, *Shows How*, DOPS (*Does*), portofolio, latihan soal, rangkuman materi, *red flags* dan eskalasi, serta berbagai kegiatan pembelajaran yang mendorong kemampuan berpikir kritis, komunikasi, pengambilan keputusan, dan penerapan asuhan keperawatan keluarga secara aman dan bertanggung jawab.

Penyusunan buku ini diharapkan dapat mendukung proses pembelajaran keperawatan komunitas yang tidak hanya menekankan penguasaan teori, tetapi juga kemampuan mengintegrasikan pengetahuan dengan situasi nyata yang dihadapi keluarga di masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu melakukan pengkajian secara komprehensif, menentukan masalah dan prioritas, menyusun serta melaksanakan intervensi, melibatkan keluarga dalam proses perawatan, melakukan evaluasi, dan menjaga kontinuitas pelayanan sesuai kebutuhan pasien dan keluarga. Penulis menyadari bahwa buku ini masih dapat terus dikembangkan seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik keperawatan komunitas. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan pada edisi berikutnya. Semoga **Buku Ajar Keperawatan Komunitas** ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa, pendidik, perawat, serta berbagai pihak yang berperan dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan keluarga dan masyarakat.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB 1 KONSEP DASAR KEPERAWATAN KELUARGA DAN SIKLUS KEHIDUPAN KELUARGA **1**
A. Pendahuluan 3
B. Keluarga sebagai Unit Asuhan Keperawatan 4
C. Konsep Keperawatan Keluarga 11
D. Tatanan keperawatan keluarga 16
E. *Duvall's Eight-Stage Life Cycle* 21
F. Siklus kehidupan dalam keluarga yang bercerai 26
G. Aktivitas 1 — Knows How 27
H. Aktivitas 2 — *Shows How* 29
I. Tabel *Red Flags* dan Ekskalasi 33
J. Rangkuman Materi 35
K. Daftar Pustaka 37

BAB 2 TEORI SISTEM KELUARGA, PERAN, FUNGSI, DAN DINAMIKA KELUARGA **41**
A. Teori Sistem Keluarga dalam Keperawatan 42
B. Tahapan Perkembangan Keluarga (Family Development Stages) 45
C. Struktur dan Peran Keluarga 47
D. Fungsi Keluarga 51
E. Komunikasi dalam Keluarga 54
F. Dinamika Keluarga 56
G. Aktivitas 1 — Knows How 57
H. Aktivitas 2 — Shows How 58
I. Rangkuman Materi 74
J. Tabel Red Flags & Eskalasi 75
K. Daftar Pustaka 77

BAB 3 PENGKAJIAN KELUARGA: GENOGRAM, ECOMAP, RISIKO, DAN KEBUTUHAN **81**
A. Pengkajian keluarga 82
B. Genogram sebagai alat pengkajian keluarga 83

C. Simbol dalam Genogram 85
D. Langkah-Langkah Penyusunan Genogram 86
E. Ecomap dalam Pengkajian Keluarga 89
F. Aktivitas 1 — *Knows How* 92
G. Aktivitas 2 93
H. Redflag 113
I. Rangkuman Materi 116
J. Daftar Pustaka 117

BAB 4 DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA DAN PERENCANAAN ASUHAN 119
A. Diagnosa Keperawatan Keluarga 121
B. Langkah-Langkah Merumuskan Diagnosa Keperawatan Keluarga 121
C. Jenis-Jenis diagnosa keperawatan keluarga: 122
D. Contoh Diagnosa Keperawatan Keluarga 123
E. Perencanaan Keperawatan Keluarga 123
F. Aktivitas 1 — *Knows How* 126
G. Aktivitas 2 — *Shows How* 127
H. DOPS (Does) 131
I. Rangkuman Materi 132
J. Daftar Pustaka 133

BAB 5 HOME VISIT: KOMUNIKASI, EDUKASI, NEGOSIASI, DAN KESELAMATAN KUNJUNGAN 135
A. Definisi 136
B. Tujuan 138
C. Indikasi 139
D. Kontraindikasi 139
E. Alat dan Bahan 139
F. Persiapan Pasien, Perawat, dan Lingkungan 139
G. Hal yang Harus Diperhatikan 140
H. Evaluasi Hasil 140
I. Dokumentasi 140
J. Aktivitas 1- Knows How 140
K. Aktivitas 2 - *Shows How* 141
L. Aktivitas 3 - DOES 148
M. Rangkuman Materi 151
N. Daftar Pustaka 152

BAB 6 MANAJEMEN KASUS KELUARGA: KRONIK, KETERGANTUNGAN, DAN *CAREGIVER* 153
A. Pendahuluan 157
B. Konsep Dasar Manajemen Kasus Keluarga 166
C. Manajemen Keluarga dengan Anggota yang Mengalami Penyakit Kronik 176
D. Ketergantungan dan Kebutuhan Perawatan dalam Keluarga 184
E. *Caregiver* dan *Caregiver Burden* dalam Keluarga 194
F. Pengkajian dan Proses Manajemen Kasus Keluarga 205
G. Intervensi Keperawatan dan Pemberdayaan Keluarga 214
H. Koordinasi, Kontinuitas Pelayanan, dan Peran Perawat Komunitas 223
I. Latihan Soal 233
J. Rangkuman Materi 239
K. Daftar Pustaka 240
L. Glosarium 242

BAB 7 EVALUASI ASUHAN KELUARGA, CONTINUITY OF CARE, DAN RUJUKAN 245
A. Konsep Dasar Asuhan Keluarga 251
B. Proses Asuhan Keluarga 255
C. Konsep Evaluasi Asuhan Keluarga 262
D. Konsep Dasar Continuity of Care 266
E. Sistem Rujukan Di Keperawatan Komunitas 268
F. Konsep Integrasi antara evaluasi, continuity of care, dan sistem rujukan 272
G. Aktivitas 1 — *Knows How* 276
H. Aktivitas 2 — Shows How 277
I. DOPS (Does) 290
J. Portofolio 293
K. Red Flags & Eskalasi 300
L. Rangkuman Materi 305
M. Daftar Pustaka 305

PROFIL PENULIS 309

BAB 1

KONSEP DASAR KEPERAWATAN KELUARGA DAN SIKLUS KEHIDUPAN KELUARGA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor.	CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi).	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menguasai konsep, ruang lingkup, peran perawat, serta prinsip etika-legal dan keselamatan dasar dalam keperawatan komunitas dan keluarga.
CPMK-2	Menganalisis PHC, determinan sosial kesehatan, dan equity untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan kebutuhan prioritas.
CPMK-3	Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi.
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian komunitas dan keluarga secara sistematis (data, pemetaan, risiko, genogram/ecomap) secara etis dan akurat.
CPMK-5	Merumuskan diagnosa keperawatan komunitas dan keluarga serta menetapkan prioritas masalah berbasis data dan partisipasi klien.
CPMK-6	Menyusun perencanaan intervensi/program dan asuhan keluarga (home visit, kemitraan, manajemen kasus, rujukan) yang terukur dan feasible.
CPMK-7	Melaksanakan implementasi–evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan outcome komunitas/keluarga untuk continuity of care dan perbaikan mutu.

Uraian Materi

A. Pendahuluan

Keperawatan keluarga merupakan bagian penting dalam praktik keperawatan kesehatan komunitas. Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga sangat menentukan status kesehatan dan kesejahteraan anggotanya. Keluarga berperan dalam proses pertumbuhan, perkembangan, dan pemulihan, serta dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan sehari-hari. Selain itu, keluarga juga dipandang sebagai suatu sistem sosial yang terdiri dari individu-individu dengan karakteristik unik yang saling memengaruhi. Dalam sistem ini, kesehatan atau kesakitan tidak hanya dialami oleh individu, tetapi juga berdampak pada seluruh anggota keluarga.

Keperawatan keluarga telah berkembang sejak tahun 1960-an. Perkembangan ini didukung oleh landasan keilmuan keperawatan. Dalam perspektif keilmuan, metaparadigma keperawatan (*person, environment, health, nursing*) yang dikemukakan Fawcett (1984), memandang *person* tidak hanya sebagai individu sebagai penerima asuhan, tetapi juga dapat mencakup keluarga sebagai suatu sistem. Artinya, dalam keperawatan, keluarga tidak hanya dipandang sebagai latar belakang individu, tetapi juga sebagai suatu kesatuan yang dapat menjadi fokus asuhan. Oleh karena itu, Friedemann (1989) menyatakan bahwa pendekatan keperawatan tidak hanya difokuskan pada individu, tetapi juga pada keluarga sebagai kesatuan unit asuhan. Perawat keluarga diharapkan mampu memberikan intervensi yang berfokus pada peningkatan kesehatan dan kesejahteraan keluarga dan anggotanya. Penegasan *Family Health Nurse* sebagai bagian dari pelayanan kesehatan primer juga telah dinyatakan WHO (2000) dalam *Munich Declaration*.

Setiap keluarga akan melalui berbagai tahap siklus kehidupan seiring perkembangan waktu, mulai dari pasangan baru menikah hingga keluarga usia lanjut. Setiap tahap perkembangan memiliki tugas, kebutuhan, dan tantangan kesehatan yang berbeda. Pemahaman terhadap siklus kehidupan keluarga menjadi penting agar perawat mampu mengidentifikasi kebutuhan asuhan, edukasi, dan dukungan sesuai dengan tahap perkembangan, serta masalah kesehatan yang dihadapi keluarga.

Bab ini membahas konsep dasar keperawatan keluarga, termasuk keluarga sebagai unit asuhan dan pendekatan siklus kehidupan keluarga, serta kebutuhan edukasi dan dukungan keluarga pada setiap tahap perkembangan. Pembahasan

ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami dan mengaplikasikan asuhan keperawatan yang berpusat pada keluarga secara tepat sesuai dengan kondisi dan tahap kehidupannya.

B. Keluarga sebagai Unit Asuhan Keperawatan

1. Definisi keluarga

Keluarga merupakan konsep yang kompleks dan dinamis. Sampai saat ini, belum ada definisi keluarga yang disepakati secara universal. Hal ini disebabkan oleh perubahan sosial, budaya, dan struktur masyarakat yang terus berkembang, yang pada akhirnya memengaruhi pemaknaan terhadap keluarga. Selain itu, perbedaan sudut pandang dari berbagai bidang ilmu seperti hukum, biologi, psikologi, dan sosiologi juga memengaruhi definisi keluarga, mulai dari hubungan darah hingga ikatan emosional.

Definisi keluarga secara tradisional dikemukakan oleh Burgess and Locke (1945), sebagai sekelompok orang yang disatukan oleh ikatan pernikahan, darah, atau adopsi, yang tinggal dalam satu rumah, saling berinteraksi dan berkomunikasi sesuai peran masing-masing (seperti suami-istri, orang tua-anak, saudara), serta membentuk dan mempertahankan budaya bersama.

Menurut Kaakinen (2010), keluarga didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang saling bergantung dalam pemenuhan kebutuhan emosional, fisik, dan ekonomi, dengan keanggotaan yang ditentukan berdasarkan pengakuan masing-masing individu. *The family is who the members say it is* (Kaakinen, Coehlo, Steele, & Robinson, 2018).

Di Indonesia, definisi keluarga mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tentang ("Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga," 2009), yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga memiliki beberapa pengertian, antara lain: (1) ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah; (2) orang seisi rumah yang menjadi tanggungan; (3) sanak saudara, kaum kerabat; dan (4) satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat (KemendikdasmenRI, 2016).

Menurut Novianti et al. (2025), keluarga dipahami sebagai sekelompok individu yang terikat melalui hubungan darah atau pernikahan, yang memiliki visi dan tujuan bersama, serta menjadi sumber kekuatan melalui dukungan emosional dan sosial berupa kasih sayang, kepedulian, perlindungan, dan

saling membantu antaranggota. Keluarga bisa tinggal satu rumah, atau terpisah karena pekerjaan atau alasan lain (Sharma, 2013). Lebih lanjut, pemikiran modern menekankan bahwa kualitas hubungan menjadi dasar utama dalam membentuk keluarga, bukan semata struktur atau ikatan formal (Lee, Bentzon, & Di Nucci, 2024).

Beragam definisi keluarga menunjukkan bahwa keluarga tidak hanya ditentukan oleh hubungan biologis atau hukum, tetapi juga oleh individu itu sendiri. Dalam praktik keperawatan keluarga, hal ini menuntut perawat untuk mengidentifikasi dan melibatkan anggota keluarga yang tepat dalam asuhan keperawatan, agar kesehatan keluarga dan anggotanya dapat dicapai dengan optimal.

2. Struktur keluarga

Struktur keluarga merujuk pada pola hubungan antaranggota keluarga serta hubungan keluarga dengan lingkungan sosial di sekitarnya. Struktur keluarga bersifat dinamis dan dapat berubah seiring dengan siklus kehidupan keluarga, sebagai akibat dari peristiwa seperti pernikahan, kelahiran, perceraian, dan kematian. Modernisasi serta berbagai transformasi demografi dan sosial juga memengaruhi struktur keluarga saat ini, sehingga muncul berbagai bentuk keluarga yang semakin beragam (Vyhrystyuk, Onina, Islamova, & Savchuk, 2018). Pemahaman terhadap struktur keluarga menjadi dasar bagi perawat dalam melakukan pengkajian dan pemberian asuhan keperawatan yang tepat.

Berdasarkan pola hubungan antaranggota dan komposisi keluarga, struktur keluarga dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk. Klasifikasi ini mencerminkan keberagaman keluarga yang berkembang dalam masyarakat modern. Klasifikasi struktur keluarga, antara lain sebagai berikut (Friedman, Bowden, & Jones, 2003; Kaakinen et al., 2018; KemenkesRI, 2021; Sharma, 2013):

a. Individu tunggal (*single person-adult, proton*)
   Keluarga yang terdiri dari satu orang dewasa lajang yang tinggal sendiri, biasanya karena tuntutan pekerjaan, pendidikan, atau kondisi lain yang mengharuskan terpisah dari keluarga asalnya.
b. Keluarga inti tanpa anak (*nuclear dyad*)
   Keluarga ini terdiri dari pasangan yang telah menikah (suami-istri), tetapi belum memiliki anak.
c. Keluarga inti (*nuclear family*)
   Keluarga ini terdiri dari suami, istri, dan anak (yang merupakan keturunannya atau hasil adopsi atau keduanya).

d. Keluarga binuklir (*binuclear family*)
   Keluarga pasca perceraian di mana anak tetap menjadi bagian dari kedua keluarga orang tuanya (keluarga baru ibu, dan keluarga baru ayah).
e. Keluarga orang tua tiri (*blended family*)
   Keluarga yang terbentuk karena suami dan istri yang membawa anak dari hubungan sebelumnya ke dalam satu keluarga.
f. Keluarga komposit (*composite family*)
   Keluarga yang terbentuk melalui perkawinan poligami, di mana suami memiliki lebih dari satu istri yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga.
g. Keluarga orang tua tunggal (*single-parent family*)
   Keluarga yang terdiri dari satu orang tua (ayah atau ibu) yang tinggal bersama dan membesarkan anak (kandung atau adopsi), yang umumnya terjadi akibat perceraian, kematian pasangan, atau kondisi lain yang menyebabkan orang tua tidak lengkap.
h. Keluarga besar (*extended family*)
   Keluarga inti yang tinggal bersama atau berhubungan dekat dengan kerabat lainnya dengan ikatan biologis (darah).
i. Keluarga komunal (*communal family*)
   Sekelompok individu yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan berbagi peran, tetapi bukan satu keluarga karena tidak ada keterikatan hubungan pernikahan atau hubungan darah.
j. Pasangan tidak menikah (*cohabiting couple*)
   Laki-laki dan perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan.
k. Pasangan sesama jenis (*homosexual couple*)
   Dua individu dengan jenis kelamin yang sama yang hidup bersama sebagai pasangan.

3. Fungsi keluarga

Fungsi keluarga merujuk pada peran keluarga dalam memenuhi kebutuhan anggotanya, serta kewajibannya terhadap masyarakat. Fungsi ini perlu dikaji oleh perawat untuk mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya keluarga, serta mendukung kesehatan keluarga melalui edukasi dan dukungan sosial. Fungsi keluarga mencakup lima aspek utama, yaitu reproduksi, sosialiasi, ekonomi, afeksi, dan perawatan kesehatan (Friedman et al., 2003; Kaakinen et al., 2018; Robinson, Coehlo, & Smith, 2022; Sheppard, 2009).

a. Fungsi reproduksi, berkaitan dengan keberlangsungan keluarga melalui kelahiran anak. Pelaksanaan fungsi ini dipengaruhi oleh nilai sosial, budaya,

ekonomi, dan moral yang berlaku dalam masyarakat. Isu reproduksi sering menimbulkan perdebatan etika, hukum, dan sosial di berbagai konteks masyarakat (Ouahid, Sebbani, Cherkaoui, Amine, & Adarmouch, 2025).

b. Fungsi sosialisasi, berkaitan dengan peran pengasuhan keluarga dalam membentuk nilai, norma, moral, bahasa, serta identitas sosial anak. Orang tua berperan dalam memberikan dukungan sekaligus kontrol sosial untuk mempersiapkan anak menjalani kehidupan bermasyarakat yang produktif. Proses sosialisasi mencakup pembelajaran peran sosial serta persiapan anak menuju kehidupan dewasa (Ramos Rangel & González Valdés, 2017). Keluarga juga memperkenalkan berbagai peristiwa penting dalam kehidupan seperti kelahiran, pubertas, pernikahan, dan kematian sebagai penanda perubahan status sosial. Latar belakang etnik, budaya, dan lingkungan tempat tinggal keluarga turut memengaruhi fungsi ini.
c. Fungsi ekonomi, berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota serta kontribusinya terhadap stabilitas ekonomi masyarakat. Keputusan keluarga sering dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, termasuk pekerjaan, pernikahan, dan pengasuhan anak. Fungsi ini mencakup pengelolaan pendapatan, konsumsi, tabungan, asuransi, dan perencanaan keuangan (Ermisch, 2018). Selain itu, nilai dan keterampilan ekonomi juga diturunkan kepada anak dalam keluarga, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.
d. Fungsi afeksi, berkaitan dengan pemberian dukungan emosional, kasih sayang (asih), serta keterikatan antaranggota keluarga, dimulai sejak tahun awal kehidupan individu dan berlanjut selama masa hidupnya. Keluarga yang sehat (*energized family*) mampu menyeimbangkan kedekatan emosional dengan kemandirian setiap anggota, serta saling menghargai dan menerima. Fungsi ini berperan dalam pembentukan identitas diri, rasa aman, rasa kemanusiaan, dan rasa memiliki dalam keluarga (*crescive bonds*) (Porta & Brown, 2016). Kualitas komunikasi, pola konflik, serta dukungan emosional sangat memengaruhi kesehatan keluarga, termasuk dalam membangun resiliensi terhadap stres dan krisis kehidupan.
e. Fungsi perawatan kesehatan, berkaitan dengan gambaran peran keluarga sebagai penyedia utama perawatan kesehatan informal bagi anggotanya. Konsep sehat dan sakit sangat bervariasi antar keluarga. Keluarga berperan dalam promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan saat sakit, serta rehabilitasi (Alexander, Waxman, & Fraser, 2024). Banyak keputusan terkait kesehatan dipengaruhi oleh keluarga, termasuk kepatuhan terhadap terapi dan pengambilan keputusan perawatan. Keluarga juga

menjadi penghubung utama dengan layanan kesehatan profesional, sehingga perawat perlu memberikan edukasi, konseling, dan dukungan sumber daya kesehatan kepada keluarga.

4. Proses keluarga

Proses keluarga merujuk pada interaksi berkelanjutan antaranggota keluarga dalam menjalankan fungsi, peran, memenuhi kebutuhan, dan menyelesaikan tugas keluarga, baik yang bersifat instrumental (misalnya ekonomi dan perawatan fisik) maupun ekspresif (dukungan emosional) (Denham, Eggenberger, Young, & Krumwiede, 2015). Proses ini mencakup cara anggota keluarga berkomunikasi, berhubungan, dan beradaptasi dalam kehidupan sehari-hari, yang membuat setiap keluarga unik. Proses keluarga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan keluarga, terutama dalam situasi perubahan atau krisis kesehatan.

Proses keluarga mencakup beberapa komponen utama berikut (Kaakinen et al., 2018):

a. Komunikasi keluarga

Komunikasi adalah cara anggota keluarga saling bertukar informasi, perasaan, dan makna. Pola komunikasi keluarga bisa fungsional atau disfungsional. Komunikasi fungsional yang terbuka dan jelas membantu keluarga dalam menghadapi masalah dan membuat keputusan bersama.

Penting bagi perawat untuk menilai bagaimana keluarga berkomunikasi saat menghadapi masalah kesehatan, karena komunikasi yang buruk dapat menghambat perawatan.

b. Peran keluarga

Di dalam keluarga, tanpa memandang strukturnya, setiap anggota keluarga memiliki peran yang melekat dengan harapan-harapan tertentu seperti pencari nafkah, pengasuh, pengambil keputusan, atau pemberi dukungan emosional. Peran tersebut dapat berubah ketika terjadi kondisi sakit atau perubahan dalam keluarga.

Penting bagi perawat untuk mengidentifikasi siapa yang menjalankan peran perawatan serta bagaimana beban peran dibagi, agar tidak terjadi kelebihan beban (*role overload*). Perawat juga dapat membantu keluarga untuk beradaptasi, bernegosiasi, melepaskan harapan tertentu, atau mencari sumber daya tambahan guna mengurangi stres keluarga ketika salah satu anggota keluarga sakit.

c. Pengambilan keputusan dalam keluarga

Keputusan dalam keluarga, terutama terkait kesehatan, biasanya merupakan hasil diskusi bersama antaranggota keluarga. Proses ini dipengaruhi oleh pola komunikasi dan pembagian kekuasaan dalam keluarga.

Penting bagi perawat untuk mengidentifikasi mekanisme pengambilan keputusan, serta siapa yang berperan sebagai pengambil keputusan dalam keluarga, agar dapat melibatkan keluarga secara tepat dalam proses pengambilan keputusan terkait perawatan anggota keluarga.

d. Pola koping keluarga

Setiap keluarga memiliki cara berbeda dalam menghadapi stres atau masalah, seperti penyakit, kehilangan, atau krisis. Koping yang baik dapat meningkatkan ketahanan keluarga (*family resilience*).

Penting bagi perawat untuk mengidentifikasi mekanisme koping yang dimiliki keluarga serta memperkuat kemampuan koping adaptif keluarga dalam menghadapi berbagai stresor, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

e. Ritual dan rutinitas keluarga

Ritual adalah kegiatan bermakna seperti perayaan keluarga atau ibadah, sedangkan rutinitas adalah kegiatan sehari-hari seperti makan bersama atau waktu tidur. Keduanya memberi struktur dan stabilitas dalam keluarga.

Penting bagi perawat untuk memahami kebiasaan keluarga yang dapat mendukung atau menghambat kepatuhan terhadap pengobatan dan perawatan.

f. Nilai dan norma keluarga (Friedman et al., 2003)

Nilai keluarga merupakan sistem keyakinan, ide, dan perilaku yang dimiliki keluarga tentang apa yang dianggap penting dan benar. Nilai ini, baik disadari atau tidak, memengaruhi cara anggota keluarga berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Norma keluarga adalah pola perilaku yang dianggap benar dan pantas oleh keluarga, yang terbentuk berdasarkan nilai-nilai keluarga dan kemudian tercermin dalam aturan-aturan yang berlaku dalam keluarga.

Penting bagi perawat untuk memahami dan menghargai nilai serta norma keluarga karena akan memengaruhi sikap, keputusan, dan perilaku keluarga dalam menjaga kesehatan agar asuhan keperawatan yang diberikan dapat diterima dan efektif.

Proses keluarga sangat penting dalam keperawatan karena kondisi kesehatan satu anggota keluarga dapat memengaruhi seluruh sistem keluarga. Dalam situasi penyakit kronis, perubahan peran, komunikasi, dan pola koping sering terjadi dan dapat menimbulkan stres dalam keluarga. Dengan memahami proses keluarga, perawat dapat memberikan asuhan yang lebih holistik, tidak hanya pada individu tetapi juga pada sistem keluarga secara keseluruhan.

5. Keluarga sehat

Sehat dan pencapaian potensi kesehatan yang optimal merupakan hak dasar setiap individu. Menurut WHO (1946), sehat tidak hanya berarti ketiadaan penyakit atau kelemahan, tetapi juga keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial. Konsep ini juga berlaku pada konteks keluarga. Kaakinen et al. (2018), menekankan bahwa kesehatan keluarga bersifat dinamis, kompleks, dan berubah-ubah, melibatkan aspek biologis, psikologis, spiritual, sosial, dan budaya dari setiap anggotanya, maupun sistem keluarga secara keseluruhan. Kemampuan keluarga untuk mempertahankan kesehatan dipengaruhi oleh siklus kehidupan, kebutuhan kesehatan, dan kesetaraan sosial, serta didukung oleh masyarakat dan sistem kesehatan (Tulchinsky, Varavikova, & Cohen, 2023).

Kondisi sehat dan sakit pada individu dan keluarga saling berhubungan secara simultan, di mana kondisi kesehatan satu anggota keluarga dapat memengaruhi fungsi keluarga secara keseluruhan, dan sebaliknya fungsi keluarga juga dapat memengaruhi kesehatan setiap anggotanya. Interaksi timbal balik antara kesehatan individu dan dinamika kesehatan keluarga ini perlu menjadi perhatian penting dalam praktik keperawatan keluarga. Namun, penentuan apakah suatu keluarga dikategorikan sehat tidak selalu memiliki standar yang sama.

Para ahli memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan dan menentukan indikator keluarga sehat, yang juga berkembang dari waktu ke waktu dalam literatur. Karakteristik keluarga sehat menurut Kaakinen (2010) ditandai oleh komunikasi yang efektif, saling mendukung antaranggota keluarga, mampu membangun kepercayaan dan tanggung jawab bersama, saling berinteraksi, meluangkan waktu bersama, serta menjunjung nilai moral, spiritual dan sosial. Selain itu, keluarga yang sehat mampu menghargai privasi, mempertahankan tradisi, serta terbuka dalam menghadapi masalah dan mencari bantuan ketika diperlukan.

Di Indonesia, penentuan status keluarga sehat mengacu pada 12 indikator utama dalam Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yang mencakup indikator program gizi untuk kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta perilaku dan kesehatan lingkungan (KemenkesRI, 2016).

Tabel 1.1: Indikator Keluarga Sehat

1	Keluarga mengikuti keluarga berencana
2	Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan
3	Bayi mendapatkan imunisasi dasar lengkap
4	Bayi diberi Air Susu Ibu Eksklusif selama 6 bulan
5	Memantau pertumbuhan balita setiap bulan
6	Penderita Tuberkulosis Paru berobat sesuai standar
7	Penderita Hipertensi berobat teratur
8	Gangguan jiwa berat tidak ditelantarkan
9	Tidak ada anggota keluarga yang merokok
10	Keluarga memiliki akses atau memiliki sarana air bersih
11	Keluarga memiliki akses atau memiliki jamban sehat
12	Sekeluarga menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Sumber: KemenkesRI (2017)

C. Konsep Keperawatan Keluarga

1. Definisi keperawatan keluarga

Keperawatan keluarga menempatkan keluarga sebagai unit utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa kesehatan dan penyakit memengaruhi seluruh anggota keluarga, serta bahwa keluarga turut memengaruhi proses dan hasil perawatan kesehatan. Asuhan keperawatan keluarga bersifat holistik, dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam tahap pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi asuhan keperawatan dengan memobilisasi sumber daya yang dimiliki keluarga di lingkungan rumah. Hal ini lah yang membedakan asuhan keperawatan keluarga dengan asuhan keperawatan individu.

Asuhan keperawatan keluarga didefinisikan sebagai proses penyediaan kebutuhan perawatan kesehatan bagi keluarga yang berada dalam ruang lingkup praktik keperawatan, guna meningkatkan, mempertahankan, dan memulihkan kesehatannya. Asuhan keperawatan ini dapat ditujukan kepada keluarga sebagai konteks, keluarga secara keseluruhan sebagai klien, keluarga

sebagai sistem, atau keluarga sebagai komponen masyarakat (Kaakinen et al., 2018; Robinson et al., 2022).

2. Karakteristik keperawatan keluarga

Menurut Kaakinen et al. (2018), terdapat sepuluh karakteristik intervensi keperawatan keluarga, antara lain: (1) berfokus pada pengalaman keluarga sepanjang waktu; (2) mempertimbangkan konteks komunitas dan budaya; (3) memperhatikan hubungan antaranggota keluarga, serta perbedaan pencapaian kesehatan tiap individu; (4) ditujukan pada keluarga dengan anggota yang sehat maupun sakit; (5) diberikan pada situasi dengan masalah fisiologis atau psikologis; (6) perubahan pada satu anggota memengaruhi seluruh sistem keluarga; (7) melibatkan pengelolaan lingkungan untuk mendukung interaksi keluarga; (8) fokus intervensi bisa berubah seiring dengan perjalanan waktu; (9) menekankan kekuatan individu dan keluarga untuk mendorong pertumbuhan bersama; dan (10) melibatkan keluarga dalam menentukan siapa orang yang termasuk dalam keluarga, serta fokus intervensi terapeutik.

3. Tujuan keperawatan keluarga

Tujuan umum dari keperawatan keluarga adalah kemandirian keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya. Sementara, tujuan khususnya adalah keluarga mampu melaksanakan tugas pemeliharaan kesehatan keluarga dan mampu menangani masalah kesehatannya, yaitu: 1) mengenal masalah kesehatan yang dihadapi anggota keluarga; 2) membuat keputusan secara tepat dalam mengatasi masalah kesehatan anggota keluarga; 3) memberi perawatan pada anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan; 4) memodifikasi lingkungan yang kondusif; dan 5) memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan untuk pemeliharaan dan perawatan anggota keluarga yang mempunyai masalah kesehatan (Denham et al., 2015; Friedman et al., 2003; Robinson et al., 2022).

4. Pendekatan keperawatan keluarga

Ada empat pendekatan berbeda dalam keperawatan keluarga, di mana masing-masing dilatarbelakangi oleh asuhan keperawatan yang berbeda, yaitu (Friedemann, 1989; Kaakinen et al., 2018):

a. Keluarga sebagai konteks

Asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan ini berfokus pada individu sebagai klien, dan keluarga sebagai konteks (*background*) yang bisa menjadi sumber dukungan atau stresor bagi individu tersebut, yang bisa memengaruhi kondisi sehat-sakit. Individu akan dikaji dan diintervensi, sementara keluarga akan dilibatkan dalam asuhan

keperawatan. Tujuan utamanya lebih pada kesehatan fisik dan kesejahteraan pribadi anggota keluarga yang menjadi klien. Pendekatan ini disebut juga *family centered* atau *family focused*, yang berakar pada kekhususan keperawatan yang melibatkan ibu-anak di berbagai *setting*.

Contoh kasus: Saat kunjungan rumah, perawat memberikan asuhan kepada balita dengan asma, dengan melakukan pengkajian terhadap frekuensi serangan, penggunaan obat, serta faktor pencetus di lingkungan. Ibu berperan dalam mendukung perawatan dengan memastikan anak menggunakan obat sesuai anjuran, menghindari paparan alergen seperti debu atau asap, serta menjaga kebersihan lingkungan rumah. Fokus utama pada balita sebagai klien, sementara keluarga berperan sebagai pendukung proses perawatan.

b. Keluarga sebagai klien

Asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan ini berfokus pada keluarga sebagai klien. Setiap anggota keluarga dikaji. Keluarga dilihat sebagai keseluruhan dari anggota keluarga. Perawatan kesehatan disediakan untuk semua anggota keluarga. Asuhan keperawatan difokuskan pada bagaimana kesehatan individu berdampak pada keluarga secara keseluruhan.

Contoh kasus: Saat kunjungan rumah, perawat memberikan asuhan pada keluarga dengan salah satu anggota yang menderita Tuberkulosis (TB). Perawat mengkaji kondisi kesehatan setiap anggota keluarga, termasuk risiko penularan dan pemahaman mereka tentang penyakit TB. Edukasi mengenai kepatuhan minum obat, etika batuk, dan pencegahan penularan diberikan kepada seluruh anggota keluarga. Fokus asuhan mencakup semua anggota keluarga, karena kesehatan masing-masing individu saling berkaitan.

c. Keluarga sebagai sistem

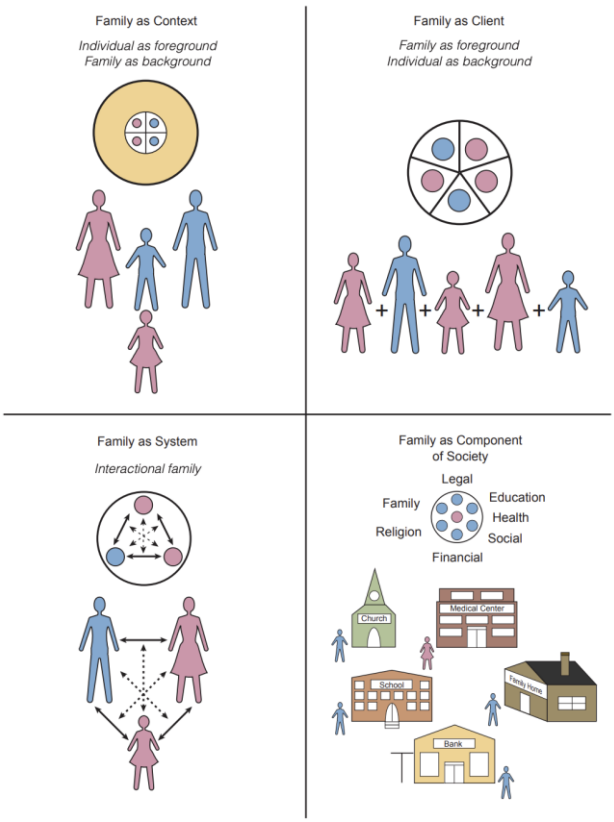
Asuhan keperawatan keluarga dengan pendekatan ini berfokus pada keluarga sebagai suatu sistem, di mana anggota keluarga saling berinteraksi dan memiliki peran masing-masing. Misalnya interaksi antara ayah dan ibu, atau antara ayah-ibu dan anak. Semakin banyak anak dalam keluarga, maka akan semakin kompleks interaksinya. Pendekatan sistem selalu meyakini bahwa ketika sesuatu terjadi pada salah satu bagian dari sistem, maka bagian sistem yang lain juga akan terkena dampaknya. Tujuan utamanya adalah membangun komunikasi, saling pengertian, dan dukungan antaranggota keluarga.

Contoh kasus: Saat kunjungan rumah, perawat mendampingi keluarga di mana ayah sebagai pencari nafkah utama mengalami stroke. Perawat mengkaji perubahan peran dalam keluarga, pola komunikasi, serta dampak kondisi tersebut terhadap aktivitas dan keseharian keluarga. Perawat memfasilitasi pembagian peran, komunikasi, dan dukungan agar fungsi keluarga tetap berjalan. Fokus asuhan pada bagaimana keluarga beradaptasi sebagai satu kesatuan, karena perubahan pada satu anggota memengaruhi seluruh sistem keluarga.

d. Keluarga sebagai komponen dalam masyarakat

Pendekatan asuhan keperawatan keluarga ini melihat keluarga sebagai bagian dari masyarakat. Keluarga berinteraksi dengan institusi lain untuk menerima, bertukar, dan saling memberi layanan. Perawat berperan menghubungkan keluarga dengan layanan dan sumber daya yang tersedia. Pendekatan ini banyak digunakan dalam studi tentang keluarga di masyarakat.

Contoh kasus: Perawat mendampingi keluarga dengan anak yang hidup dengan HIV. Perawat membantu keluarga berkomunikasi dengan pihak sekolah, menghubungkan dengan kelompok dukungan di masyarakat, serta mengoordinasikan layanan yang dibutuhkan. Upaya ini bertujuan mengurangi stres keluarga dan meningkatkan kualitas perawatan.



Gambar 8.1: Pendekatan keperawatan keluarga (Kaakinen et al., 2018)

Sasaran keperawatan keluarga

Asuhan keperawatan keluarga menjadi bagian penting dari perawatan kesehatan masyarakat (Perkemas) di tatanan layanan kesehatan primer di Indonesia sesuai dengan Kepmenkes RI Nomor 279 tahun 2006 tentang ("Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas,") (Kholifah & Widagdo, 2016). Dalam perkembangannya Perkemas terintegrasi dalam pendekatan pelayanan kesehatan keluarga melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), yang menekankan upaya promotif dan preventif berbasis keluarga.

Sasaran asuhan keperawatan keluarga, antara lain (Kholifah, Siti Nur; Widagdo, 2016):

a. Keluarga sehat, di mana seluruh anggota keluarga dalam kondisi tidak mempunyai masalah kesehatan, tetapi masih memerlukan antisipasi terkait dengan siklus perkembangan manusia dan tahapan tumbuh kembang keluarga. Misalnya keluarga dengan anak usia balita yang memerlukan stimulasi tumbuh kembang.
b. Keluarga risiko tinggi dan rawan kesehatan, di mana jika satu atau lebih anggota keluarga memerlukan perhatian khusus dan memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan diri, terkait siklus perkembangan

anggota keluarga dan keluarga dengan faktor risiko penurunan status kesehatan. Misalnya keluarga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir (TPA) sampah, dengan kondisi sosial ekonomi rendah yang rentan terhadap paparan infeksi.

c. Keluarga yang memerlukan tindak lanjut, merupakan keluarga yang mempunyai masalah kesehatan baik akut maupun kronis, dan memerlukan tindak lanjut pelayanan keperawatan atau kesehatan di rumah. Misalnya klien pasca hospitalisasi penyakit akut yang memerlukan *recovery*, penyakit degeneratif yang memerlukan rehabilitasi, pasca tindakan pembedahan, dan penyakit terminal.

D. Tatanan keperawatan keluarga

Pelayanan asuhan keperawatan keluarga bisa dilakukan di berbagai tatanan, seperti di rumah, rumah sakit, tempat praktik perawat, klinik, dan unit pemulihan kesehatan (Ochs, Roper, & Schwartz, 2024). Di Indonesia, praktik asuhan keperawatan keluarga menjadi bagian dari layanan di pusat pelayanan kesehatan primer (KemenkesRI, 2016).

1. Ruang lingkup keperawatan keluarga

WHO (2000) menegaskan bahwa asuhan keperawatan keluarga bertujuan membantu keluarga untuk mempertahankan kesehatan dan beradaptasi dalam menghadapi ancaman kesehatan (*stresor*). Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai tingkat pencegahan primer, sekunder, tersier, serta pemberian asuhan langsung sesuai kebutuhan keluarga (*direct care*). Pendekatan ini menjadi dasar dalam penentuan ruang lingkup praktik keperawatan keluarga yang meliputi:

a. Pencegahan primer

Pada pencegahan primer, perawat mengkaji dan mengidentifikasi stresor atau ancaman kesehatan, serta secara proaktif mencegah dampaknya pada keluarga. Perawat membantu memperkuat sumber daya yang dimiliki keluarga melalui upaya promotif seperti edukasi, dukungan, memobilisasi sumber daya, serta memantau kondisi keluarga dengan mendeteksi potensi stresor sejak dini. Tujuannya untuk meningkatkan kesehatan individu dan keluarga.

Misalnya: penyuluhan kesehatan, olahraga teratur, peningkatan gizi, dan lain-lain.

b. Pencegahan sekunder

Pada pencegahan sekunder, perawat terlibat dalam upaya deteksi masalah kesehatan sejak dini dan mengambil langkah preventif untuk

mencegah dampak lebih lanjut. Apabila diperlukan juga menghubungkan keluarga dengan tenaga ahli lain yang sesuai kebutuhan.

Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan terhadap kesehatan individu dan keluarga.

Misalnya: imunisasi, pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian vitamin, dan lain-lain.

c. Asuhan sesuai kebutuhan (*direct care*)

Perawat memberikan asuhan perawatan langsung saat keluarga/individu tidak mampu mengatasi masalah kesehatan.

Tujuannya untuk merawat dan mengobati anggota keluarga yang sedang mengalami masalah kesehatan.

Misalnya: perawatan individu yang sakit di rumah, perawatan ibu hamil patologis, dan lain-lain.

d. Pencegahan tersier

Pada pencegahan tersier, perawat membantu pemulihan kondisi keluarga dan memperkuat kembali sumber daya ketahanan keluarga.

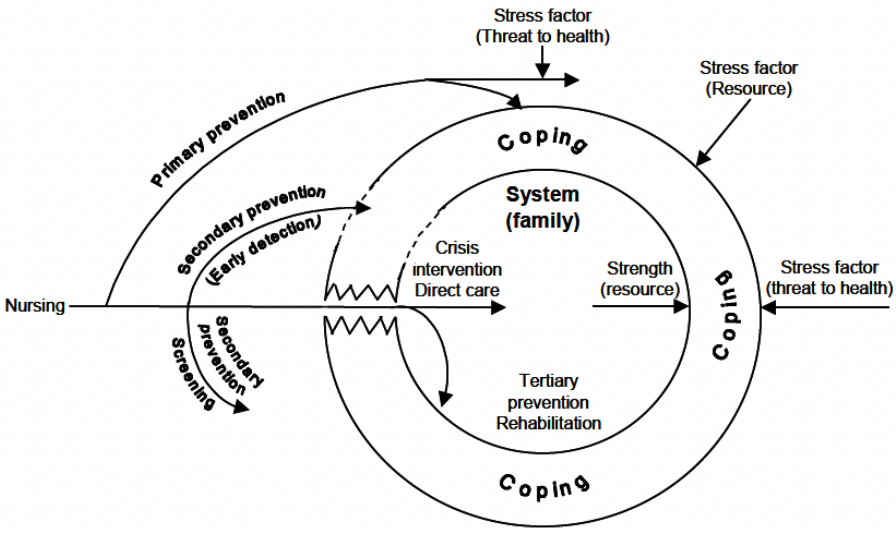
Tujuannya untuk mengurangi keparahan masalah kesehatan hingga tingkat serendah mungkin untuk meminimalkan disabilitas dan pengembalian atau pemulihan kesehatan bagi anggota keluarga yang dirawat di rumah.

Misalnya: latihan rentang gerak sendi bagi penderita post-stroke, latihan napas bagi penderita TB, dan lain-lain.

KemenkesRI (2021) menambahkan satu lagi ruang lingkup praktik keperawatan keluarga, yaitu:

e. Resosialisasi, yaitu upaya untuk mengembalikan individu dan keluarga agar dapat berfungsi dan berinteraksi kembali secara optimal dalam kehidupan bermasyarakat.

Misalnya: pada kasus gangguan jiwa yang sudah stabil, AIDS, atau kusta.



Gambar 8.2 Level pencegahan dalam keperawatan keluarga (WHO, 2000)

2. Peran perawat keluarga

Perawat keluarga memiliki berbagai peran penting dalam membantu keluarga mencapai derajat kesehatan yang optimal. Peran tersebut antara lain (Kaakinen et al., 2018):

a. Pendidik (*educator*)

Perawat keluarga memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga secara berkelanjutan.

Contoh: Perawat mengajarkan ibu cara merawat balita dengan asma dan menghindari faktor pencetus.

b. Kolaborator (*collaborator*)

Perawat mengoordinasikan pelayanan dan menghubungkan keluarga dengan berbagai sumber layanan kesehatan.

Contoh: Perawat membantu keluarga pasien stroke mengakses layanan *home care* di lingkungan sekitarnya.

c. Pemberi asuhan (*care provider*)

Perawat memberikan asuhan keperawatan sesuai kebutuhan keluarga.
Contoh: Perawat melakukan perawatan luka pada pasien diabetes di rumah dan memantau perkembangannya.

d. Advokator (*advocator*)

Perawat membela dan memperjuangkan hak, serta kebutuhan kesehatan keluarga.

Contoh: Perawat membantu keluarga memperoleh akses Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk pengobatan anaknya.

e. Konsultan (*consultant*)
   Perawat memberikan saran profesional untuk membantu keluarga mengambil keputusan kesehatan.
   Contoh: Perawat memberi saran tempat perawatan jangka panjang untuk lansia post-stroke dengan kondisi kronis.
f. Konselor (*counsellor*)
   Perawat membantu keluarga mengatasi masalah dan perubahan perilaku melalui pendekatan terapeutik.
   Contoh: Perawat mendampingi keluarga agar lebih siap menerima kondisi penyakit terminal yang dialami oleh salah satu anggotanya.
g. Penemu kasus (*case finder*)
   Perawat mengidentifikasi dan menelusuri masalah kesehatan serta risiko penularan dalam keluarga.
   Contoh: Perawat melakukan skrining TB pada anggota keluarga pasien untuk mencegah penularan.
h. Pembina lingkungan sehat (*environmental specialist*)
   Perawat membantu memodifikasi lingkungan agar mendukung kesehatan keluarga.
   Contoh: Perawat menyarankan perbaikan ventilasi rumah dan menghilangkan *allergen* untuk mencegah kekambuhan penyakit asma.
i. Pemberi penjelasan informasi kesehatan (*interpreter*)
   Perawat menjelaskan informasi kesehatan agar mudah dipahami oleh keluarga.
   Contoh: Perawat menjelaskan hasil pemeriksaan laboratorium kepada keluarga pasien.
j. Pengganti sementara (*surrogate*)
   Perawat mengambil peran sementara untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga.
   Contoh: Perawat mendampingi ibu remaja saat persalinan, ketika tidak ada anggota keluarganya yang menemani.
k. Peneliti (*researcher*)
   Perawat mengidentifikasi masalah dan mencari solusi berbasis penelitian.
   Contoh: Perawat melakukan riset untuk meningkatkan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi.
l. Teladan (*role model*)
   Perawat menjadi contoh dalam perilaku hidup sehat bagi keluarga.
   Contoh: Perawat menunjukkan praktik cuci tangan pakai sabun dan air mengalir kepada keluarga binaannya.

m. Manajer kasus (*case manager*)

Perawat mengelola dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan keluarga secara menyeluruh.

Contoh: Perawat mengatur rencana perawatan terpadu bagi pasien lansia dengan penyakit kronis.

3. Siklus Kehidupan Keluarga dalam Keperawatan

Keluarga merupakan sistem yang dinamis dan terus berubah akibat interaksi antaranggota keluarga, lingkungan, serta berbagai peristiwa kehidupan. Riwayat keluarga mencakup tahap perkembangan dan peristiwa penting, seperti pembentukan keluarga, pengasuhan anak, sampai pengalaman kehilangan pasangan. Setiap tahap dan perubahan tersebut menuntut penyesuaian peran dan tugas dalam keluarga (Dupont, 2018). Teori perkembangan keluarga beranggapan bahwa setiap keluarga akan melewati tahapan-tahapan yang sama, dengan urutan dan waktu yang relatif tetap, mirip seperti tahap perkembangan pada anak (Clingempeel & Henggeler, 2009).

Duvall (1957) dengan merupakan salah satu ahli yang pertama kali membagi siklus kehidupan keluarga menjadi delapan tahap, dengan tugas perkembangan pada setiap tahap. Pembagian tahap dalam *The Eight-Stage Life Cycle Theory* ini didasarkan pada kriteria berikut: (1) perubahan utama dalam ukuran keluarga; (2) tahap perkembangan mengacu pada anak tertua (kecuali pada dua tahap terakhir siklus kehidupan keluarga saat anak tidak lagi berada di dalam keluarga); dan (3) status pekerjaan pencari nafkah (Friedman et al., 2003). Meskipun teori ini mendapatkan kritik karena terlalu fokus pada struktur keluarga tradisional dan mengesampingkan bentuk struktur keluarga modern yang lain, seperti keluarga yang bercerai, menunda kehamilan, dewasa yang melajang, dan lain-lain (Martin, 2018), tetapi teori ini tetap digunakan dalam asuhan keperawatan keluarga karena membantu perawat memahami perubahan normal dalam keluarga sepanjang kehidupan, serta menilai individu dan keluarga secara menyeluruh.

Setiap individu memiliki tugas perkembangan yang harus dicapai agar mampu berkembang secara sukses pada tahap perkembangan berikutnya. Oleh karena itu, setiap tahap perkembangan keluarga juga memiliki tugas perkembangan atau harapan peran tertentu yang harus dicapai, di samping lima fungsi dasar keluarga (reproduksi, sosialisasi, afeksi, ekonomi, dan perawatan kesehatan). Kegagalan menjalankan tugas sesuai tahapan perkembangan dapat berdampak pada stres, keterlambatan perkembangan keluarga, disfungsi keluarga intergenerasi, dan masalah kesehatan (Rago, 2016).

E. *Duvall's Eight-Stage Life Cycle*

1. Keluarga baru menikah (pasangan baru)

Pembentukan pasangan dalam ikatan pernikahan menandai terbentuknya suatu keluarga baru. Tugas kritis pada tahap perkembangan keluarga ini adalah: (1) membentuk pernikahan yang memuaskan bagi kedua belah pihak; (2) berhubungan secara harmonis dengan sanak saudara (jejaring kekerabatan); dan (3) perencanaan keluarga (keputusan tentang menjadi orang tua).

Pada tahap pasangan baru menikah, perhatian kesehatan berfokus pada penyesuaian peran sebagai suami dan istri, termasuk dalam hubungan seksual dan dinamika pernikahan, serta komunikasi yang efektif antar pasangan. Selain itu, pasangan memerlukan edukasi dan konseling terkait persiapan kehamilan, kesiapan menjadi orang tua, serta perencanaan keluarga (keluarga berencana). Pada tahap ini, sering perawat keluarga terperangkap di antara dua keluarga, yang perlu dilakukan adalah tetap profesional berusaha untuk membantu setiap kelompok memahami diri mereka dan orang lain.

2. Keluarga *childbearing*

Tahap perkembangan keluarga kedua ini dimulai dengan kelahiran anak pertama sampai dengan anak tersebut berusia 30 bulan. Transisi penting dalam tahap ini adalah pasangan memasuki masa menjadi orang tua, yang menjadi kunci bagi tahap-tahap perkembangan selanjutnya. Tugas kritis pada tahap perkembangan keluarga ini adalah: (1) membentuk keluarga muda sebagai suatu unit yang stabil (menggabungkan bayi yang baru ke dalam keluarga); (2) memperbaiki hubungan setelah terjadinya konflik mengenai tugas perkembangan dan kebutuhan berbagai anggota keluarga; (3) mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan; dan (4) memperluas hubungan dengan keluarga besar dengan menambah peran menjadi orang tua dan menjadi kakek/nenek.

Pada tahap keluarga *childbearing*, perhatian kesehatan berfokus pada pendidikan maternitas yang berpusat pada keluarga untuk mempersiapkan orang tua menghadapi persalinan serta transisi menjadi orang tua. Selain itu, tindak lanjut melalui kunjungan rumah diperlukan untuk memberikan edukasi dan dukungan dalam perawatan bayi, penatalaksanaan masalah kesehatan anak, imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Edukasi juga mencakup upaya menjaga keamanan anak, meningkatkan interaksi keluarga, serta mempromosikan perilaku hidup sehat, seperti pola tidur, nutrisi, dan aktivitas fisik. Di samping itu, konseling dan edukasi keluarga berencana

juga penting diberikan, mengingat kehamilan dengan jarak yang terlalu dekat dapat berdampak pada kesehatan ibu, ayah, anak, dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

3. Keluarga dengan anak prasekolah

Tahap perkembangan keluarga ketiga ini dimulai saat anak pertama berusia 2,5 tahun dan diakhiri ketika anak berusia 5 tahun. Keluarga pada tahap ini biasanya berisi tiga sampai lima orang, dengan peran sebagai pasangan suami-ayah, istri-ibu, putra-saudara laki-laki, dan putri-saudara perempuan. Keluarga menjadi lebih kompleks, sibuk, dan lebih menuntut. Tugas kritis pada tahap perkembangan keluarga ini adalah: (1) memenuhi kebutuhan anggota keluarga akan rumah, ruang, privasi dan keamanan yang memadai; (2) mensosialisasikan anak; (3) mengintegrasikan anak kecil sebagai anggota keluarga baru sementara tetap memenuhi kebutuhan anak lain; dan (4) mempertahankan hubungan yang sehat di dalam keluarga (hubungan pernikahan dan hubungan orang tua-anak) dan di luar keluarga (hubungan dengan keluarga besar dan komunitas).

Pada tahap keluarga dengan anak prasekolah, perhatian kesehatan berfokus pada masalah kesehatan fisik yang sering terjadi pada anak seperti penyakit menular, cedera (akibat jatuh, luka bakar, atau keracunan) yang terjadi selama masa prasekolah. Perhatian utama tentang kesehatan psikososial keluarga termasuk penurunan kepuasan dalam hubungan pernikahan, persaingan sibling, dan keluarga berencana.

Keluarga juga perlu memperhatikan stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menghadapi berbagai tantangan dalam pengasuhan, seperti penetapan batasan (disiplin), pencegahan penganiayaan dan pengabaian anak, keamanan lingkungan rumah, dan komunikasi dalam keluarga. Edukasi dan strategi promosi kesehatan terkait perilaku hidup bersih dan sehat tetap menjadi prioritas, karena kebiasaan yang dibentuk pada masa kanak-kanak akan berpengaruh hingga dewasa. Dalam hal ini, perawat berperan bekerja sama dengan anak dan keluarga untuk memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan yang sehat dan optimal.

4. Keluarga dengan anak sekolah

Tahap perkembangan keluarga keempat ini dimulai saat anak pertama berusia 5 tahun dan memasuki sekolah dalam waktu penuh, serta diakhiri ketika anak mencapai pubertas sekitar usia 13 tahun. Keluarga biasanya sudah mencapai pada jumlah anggota keluarga yang maksimal. Di masa ini semua

anggota keluarga, baik orang tua maupun anak-anak sibuk dengan minat dan aktifitas harian masing-masing. Tugas kritis pada tahap perkembangan keluarga ini adalah: (1) mensosialiasikan anak-anak, termasuk meningkatkan prestasi sekolah dan membantu hubungan anak-anak yang sehat dengan teman sebayanya; (2) mempertahankan hubungan pernikahan yang memuaskan; dan (3) memenuhi kebutuhan fisik anggota keluarga.

Pada tahap keluarga dengan anak usia sekolah, perhatian kesehatan tidak hanya berfokus pada keluarga, tetapi juga pada lingkungan sekolah yang melibatkan guru dan perawat sekolah. Pada tahap ini, berbagai masalah kesehatan anak mulai dapat terdeteksi melalui skrining, seperti gangguan penglihatan, pendengaran, dan kemampuan berbicara. Selain itu, masalah kesehatan lain seperti kesehatan gigi, penyakit menular, dan penyakit kronis juga memerlukan penanganan serta rujukan yang tepat.

Konseling dan intervensi keluarga diperlukan pada anak yang mengalami masalah perilaku, penyalahgunaan zat, serta kasus penganiayaan dan pengabaian. Di samping itu, edukasi dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat tetap menjadi prioritas dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

5. Keluarga dengan anak remaja

Tahap perkembangan keluarga kelima ini dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan berlangsung lama, sampai anak berusia 20 tahun. Bisa lebih singkat jika anak meninggalkan keluarga lebih awal, atau justru lebih lama karena anak tetap tinggal di rumah pada usianya yang lebih dari 20 tahun. Tujuan utama dalam masa ini adalah melonggarkan ikatan keluarga untuk memberikan tanggung jawab dan kebebasan remaja yang lebih besar dalam mempersiapkan diri menjadi seorang dewasa muda. Tugas kritis pada tahap perkembangan keluarga ini adalah: (1) menyeimbangkan kebebasan dengan tanggung jawab pada saat anak remaja telah dewasa dan semakin mandiri; (2) menfokuskan kembali hubungan pernikahan; dan (3) berkomunikasi secara terbuka antara orang tua dan anak.

Pada tahap keluarga dengan anak usia remaja, perhatian kesehatan tetap berfokus pada penerapan perilaku hidup sehat, serta pencegahan berbagai masalah kesehatan, seperti cedera akibat kecelakaan atau aktivitas olahraga. Selain itu, isu-isu seperti penyalahgunaan alkohol dan zat terlarang, penggunaan kontrasepsi, kehamilan yang tidak diinginkan, serta kesehatan reproduksi dan seksual menjadi area yang penting dan relevan untuk mendapatkan edukasi dan konseling. Perawat dapat mengambil peran sebagai

fasilitator komunikasi dan diskusi antara remaja dan orang tua terkait berbagai isu tersebut. Kebutuhan kesehatan lainnya meliputi dukungan dalam memperkuat hubungan pernikahan orang tua serta hubungan antara orang tua dan remaja. Pada kondisi tertentu, rujukan untuk konseling pada sumber yang tersedia di komunitas sekitar keluarga juga dapat diperlukan.

6. Keluarga yang melepas anak (*launching families*)

Tahap perkembangan keluarga keenam ini dimulai saat perginya anak pertama dari rumah orang tua dan berakhir saat kosongnya rumah, ketika anak terakhir juga sudah meninggalkan rumah. Tahap ini bisa berlangsung lama atau singkat, tergantung dari jumlah anak. Pada masa ini orang tua mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang mandiri, melepaskan anak-anaknya pergi, juga melepaskan peran sebagai orang tua yang telah dijalankan bertahun-tahun, dan kembali kepada pasangan hidupnya. Tugas kritis pada tahap perkembangan keluarga ini adalah: (1) memperluas lingkaran keluarga terhadap anak dewasa muda, termasuk memasukkan anggota keluarga baru yang berasal dari pernikahan anak-anaknya; (2) melanjutkan untuk memperbarui dan menyesuaikan kembali hubungan pernikahan; dan (3) membantu orang tua suami dan istri yang sudah menua dan sakit.

Pada tahap keluarga yang melepas anak, perhatian kesehatan berfokus pada komunikasi antara orang tua dan anak dewasa muda, serta penyesuaian peran dalam keluarga, terutama bagi suami dan istri. Selain itu, keluarga juga mulai menghadapi tanggung jawab dalam memberikan asuhan kepada orang tua lansia, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi kesehatan kronis dan faktor risiko, seperti kadar kolesterol tinggi, peningkatan glukosa darah, dan hipertensi yang berkaitan dengan gaya hidup tidak sehat. Pada tahap ini, wanita juga dapat mulai mengalami kekhawatiran terkait menopause. Oleh karena itu, promosi kesehatan mengenai perilaku hidup sehat menjadi semakin penting, khususnya bagi dewasa muda yang sedang mempersiapkan diri untuk hidup mandiri.

7. Keluarga usia pertengahan/paruh baya (*middle-age families*)

Tahap perkembangan keluarga ketujuh ini merupakan masa pertengahan bagi orang tua, yang dimulai sejak anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir dengan pensiun atau kematian salah satu pasangan. Pada tahap ini biasanya keluarga usia pertengahan berinteraksi dalam keluarga inti, di samping berinteraksi dengan orang tua lansia mereka dan kerabat dari keluarga asalnya, serta dengan keluarga baru yang didapat dari pernikahan

anak cucu (keturunan) mereka. Tahap ini disebut sebgaai tahap terbaik dalam kehidupan keluarga. Tugas kritis pada tahap perkembangan keluarga ini adalah: (1) menyediakan lingkungan yang meningkatkan kesehatan; (2) mempertahankan kepuasan dan hubungan yang bermakna antara orang tua yang telah menua dan anak mereka; dan (3) memperkuat hubungan pernikahan.

Pada tahap keluarga usia pertengahan, perhatian kesehatan berfokus pada promosi perilaku hidup sehat, seperti istirahat yang cukup, aktivitas fisik, nutrisi seimbang, serta menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, disertai dengan peningkatan pemeriksaan kesehatan secara rutin sebagai upaya preventif. Selain itu, perhatian juga diberikan pada kualitas hubungan pernikahan, komunikasi dengan anak, keluarga pasangan, cucu, serta orang tua yang semakin menua. Keluarga juga mulai menghadapi peran dalam memberikan asuhan kepada orang tua lansia, serta menyesuaikan diri dengan perubahan fisiologis, termasuk perubahan hormonal dan menopause pada wanita.

8. Keluarga lansia (*aging families*)

Tahap perkembangan keluarga yang kedelapan dimulai saat salah satu atau kedua pasangan memasuki masa pensiun, dan berlangsung hingga akhir kehidupan pasangan. Tahap ini umumnya terjadi pada usia lanjut (≥60 tahun) dan ditandai dengan berbagai perubahan dan kehilangan, seperti penurunan kondisi ekonomi, perubahan tempat tinggal (misalnya pindah ke rumah yang lebih kecil atau panti lansia), berkurangnya hubungan sosial, serta penurunan kondisi kesehatan. Tugas kritis pada tahap perkembangan keluarga ini adalah: (1) mempertahankan penataan kehidupan yang memuaskan; (2) menyesuaikan terhadap penghasilan yang berkurang; (3) mempertahankan hubungan pernikahan; (4) menyesuaikan terhadap kehilangan pasangan; (5) mempertahankan ikatan keluarga antargenerasi; dan (6) melanjutkan untuk merasionalisasi kehilangan keberadaan anggota keluarga.

Pada tahap keluarga lansia, perhatian kesehatan berfokus pada meningkatnya disabilitas fungsional, gangguan mobilitas, penyakit kronik, serta penurunan kekuatan dan fungsi fisik. Dalam hal ini, perawat berperan memberikan edukasi kepada keluarga terkait perawatan lansia, manajemen penyakit kronik, serta pencegahan komplikasi dan cedera. Selain itu, perawat juga memberikan konseling untuk membantu lansia dan keluarga dalam menghadapi perubahan psikologis, seperti perasaan kehilangan, isolasi sosial, berduka, dan depresi. Intervensi keperawatan juga mencakup dukungan dalam

perawatan jangka panjang, termasuk pelatihan *caregiver* primer dalam memberikan asuhan sehari-hari.

Pada kondisi tertentu, perawat perlu melakukan rujukan ke tenaga kesehatan lain, seperti dokter, fisioterapis, atau tenaga kesehatan jiwa, terutama pada lansia dengan gangguan mobilitas berat, penyakit kronik multipel, atau gangguan kognitif. Dengan demikian, perawat berperan dalam meningkatkan kualitas hidup lansia dan mendukung keluarga dalam memberikan perawatan yang optimal.

F. Siklus kehidupan dalam keluarga yang bercerai

Salah satu variasi dalam siklus kehidupan keluarga adalah perceraian orang tua. Dalam masyarakat modern, perceraian semakin sering terjadi dan menjadi bagian dari dinamika kehidupan keluarga. McGoldrick and Carter (2003) menggambarkan perceraian sebagai gangguan terhadap siklus kehidupan keluarga tradisional. Keluarga yang mengalami perceraian akan menghadapi perubahan dalam peran, hubungan, serta tugas-tugas perkembangan yang perlu diselesaikan agar keluarga dapat beradaptasi dan melanjutkan tahap perkembangan berikutnya.

1. Tahap perceraian (*divorce*)

Tahap ini terdiri atas keputusan untuk bercerai, merencanakan pemutusan sistem, perpisahan, dan perceraian. Tahap perceraian diawali pasangan mulai menerima bahwa konflik pernikahan tidak dapat diselesaikan dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan. Proses ini melibatkan perencanaan perpisahan, termasuk pengaturan pengasuhan anak dan tanggung jawab finansial. Pada fase ini, penting bagi kedua pihak untuk mulai membangun kerja sama sebagai orang tua (*co-parenting*) demi kepentingan anak.

Pada fase ini, perawat berperan memberikan edukasi mengenai dampak perceraian terhadap anak dan keluarga, serta pentingnya *co-parenting*. Selain itu, perawat dapat memberikan konseling awal untuk membantu keluarga menghadapi keputusan perceraian, serta melakukan rujukan bila diperlukan, misalnya ke konselor keluarga atau tenaga kesehatan jiwa (Marcussen et al., 2019).

2. Tahap pasca perceraian (*postdivorce*)

Pada tahap ini, orang tua yang tinggal bersama anak (*custodial*) menjalankan peran utama dalam pengasuhan sehari-hari. Penyesuaian diri dengan peran sebagai orang tua tunggal, mengelola kebutuhan ekonomi,

serta memastikan hubungan anak dengan orang tua lainnya tetap terjaga. Sementara orang tua yang tidak tinggal bersama anak (*noncustodial*) tetap memiliki tanggung jawab dalam menjaga hubungan emosional dan mendukung kebutuhan anak, termasuk secara finansial. Adaptasi diperlukan untuk menjalankan peran sebagai orang tua dalam kondisi terpisah.

Pada fase ini, perawat memberikan edukasi tentang pengasuhan anak dan tumbuh kembang, serta dukungan dalam mengelola stres dan beban peran. Perawat juga membantu mengidentifikasi sumber daya keluarga, cara komunikasi efektif, dan melakukan rujukan bila terdapat masalah psikososial.

G. Aktivitas 1 — Knows How

Tes tertulis (tugas individu)

1. Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada seorang lansia yang tinggal bersama tetangga dekatnya dan tidak memiliki hubungan darah. Lansia tersebut menganggap tetangganya sebagai keluarga karena selalu merawatnya saat sakit.
   Pendekatan konsep keluarga yang paling tepat adalah:
   A. Keluarga berdasarkan hukum
   B. Keluarga sebagai unit ekonomi
   C. Keluarga sebagai sistem tertutup
   D. Keluarga berdasarkan hubungan biologis
   E. Keluarga ditentukan oleh anggotanya sendiri

2. Seorang ibu tinggal bersama dua anaknya setelah bercerai. Ia menjadi satu-satunya pencari nafkah dan pengasuh anak.
   Struktur keluarga tersebut adalah:
   A. Nuclear family
   B. Blended family
   C. Extended family
   D. Binuclear family
   E. Single parent family

3. Keluarga mengajarkan anak tentang norma sosial, sopan santun, dan nilai budaya sejak kecil.
   Fungsi keluarga yang ditunjukkan adalah:
   A. Afeksi
   B. Ekonomi

C. Sosialisasi
D. Reproduksi
E. Perawatan kesehatan

4. Dalam suatu keluarga, keputusan pengobatan anak selalu ditentukan oleh ayah tanpa melibatkan anggota keluarga lain.
   Masalah utama dalam proses keluarga tersebut, adalah:
   A. Peran
   B. Koping
   C. Komunikasi
   D. Nilai keluarga
   E. Pengambilan Keputusan

5. Perawat memberikan asuhan pada pasien TB dengan melibatkan seluruh anggota keluarga untuk mencegah penularan.
   Pendekatan yang digunakan adalah:
   A. Keluarga sebagai klien
   B. Keluarga sebagai sistem
   C. Keluarga sebagai individu
   D. Keluarga sebagai konteks
   E. Keluarga sebagai komunitas

6. Perawat membantu keluarga pasien stroke mendapatkan akses layanan home care dan rehabilitasi.
   Peran perawat dalam hal ini adalah sebagai:
   A. *Educator*
   B. *Counsellor*
   C. *Role model*
   D. *Collaborator*
   E. *Care provider*

7. Keluarga dengan anak pertama usia 2 tahun datang ke puskesmas untuk pemantauan tumbuh kembang.
   Tahap perkembangan keluarga tersebut saat ini adalah:
   A. Remaja
   B. Sekolah
   C. Prasekolah
   D. *Childbearing*

E. Pasangan baru

8. Seorang balita mengalami stunting. Orang tua jarang membawa anak ke posyandu, tidak memahami gizi seimbang, dan komunikasi dalam keluarga kurang baik.

   Masalah utama keluarga berdasarkan tugas perkembangan adalah:

   A. Tidak mampu memperluas keluarga
   B. Tidak mampu memenuhi fungsi ekonomi
   C. Tidak mampu menjalankan fungsi reproduksi
   D. Tidak mampu mempertahankan hubungan sosial
   E. Tidak mampu menjalankan tugas perawatan kesehatan keluarga

H. Aktivitas 2 — *Shows How*

Studi Kasus dan Simulasi (diskusi kelompok)

Kasus 1

Saat kunjungan rumah, perawat bertemu keluarga yang terdiri dari ayah (32 tahun), ibu (28 tahun), dan seorang anak pertama laki-laki berusia 20 bulan. Ayah bekerja sebagai pekerja informal dengan penghasilan tidak tetap, sedangkan ibu adalah ibu rumah tangga. Sejak kelahiran anak, ibu mengaku mengalami kesulitan dalam menyusui sehingga pemberian ASI eksklusif tidak optimal. Saat ini, anak lebih sering diberikan makanan seadanya dengan variasi yang terbatas dan jadwal makan yang tidak teratur. Ibu juga menyampaikan bahwa anak sering menolak makan.

Hasil penimbangan terakhir menunjukkan bahwa berat badan dan tinggi badan anak berada di bawah standar usianya, dan anak dinyatakan mengalami stunting. Namun, keluarga belum memahami kondisi tersebut sebagai masalah kesehatan yang serius.

Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga jarang membawa anak ke pusat pelayanan kesehatan, kecuali saat imunisasi. Hubungan antara suami dan istri dalam pengasuhan anak belum optimal, di mana sebagian besar tanggung jawab pengasuhan dibebankan kepada ibu. Selain itu, kondisi lingkungan tempat tinggal memiliki keterbatasan akses air bersih dan sanitasi yang kurang memadai.

Pertanyaan diskusi

1. Identifikasi masalah utama yang terjadi pada keluarga berdasarkan kasus di atas (biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan)!
2. Tentukan tahap perkembangan keluarga saat ini dan jelaskan apakah tugas perkembangan keluarga telah berjalan optimal!

3. Identifikasi tugas kesehatan keluarga yang belum terpenuhi disertai dengan data pendukung dari kasus!
4. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya stunting pada anak dalam kasus tersebut (faktor individu, keluarga, dan lingkungan)!
5. Tentukan fokus pelayanan keperawatan keluarga yang tepat berdasarkan prioritas masalah!
6. Jelaskan peran perawat keluarga yang dapat dilakukan dalam menangani kasus tersebut!

Petunjuk pengerjaan kelompok

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok berdasarkan data kasus yang diberikan.
2. Gunakan pendekatan keperawatan keluarga (*family nursing process*) dalam menganalisis kasus.
3. Dukung jawaban dengan sumber referensi yang relevan (buku teks, jurnal ilmiah, atau pedoman seperti WHO/Kemenkes).
4. Susun hasil diskusi secara sistematis sesuai dengan komponen: (1) Tahap perkembangan keluarga; (2) Tugas perkembangan; (3) Tugas kesehatan keluarga; (4) Fokus pelayanan; dan (5) Peran perawat.
5. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara jelas, ringkas, dan menggunakan media yang menarik (*Power Point*).
6. Lakukan simulasi komunikasi dengan keluarga, dengan pembagian peran:
   1 mahasiswa sebagai perawat, dan 2 mahasiswa sebagai anggota keluarga.
   Fokuskan simulasi pada:
   a. Mengidentifikasi tahap perkembangan keluarga secara verbal.
   b. Menjelaskan tuugas perkembangan keluarga.
   c. Mengaitkan masalah dengan kondisi keluarga.
   d. Memberikan edukasi sederhana secara terapeutik.

Kasus 2

Saat kunjungan rumah, perawat menemui sebuah keluarga yang terdiri dari seorang lansia laki-laki (67 tahun), anak perempuanya (35 tahun) yang sudah menikah, serta menantu laki-laki (37 tahun). Lansia tersebut tinggal bersama anak dan menantunya sejak istrinya meninggal dua tahun yang lalu. Anak bekerja sebagai pegawai swasta, sedangkan menantu bekerja sebagai sopir dengan jadwal kerja yang tidak tetap.

Lansia memiliki riwayat hipertensi sejak lima tahun yang lalu, namun tidak rutin mengonsumsi obat yang diberikan oleh puskesmas. Ia sering mengatakan bahwa dirinya merasa "baik-baik saja" sehingga tidak perlu minum obat setiap hari. Selain itu, lansia memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan tinggi garam seperti ikan asin, serta makanan bersantan yang dikonsumsi hampir setiap hari.

Keluarga menyampaikan bahwa mereka sudah beberapa kali mengingatkan lansia untuk mengurangi konsumsi makanan tersebut dan minum obat secara teratur, namun lansia sering menolak dan marah-marah. Dalam aktivitas sehari-hari, lansia masih mampu melakukan kegiatan secara mandiri, tetapi jarang melakukan aktivitas fisik seperti olahraga ringan.

Hasil pemeriksaan terakhir menunjukkan tekanan darah lansia 150/100 mmHg. Namun, keluarga belum memahami risiko komplikasi dari hipertensi yang tidak terkontrol, seperti stroke atau penyakit jantung. Selain itu, keluarga jarang membawa lansia ke fasilitas pelayanan kesehatan, kecuali jika ada keluhan yang dirasa berat.

Dari aspek lingkungan, keluarga tinggal di daerah padat penduduk dengan kebiasaan konsumsi makanan tinggi garam yang cukup umum di lingkungan tersebut. Dukungan keluarga dalam pengelolaan penyakit lansia belum optimal, terutama dalam hal pengawasan diet dan kepatuhan pengobatan.

Pertanyaan diskusi

1. Identifikasi masalah utama yang terjadi pada keluarga berdasarkan kasus di atas (biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan)!
2. Tentukan tahap perkembangan keluarga saat ini dan jelaskan apakah tugas perkembangan keluarga telah berjalan optimal!
3. Identifikasi tugas kesehatan keluarga yang belum terpenuhi disertai dengan data pendukung dari kasus!
4. Analisis faktor-faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan penatalaksanaan kesehatan pada lansia dalam kasus tersebut (faktor individu, keluarga, dan lingkungan)!
5. Tentukan fokus pelayanan keperawatan keluarga yang tepat berdasarkan prioritas masalah!

6. Jelaskan peran perawat keluarga yang dapat dilakukan dalam menangani kasus tersebut!

Petunjuk pengerjaan kelompok

1. Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok berdasarkan data kasus yang diberikan.
2. Gunakan pendekatan keperawatan keluarga (*family nursing process*) dalam menganalisis kasus.
3. Dukung jawaban dengan sumber referensi yang relevan (buku teks, jurnal ilmiah, atau pedoman seperti WHO/Kemenkes).
4. Susun hasil diskusi secara sistematis sesuai dengan komponen: (1) Tahap perkembangan keluarga; (2) Tugas perkembangan; (3) Tugas kesehatan keluarga; (4) Fokus pelayanan; dan (5) Peran perawat.
5. Presentasikan hasil diskusi di kelas secara jelas, ringkas, dan menggunakan media yang menarik (*Power Point*).
6. Lakukan simulasi komunikasi dengan keluarga, dengan pembagian peran:
   1 mahasiswa sebagai perawat, dan 2 mahasiswa sebagai anggota keluarga.
   Fokuskan simulasi pada:
   a. Mengidentifikasi tahap perkembangan keluarga secara verbal.
   b. Menjelaskan tuugas perkembangan keluarga.
   c. Mengaitkan masalah dengan kondisi keluarga.
   d. Memberikan edukasi sederhana secara terapeutik.

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	**Tes tertulis (tugas individu)**
Shows How	**Studi Kasus dan Simulasi (diskusi kelompok)**

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *menjelaskan.*
  OSCE tidak sesuai.

DOPS (Does) → CP Bab "menjelaskan"

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Anak dengan Diare
- *Checklist* + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Portofolio → CP Bab "menjelaskan"

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- *Feedback* CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

I. Tabel *Red Flags* dan Ekskalasi

Konsep Dasar Keperawatan Keluarga Dan Siklus Kehidupan Keluarga

Aspek	*Red Flags* (Tanda Risiko)	Tindakan Ekskalasi
Struktur keluarga	Struktur tidak jelas/perubahan (*single parent*, lansia tinggal sendiri) tanpa adaptasi	Berikan dukungan sosial dan penguatan sistem keluarga
Fungsi keluarga	Fungsi tidak berjalan optimal (afeksi, ekonomi, sosialisasi, kesehatan)	Perlu intervensi berbasis fungsi keluarga
Peran keluarga	Peran tidak seimbang atau konflik peran	Perlu klarifikasi dan redistribusi peran
Komunikasi pengambilan keputusan	Komunikasi tidak efektif, dominasi satu pihak	Lakukan pendekatan komunikasi terapeutik
Pola koping keluarga	Koping keluarga tidak efektif/adaptif terhadap stresor yang dialami	Bantu keluarga mempelajari mekanisme koping yang tepat untuk menghadapi stresor.
Nilai dan norma	Nilai/norma menghambat kesehatan	Edukasi dengan pendekatan budaya
Mengenali masalah kesehatan	Keluarga tidak menyadari kondisi/masalah kesehatan	Peningkatan literasi kesehatan
Pengambilan keputusan	Keputusan kesehatan tidak tepat/ditunda	Pendampingan dalam pengambilan keputusan
Perawatan anggota keluarga	Perawatan tidak adekuat	Edukasi dan monitoring-evaluasi kemampuan keluarga melakukan perawatan pada anggotanya
Pemanfaatan fasilitas kesehatan	Jarang atau tidak memanfaatkan layanan kesehatan	Berikan informasi mengenai fasilitas layanan kesehatan terdekat, advokasi, dan fasilitasi akses layanan
Lingkungan keluarga	Sanitasi buruk, air tidak bersih, lingkungan tidak sehat	Berikan intervensi untuk memodifikasi lingkungan dengan kolaborasi lintas sektor

Tahap perkembangan keluarga	Tidak mampu menjalankan tugas sesuai tahap	Edukasi sesuai tahap siklus kehidupan keluarga
Tugas perkembangan	Ketidaksesuaian peran	Perlu penguatan peran dan fungsi keluarga

Form *checklist* "Saya sudah bisa…"

Konsep Dasar Keperawatan Keluarga Dan Siklus Kehidupan Keluarga

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik/*Skill Lab* : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan definisi keluarga	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelasan konsep struktur keluarga	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan berbagai fungsi keluarga	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menjelaskan berbagai komponen proses keluarga (komunikasi, peran, pengambilan keputusan, pola koping, runitinas, norma/nilai)	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menjelaskan definisi keluarga sehat dan indikatornya	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa menjelaskan definisi keperawatan keluarga	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa menjelaskan karakteristik keperawatan keluarga	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan keperawatan keluarga	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menjelaskan berbagai pendekatan yang digunakan dalam asuhan keperawatan keluarga	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menjelaskan sasaran keperawatan keluarga	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menjelaskan tatanan dan ruang lingkup praktik keperawatan keluarga	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa menjelaskan peran perawat keluarga	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa menjelaskan siklus kehidupan keluarga beserta tugas dan kebutuhan edukasi/dukungannya dari perawat	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

J. Rangkuman Materi

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan status kesehatan anggotanya. Dalam konteks keperawatan, keluarga tidak hanya dipahami sebagai kumpulan individu yang terikat oleh hubungan darah atau hukum, tetapi juga sebagai suatu sistem yang dibentuk oleh ikatan emosional, komitmen, dan pengakuan antaranggota. Oleh karena itu, definisi keluarga bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perubahan sosial, budaya, serta kondisi kehidupan yang dialami.

Struktur keluarga menggambarkan komposisi dan pola hubungan antaranggota keluarga, yang dapat berubah seiring dengan siklus kehidupan dan dinamika sosial. Perubahan struktur ini akan memengaruhi fungsi keluarga, yaitu peran yang dijalankan dalam memenuhi kebutuhan anggotanya. Fungsi keluarga mencakup aspek reproduksi, sosialisasi, ekonomi, afeksi, serta perawatan kesehatan. Seluruh fungsi tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap kesejahteraan fisik, psikologis, dan sosial anggota keluarga.

Selain struktur dan fungsi, proses keluarga juga menjadi komponen penting yang memengaruhi kesehatan keluarga. Proses ini meliputi pola komunikasi, pembagian peran, pengambilan keputusan, mekanisme koping, serta nilai dan norma yang dianut oleh keluarga. Interaksi yang efektif dan adaptif dalam proses keluarga akan mendukung terciptanya keluarga yang sehat. Keluarga sehat ditandai oleh kemampuannya dalam menjalankan fungsi secara optimal, beradaptasi terhadap perubahan, serta memberikan dukungan emosional dan sosial kepada setiap anggotanya.

Keperawatan keluarga merupakan bentuk asuhan yang bersifat holistik dengan menjadikan keluarga sebagai unit utama pelayanan. Pendekatan ini menekankan bahwa intervensi tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada sistem keluarga secara keseluruhan. Tujuan utama keperawatan keluarga adalah meningkatkan kemandirian keluarga dalam mengenali masalah kesehatan,

mengambil keputusan yang tepat, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, serta memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan secara optimal.

Dalam praktiknya, keperawatan keluarga dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu keluarga sebagai konteks, sebagai klien, sebagai sistem, dan sebagai bagian dari masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan perawat untuk memahami keluarga secara komprehensif, baik dari aspek internal maupun eksternal. Ruang lingkup praktik keperawatan keluarga meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga resosialisasi, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga.

Perawat keluarga memiliki peran yang sangat beragam, antara lain sebagai edukator, pemberi asuhan, konselor, advokat, kolaborator, konsultan, penemu kasus, pembina lingkungan sehat, pemberi informasi kesehatan, pengganti sementara, peneliti, teladan, serta manajer kasus. Peran-peran tersebut dijalankan secara terpadu untuk mendukung tercapainya derajat kesehatan keluarga yang optimal.

Keluarga juga mengalami perkembangan melalui siklus kehidupan yang terdiri dari delapan tahap, yaitu pasangan baru, keluarga dengan bayi (*childbearing*), keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak usia sekolah, keluarga dengan anak remaja, keluarga yang melepas anak (*launching*), keluarga usia pertengahan, dan keluarga lansia. Setiap tahap memiliki tugas perkembangan dan kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan asuhan yang spesifik. Pemahaman terhadap siklus kehidupan keluarga menjadi penting bagi perawat dalam mengidentifikasi kebutuhan edukasi, dukungan, dan intervensi yang sesuai, sehingga asuhan keperawatan dapat diberikan secara tepat, efektif, dan berkelanjutan.

Inti bab ini adalah memahami keluarga sebagai sistem yang dinamis, peran dan fungsi keluarga dalam kesehatan, serta pentingnya pendekatan keperawatan keluarga yang holistik dan berbasis siklus kehidupan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga.

K. Daftar Pustaka

Alexander, M., Waxman, D., & Fraser, K. (2024). Family dynamics. In Cinemeducation: A Comprehensive Guide to using Film in Medical Education (pp. 35-41).

Burgess, E. W., & Locke, H. J. (1945). The family: from institution to companionship. Oxford, England: American Book Co.

Clingempeel, W. G., & Henggeler, S. W. (2009). Family Development, Theories of. In The Corsini Encyclopedia of Psychology (pp. 1-3).

Denham, S. A., Eggenberger, S., Young, P., & Krumwiede, N. (2015). Family-focused nursing care: FA Davis.

Dupont, S. (2018). The family life cycle: An essential concept to look at contemporary families. Therapie Familiale, 39(2), 169-181. doi:10.3917/tf.182.0169

Duvall, E. (1957). Family Development. Philadelphia: J. B. Lippincott.

Ermisch, J. (2018). Family Economics. In The New Palgrave Dictionary of Economics, Third Edition (pp. 4450-4455).

Fawcett, J. (1984). Analysis and evaluation of conceptual models of nursing. Philadelphia, USA: F.A. Davis.

Friedemann, M. L. (1989). The concept of family nursing. J Adv Nurs, 14(3), 211-216. doi:10.1111/j.1365-2648.1989.tb01527.x

Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. (2003). Family nursing : research, theory & practice (5th ed.). Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall.

Kaakinen, J. R. (2010). Family health care nursing : theory, practice and research (4th ed.). Philadelphia: F.A. Davis Co.

Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., & Robinson, M. (2018). Family health care nursing: Theory, practice, and research: FA Davis.

KemendikdasmenRI. (2016). KBBI VI Daring. Retrieved from https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/keluarga. Retrieved 30 Maret 2026, from Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/keluarga

KemenkesRI. (2016). Pedoman Umum Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Jakarta: Kemenkes RI.

KemenkesRI. (2017). Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kemenkes RI.

KemenkesRI. (2021). Modul Pembelajaran Retaker Sarjana Keperawatan : Keperawatan Keluarga. Jakarta: Kemenkes RI.

Kholifah, S. N., & Widagdo, W. (2016). Keperawatan keluarga dan komunitas. In. Jakarta, Indonesia: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lee, J. Y., Bentzon, R., & Di Nucci, E. (2024). What Is A Family? A Constitutive-Affirmative Account. Journal of Bioethical Inquiry, 21(4), 647-657. doi:10.1007/s11673-024-10339-x

Marcussen, J., Hounsgaard, L., Bruun, P., Laursen, M. G., Thuen, F., & Wilson, R. (2019). The Divorced Family–Focused Care Model: A Nursing Model to Enhance Child and Family Mental Health and Well-Being of Doubly Bereaved Children Following Parental Divorce and Subsequent Parental Cancer and Death. Journal of Family Nursing, 25(3), 419-446. doi:10.1177/1074840719863918

Martin, T. (2018). Family Development Theory 30 Years Later. Journal of Family Theory & Review, 10(1), 49-69. doi:10.1111/jftr.12237

McGoldrick, M., & Carter, B. (2003). The family life cycle. Normal family processes: Growing diversity and complexity, 17, 375-398.

Novianti, L. E., Purba, F. D., Puspitasari, S. V., Nadirah, A. A., Purba, I. N. B., Karremans, J. C., & Agustiani, H. (2025). The meaning of marriage, the meaning of family, and the function of family for Indonesian married people. BMC Psychol, 13(1), 1410. doi:10.1186/s40359-025-03670-4

Ochs, J., Roper, S., & Schwartz, S. (2024). Population Health for Nurses. Retrieved from https://openstax.org/books/population-health/pages/28-3-family-health-nursing

Ouahid, H., Sebbani, M., Cherkaoui, M., Amine, M., & Adarmouch, L. (2025). The influence of gender norms on women's sexual and reproductive health outcomes: a systematic review. BMC women's health, 25(1). doi:10.1186/s12905-025-03768-2

Pedoman Penyelenggaraan Upaya Keperawatan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas, KemenkesRI, 279 Stat. (KemenkesRI 2006).

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Republik Indonesia, 52 Stat. (Republik Indonesia 2009).

Porta, N. J., & Brown, K. S. (2016). Family Cohesion. In The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies (pp. 1-2).

Rago, M. (2016). Family Development Theory. In The Wiley Blackwell Encyclopedia of Family Studies (pp. 1-6).

Ramos Rangel, Y., & González Valdés, M. Á. (2017). An approach to the family educative function. Revista Cubana de Medicina General Integral, 33(1), 100-

114. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85040821988&partnerID=40&md5=1b0bff141fd81af3ede4190cdcbcd40c

Robinson, M., Coehlo, D. P., & Smith, P. S. (2022). Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research: FA Davis.

Sharma, R. (2013). The Family and Family Structure Classification Redefined for the Current Times. J Family Med Prim Care, 2(4), 306-310. doi:10.4103/2249-4863.123774

Sheppard, R. (2009). Gender, marriage, and family in post-industrial society: An international perspective. In The Welfare State in Post-Industrial Society: A Global Perspective (pp. 99-124).

Tulchinsky, T. H., Varavikova, E. A., & Cohen, M. J. (2023). Chapter 6 - Family health and primary prevention. In T. H. Tulchinsky, E. A. Varavikova, & M. J. Cohen (Eds.), The New Public Health (Fourth Edition) (pp. 467-549). San Diego: Academic Press.

Vyhrystyuk, M. S., Onina, S. V., Islamova, J. V., & Savchuk, I. P. (2018). The image of the family in the modern advertising discourse of Russian media. Astra Salvensis, 6(12), 711-717. Retrieved from https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85055775716&partnerID=40&md5=e0bbea96bb8c7a9d1a4a6c65cf8424f9

WHO. (1946, 2026). Constitution of the World Health Organization. Retrieved from https://www.who.int/about/governance/constitution

WHO. (2000). The family health nurse: context, conceptual framework and curriculum. Regional Office for Europe: WHO.

BAB 2

TEORI SISTEM KELUARGA, PERAN, FUNGSI, DAN DINAMIKA KELUARGA

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor.	CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi).	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-3	Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi.
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian komunitas dan keluarga secara sistematis (data, pemetaan, risiko, genogram/ecomap) secara etis dan akurat.
CPMK-6	Menyusun perencanaan intervensi/program dan asuhan keluarga (home visit, kemitraan, manajemen kasus, rujukan) yang terukur dan feasible.

Uraian Materi

A. Teori Sistem Keluarga dalam Keperawatan

1. Konsep Dasar Teori Sistem Keluarga

Teori sistem keluarga menjelaskan bahwa keluarga merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap anggota keluarga memiliki peran tertentu dan berkontribusi terhadap fungsi sistem secara keseluruhan. Perubahan pada satu bagian sistem akan memengaruhi bagian lainnya (Friedemann, 1989)

Keluarga sebagai sistem juga memiliki sifat terbuka, artinya keluarga terus berinteraksi dengan lingkungan eksternal seperti masyarakat, budaya, dan sistem pelayanan kesehatan. Interaksi ini memengaruhi kemampuan keluarga dalam beradaptasi terhadap perubahan dan menghadapi berbagai masalah kesehatan (Kaakinen et al., 2018).

2. Karakteristik Sistem Keluarga

a. Kesatuan (*Wholeness*)

Keluarga dipandang sebagai satu kesatuan utuh. Artinya, perilaku atau kondisi satu anggota tidak dapat dipahami secara terpisah dari anggota lainnya.

b. Saling keteregantungan (*Interdependensi*)

Setiap anggota keluarga memiliki hubungan yang erat dan saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan fisik maupun emosional.

c. Batasan (*Boundaries*)

Batasan mengatur sejauh mana interaksi terjadi dalam keluarga dan antara keluarga dengan lingkungan luar. Batasan yang terlalu kaku dapat menghambat komunikasi, sedangkan batasan yang terlalu longgar dapat menyebabkan kurangnya kontrol.

d. Homeostasis (Keseimbangan)

Keluarga memiliki kecenderungan untuk mempertahankan kondisi stabil meskipun terjadi perubahan.

e. Adapatasi

Kemampuan keluarga dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan, seperti perubahan peran, kondisi ekonomi, atau masalah kesehatan (Kaakinen et al., 2018).

3. Subsistem dalam Keluarga

a. Pengertian Subsistem dalam Keluarga

Dalam teori sistem keluarga, keluarga tidak hanya dipandang sebagai satu kesatuan utuh, tetapi juga terdiri dari beberapa bagian yang lebih kecil yang disebut **subsistem**. Subsistem merupakan kelompok kecil dalam keluarga yang terbentuk berdasarkan hubungan, fungsi, atau peran tertentu (Wright & Leahey, 2005). Subsistem terbentuk karena keluarga perlu membagi tugas, peran, dan tanggung jawab agar fungsi keluarga dapat berjalan dengan efektif. Setiap anggota keluarga dapat menjadi bagian dari lebih dari satu subsistem, tergantung pada peran yang dimilikinya dalam keluarga (Wright & Leahey, 2005). Selain itu, dalam perspektif teori sistem keluarga, subsistem membantu menjelaskan bagaimana interaksi dalam keluarga berlangsung secara lebih spesifik dan terstruktur. Hal ini penting dalam memahami dinamika keluarga secara menyeluruh.

b. Jenis-Jenis Subsistem dalam Keluarga

1) Subsistem Pasangan (Suami–Istri / *Marital Subsystem*)

Subsistem pasangan terdiri dari hubungan antara suami dan istri sebagai inti dari keluarga. Subsistem ini berfungsi sebagai dasar dalam pembentukan keluarga dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan serta menjaga stabilitas keluarga.

Fungsi utama subsistem pasangan meliputi:

a) Menjalin hubungan emosional yang stabil
b) Mengambil keputusan keluarga
c) Menjadi model bagi anak dalam hubungan interpersonal

Hubungan yang sehat dalam subsistem ini akan mendukung fungsi keluarga secara keseluruhan. Sebaliknya, konflik dalam hubungan suami-istri dapat berdampak pada seluruh anggota keluarga (Fingerman & Bermann, 2000)

2) Subsistem Orang Tua–Anak (*Parental Subsystem*)

Subsistem ini terdiri dari interaksi antara orang tua dan anak. Fokus utama subsistem ini adalah pada proses pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan perilaku anak.

Fungsi utama:

a) Memberikan pengasuhan dan perlindungan
b) Menanamkan nilai dan norma
c) Mengontrol dan membimbing perilaku anak

Subsistem ini memiliki batasan yang jelas antara peran orang tua dan anak. Ketidaktegasan batasan, misalnya anak mengambil peran orang tua, dapat menyebabkan gangguan dalam struktur keluarga (Wright & Leahey, 2005)

3) Subsistem Saudara Kandung (*Sibling Subsystem)*

Subsistem saudara kandung terbentuk dari hubungan antar anak dalam keluarga. Subsistem ini penting dalam perkembangan sosial dan emosional anak.

Fungsi utama:

a) Sarana belajar interaksi sosial
b) Mengembangkan keterampilan komunikasi
c) Belajar berbagi dan menyelesaikan konflik

Hubungan saudara yang sehat dapat meningkatkan dukungan emosional dalam keluarga. Sebaliknya, konflik yang berkepanjangan dapat memengaruhi keseimbangan keluarga

c. Karakteristik Subsistem Keluarga

Subsistem dalam keluarga memiliki beberapa karakteristik penting:

1) Dibentuk Berdasarkan Fungsi dan Peran

Subsistem terbentuk untuk menjalankan fungsi tertentu dalam keluarga, seperti pengasuhan, dukungan emosional, atau pengambilan keputusan (Alexander et al., 2024)

2) Memiliki Batasan (*Boundaries*)

Setiap subsistem memiliki batasan yang mengatur interaksi antaranggota. Batasan ini dapat bersifat:

a) Terbuka (fleksibel)
b) Tertutup (kaku)

Batasan yang tidak jelas dapat menyebabkan konflik peran dalam keluarga (Malik, 2020)

3) Bersifat Dinamis

Subsistem dapat berubah sesuai dengan perkembangan keluarga, misalnya saat anak tumbuh dewasa atau terjadi perubahan struktur keluarga.

4) Saling Berhubungan

Subsistem tidak berdiri sendiri, tetapi saling memengaruhi satu sama lain. Perubahan pada satu subsistem akan berdampak pada subsistem lainnya.

Contoh:

Konflik dalam subsistem pasangan dapat memengaruhi hubungan orang tua dengan anak.

d. Peran Subsistem dalam Keperawatan Keluarga

Dalam praktik keperawatan, pemahaman tentang subsistem keluarga sangat penting karena:

1) Membantu perawat mengidentifikasi sumber masalah dalam keluarga
2) Mempermudah analisis dinamika keluarga
3) Menjadi dasar dalam penyusunan intervensi keperawatan

Pendekatan ini digunakan dalam model *Calgary Family Assessment Model* (CFAM) yang dikembangkan oleh *Wright* dan *Leahey*, yang menekankan pentingnya memahami struktur dan interaksi keluarga secara menyeluruh (Zimansky et al., 2020)

B. Tahapan Perkembangan Keluarga (Family Development Stages)

1. Pengertian Tahapan Perkembangan Keluarga

Tahapan perkembangan keluarga merupakan proses perubahan yang dialami keluarga sepanjang siklus kehidupan, dimulai dari pembentukan keluarga hingga tahap usia lanjut. Setiap tahap memiliki karakteristik, peran, serta tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh anggota keluarga (M. M. Friedman, 2010).

Teori perkembangan keluarga yang paling banyak digunakan dalam keperawatan adalah teori **Evelyn Duvall**, yang menjelaskan bahwa keluarga berkembang secara bertahap mengikuti pertumbuhan anak tertua dalam keluarga. Setiap tahap memiliki **tugas perkembangan (developmental tasks)** yang harus dipenuhi agar keluarga dapat berfungsi secara optimal (Syahas, 2019).

Apabila tugas perkembangan tidak terpenuhi, maka keluarga dapat mengalami gangguan fungsi, konflik, atau **kesulitan** dalam memasuki tahap berikutnya.

2. Tahapan Perkembangan Keluarga

Dalam praktik keperawatan, tahapan perkembangan keluarga sering disederhanakan menjadi beberapa fase utama berikut:

a. Keluarga Baru Menikah (*Beginning Family*)

Tahap ini dimulai ketika pasangan menikah dan membentuk keluarga baru tanpa anak.

Tugas perkembangan:

1) Menyesuaikan diri sebagai pasangan
2) Membina hubungan intim dan komunikasi

3) Menentukan tujuan keluarga
4) Menjalin hubungan dengan keluarga besar

Pada tahap ini, pasangan belajar menjalankan peran baru sebagai suami dan istri serta membangun dasar kehidupan keluarga

b. Keluarga dengan Anak Kecil (*Childbearing Family*)

Tahap ini dimulai sejak kelahiran anak pertama hingga anak usia balita.

Tugas perkembangan**:**

1) Adaptasi peran sebagai orang tua
2) Membagi tanggung jawab pengasuhan
3) Mempertahankan hubungan suami-istri
4) Memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak

Tahap ini sering menjadi fase krisis karena adanya perubahan peran dan tanggung jawab dalam keluarga

c. Keluarga dengan Anak Usia Sekolah

Tahap ini terjadi ketika anak mulai memasuki usia sekolah.

Tugas perkembangan:

1) Mendukung pendidikan anak
2) Membantu anak bersosialisasi
3) Mengembangkan kemampuan intelektual anak
4) Menyesuaikan peran orang tua dengan aktivitas anak

Pada tahap ini, keluarga mulai berinteraksi lebih luas dengan lingkungan sosial seperti sekolah dan masyarakat

d. Keluarga dengan Anak Remaja

Tahap ini ditandai dengan anak memasuki masa remaja.

Tugas perkembangan:

1) Memberikan kebebasan yang bertanggung jawab
2) Menjaga komunikasi terbuka
3) Menyesuaikan peran dan aturan dalam keluarga
4) Mendukung perkembangan identitas anak

Tahap ini sering ditandai dengan konflik karena perubahan psikologis dan kebutuhan kemandirian anak

e. Keluarga dengan Anak Dewasa (*Launching Stage*)

Tahap ini dimulai ketika anak mulai mandiri dan meninggalkan rumah.

Tugas perkembangan**:**

1) Melepaskan anak secara emosional dan sosial
2) Menyesuaikan kembali hubungan suami-istri
3) Mendukung kemandirian anak

Keluarga harus beradaptasi dengan perubahan struktur dan peran dalam keluarga

f. Keluarga Usia Lanjut (*Aging Family*)

Tahap ini terjadi ketika pasangan memasuki usia lanjut.

Tugas perkembangan**:**

1) Menyesuaikan diri dengan masa pensiun
2) Menghadapi perubahan kesehatan
3) Mempertahankan hubungan sosial
4) Mempersiapkan kehilangan pasangan

Tahap ini menuntut adaptasi terhadap perubahan fisik, psikologis, dan sosial (Syahas, 2019).

C. Struktur dan Peran Keluarga

1. Struktur Keluarga

Struktur keluarga merujuk pada susunan anggota keluarga serta pola hubungan yang terbentuk di antara anggota tersebut, termasuk pembagian peran, kekuasaan, dan interaksi dalam keluarga. Struktur ini menjadi kerangka dasar yang menentukan bagaimana keluarga menjalankan fungsi, berkomunikasi, serta mengambil keputusan terkait kesehatan dan kesejahteraan anggotanya (Kaakinen et al., 2018).

Dalam perspektif keperawatan keluarga, struktur keluarga tidak hanya dilihat dari jumlah anggota, tetapi juga dari kualitas hubungan, pola interaksi, serta sistem dukungan yang tersedia. Struktur keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti budaya, nilai, kondisi sosial ekonomi, serta perubahan sosial yang terjadi di Masyarakat (Stanhope & Lancaster, 2015).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perubahan struktur keluarga modern, seperti meningkatnya keluarga tunggal dan keluarga campuran, berpengaruh terhadap pola asuh, dukungan sosial, serta status kesehatan anggota keluarga (Amato, 2000) (Walsh, 2015).

a. Karakteristik Struktur Keluarga

Struktur keluarga memiliki beberapa karakteristik penting, yaitu:

1) Komposisi anggota keluarga, meliputi jumlah dan hubungan antar anggota
2) Pola hubungan, termasuk kedekatan emosional dan komunikasi
3) Distribusi peran dan kekuasaan, yang menentukan pengambilan keputusan
4) Batasan (boundaries) antara anggota keluarga dan lingkungan

Struktur keluarga yang sehat ditandai dengan hubungan yang fleksibel, komunikasi yang efektif, serta pembagian peran yang jelas (Walsh, 2015).

b. Jenis Struktur Keluarga

1) Keluarga Inti (*Nuclear Family*)

Keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal dalam satu rumah. Struktur ini merupakan bentuk keluarga yang paling umum ditemukan dalam masyarakat modern. Keluarga inti memiliki interaksi yang lebih intens antar anggota, namun juga memiliki keterbatasan dalam dukungan sosial dibandingkan keluarga besar (Stanhope & Lancaster, 2015)

2) Keluarga Besar (*Extended Family)*

Keluarga besar mencakup anggota keluarga yang lebih luas seperti kakek, nenek, paman, bibi, dan kerabat lainnya yang tinggal bersama atau memiliki hubungan yang erat. Struktur ini biasanya ditemukan dalam budaya kolektif, termasuk di Indonesia. Kelebihannya adalah adanya dukungan sosial yang kuat, namun dapat menimbulkan konflik peran karena banyaknya anggota keluarga (Rector, 2010)

3) Keluarga Tunggal (*Single Parent Family*)

Keluarga tunggal terdiri dari satu orang tua dengan anak, yang dapat disebabkan oleh perceraian, kematian pasangan, atau pilihan hidup. Struktur ini memiliki tantangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab, sehingga berpotensi menimbulkan beban psikologis dan ekonomi yang lebih besar (Kaakinen et al., 2018).

4) Keluarga Campuran (*Blended Family*)

Keluarga campuran terbentuk dari pernikahan kembali yang melibatkan anak dari hubungan sebelumnya. Struktur ini memerlukan proses adaptasi yang lebih kompleks karena adanya perbedaan latar belakang, nilai, dan peran dalam keluarga (Wright & Leahey, 2005)

c. Faktor yang Mempengaruhi Struktur Keluarga

Struktur keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

1) Budaya

Budaya menentukan pola hubungan, peran, serta nilai dalam keluarga.

2) Status Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi memengaruhi bentuk keluarga dan pembagian peran.

3) Perubahan Sosial

Modernisasi dan urbanisasi menyebabkan perubahan struktur keluarga.

4) Pendidikan

Tingkat pendidikan memengaruhi pola pikir dan interaksi keluarga.

5) Kondisi Kesehatan

Penyakit kronis dapat mengubah struktur dan peran dalam keluarga (Kaakinen et al., 2018)

2. Peran Keluarga

a. Pengertian Peran Keluarga

Peran keluarga adalah pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota keluarga sesuai dengan posisi dan statusnya dalam struktur keluarga. Peran ini mencerminkan bagaimana tanggung jawab, fungsi, dan interaksi dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif keperawatan keluarga, peran menjadi komponen penting karena berhubungan langsung dengan fungsi keluarga, pengambilan keputusan, serta pemeliharaan kesehatan anggota keluarga (Kaakinen et al., 2018).

Peran dalam keluarga bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai dengan perkembangan keluarga, kondisi sosial ekonomi, serta perubahan nilai dan budaya dalam masyarakat. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam menjalankan peran menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan keluarga (Denham, 2003).

b. Jenis Peran dalam Keluarga

1) Peran Formal

Peran formal adalah peran yang secara jelas terlihat dan diakui dalam struktur keluarga. Peran ini biasanya berkaitan dengan posisi sosial anggota keluarga.

Contoh peran formal:

a) Ayah sebagai pencari nafkah

Ayah sering diasosiasikan sebagai penyedia kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, dalam perkembangan modern, peran ini dapat bersifat fleksibel dan dibagi dengan ibu.

b) Ibu sebagai pengasuh

Ibu umumnya berperan dalam pengasuhan anak, pengelolaan rumah tangga, serta pemenuhan kebutuhan emosional keluarga.

c) Anak sebagai anggota keluarga

Anak memiliki peran dalam proses perkembangan, belajar, serta berpartisipasi dalam kehidupan keluarga sesuai usia dan tahap perkembangannya.

Penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran formal yang seimbang antara ayah dan ibu dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dan perkembangan anak (Bornstein, 2017).

2) Peran Informal

Peran informal merupakan peran yang tidak tertulis namun muncul secara alami dalam interaksi keluarga. Peran ini sering kali lebih fleksibel dan sangat berpengaruh terhadap dinamika keluarga.

Contoh peran informal:

a) Caregiver

Anggota keluarga yang memberikan perawatan kepada anggota lain yang sakit atau membutuhkan bantuan.

b) Pemberi dukungan emosional

Individu yang memberikan empati, motivasi, dan perhatian kepada anggota keluarga lain.

c) Pengambil Keputusan

Anggota keluarga yang berperan dalam menentukan pilihan penting, terutama terkait kesehatan dan ekonomi.

d) Penengah konflik

Individu yang membantu menyelesaikan konflik antar anggota keluarga.

Peran informal sangat penting dalam menjaga stabilitas emosional keluarga dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam menghadapi stres (Kaakinen et al., 2018).

c. Dampak Ketidakseimbangan Peran Keluarga

Ketidakseimbangan peran terjadi ketika terdapat distribusi tugas yang tidak adil atau tidak sesuai dengan kemampuan anggota keluarga. Kondisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak, antara lain:

1) Stres psikologis pada anggota keluarga
2) Konflik interpersonal
3) Gangguan komunikasi
4) Penurunan fungsi keluarga
5) Dampak negatif terhadap kesehatan fisik dan mental

Penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan peran dalam keluarga berkaitan dengan peningkatan stres, depresi, dan penurunan kualitas hidup anggota keluarga (Nomaguchi & Milkie, 2020)

d. Faktor yang Mempengaruhi Peran Keluarga

Peran dalam keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain:

1) Budaya

Budaya menentukan norma, nilai, serta pembagian peran dalam keluarga, termasuk peran gender.

2) Pendidikan

Tingkat pendidikan memengaruhi pola pikir, cara pengambilan keputusan, serta pembagian tanggung jawab dalam keluarga.

3) Status Sosial Ekonomi

Kondisi ekonomi keluarga memengaruhi siapa yang bekerja, bagaimana peran dibagi, dan bagaimana kebutuhan keluarga dipenuhi.

4) Nilai dan Kepercayaan

Nilai yang dianut keluarga akan menentukan bagaimana peran dijalankan dan dipertahankan.

5) Kondisi Kesehatan Anggota Keluarga

Adanya anggota keluarga yang sakit dapat menyebabkan perubahan peran, misalnya munculnya caregiver dalam keluarga (Denham, 2003)

D. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam menjalankan perannya untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan kesehatan anggota keluarga. Keberfungsian keluarga menjadi indikator penting dalam menentukan derajat kesehatan keluarga dan keberhasilan intervensi keperawatan (Kaakinen et al., 2018).

Dalam praktik keperawatan komunitas, fungsi keluarga menjadi dasar dalam pengkajian, diagnosis keperawatan, dan intervensi berbasis keluarga.

1. Fungsi Afektif

Fungsi afektif adalah kemampuan keluarga dalam memberikan kasih sayang, rasa aman, perhatian, dan dukungan emosional kepada anggota keluarga.

Fungsi ini berperan penting dalam pembentukan kesehatan mental, konsep diri, serta kemampuan individu dalam mengatasi stres. Keluarga yang

memiliki hubungan emosional yang baik akan meningkatkan kesejahteraan psikologis anggota keluarga.

Penelitian menunjukkan bahwa dukungan emosional keluarga berhubungan signifikan dengan penurunan stres, kecemasan, dan depresi, khususnya pada ibu hamil dan pasien penyakit kronis (Jiang et al., 2021).

2. Fungsi Sosialisasi

Fungsi sosialisasi adalah peran keluarga dalam membentuk perilaku, nilai, norma, dan kebiasaan anggota keluarga.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam proses pembelajaran sosial. Nilai dan kebiasaan yang ditanamkan dalam keluarga akan mempengaruhimempengaruhi perilaku kesehatan individu sepanjang hidupnya.

Penelitian menunjukkan bahwa pola asuh dan peran keluarga sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan anak, termasuk pola makan, aktivitas fisik, dan pencegahan penyakit (Lange et al., 2019). Selain itu, peran keluarga dalam sosialisasi terbukti berkontribusi dalam pencegahan stunting melalui praktik pemberian makan yang tepat (Fajar et al., 2024).

3. Fungsi Reproduksi

Fungsi reproduksi adalah kemampuan keluarga dalam melanjutkan keturunan dan menjaga keberlangsungan generasi.

Fungsi ini mencakup perencanaan kehamilan, kesehatan reproduksi, serta pengasuhan anak. Keluarga yang memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam fungsi reproduksi akan meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.

Menurut (WHO, 2022), pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi dalam keluarga dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Penelitian juga menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perawatan kehamilan berperan dalam pencegahan stunting (Fajar et al., 2024).

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi adalah kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan akses pelayanan kesehatan.

Kondisi ekonomi keluarga sangat mempengaruhimempengaruhi status kesehatan anggota keluarga. Keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan kurangnya akses terhadap gizi yang baik dan pelayanan kesehatan.

Penelitian menunjukkan bahwa status ekonomi rendah berhubungan dengan meningkatnya risiko malnutrisi dan stunting pada anak (Glewwe et al., 2004)

5. Fungsi Perawatan Kesehatan

Fungsi perawatan kesehatan adalah kemampuan keluarga dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan anggota keluarga.

Fungsi ini merupakan inti dari keperawatan keluarga, karena keluarga menjadi unit utama dalam perawatan kesehatan.

Fungsi perawatan kesehatan keluarga meliputi beberapa komponen utama sebagai berikut:

a. Mengenali masalah kesehatan

Kemampuan keluarga dalam mengidentifikasi tanda dan gejala penyakit serta faktor risiko yang dapat mempengaruhimempengaruhi kesehatan anggota keluarga.

Keluarga yang mampu mengenali masalah kesehatan secara dini akan lebih cepat mencari pertolongan sehingga dapat mencegah komplikasi yang lebih serius. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan keluarga dalam mengenali masalah kesehatan berhubungan signifikan dengan deteksi dini penyakit pada anak dan lansia (Yu et al., 2025)

b. Mengambil keputusan terkait tindakan kesehatan

Kemampuan keluarga dalam menentukan tindakan yang tepat ketika menghadapi masalah kesehatan, termasuk keputusan untuk melakukan perawatan mandiri atau mencari bantuan tenaga kesehatan.

Pengambilan keputusan dipengaruhi oleh pengetahuan, budaya, pengalaman, dan akses terhadap informasi kesehatan. Studi menunjukkan bahwa keluarga dengan tingkat pengetahuan yang baik cenderung lebih cepat dalam mengambil keputusan untuk mencari pelayanan kesehatan (WHO, 2022)

c. Merawat anggota keluarga yang sakit

Kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan langsung kepada anggota keluarga yang sakit, baik dalam bentuk perawatan dasar maupun dukungan emosional.

Perawatan keluarga yang optimal dapat mempercepat proses penyembuhan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dalam perawatan pasien kronis dapat meningkatkan kepatuhan terapi dan menurunkan angka kekambuhan (Sari et al., 2024)

d. Memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan

Kemampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan yang tersedia, seperti puskesmas, rumah sakit, posyandu, dan layanan kesehatan lainnya.

Pemanfaatan layanan kesehatan yang optimal akan meningkatkan derajat kesehatan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan berkaitan erat dengan status kesehatan masyarakat, termasuk penurunan angka kesakitan dan kematian

E. Komunikasi dalam Keluarga

Komunikasi dalam keluarga merupakan proses penyampaian pesan, informasi, perasaan, dan makna antar anggota keluarga yang sangat memengaruhi kualitas hubungan dan keharmonisan keluarga. Komunikasi yang efektif akan membentuk hubungan yang sehat, meningkatkan dukungan emosional, serta memperkuat fungsi keluarga (Kaakinen et al., 2018) (M. M. Friedman et al., 2003).

Sebaliknya, komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan konflik, kesalahpahaman, serta gangguan dalam menjalankan fungsi keluarga, termasuk fungsi afektif dan perawatan Kesehatan (Epstein et al., 1978)

1. Jenis Pola Komunikasi dalam Keluarga

a. Pola Komunikasi Terbuka

Pola komunikasi terbuka ditandai dengan adanya kejujuran, keterbukaan, saling menghargai, dan komunikasi dua arah yang efektif antar anggota keluarga.

Karakteristik:

1) Anggota keluarga bebas mengungkapkan pendapat
2) Adanya empati dan saling mendengarkan
3) Tidak ada rasa takut atau tekanan

Dampak:

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi terbuka berhubungan dengan peningkatan kesehatan mental, kepuasan keluarga, dan kemampuan coping (Weitkamp & Bodenmann, 2022).

b. Pola Komunikasi Tertutup

Pola komunikasi tertutup ditandai dengan kurangnya interaksi, minimnya keterbukaan, dan adanya pembatasan dalam menyampaikan perasaan atau pendapat.

Karakteristik:

1) Komunikasi terbatas
2) Kurangnya ekspresi emosi
3) Adanya jarak emosional

Dampak:

Kondisi ini dapat menyebabkan kesalahpahaman dan meningkatkan risiko konflik dalam keluarga (B. & J. Friedman, 2010).

c. Pola Komunikasi Otoriter

Pola komunikasi otoriter merupakan komunikasi satu arah, biasanya dari orang tua kepada anak, tanpa memberikan kesempatan bagi anggota keluarga lain untuk berpendapat.

Karakteristik:

1) Dominasi satu pihak
2) Minim diskusi
3) Cenderung memerintah

Dampak**:**

Penelitian menunjukkan bahwa pola komunikasi otoriter dapat menurunkan kepercayaan diri anak dan meningkatkan stres psikologis (Roșca et al., 2024)

d. Pola Komunikasi Demokratis

Pola komunikasi demokratis ditandai dengan komunikasi dua arah, saling menghargai pendapat, serta adanya keterlibatan semua anggota keluarga dalam pengambilan keputusan.

Karakteristik**:**

1) Diskusi terbuka
2) Pengambilan keputusan bersama
3) Saling menghargai

Dampak**:**

Pola ini terbukti meningkatkan keharmonisan keluarga, perkembangan psikososial anak, dan kepatuhan terhadap perilaku kesehatan (Scott & Saginak, 2016).

2. Dampak Komunikasi Tidak Efektif

Komunikasi yang tidak efektif dalam keluarga dapat menyebabkan:

a. Konflik antar anggota keluarga
b. Kesalahpahaman
c. Gangguan fungsi keluarga
d. Penurunan dukungan emosional
e. Masalah kesehatan mental

Penelitian menunjukkan bahwa komunikasi keluarga yang buruk berhubungan dengan meningkatnya kecemasan, depresi, dan perilaku maladaptif (Epstein et al., 1978)

3. Hambatan Komunikasi dalam Keluarga

a. Perbedaan Persepsi

Setiap anggota keluarga memiliki latar belakang, pengalaman, dan cara pandang yang berbeda sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman.

b. Emosi yang Tidak Stabil

Kondisi emosi seperti marah, stres, atau cemas dapat menghambat penyampaian pesan secara efektif.

c. Kurangnya Keterbukaan

Ketidakmauan untuk berbagi informasi atau perasaan dapat menghambat komunikasi yang sehat.

d. Faktor Budaya

Perbedaan nilai, norma, dan kebiasaan budaya dapat mempengaruhimempengaruhi cara berkomunikasi dalam keluarga.

Penelitian menunjukkan bahwa faktor budaya dan emosi memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas komunikasi keluarga (Schrodt, 2026)

F. Dinamika Keluarga

Dinamika keluarga adalah pola interaksi yang terus berubah antara anggota keluarga yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Dinamika ini mencerminkan bagaimana keluarga beradaptasi terhadap perubahan, menyelesaikan masalah, serta mengelola stresor (Kaakinen et al., 2018)

Dalam konteks keperawatan keluarga, pemahaman dinamika keluarga penting karena membantu perawat mengidentifikasi kebutuhan, kekuatan, dan masalah yang muncul dalam keluarga sehingga intervensi yang dirancang menjadi tepat sasaran dan efektif.

1. Komponen Utama Dinamika Keluarga

a. Stresor Keluarga

Stresor keluarga adalah peristiwa atau kondisi yang menimbulkan tekanan dan menuntut adaptasi. Stresor dapat bersifat *normatif* (perubahan yang terjadi sebagai bagian dari siklus hidup keluarga, misalnya pernikahan, kelahiran, anak remaja, pensiun) atau *non-normatif* (peristiwa tak terduga seperti penyakit, kehilangan pekerjaan, kematian anggota keluarga). Stresor dapat mempengaruhimempemgaruhi keseimbangan sistem keluarga, memicu konflik, dan menuntut sumber daya koping keluarga (Walsh, 2015).

b. Mekanisme Koping Keluarga

Koping keluarga adalah strategi yang digunakan keluarga untuk mengatasi stresor dan mempertahankan stabilitasnya. Koping dapat bersifat:

1) Koping adaptif yaitu strategi yang mempromosikan pemecahan masalah, dukungan antaranggota, dan interaksi positif.
2) Koping maladaptif, yaitu strategi yang menghindari konflik, menarik diri dari interaksi, atau menunda penyelesaian masalah.

c. Dukungan Sosial dalam Keluarga

Dukungan keluarga meliputi bantuan emosional, informasi, instrumental (bantuan nyata), dan evaluatif. Dukungan dapat berasal dari dalam keluarga (saudara kandung, pasangan) atau sumber eksternal (keluarga besar, komunitas, layanan kesehatan). Dukungan sosial yang kuat membantu keluarga mengatasi stresor dengan lebih efektif dan berkontribusi pada kesejahteraan psikologis anggota keluarga (Cohen & Wills, 1985)

d. Konflik Keluarga

Konflik keluarga adalah ketidaksepakatan atau pertentangan antara anggota keluarga yang muncul karena perbedaan nilai, kebutuhan, harapan, atau persepsi. Konflik merupakan bagian dari dinamika keluarga, tetapi bila tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu hubungan, komunikasi, serta fungsi keluarga secara keseluruhan

G. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Contoh:

Seorang ibu berusia 32 tahun datang ke puskesmas bersama suami dan dua orang anaknya (usia 10 tahun dan 5 tahun). Ibu mengeluhkan sering merasa kelelahan, mudah marah, dan merasa tidak mendapat dukungan dari anggota keluarga.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Ibu bekerja sekaligus mengurus rumah tangga
- Suami bekerja hingga larut malam dan jarang terlibat dalam pengasuhan anak
- Anak pertama sering membantu pekerjaan rumah, tetapi terlihat tertekan
- Anak kedua cenderung manja dan bergantung pada ibu
- Komunikasi dalam keluarga kurang terbuka
- Keputusan keluarga lebih banyak diambil oleh ibu

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi keluarga tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi tipe keluarga dan struktur keluarga pada kasus tersebut.
2. Analisis peran masing-masing anggota keluarga (formal dan informal).
3. Identifikasi fungsi keluarga yang tidak berjalan optimal.
4. Jelaskan dinamika keluarga yang terjadi pada kasus tersebut.
5. Tentukan masalah keperawatan keluarga yang mungkin muncul.
6. Jelaskan intervensi keperawatan keluarga yang dapat dilakukan.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

H. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi Pengkajian dan Perencanaan Asuhan Keperawatan Keluarga

Fokus:

- Pengkajian keluarga (struktur, peran, fungsi, komunikasi)
- Analisis dinamika keluarga (stresor, koping, konflik, dukungan)
- Penentuan masalah keperawatan keluarga
- Perencanaan intervensi (edukasi, home visit, rujukan)
- Komunikasi terapeutik dan pemberdayaan keluarga

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Pengkajian & Perencanaan Keluarga

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Komunikasi terapeutik & etik
- Identifikasi struktur & anggota keluarga
- Pengkajian peran dan fungsi keluarga
- Analisis dinamika keluarga (stresor & koping)
- Penyusunan masalah keperawatan keluarga
- Perencanaan intervensi yang realistis (feasible)

OSCE

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Keluarga dengan Ketidakseimbangan Peran dan Disfungsi Dinamika Keluarga

No.	Komponen	Isi
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta dalam menerapkan konsep teori sistem keluarga, peran, fungsi, dan dinamika keluarga dalam pengkajian, diagnosis, dan edukasi keperawatan keluarga.
5	Kompetensi	1. Komunikasi terapeutik keluarga 2. Pengkajian keperawatan keluarga 3. Analisis peran dan fungsi keluarga 4. Diagnosis dan perencanaan keperawatan 5. Edukasi keluarga 6. Perilaku profesional
6	Kategori	1. Psikososial 2. Sistem keluarga 3. Peran dan fungsi keluarga 4. Dinamika keluarga 5. Koping keluarga
7	Instruksi untuk Peserta Ujian	Skenario klinik: Seorang ibu usia 32 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan merasa sangat lelah karena harus bekerja sekaligus mengurus rumah tangga sendiri. Ibu mengatakan suami jarang membantu dalam pengasuhan anak dan pekerjaan rumah. Anak pertama (8 tahun) tampak pendiam dan sering menyendiri, sedangkan anak kedua (3 tahun) sangat bergantung pada ibu. Ibu juga mengatakan jarang berkomunikasi dengan suami terkait pembagian tugas dan sering memendam perasaan. TUGAS: 1. Lakukan **pengkajian fokus keluarga** pada klien standar (KS) meliputi: • Struktur dan tipe keluarga • Peran anggota keluarga • Fungsi keluarga (afektif, sosialisasi) • Pola komunikasi keluarga

No.	Komponen	Isi
		• Dinamika dan koping keluarga 2. Tuliskan **diagnosis** keperawatan **keluarga** pada lembar jawab. **3.** Tuliskan perencanaan**/intervensi keperawatan keluarga**. 4. Lakukan **edukasi** kepada **ibu** tentang: • Pembagian peran dalam keluarga • Fungsi keluarga yang sehat • Komunikasi efektif dalam keluarga
8	Instruksi untuk Penguji	Fokus Penilaian: 1. **Pengkajian (Teori Sistem Keluarga)** • Menggali struktur keluarga • Mengidentifikasi ketidakseimbangan peran • Mengkaji fungsi afektif & sosialisasi • Mengidentifikasi pola komunikasi (tertutup/tidak efektif) • Mengidentifikasi dinamika keluarga (konflik, beban peran) 2. **Diagnosis Keperawatan (SDKI)** • Peserta diharapkan menuliskan salah satu: • Ketidakseimbangan peran keluarga • Disfungsi proses keluarga • Koping keluarga tidak efektif 3. **Perencanaan (SIKI)** • Edukasi pembagian peran keluarga • Peningkatan komunikasi efektif • Penguatan fungsi keluarga • Dukungan koping keluarga 4. **Edukasi (Implementasi)** Dinilai dari: • Menjelaskan peran keluarga • Menjelaskan pentingnya komunikasi • Memberikan solusi praktis (diskusi, pembagian tugas) • Bahasa mudah dipahami 5. **Perilaku Profesional**

No.	Komponen	Isi
		• Empati • Kontak mata • Sikap tidak menghakimi • Komunikasi terapeutik
9	Instruksi untuk Klien Standar (KS)	• Peran: Ibu usia 32 tahun • Ekspresi: lelah, cemas, sedikit emosional informasi yang diberikan jika ditanya: • Suami bekerja, jarang membantu di rumah • Ibu mengurus semua sendiri • Anak pertama sering diam dan tidak banyak bicara • Anak kedua selalu ingin bersama ibu • Jarang diskusi dengan suami • Ibu sering merasa capek dan kesal Harapan: "Ibu ingin suami lebih membantu dan keluarga lebih harmonis"
10	Setting Station	• Ruang konseling / puskesmas • Meja dan kursi konseling • KS (ibu) • Penguji • Kursi Laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	• Handrub • Lembar pengkajian keluarga • Lembar jawaban • Alat tulis • Leaflet (opsional: peran & komunikasi keluarga) Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	.....
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI.

No.	Komponen	Isi
		Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2019). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2019). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI. (2021). *Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan* (Edisi 1). Jakarta: DPP PPNI. Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. H. (2018). *Family Health Care Nursing: Theory, Practice, and Research* (6th ed.). Philadelphia: F.A. Davis. Stanhope, M., & Lancaster, J. (2021). *Public Health Nursing: Population-Centered Health Care in the Community* (10th ed.). St. Louis: Elsevier. Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. G. (2003). *Family Nursing: Research, Theory, and Practice* (5th ed.). New Jersey: Prentice Hall. Wright, L. M., & Leahey, M. (2005). *Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention* (4th ed.). Philadelphia: F.A. Davis.

SOP PENGKAJIAN DAN EDUKASI KEPERAWATAN KELUARGA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	**Pra Interaksi**				
1	Menyiapkan alat (lembar pengkajian, alat tulis, handrub)				
2	Mencuci tangan				
B	**Orientasi**				
3	Salam, perkenalan diri, dan menjelaskan tujuan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
4	Identifikasi anggota keluarga & membuat kontrak waktu				
5	Menjaga privasi dan membangun hubungan terapeutik				
C	**Pengkajian Keluarga**				
6	Mengkaji struktur keluarga (anggota & tipe keluarga)				
7	Mengkaji peran anggota keluarga				
8	Mengkaji fungsi keluarga (afektif, sosialisasi, kesehatan)				
9	Mengkaji pola komunikasi keluarga				
10	Mengidentifikasi masalah peran (ketidakseimbangan peran)				
D	**Analisis & Diagnosis**				
11	Mengidentifikasi stresor dan koping keluarga				
12	Mengidentifikasi konflik dan dukungan keluarga				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
13	Menentukan diagnosis keperawatan keluarga				
E	**Perencanaan & Edukasi**				
14	Menjelaskan masalah keluarga secara sederhana				
15	Edukasi pembagian peran keluarga				
16	Edukasi komunikasi efektif dalam keluarga				
17	Memberikan solusi praktis (pembagian tugas/koping)				
18	Memastikan pemahaman keluarga (feedback)				
F	**Terminasi**				
19	Menyimpulkan dan evaluasi respon keluarga				
20	Memberikan reinforcement dan rencana tindak lanjut				
21	Menutup interaksi dengan baik				
F	Dokumentasi & Profesional				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
22	Mendokumentasikan hasil pengkajian & intervensi				
23	Menunjukkan sikap profesional (empatik, komunikatif, etis)				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA DENGAN KETIDAKSEIMBANGAN PERAN DAN DINAMIKA KELUARGA

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	Pengkajian Keperawatan Keluarga	Menggali struktur keluarga, anggota keluarga, peran, fungsi keluarga (afektif, sosialisasi, kesehatan), serta pola komunikasi					2	
2	Diagnosis dan perencanaan keperawatan	Menetapkan diagnosis keperawatan keluarga yang tepat serta menyusun rencana intervensi yang sesuai					3	
3	Implementasi keperawatan: edukasi keluarga	Menjelaskan masalah keluarga, memberikan edukasi tentang pembagian peran, komunikasi efektif, koping keluarga, serta solusi praktis					3	
4	Perilaku profesional	Komunikasi terapeutik, empati, menjaga privasi, sistematis, aman, teliti, responsif					2	
	Jumlah						**10**	

Keterangan skor:

0 = tidak dilakukan

1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap

2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap

3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian Keperawatan Keluarga Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menggali data keluarga meliputi struktur keluarga, peran anggota keluarga, fungsi keluarga (afektif, sosialisasi, kesehatan), serta pola komunikasi keluarga secara sistematis dan relevan dengan kasus.					2	
2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menegakkan diagnosis keperawatan keluarga sesuai masalah (misal: ketidakseimbangan peran, koping tidak efektif) serta menyusun rencana intervensi yang realistis dan sesuai kebutuhan keluarga.					3	
3. Implementasi: Edukasi Keluarga Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam memberikan edukasi kepada keluarga mengenai pembagian peran, komunikasi efektif, dan peningkatan fungsi keluarga dengan cara yang jelas, sistematis, dan aplikatif.					3	
4. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta dalam menunjukkan komunikasi terapeutik, empati, menjaga privasi, serta sikap profesional selama interaksi dengan keluarga.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

1. Pengkajian Keperawatan Keluarga

Skor	Deskripsi
0	Tidak melakukan pengkajian atau tidak relevan dengan kasus keluarga
1	Pengkajian sangat terbatas, hanya menggali sebagian kecil data, tidak sistematis
2	Pengkajian cukup baik dan cukup sistematis, sebagian besar data tergali tetapi masih ada yang terlewat
3	Pengkajian lengkap, sistematis, meliputi struktur, peran, fungsi, komunikasi, dan relevan dengan kasus

2. Diagnosis dan Perencanaan Keperawatan

Skor	Deskripsi
0	Tidak mampu menegakkan diagnosis dan tidak menyusun rencana
1	Diagnosis kurang tepat, rencana sangat terbatas dan tidak relevan
2	Diagnosis cukup tepat, rencana cukup sesuai tetapi kurang lengkap
3	Diagnosis tepat sesuai masalah utama, rencana lengkap, sistematis, dan realistis

3. Implementasi: Edukasi Keluarga

Skor	Deskripsi
0	Tidak melakukan edukasi atau edukasi tidak sesuai
1	Edukasi sangat terbatas, tidak jelas dan tidak sistematis
2	Edukasi cukup baik, sebagian besar benar tetapi kurang lengkap
3	Edukasi lengkap, jelas, sistematis, aplikatif, dan memberdayakan keluarga

4. Perilaku Profesional

Skor	Deskripsi
0	Tidak menunjukkan perilaku profesional
1	Profesionalisme sangat kurang
2	Cukup profesional, masih ada kekurangan kecil
3	Sangat profesional, empatik, komunikatif, menjaga privasi dan etika

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / tidak sesuai
1	Sangat kurang / tidak tepat
2	Cukup
3	Baik / lengkap

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada **Asuhan Keperawatan Keluarga**
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Contoh Penerapan DOPS pada Keperawatan Keluarga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga
Metode penilaian	Observasi langsung performa mahasiswa dalam encounter keluarga	Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan pengkajian dan edukasi keluarga
Tujuan penilaian	Menilai integrasi pengkajian, analisis, komunikasi, dan edukasi	Mahasiswa mampu menjelaskan masalah peran dan solusi kepada keluarga
Kasus klinik	Kasus keluarga dengan ketidakseimbangan peran dan dinamika keluarga	Ibu kelelahan, ayah kurang terlibat, anak tertekan
Aktivitas mahasiswa	Melakukan pengkajian, analisis, dan edukasi	Mahasiswa menggali peran, komunikasi, lalu memberi edukasi
Aspek yang dinilai	Pengkajian, diagnosis, komunikasi, edukasi, profesionalisme	Dinilai kemampuan menggali masalah dan memberi solusi
Umpan balik	Diberikan langsung setelah observasi	Misal: komunikasi baik, perlu memperdalam analisis dinamika
Keputusan penilaian	Kompeten / supervisi / remedial	Berdasarkan performa keseluruhan
Makna dalam OBE	Bukti capaian level **does**	Mahasiswa mampu praktik nyata

Portofolio OSCE Keluarga – Teori Sistem Keluarga

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS keluarga
- Catatan kasus singkat keluarga
- Refleksi patient safety keluarga
- Feedback CI/dosen

Tabel Portofolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga
Hakikat portofolio	Kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara berkelanjutan, sesuai teori sistem keluarga.	Mahasiswa menunjukkan kemampuan mengidentifikasi anggota keluarga, peran formal dan informal, fungsi keluarga, serta pola interaksi dalam keluarga dengan ketidakseimbangan peran.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa.	Mahasiswa menunjukkan bagaimana intervensi konseling peran dan komunikasi dalam keluarga berkembang setelah mendapat masukan dari CI/dosen.
OSCE & DOPS	Bukti keterampilan terstruktur di laboratorium (OSCE) dan performa nyata di lahan praktik (DOPS) terkait interaksi sistemik keluarga.	OSCE: simulasi wawancara keluarga untuk mengidentifikasi peran dan fungsi anggota; DOPS: observasi intervensi nyata mahasiswa saat membantu redistribusi peran ibu dan ayah.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus keluarga, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus: ibu kelelahan karena peran ganda, ayah jarang terlibat, anak pertama stres, anak kedua bergantung; diagnosis prioritas: ketidakseimbangan peran dan fungsi; intervensi: edukasi peran, konseling komunikasi, evaluasi dinamika keluarga.
Refleksi patient safety	Menggambarkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan anggota keluarga, menganalisis potensi masalah, dan menyusun tindakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan risiko: stres anak, kelelahan ibu, konflik antar anggota; tindakan pencegahan: membagi peran ayah-ibu, edukasi komunikasi efektif, pemantauan kesehatan anggota keluarga.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga
Feedback CI/dosen	Bukti pembinaan yang menunjukkan kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan mahasiswa sudah baik dalam mengidentifikasi peran formal/informal dan pola komunikasi keluarga, tetapi perlu memperkuat strategi redistribusi peran secara realistis.
Karakteristik penilaian	Kumpulan bukti dibangun berulang dan berkesinambungan. Fokus pada konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman keluarga, menunjukkan konsistensi kemampuan menilai dan memodifikasi dinamika, peran, dan fungsi keluarga.
Bukti konsistensi kompetensi	Memperlihatkan kemampuan mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan dan waktu.	OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik menunjukkan mahasiswa konsisten mampu menganalisis sistem keluarga, mengidentifikasi ketidakseimbangan peran, dan mengimplementasikan intervensi efektif.
Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran terlihat dalam performa nyata, berulang, dan terdokumentasi.	Mahasiswa tidak hanya memahami teori sistem keluarga, peran, fungsi, dan dinamika, tetapi juga mampu menerapkannya pada praktik nyata dengan konsisten.

Tabel Case Report OSCE Sistem Keluarga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga
Hakikat case report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus keluarga, menunjukkan kemampuan mahasiswa menganalisis dinamika, peran, dan fungsi anggota keluarga.	Mahasiswa menyusun laporan keluarga: ibu kelelahan, ayah jarang terlibat, anak pertama stres, anak kedua bergantung.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengintegrasikan	Mahasiswa menulis diagnosis: ketidakseimbangan peran dan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga
	data pengkajian, masalah keperawatan, rencana, intervensi, dan evaluasi hasil.	fungsi keluarga; intervensi: redistribusi peran, edukasi komunikasi, evaluasi respons keluarga.
Isi laporan	Identitas keluarga, keluhan, data subjektif/objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, pembelajaran.	Mahasiswa menulis pengkajian anggota keluarga, peran formal/informal, pola komunikasi, ketidakseimbangan peran, intervensi konseling, evaluasi perbaikan dinamika.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, relevansi analisis, logika penalaran, ketepatan intervensi, evaluasi hasil.	Pembimbing menilai mahasiswa mampu menghubungkan ketidakseimbangan peran dengan stres anak dan kelelahan ibu, memilih intervensi sesuai fungsi keluarga, dan mengevaluasi hasil.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, refleksi ilmiah.	Mahasiswa belajar merancang intervensi keluarga sistemik yang realistis dan bertanggung jawab.
Makna dalam OBE	Bukti mahasiswa mampu menerapkan teori sistem keluarga, peran, fungsi, dan dinamika ke dalam praktik nyata secara bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan penerapan teori keluarga ke praktik nyata dengan dokumentasi lengkap dan analisis sistemik.

Tabel Refleksi Patient Safety OSCE Teori Sistem Keluarga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga
Hakikat refleksi	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan keluarga, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Mahasiswa menulis risiko keluarga: ibu kelelahan, ayah jarang terlibat, anak stres; potensi konflik antar anggota.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan anggota keluarga penting pada setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa intervensi yang salah atau tidak tepat dapat memperburuk stres anak dan beban ibu.
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, pembelajaran.	Risiko: ketidakseimbangan peran, konflik, stres anak; tindakan pencegahan: pembagian peran, edukasi komunikasi, pemantauan kesejahteraan anak dan ibu.
Risiko yang diidentifikasi	Menunjukkan kemampuan mengenali situasi berpotensi membahayakan keluarga.	Risiko: ibu kelelahan, anak dependen berlebihan, anak pertama stres, ayah kurang terlibat.
Tindakan pencegahan	Langkah konkret untuk mengurangi risiko.	Redistribusi peran, fasilitasi komunikasi efektif, edukasi keluarga, monitoring respons anak.
Pembelajaran mahasiswa	Apa yang dipelajari mahasiswa dan pengaruhnya pada praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari pentingnya pengkajian sistemik keluarga, peran, fungsi, dan dinamika untuk keselamatan dan kesejahteraan semua anggota.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab, kemampuan berpikir kritis terhadap keselamatan keluarga.	Mahasiswa mampu mengevaluasi risiko, menerapkan intervensi aman, dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan keluarga berkelanjutan.

I. Rangkuman Materi

Teori Sistem Keluarga, Peran, Fungsi, dan Dinamika Keluarga

Bab ini menekankan pentingnya keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat yang berfungsi sebagai sistem sosial, di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Konsep sistem keluarga berangkat dari teori sistem, yang melihat keluarga sebagai kesatuan yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Setiap perubahan pada salah satu anggota keluarga dapat menimbulkan perubahan pada anggota lainnya maupun pada sistem keluarga secara keseluruhan. Pendekatan sistem ini membantu mahasiswa memahami bahwa keluarga bukan sekadar sekumpulan individu, tetapi sebuah sistem yang memiliki struktur, peran, fungsi, dan dinamika internal.

Dalam keluarga, **peran** merupakan pola perilaku yang diharapkan dari setiap anggota berdasarkan posisinya. Peran dapat bersifat formal, seperti ayah sebagai pencari nafkah atau ibu sebagai pengasuh utama, maupun informal, yang muncul sesuai kebutuhan situasional. Ketidakseimbangan peran terjadi ketika distribusi tanggung jawab tidak adil atau tidak sesuai kemampuan anggota, sehingga dapat menimbulkan konflik, stres, atau gangguan fungsi keluarga. Pemahaman tentang peran penting untuk membantu mahasiswa mengenali pola interaksi dan kontribusi setiap anggota terhadap kesejahteraan keluarga.

Fungsi keluarga merujuk pada tujuan yang dijalankan keluarga untuk memenuhi kebutuhan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual anggotanya. Fungsi keluarga meliputi fungsi afektif, reproduksi, sosialisasi, ekonomi, perlindungan, dan perawatan kesehatan. Fungsi yang berjalan harmonis menunjukkan keluarga yang sehat, sedangkan disfungsi pada salah satu fungsi dapat memengaruhi stabilitas sistem keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu, memahami fungsi keluarga membantu mahasiswa melihat keluarga sebagai entitas yang kompleks namun terstruktur.

Selain peran dan fungsi, **dinamika keluarga** menekankan perubahan dan interaksi antaranggota dari waktu ke waktu. Dinamika ini dipengaruhi oleh tahap perkembangan keluarga, budaya, nilai-nilai, serta tekanan internal dan eksternal. Misalnya, keluarga dengan anak usia remaja menghadapi tantangan komunikasi dan pembagian peran yang berbeda dibandingkan keluarga dengan anak kecil. Dinamika juga mencakup kemampuan keluarga dalam menyelesaikan konflik, adaptasi terhadap perubahan, dan pemeliharaan keseimbangan peran dan fungsi.

Dengan memahami konsep sistem keluarga, peran, fungsi, dan dinamika keluarga, mahasiswa diharapkan mampu melihat keluarga sebagai unit yang utuh dan saling terkait. Pemahaman ini menjadi dasar teori bagi praktik keperawatan berbasis keluarga, intervensi kesehatan masyarakat, serta pengembangan strategi

promosi kesehatan yang relevan dengan kebutuhan masing-masing keluarga. Pengetahuan konseptual ini juga membekali mahasiswa untuk menganalisis masalah keluarga, mengenali potensi disfungsi, serta memahami faktor yang memengaruhi kesejahteraan dan kesehatan anggota keluarga secara menyeluruh.

J. Tabel Red Flags & Eskalasi

Red flags / Indikator	Makna Konseptual	Tindakan / Refleksi Mahasiswa
Ketidakseimbangan peran anggota keluarga	Terjadi ketika distribusi tanggung jawab tidak adil atau tidak sesuai kemampuan anggota	Mahasiswa perlu mengidentifikasi dan mendiskusikan dampak pada fungsi dan kesejahteraan keluarga
Fungsi keluarga tidak berjalan optimal	Keluarga gagal memenuhi kebutuhan afektif, sosialisasi, ekonomi, atau kesehatan	Mahasiswa menganalisis fungsi keluarga yang terganggu dan menyarankan intervensi teoritis sesuai konsep
Konflik keluarga yang berulang	Menunjukkan dinamika keluarga yang tidak sehat atau kurang adaptif	Mahasiswa mengevaluasi pola interaksi, komunikasi, dan strategi penyelesaian konflik dalam teori sistem keluarga
Peran ganda yang berlebihan	Anggota keluarga memikul peran di luar kapasitasnya	Mahasiswa menilai risiko stres anggota dan dampak pada keseimbangan sistem keluarga
Komunikasi antar anggota lemah	Menjadi tanda gangguan koordinasi dan dinamika	Mahasiswa mendiskusikan strategi meningkatkan komunikasi dan interaksi dalam keluarga
Tidak ada adaptasi terhadap perubahan	Keluarga tidak menyesuaikan diri terhadap tahap perkembangan atau tekanan eksternal	Mahasiswa merumuskan langkah konseptual untuk mendukung adaptasi keluarga

Red flags / Indikator	Makna Konseptual	Tindakan / Refleksi Mahasiswa
Keterlibatan orang tua rendah dalam pengasuhan	Menunjukkan distribusi peran tidak seimbang	Mahasiswa menilai peran formal dan informal orang tua dalam teori peran keluarga
Ketidakmampuan mengenali kebutuhan anggota	Menunjukkan kurangnya fungsi afektif dan sosial	Mahasiswa mengkaji dampak pada kesejahteraan anggota dan stabilitas keluarga
Pola interaksi destruktif	Menandakan dinamika negatif dalam sistem keluarga	Mahasiswa menganalisis akar penyebab dan alternatif intervensi berbasis teori

Form Checklist "Saya sudah bisa…"
Bab: Konsep Teori Sistem Keluarga, Peran, Fungsi, dan Dinamika Keluarga
Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik / Skill Lab : _____
Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep sistem keluarga	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa mengidentifikasi peran formal dan informal anggota keluarga	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa menjelaskan fungsi keluarga dan indikator keluargasehat	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menganalisis ketidakseimbangan peran dalam keluarga	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa mengenali dinamika keluarga yang adaptif dan tidak adaptif	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mendiskusikan dampak konflik dan interaksi negatif pada sistem keluarga	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
7	Saya sudah bisa memberikan contoh intervensi atau strategi teoretis untuk meningkatkan fungsi keluarga	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa menerapkan teori sistem keluarga untuk memahami kesejahteraan anggota	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa mengevaluasi peran orang tua dalam konteks pengasuhan anak	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menyusun refleksi singkat mengenai pemahaman konsep keluarga	☐	☐	_____

K. Daftar Pustaka

Alexander, A. R., Mendez, L., & Kerig, P. K. (2024). Moral injury as a transdiagnostic risk factor for mental health problems in detained youth. *Criminal Justice and Behavior*, *51*(2), 194–212.

Amato, P. R. (2000). The consequences of divorce for adults and children. *Journal of Marriage and Family*, *62*(4), 1269–1287.

Bornstein, M. H. (2017). Parenting in acculturation: Two contemporary research designs and what they tell us. *Current Opinion in Psychology*, *15*, 195–200.

Bradbury, T. N., & Bodenmann, G. (2020). Interventions for couples. *Annual Review of Clinical Psychology*, *16*(1), 99–123.

Carter, B. (1999). The expanded family life cycle. *Individyual Family and Social Perspective*.

Cohen, S., & Wills, T. A. (1985). Stress, social support, and the buffering hypothesis. *Psychological Bulletin*, *98*(2), 310.

Conger, R. D., Conger, K. J., & Martin, M. J. (2010). Socioeconomic status, family processes, and individual development. *Journal of Marriage and Family*, *72*(3), 685–704.

Denham, S. A. (2003). Family health: A framework for nursing. *(No Title)*.

Epstein, N. B., Bishop, D. S., & Levin, S. (1978). The McMaster model of family functioning. *Journal of Marital and Family Therapy*, *4*(4), 19–31.

Fajar, N. A., Zulkarnain, M., Taqwa, R., Sulaningsi, K., Ananingsih, E. S., Rachmayanti, R. D., & Sin, S. C. (2024). *Family roles and support in preventing stunting: A systematic review*.

Fingerman, K. L., & Bermann, E. (2000). Applications of family systems theory to the

study of adulthood. *The International Journal of Aging and Human Development*, *51*(1), 5–29.

Friedemann, M. (1989). The concept of family nursing. *Journal of Advanced Nursing*, *14*(3), 211–216.

Friedman, B. & J. (2010). *Buku Ajar Keperawatan Keluarga Riset, Teori & Praktik* (edisi 5). EGC.

Friedman, M. M. (2010). *Buku ajar keperawatan keluarga : Riset, Teori dan. Praktek*. EGC.

Friedman, M. M., Bowden, V. R., & Jones, E. (2003). *Family nursing: Research, theory & practice* (Vol. 16). Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.

Glewwe, P., Koch, S., & Nguyen, B. L. (2004). Child Nutrition, Economic Growth. *Economic Growth, Poverty, and Household Welfare in Vietnam*, *842*, 351.

Jiang, H., Jin, L., Qian, X., Xiong, X., La, X., Chen, W., Yang, X., Yang, F., Zhang, X., & Abudukelimu, N. (2021). Maternal mental health status and approaches for accessing antenatal care information during the COVID-19 epidemic in China: cross-sectional study. *Journal of Medical Internet Research*, *23*(1), e18722.

Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., & Robinson, M. (2018). *Family health care nursing: Theory, practice, and research*. FA Davis.

Lange, B. C. L., Callinan, L. S., & Smith, M. V. (2019). Adverse childhood experiences and their relation to parenting stress and parenting practices. *Community Mental Health Journal*, *55*(4), 651–662.

Malik, N. (2020). Family systems theory. In *Encyclopedia of behavioral medicine* (pp. 855–856). Springer.

Nomaguchi, K., & Milkie, M. A. (2020). Parenthood and well-being: A decade in review. *Journal of Marriage and Family*, *82*(1), 198–223.

Organization, W. H. (2022). *Guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services*. World Health Organization.

Rector, C. (2010). Working with Vulnerable People. Allender, JA., Rector, C., Warner, KD. *Community Health Nursing Promoting and Protecting the Public's Health*, 712–730.

Roșca, G. M., Iuga, I. A., & David, O. A. (2024). Inside-out mechanisms of parental practices and children's externalizing problems: the role of authoritarian parenting style, parental irrational beliefs, emotion regulation, and distress. *Current Psychology*, *43*(4), 3292–3306.

Sari, D. W., Amartasari, C. K., Ayuntyas, H., Akhsinadya, F., Baroya, H., Ferinasmara, F. F., Mufida, R. G., Azizah, P. A., Wulandari, A. N., & Wati, F. I. (2024). The Effect of a nurse's home visit intervention on knowledge, dietary salt adherence, and blood pressure in hypertensive patients at primary health care. *Jurnal*

Keperawatan, *15*(02).

Schrodt, P. (2026). Family Communication Patterns Theory: Past Developments, Present Applications, and Future Directions. *Journal of Family Communication*, 1–15.

Scott, S. K., & Saginak, K. A. (2016). Adolescence: Emotional and social development. *Human Growth and Development across the Lifespan: Applications for Counselors*, 347–386.

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2015). *Public health nursing: Population-centered health care in the community*. Elsevier Health Sciences.

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2021). *Foundations for Population Health in Community/Public Health Nursing-E-Book: Foundations for Population Health in Community/Public Health Nursing-E-Book*. Elsevier Health Sciences.

Syahas, A. N. R. (2019). *Analisis Teori Keluarga*.

Walsh, F. (2015). *Strengthening family resilience*. Guilford publications.

Weitkamp, K., & Bodenmann, G. (2022). Couples coping together: A scoping review of the quantitative and qualitative evidence and conceptual work across three decades. *Frontiers in Psychology*, *13*, 876455.

Wright, L. M., & Leahey, M. (2005). *Nurses and families: A guide to family assessment and intervention*. FA Davis.

Yu, J., Zhang, H., Chen, S., Xu, R. H., Zhang, S., & Dong, D. (2025). Capability wellbeing of parents caring for children with rare diseases: a national cross-sectional study. *BMC Public Health*, *25*(1), 4190.

Zimansky, M., Stasielowicz, L., Franke, I., Remmers, H., Friedel, H., & Atzpodien, J. (2020). Effects of implementing a brief family nursing intervention with hospitalized oncology patients and their families in Germany: A quasi-experimental study. *Journal of Family Nursing*, *26*(4), 346–357.

BAB 3

PENGKAJIAN KELUARGA: GENOGRAM, ECOMAP, RISIKO, DAN KEBUTUHAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor.	CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi).	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	**Rumusan CPMK**
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian komunitas dan keluarga secara sistematis (data, pemetaan, risiko, genogram/ecomap) secara etis dan akurat.
CPMK-1	Menguasai konsep, ruang lingkup, peran perawat, serta prinsip etika-legal dan keselamatan dasar dalam keperawatan komunitas dan keluarga.
CPMK-3	Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi.

Uraian Materi

Pengkajian merupakan fondasi krusial dalam proses keperawatan keluarga. Pengkajian tidak hanya sekadar pengumpulan data, melainkan sebuah proses dinamis untuk memahami keluarga sebagai sistem sosial yang saling berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas. Dalam perspektif keperawatan keluarga, individu tidak dilihat secara terisolasi namun dilihat secara komprehensif bahwa kesehatan satu anggota keluarga secara fundamental akan memengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika seluruh unit keluarga (Friedman, 2010). Oleh karena itu, kemampuan melakukan pengkajian yang komprehensif menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh perawat komunitas untuk menentukan diagnosis dan intervensi yang tepat.

Perawat perlu memiliki kemampuan dalam memandang keluarga sebagai satu kesatuan yang unik. Keluarga satu mungkin memiliki struktur dan fungsi yang berbeda dengan keluarga yang lain. Instrumen visual seperti genogram dan ecomap menjadi penting dikaji untuk menunjukkan kekhasan dan kompleksitas dari suatu keluarga. Genogram merupakan bagian dari pengkajian keluarga yang berfungsi sebagai peta genetik dan psikososial yang merangkum struktur keluarga, riwayat kesehatan, serta pola hubungan antar generasi setidaknya selama tiga generasi. Melalui genogram, perawat dapat mengidentifikasi pola penyakit herediter serta dinamika hubungan yang mungkin menjadi sumber stres atau kekuatan bagi keluarga.

Ecomap memberikan gambaran mengenai sistem ekologi keluarga. Berdasarkan model sistem Wright & Leahey (2019) dalam *Calgary Family Assessment Model* (CFAM), ecomap menggambarkan interaksi keluarga dengan sistem luar seperti tempat kerja, sekolah, layanan kesehatan, hingga komunitas religius. Alat ini memungkinkan perawat dan keluarga secara visual mengidentifikasi dari mana dukungan mengalir dan di mana terjadi konflik atau beban (*stresson*).

Data yang dikumpulkan dari genogram dan ecomap harus disintesis untuk mengidentifikasi kebutuhan keluarga yang prioritas. Kebutuhan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek fisik, psikologis, sosial, hingga spiritual. Dengan berbasis pada data pengkajian yang akurat, perawat dapat berkolaborasi dengan keluarga untuk mengembangkan strategi koping yang adaptif.

A. Pengkajian keluarga

Proses pengkajian atau pengambilan data dalam keluarga merupakan salah satu proses keperawatan yang harus dilakukan agar asuhan keperawatan yang dilakukan pada keluarga dapat tepat sasaran. Pengkajian dilakukan secara terus-menerus, bersifat siklik dan dinamis, sehingga perawat dapat mengumpulkan

informasi yang valid, menemukan kemungkinan atau potensi masalah, dan menggali permasalahan tersebut lebih dalam.

Teori Family Care Nursing menyebutkan bahwa proses keperawatan dalam keluarga dimulai dengan pengkajian keluarga meliputi identifikasi data sosial budaya, data lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga, serta stress dan strategi koping keluarga. Kemudian dilanjutkan dengan pengkajian anggota keluarga sebagai individu meliputi pengkajian mental, fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Perawat mengidentifikasi data yang terkumpul baik dari keluarga, subsistem, maupun individu, kemudian menegakkan masalah keperawatan yang muncul, merencanakan perawatan, melaksanakan intervensi, dan melakukan intervensi (Friedman, 2010).

Data dalam pengkajian keluarga berasal dari berbagai sumber, misalnya wawancara tentang peristiwa yang lalu dan masa kini, data obyektif berdasarkan hasil observasi, data subyektif contohnya pengalaman yang dilaporkan oleh anggota keluarga, informasi tertulis dan lisan dari pihak lain yang bekerja dengan keluarga, serta laporan rujukan dari tenaga kesehatan lain yang merawat anggota keluarga. Wawancara dilakukan secara tatap muka baik dalam atau luar jaringan dengan satu anggota keluarga atau lebih. Wawancara bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada setiap anggota keluarga untuk berbagi persepsi dan perawat dapat melihat interaksi antar anggota keluarga. Dalam proses wawancara, perawat mengajukan pertanyaan, mendengarkan jawaban, serta mengamati interaksi dengan menggunakan kuesioner atau daftar tilik, genogram dan ecomap sesuai kebutuhan.

B. Genogram sebagai alat pengkajian keluarga

Genogram bukan sekadar pohon keluarga (*family tree*) konvensional yang bersifat statis. Dalam keperawatan keluarga, genogram adalah instrumen pengkajian format visual yang dinamis. Genogram merupakan representasi grafis dari struktur keluarga yang menggambarkan hubungan antaranggota keluarga lintas generasi, biasanya hingga tiga generasi atau lebih. Lebih dari sekadar pohon keluarga, genogram memuat informasi tentang hubungan emosional, pola penyakit, peristiwa penting dalam keluarga, serta dinamika sosial yang relevan dengan kesehatan (Wright & Leahey, 2019). Dalam konteks keperawatan keluarga, genogram memiliki peran penting dalam membantu perawat mengidentifikasi pola kesehatan, faktor risiko genetik, serta pola interaksi keluarga yang dapat memengaruhi kesejahteraan individu dan keluarga secara keseluruhan (Friedman, 2010; Kaakinen et al., 2015).

Genogram pertama kali dikembangkan sebagai alat untuk memahami pola hubungan antar anggota keluarga. Dalam perkembangannya, genogram tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga sebagai alat komunikasi antara perawat dan keluarga. Proses penyusunan genogram dapat menjadi sarana terapeutik yang membantu keluarga merefleksikan hubungan mereka (Joseph, Dickenson, McCall, & Roga, 2023).

Genogram memiliki manfaat spesifik bagi perawat, antara lain untuk;

1. Menggambarkan struktur dan komposisi keluarga
2. Mengidentifikasi hubungan biologis dan sosial
3. Menelusuri pola interaksi antar anggota keluarga
4. Mengidentifikasi kejadian penting dalam keluarga
5. Mengidentifikasi riwayat kesehatan keluarga
6. Mengidentifikasi faktor risiko genetik dan lingkungan

Genogram memiliki beberapa komponen utama, yaitu ;

1. Struktur keluarga dan komposisi keluarga
   Bagian ini mencakup bentuk keluarga baik keluarga tradisional maupun modern meliputi keluarga inti, keluarga besar, keluarga orang tua tunggal, keluarga dengan orang tua tiri, dan lain sebagainya. Sedangkan komposisi keluarga menggambarkan anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah baik yang terhubung secara biologis, contohnya orang tua kandung dan anak kandung, atau hubungan non-biologis contohnya anak hasil adopsi atau pernikahan ulang.
2. Informasi Demografis
   Setiap anggota keluarga yang tergambar dalam genogram, dilengkapi dengan informasi berupa nama atau inisial, usia, jenis kelamin, dan status hidup atau sudah meninggal dunia.
3. Hubungan antar anggota keluarga
   Hubungan anggota keluarga digambarkan dengan garis tertentu, contohnya garis tegas lurus artinya hubungan pernikahan, garis lurus putus-putus artinya tidak terikat hubungan pernikahan, garis melingkar putus-putus artinya tinggal dalam satu rumah, dan lain sebagainya.
4. Riwayat Kesehatan
   Riwayat kesehatan keluarga dalam genogram digambarkan dengan penyakit kronis yang diderita anggota keluarga, penyakit genetik, gangguan mental, dan penyebab kematian anggota keluarga.
5. Peristiwa Penting
   Peristiwa penting yang tergambar dalam genogram contohnya perceraian dan kematian.

C. Simbol dalam Genogram

Genogram memiliki simbol standar untuk merepresentasikan struktur keluarga, hubungan antar anggota keluarga, serta informasi kesehatan lintas generasi. Penggunaan simbol dalam genogram harus konsisten dan terstandar agar genogram dapat dipahami secara universal oleh tenaga kesehatan (Wright & Leahey, 2019). Dalam praktik keperawatan keluarga, pemahaman simbol genogram menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki perawat untuk melakukan pengkajian yang akurat (Friedman, 2010; Kaakinen et al., 2015).

1. Simbol Dasar Individu

Simbol dasar individu menggambarkan anggota keluarga berdasarkan jenis kelamin dan status hidup. Informasi tambahan yang perlu dicantumkan pada setiap individu adalah inisial nama, usia/tanggal lahir, tahun kematian, dan kondisi kesehatan atau jenis penyakit

- Laki-laki digambarkan dengan persegi **(□)**
- Perempuan digambarkan dengan lingkaran (O)
- Individu telah meninggal digambarkan dengan tanda silang (X)
- Klien utama digambarkan dengan tanda panah (→)

2. Simbol Hubungan Perkawinan dan Pasangan

Simbol ini menggambarkan hubungan antara dua individu atau lebih, baik yang terikat hubungan perkawinan atau tidak.

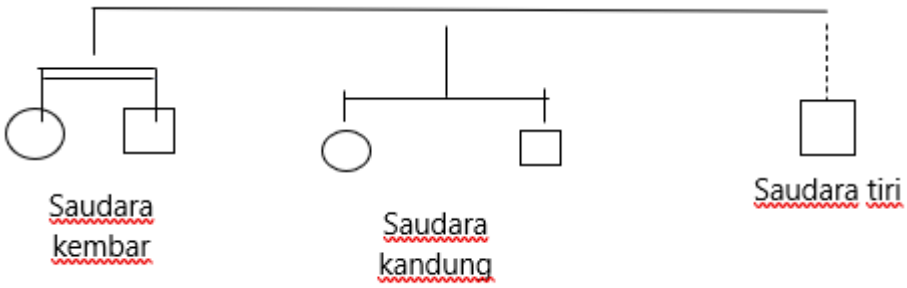
- Pernikahan sah digambarkan dengan garis horizontal lurus **(—)**
- Hubungan tidak resmi atau kohabitasi digambarkan dengan garis putus-putus (----)
- Pasangan yang sudah bercerai digambarkan dengan dua garis miring (—//—) atau *separation* pada garis pernikahan
- Pernikahan dengan lebih dari satu orang dalam satu orang digambarkan dengan beberapa garis hubungan ke pasangan yang berbeda secara berurutan

3. Simbol Hubungan Orang Tua dan Anak

Garis keturunan dalam keluarga digambarkan oleh beberapa simbil, diantaranya;

- Garis vertikal (|) menggambarkan hubungan orang tua dengan anak kandung
- Garis horizontal penghubung anak (sibship line) menggambarkan hubungan antara saudara kandung

- Urutan anak berdasarkan urutan kelahiran dari kiri ke kanan. Anak tertua berada di sebelah kiri.
- Anak kembar digambarkan dengan garis bercabang dengan garis bercabang di antara keduanya, sedangkan kembar identik digambarkan dengan garis penghubung
- Anak angkat digambarkan dengan garis putus-putus dari orang tua
- Anak tiri digambarkan dengan hubungan dari pernikahan sebelumnya



Gambar 3.1: Simbol hubungan orang tua dengan anak (Wright & Leahey, 2019)

4. Kondisi Kesehatan

Genogram juga memuat informasi kesehatan yang dialami oleh anggota keluarga. Anggota keluarga dengan penyakit tertentu akan diberi symbol berupa pewarnaan atau kode, contohnya DM untuk Diabetes Mellitus, HT untuk Hipertensi, CA untuk kanker, dan lain sebagainya. Penggunaan symbol-simbol ini harus konsisten dan disertai dengan keterangan pada bagian bawah genogram, sehingga tidak menimbulkan misinterpretasi.

D. Langkah-Langkah Penyusunan Genogram

Dalam praktik keperawatan keluarga, genogram tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi struktur keluarga, tetapi juga sebagai sarana untuk memahami dinamika relasional dan sebagai bagian dari intervensi terapeutik. Pendekatan yang dikembangkan oleh Wright dan Leahey menekankan bahwa proses penyusunan genogram merupakan kegiatan kolaboratif antara perawat dan keluarga yang berlangsung dalam konteks hubungan terapeutik.

Tahap awal dalam pembuatan genogram dimulai dengan menjelaskan tujuan kepada keluarga. Perawat perlu mengkomunikasikan bahwa genogram digunakan untuk memahami struktur keluarga, pola hubungan, serta riwayat kesehatan yang mungkin berpengaruh terhadap kondisi saat ini. Penjelasan ini penting untuk

membangun kepercayaan dan keterbukaan keluarga, sehingga proses pengkajian dapat berlangsung secara efektif. Dalam pendekatan ini, keterlibatan aktif keluarga sejak awal dipandang sebagai bagian dari intervensi, bukan sekadar pengumpulan data.

Setelah keluarga memahami tujuan penyusunan genogram, perawat mulai mengidentifikasi anggota keluarga. Genogram perlu cakup setidaknya tiga generasi dalam genogram, yaitu generasi klien, orang tua, serta kakek-nenek. Pengkajian lintas generasi ini memungkinkan perawat mengidentifikasi pola-pola yang berulang dalam keluarga, baik yang berkaitan dengan kesehatan maupun hubungan interpersonal.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data demografis dasar dari setiap anggota keluarga. Informasi yang dikumpulkan meliputi nama atau inisial, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, serta status hidup atau meninggal. Data ini menjadi dasar dalam penyusunan struktur genogram dan harus dikumpulkan secara akurat. Pada tahap ini, perawat juga mulai membangun pemahaman awal mengenai komposisi keluarga dan perubahan yang terjadi di dalamnya.

Setelah data dasar diperoleh, perawat mulai menggambarkan struktur keluarga menggunakan simbol genogram yang standar. Simbol-simbol ini digunakan untuk merepresentasikan individu dan hubungan biologis maupun sosial, seperti hubungan pernikahan dan hubungan orang tua–anak. Wright dan Leahey menekankan bahwa penggunaan simbol yang konsisten sangat penting agar genogram dapat berfungsi sebagai alat komunikasi profesional antar tenaga kesehatan.

Namun, genogram dalam pendekatan ini tidak berhenti pada aspek struktural. Tahap selanjutnya adalah menambahkan informasi mengenai hubungan antaranggota keluarga. Perawat mengidentifikasi kualitas hubungan, seperti hubungan yang dekat, konflik, atau terputus, dan menggambarkannya dalam genogram. Fokus pada aspek relasional ini merupakan karakteristik utama pendekatan Wright dan Leahey, yang melihat keluarga sebagai sistem interaksi, bukan sekadar kumpulan individu.

Selain hubungan, perawat juga mengidentifikasi pola dan peristiwa penting dalam keluarga. Informasi yang dikaji meliputi riwayat penyakit kronis atau genetik, kejadian kematian, perceraian, serta peristiwa transisional atau stresor yang dialami keluarga. Dengan mengintegrasikan informasi ini ke dalam genogram, perawat dapat mengidentifikasi pola lintas generasi yang mungkin memengaruhi kondisi kesehatan dan kesejahteraan keluarga.

Untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika keluarga, Wright dan Leahey menganjurkan penggunaan pertanyaan sirkular *(circular questioning).*

Melalui pertanyaan ini, perawat dapat mengeksplorasi persepsi anggota keluarga tentang hubungan satu sama lain, misalnya dengan menanyakan siapa yang paling dekat dalam keluarga atau bagaimana interaksi antara anggota tertentu. Pendekatan ini tidak hanya menghasilkan data yang lebih kaya, tetapi juga mendorong refleksi dalam keluarga.

Selanjutnya, proses penyusunan genogram dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan keluarga secara aktif. Perawat tidak hanya berperan sebagai pengumpul data, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu keluarga memahami struktur dan dinamika mereka sendiri. Validasi informasi dengan keluarga menjadi langkah penting untuk memastikan keakuratan genogram serta meningkatkan rasa memiliki terhadap hasil pengkajian.

Tahap berikutnya adalah interpretasi genogram bersama keluarga. Dalam tahap ini, perawat dan keluarga bersama-sama mengidentifikasi pola, hubungan, serta makna dari informasi yang telah digambarkan. Proses ini memiliki nilai terapeutik karena dapat membantu keluarga menyadari kekuatan maupun masalah yang ada dalam sistem mereka.

Akhirnya, genogram digunakan sebagai dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan. Informasi yang diperoleh dari genogram memungkinkan perawat untuk mengidentifikasi masalah keperawatan, menentukan prioritas, serta merancang intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks keluarga. Dengan demikian, genogram tidak hanya berfungsi sebagai alat pengkajian, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan klinis dalam keperawatan keluarga.

Secara keseluruhan, langkah-langkah pembuatan genogram memerlukan pendekatan yang holistik, relasional, dan kolaboratif. Proses ini tidak hanya menghasilkan data yang komprehensif, tetapi juga memperkuat hubungan antara perawat dan keluarga serta mendukung tercapainya asuhan keperawatan yang berpusat pada keluarga.

Tabel 3.1: Langkah Pembuatan Genogram (Wright & Leahey, 2019)

No	Langkah	Uraian Singkat	Tujuan
1	Menjelaskan tujuan kepada keluarga	Perawat menjelaskan fungsi genogram sebagai alat untuk memahami struktur, hubungan, dan riwayat kesehatan keluarga	Membangun kepercayaan dan keterlibatan keluarga
2	Mengidentifikasi anggota keluarga	Mengidentifikasi anggota keluarga minimal tiga generasi (kakek-nenek, orang tua, anak)	Mengetahui struktur keluarga lintas generasi

3	Mengumpulkan data demografis	Mengumpulkan data dasar (nama, usia, jenis kelamin, status hidup/mati)	Menyusun dasar informasi genogram
4	Menggambar struktur keluarga	Menyusun genogram menggunakan simbol standar (individu dan hubungan keluarga)	Memvisualisasikan struktur keluarga
5	Menambahkan hubungan emosional	Menggambarkan kualitas hubungan (dekat, konflik, terputus) antaranggota keluarga	Memahami dinamika relasional
6	Mengidentifikasi pola & peristiwa penting	Mengkaji riwayat penyakit, kematian, perceraian, dan peristiwa signifikan lainnya	Mengidentifikasi pola lintas generasi
7	Menggunakan pertanyaan sirkular	Mengajukan pertanyaan reflektif untuk menggali hubungan dan persepsi anggota keluarga	Memperdalam pemahaman relasi keluarga
8	Melibatkan keluarga secara aktif	Menyusun genogram secara kolaboratif dan melakukan validasi data bersama keluarga	Meningkatkan akurasi dan keterlibatan keluarga
9	Menginterpretasi genogram bersama	Menganalisis pola dan makna genogram bersama keluarga	Meningkatkan kesadaran keluarga terhadap dinamika mereka
10	Menggunakan untuk intervensi	Menggunakan hasil genogram untuk menentukan masalah dan merencanakan asuhan keperawatan	Mendukung intervensi berbasis keluarga

E. Ecomap dalam Pengkajian Keluarga

Ecomap merupakan salah satu alat penting dalam pengkajian keluarga yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara keluarga dengan lingkungan eksternal. Ecomap dipahami sebagai alat visual yang membantu perawat dan

keluarga melihat secara lebih luas konteks sosial di mana keluarga berada, termasuk sumber dukungan dan sumber stres yang memengaruhi fungsi keluarga.

Berbeda dengan genogram yang berfokus pada struktur dan hubungan internal keluarga, ecomap berfungsi untuk memetakan jaringan sosial keluarga serta interaksi mereka dengan berbagai sistem di luar keluarga. Sistem tersebut dapat mencakup layanan kesehatan, institusi pendidikan, tempat kerja, komunitas, serta hubungan sosial lainnya yang relevan dengan kehidupan keluarga. Dengan demikian, ecomap memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai lingkungan keluarga sebagai suatu sistem terbuka (Wright & Leahey, 2019).

Ecomap dalam keperawatan keluarga tidak hanya digunakan sebagai alat pengkajian, tetapi juga sebagai bagian dari proses intervensi terapeutik. Proses penyusunan ecomap dilakukan secara kolaboratif antara perawat dan keluarga, sehingga memungkinkan keluarga untuk merefleksikan hubungan mereka dengan lingkungan sekitar. Melalui proses ini, keluarga dapat menyadari sumber dukungan yang tersedia maupun tekanan yang mereka hadapi, yang sering kali tidak disadari sebelumnya (Mathiasen, Kjærgaard, & Piil, 2023).

Ecomap disusun dengan menempatkan keluarga sebagai pusat, yang biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran. Di sekeliling keluarga digambarkan berbagai sistem eksternal yang memiliki hubungan dengan keluarga. Hubungan antara keluarga dan sistem eksternal tersebut ditunjukkan dengan garis yang menggambarkan kualitas interaksi, seperti hubungan yang kuat, lemah, atau penuh stres. Selain itu, arah aliran dukungan juga dapat ditunjukkan untuk menggambarkan apakah hubungan tersebut bersifat timbal balik atau tidak (Wright & Leahey, 2019; Kaakinen, Coehlo, Steele, Tabacco, & Hanson, 2015).

Perawat perlu melakukan eksplorasi kualitas hubungan dalam ecomap. Perawat tidak hanya mengidentifikasi keberadaan hubungan, tetapi juga menilai bagaimana hubungan tersebut dirasakan oleh keluarga. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan ecomap, perawat menggunakan pertanyaan reflektif atau pertanyaan sirkular untuk menggali persepsi keluarga tentang hubungan mereka dengan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengalaman subjektif keluarga.

Melalui ecomap, perawat dapat mengidentifikasi berbagai sumber dukungan yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan asuhan keperawatan. Sumber dukungan tersebut dapat berupa individu, kelompok, maupun institusi yang memberikan bantuan emosional, instrumental, atau informasi kepada keluarga. Di sisi lain, ecomap juga membantu mengidentifikasi sumber stres yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga, seperti konflik

dengan lingkungan sosial atau keterbatasan akses terhadap layanan (Mathiasen, Kjærgaard, & Piil, 2023).

Dalam praktik keperawatan keluarga, informasi yang diperoleh dari ecomap digunakan untuk merancang intervensi yang lebih tepat dan kontekstual. Misalnya, perawat dapat memperkuat hubungan dengan sumber dukungan yang sudah ada, atau membantu keluarga mengatasi hambatan dalam mengakses sumber daya. Selain itu, ecomap juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam jaringan sosial keluarga yang perlu diintervensi. Penggunaan ecomap juga memungkinkan perawat dan keluarga untuk bersama-sama memahami hubungan antara keluarga dan lingkungan, serta memanfaatkan informasi tersebut untuk meningkatkan fungsi keluarga dan kualitas asuhan keperawatan.

Tabel 3.2: Perbedaan Genogram dan Ecomap
(Kaakinen, Coehlo, Steele, Tabacco, & Hanson, 2015; Wright & Leahey, 2019)

Aspek	Genogram	Ecomap
Definisi	Representasi visual struktur keluarga dan hubungan antaranggota keluarga lintas generasi	Representasi visual hubungan antara keluarga dan lingkungan eksternal
Fokus utama	Struktur internal keluarga (siapa saja anggota keluarga dan hubungan biologis/emosional)	Interaksi keluarga dengan sistem eksternal (lingkungan sosial)
Cakupan	Minimal 2–3 generasi	Kondisi saat ini (current situation)
Posisi keluarga	Sebagai bagian dari diagram (tidak selalu di tengah)	Selalu berada di tengah sebagai pusat sistem
Jenis hubungan yang dikaji	Hubungan biologis, hukum, dan emosional dalam keluarga	Hubungan sosial, ekonomi, dan layanan dengan lingkungan luar
Komponen utama	Individu, garis hubungan keluarga, simbol status hidup/mati, pola relasi	Keluarga inti, sistem eksternal (sekolah, RS, tempat kerja, dll), garis hubungan
Informasi yang dihasilkan	Riwayat keluarga, pola penyakit, pola relasi lintas generasi	Sumber daya (support) dan stresor (pressure) dari lingkungan
Orientasi waktu	Historis (masa lalu hingga sekarang)	Aktual/kontekstual (situasi saat ini)
Tujuan penggunaan	Mengidentifikasi pola keluarga dan masalah lintas generasi	Mengidentifikasi dukungan dan hambatan dari lingkungan
Peran dalam pengkajian	Memberikan gambaran mendalam tentang struktur dan dinamika keluarga	Memberikan gambaran konteks sosial dan jaringan dukungan

Simbol utama	Persegi (laki-laki), lingkaran (perempuan), garis hubungan keluarga	Lingkaran/diagram sistem eksternal dan garis hubungan (kuat, lemah, stres)
Jenis data	Data demografis, hubungan keluarga, riwayat kesehatan	Data sosial, akses layanan, jaringan dukungan
Kegunaan klinis	Deteksi risiko genetik, konflik keluarga, pola perilaku	Perencanaan intervensi berbasis sumber daya komunitas

Arti Garis dalam Ecomap

Hubungan keluarga dengan pihak eksternal digambarkan dengan beberapa simbol atau garis yang memiliki interpretasi yang berbeda-beda.

- Garis lurus dan tegas (▬▬▬▬) menggambarkan hubungan yang kuat
- Garis putus-putus (▬ ▬ ▬) menggambarkan hubungan yang renggang atau lemah
- Garis vertical di sepanjang garis horizontal (⊢┼┼┼┼┼⊣) menggambarkan hubungan dengan ketegangan
- Tanda panah (←——— ——→) menggambarkan arah pertukaran energi (dukungan, informasi, bantuan, atau stres) antara keluarga dan lingkungan eksternal

F. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Keluarga Bapak Ahmad tinggal di wilayah perkotaan dengan anggota keluarga sebagai berikut:

- Bapak Ahmad (58 tahun), kepala keluarga, bekerja sebagai sopir, memiliki riwayat Diabetes Mellitus sejak 10 tahun lalu
- Ibu Siti (55 tahun), ibu rumah tangga, memiliki Hipertensi
- Anak pertama: Rina (30 tahun), sudah menikah, tinggal terpisah
- Anak kedua: Andi (25 tahun), bekerja sebagai buruh pabrik, tinggal serumah
- Anak ketiga: Dika (17 tahun), siswa SMA
- Keluarga ini juga pernah kehilangan anak keempat (meninggal saat bayi)

Riwayat Kesehatan dan Pola Keluarga

- Ayah dari Bapak Ahmad meninggal karena komplikasi Stroke
- Ibu dari Bapak Ahmad masih hidup (80 tahun), tinggal di desa
- Keluarga memiliki riwayat penyakit kronis (DM dan hipertensi) lintas generasi

- Hubungan antara Bapak Ahmad dan Andi cukup tegang karena masalah ekonomi
- Ibu Siti memiliki hubungan dekat dengan anak-anak

Kondisi Psikososial

- Pendapatan keluarga terbatas
- Bapak Ahmad sering merasa stres karena penyakit dan beban ekonomi
- Andi menjadi tulang punggung tambahan keluarga
- Dika sering menghabiskan waktu dengan teman sebaya

Lingkungan dan Sistem Pendukung

- Keluarga terdaftar di Puskesmas setempat (akses layanan kesehatan)
- Memiliki hubungan baik dengan tetangga
- Aktif dalam kegiatan keagamaan di masjid
- Memiliki BPJS, tetapi jarang kontrol rutin
- Lingkungan kerja Andi cukup berat dan kurang mendukung kesehatan

Tugas Mahasiswa:

Mahasiswa diminta untuk berdiskusi untuk menjawab pertanyaan berikut ini dan mempresentasikannya

1. Apa pola penyakit yang terlihat dalam genogram?
2. Bagaimana hubungan antar anggota keluarga?
3. Sistem mana yang menjadi sumber dukungan utama?
4. Sistem mana yang menjadi stresor?
5. Bagaimana arah aliran energi dalam ecomap?
6. Apa masalah keperawatan keluarga yang mungkin muncul?

G. Aktivitas 2

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	..... (Dikosongkan)
2	Judul station	Pengkajian keluarga dengan genogram dan ecomap
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian dan menyusun genogram dan ecomap
5	Kompetensi	1. Komunikasi 2. Pengkajian 3. Perilaku professional

6	Kategori	Psikososial Keluarga Komunitas
7	Instruksi untuk peserta ujian	**SKENARIO KLINIK** Keluarga Bapak Ahmad tinggal di wilayah perkotaan. Anggota keluarga terdiri dari Bapak Ahmad (58 tahun) dengan riwayat Diabetes Mellitus, Ibu Siti (55 tahun) dengan hipertensi, serta dua anak yang tinggal serumah. Salah satu anak memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan ayah karena masalah ekonomi. Keluarga memiliki riwayat penyakit kronis lintas generasi dan mengalami keterbatasan dalam akses pelayanan kesehatan meskipun terdaftar di fasilitas kesehatan. Hubungan sosial dengan tetangga cukup baik, namun pemanfaatan layanan kesehatan belum optimal. **TUGAS** Peserta diminta untuk: • Melakukan pengkajian keluarga secara singkat • Membuat genogram minimal 3 generasi • Membuat ecomap keluarga • Menjelaskan interpretasi hasil (pola keluarga, sumber dukungan, dan stresor) • Menunjukkan perilaku profesional
8	Instruksi untuk penguji	**SKENARIO KLINIK** Keluarga Bapak Ahmad tinggal di wilayah perkotaan. Anggota keluarga terdiri dari Bapak Ahmad (58 tahun) dengan riwayat Diabetes Mellitus, Ibu Siti (55 tahun) dengan hipertensi, serta dua anak yang tinggal serumah. Salah satu anak memiliki hubungan yang kurang harmonis dengan ayah karena masalah ekonomi. Keluarga memiliki riwayat penyakit kronis lintas generasi dan mengalami keterbatasan dalam akses pelayanan kesehatan meskipun terdaftar di fasilitas kesehatan. Hubungan sosial dengan tetangga cukup baik, namun pemanfaatan layanan kesehatan belum optimal. **TUGAS**

		Peserta diminta untuk: • Melakukan pengkajian keluarga secara singkat • Membuat genogram minimal 3 generasi • Membuat ecomap keluarga • Menjelaskan interpretasi hasil (pola keluarga, sumber dukungan, dan stresor) • Menunjukkan perilaku profesional **INSTRUKSI PENGUJI** 1. Mengamati dan menilai performa peserta berdasarkan checklist 2. Tidak memberikan bantuan/verbal cue selama ujian berlangsung 3. Hanya menjawab pertanyaan jika sesuai konteks dan secara terbatas
9	Instruksi untuk klien standar	Instruksi Fokus Genogram, hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: 1. **Identitas pasien sesuai kasus**: Klien adalah Bapak Ahmad, laki-laki usia 58 tahun. KS berperan sebagai kepala keluarga yang tinggal bersama istri dan anak. 2. **Komposisi keluarga inti**: o Istri: Ny. Siti, usia 55 tahun, ibu rumah tangga o Anak pertama: laki-laki, sudah menikah, tinggal terpisah o Anak kedua: laki-laki, tinggal serumah, bekerja o Anak ketiga: perempuan, masih sekolah, tinggal serumah 3. **Riwayat keluarga (minimal 2–3 generasi)**: o Ayah klien: meninggal karena stroke o Ibu klien: masih hidup, usia lanjut o Tidak semua anggota keluarga memiliki penyakit, tetapi ada riwayat penyakit kronis dalam keluarga 4. **Hubungan dalam keluarga (kunci genogram)**: o Hubungan dengan istri: baik

		○ Hubungan dengan anak pertama: baik ○ Hubungan dengan anak kedua: kurang harmonis (sering berbeda pendapat) ○ Hubungan dengan anak ketiga: dekat 5. **Riwayat penyakit dalam keluarga**: ○ Klien memiliki Diabetes Mellitus ○ Ayah memiliki riwayat stroke ○ Tidak ada penyakit menular dalam keluarga saat ini 6. **Bila peserta menanyakan anggota keluarga secara detail**, jawaban KS: ○ "Saya punya 3 anak…" ○ "Anak pertama sudah menikah dan tinggal sendiri…" ○ "Anak kedua tinggal di rumah, tapi kami kadang kurang cocok…" ○ "Anak ketiga masih sekolah, dekat dengan saya…" 7. **Bila peserta menanyakan hubungan emosional**, jawaban KS: ○ "Ya, hubungan keluarga baik, tapi ada sedikit masalah dengan anak kedua…" 8. **Bila peserta tidak menggali**, KS tidak memberikan informasi tambahan secara sukarela. 9. **Posisi dan ekspresi selama OSCE**: ○ Duduk tenang ○ Ekspresi netral cenderung sedikit serius ○ Saat membahas anak kedua → ekspresi sedikit berubah (ragu/tidak nyaman) 10. **Tujuan peran KS dalam skenario ini**: • Memberikan informasi struktur keluarga • Memberikan gambaran hubungan keluarga untuk digambarkan dalam genogram Instruksi Fokus Ecomap 1. **Identitas pasien sesuai kasus**: Klien adalah Bapak Ahmad, laki-laki usia 58 tahun, bekerja sebagai sopir, tinggal bersama keluarga.

		2. **Kondisi umum saat ini**: Klien memiliki Diabetes Mellitus, sering merasa lelah, dan tidak rutin kontrol ke fasilitas kesehatan. 3. **Hubungan dengan sistem eksternal (inti ecomap)**: • **Fasilitas kesehatan (puskesmas)**: Ada, tetapi jarang dimanfaatkan → hubungan lemah • **Tetangga**: Hubungan baik, sering berinteraksi ringan → hubungan cukup kuat • **Tempat kerja**: Bekerja sebagai sopir, hubungan biasa saja dengan rekan kerja → hubungan sedang • **Keluarga besar**: Jarang bertemu, komunikasi terbatas → hubungan lemah • **Lingkungan sosial/masyarakat**: Kadang ikut kegiatan, tetapi tidak aktif → hubungan sedang • **Sistem jaminan kesehatan (BPJS)**: Memiliki, tetapi jarang digunakan → hubungan lemah 4. **Bila peserta menanyakan akses layanan kesehatan**, jawaban KS: "Ada puskesmas, tapi saya jarang ke sana…" 5. **Bila peserta menanyakan hubungan dengan tetangga**, jawaban KS: "Tetangga baik, kadang ngobrol…" 6. **Bila peserta menanyakan dukungan sosial**, jawaban KS: "Ya ada, tapi saya tidak terlalu sering minta bantuan…" 7. **Bila peserta menanyakan pekerjaan**, jawaban KS: "Saya kerja sebagai sopir… ya biasa saja…" 8. **Bila peserta menanyakan keikutsertaan kegiatan masyarakat**, jawaban KS: "Kadang ikut, tapi tidak rutin…"

		9. **Respons emosional (kunci ecomap)**: • Saat bicara tentang kesehatan → sedikit khawatir • Saat bicara tentang tetangga → lebih santai • Saat bicara tentang layanan kesehatan → cenderung ragu 10. **Posisi dan ekspresi selama OSCE**: • Duduk santai • Ekspresi sedikit lelah • Nada suara biasa, kadang ragu 11. **Tujuan peran KS dalam skenario ini**: • Memberikan informasi hubungan antara keluarga dengan lingkungan eksternal • Menunjukkan kekuatan dan kelemahan hubungan sosial **Catatan Penting (Untuk Kedua Skenario)** • KS hanya menjawab jika ditanya • Tidak memberikan informasi berlebihan • Tidak membantu peserta menggambar • Menjaga konsistensi jawaban antar peserta • Tidak keluar dari skenario
10	Setting station	• Peserta duduk berhadapan dengan klien • Data kasus tersedia dalam lembar soal • Fokus pada pengkajian keluarga
11	Peralatan yang dibutuhkan	• Kertas kosong / lembar ecomap dan genogram • Pulpen/pensil • Meja dan kursi • Instruksi peserta • Checklist penilaian
12	Penulis	Ns. Arnindya Kanti Prasasti, S.Kep, M.Kep, Sp.Kep.K
13	Referensi	• Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. • Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

		• Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. • Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. (2015). *Family Health Care Nursing : Theory, Practice, Research.* Philadelpia: FA Davis Company. • Wright, L. M., & Leahey, M. (2019). *Nurses and Families : A Guide to Family Asessment and Intervention.* FA Davis Company: Philadelphia.

SOP PENGKAJIAN KELUARGA: PERUMUSAN GENOGRAM DAN ECOMAP

No	Kegiatan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
Fase Pra-orientasi					
1	Menyiapkan alat: kertas, pulpen, format genogram/ecomap				
2	Mempelajari kasus/identitas klien				
3	Menentukan tujuan pengkajian (genogram atau ecomap)				
4	Menyiapkan diri (penampilan rapi, sikap profesional)				
5	Mempersiapkan lingkungan yang nyaman dan kondusif				
Fase Orientasi					
6	Memberi salam dan memperkenalkan diri				

7	Melakukan identifikasi klien (nama, usia, dll)				
8	Menjelaskan tujuan kegiatan (pengkajian keluarga)				
9	Menjelaskan prosedur yang akan dilakukan				
10	Menjaga privasi dan meminta persetujuan klien				
11	Membangun hubungan saling percaya				
Fase Kerja (pengkajian Genogram)					
12	Menggali anggota keluarga inti dan keluarga besar				
13	Mengidentifikasi hubungan antar anggota keluarga				
14	Mengidentifikasi riwayat penyakit keluarga				
15	Menanyakan hubungan emosional dalam keluarga				
16	Mencatat data secara sistematis				
17	Menggambar genogram yang terdiri dari 3 generasi				
18	Menggunakan simbol genogram dengan benar				

Fase Kerja (Pengkajian Ecomap)					
19	Mengidentifikasi sistem eksternal (tetangga, fasilitas kesehatan, pekerjaan, dll)				
20	Menggali hubungan keluarga dengan lingkungan				
21	Mengidentifikasi dukungan sosial yang tersedia				
22	Menilai kekuatan hubungan (kuat, lemah, konflik)				
23	Mengidentifikasi arah aliran energi (memberi/ menerima dukungan)				
24	Mencatat data secara sistematis				
25	Menggambar ecomap dengan simbol yang tepat				
Fase Terminasi					
26	Menyimpulkan hasil pengkajian bersama klien				
27	Memberikan kesempatan klien bertanya				
28	Memberikan reinforcement positif				
29	Menyampaikan rencana tindak lanjut (jika ada)				

30	Mengakhiri interaksi dengan sopan (salam penutup)				

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN
STATION: PENGKAJIAN KELUARGA: PENYUSUNAN GENOGRAM DAN ECOMAP

I. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Komunikasi : • **Fase orientasi :** membuka interaksi melalui salam, memperkenalkan diri, melakukan identifikasi klien, serta menjelaskan tujuan dan prosedur Tindakan • **Sikap komunikasi**: penggunaan bahasa yang mudah dipahami, kontak mata yang adekuat, serta sikap empatik dan tidak menghakimi • **Teknik komunikasi :** menggunakan pertanyaan terbuka, melakukan klarifikasi, dan refleksi terhadap pernyataan klien • **kemampuan membangun hubungan saling percaya** • **Respons terhadap klien** : kemampuan peserta dalam menanggapi keluhan, perasaan, atau kekhawatiran klien secara tepat dan empatik. • **Fase terminasi**, yang mencakup kemampuan menyimpulkan hasil interaksi, memberikan kesempatan kepada klien untuk bertanya, serta menutup komunikasi dengan sopan dan profesional.					3	
2. Pengkajian Keperawatan a. Genogram • **Identifikasi anggota keluarga**: kemampuan peserta menggali informasi tentang anggota keluarga inti dan keluarga besar minimal dua hingga tiga generasi.					5	

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
• **Penyusunan struktur keluarga**: kemampuan dalam menentukan hubungan antar anggota keluarga secara tepat, termasuk hubungan orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya. • **Pengkajian riwayat penyakit keluarga**: peserta mampu mengidentifikasi adanya penyakit kronis atau riwayat kesehatan yang relevan dalam keluarga. • **Identifikasi hubungan emosional dalam keluarga:** hubungan harmonis, konflik, atau hubungan yang renggang antar anggota keluarga. • **Ketepatan penggunaan simbol genogram**: kemampuan peserta dalam menerapkan standar simbolisasi secara benar. • **Kerapihan dan sistematika gambar** b. Ecomap • **Identifikasi sistem eksternal**, : mengenali berbagai sistem yang berinteraksi dengan keluarga, seperti fasilitas kesehatan, lingkungan sosial, pekerjaan, dan keluarga besar. • **Pengkajian hubungan dengan lingkungan**, yaitu kemampuan menggali bagaimana interaksi antara keluarga dengan sistem eksternal tersebut. • **Identifikasi dukungan sosial**, yaitu kemampuan peserta dalam mengenali sumber dukungan yang tersedia bagi keluarga. • **Penilaian kekuatan hubungan**, yaitu kemampuan menentukan apakah						

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
hubungan tersebut bersifat kuat, lemah, atau konflik. • **Identifikasi arah aliran energi**, yaitu kemampuan menilai apakah hubungan tersebut bersifat memberi, menerima, atau timbal balik dalam hal dukungan. • **Ketepatan penggunaan simbol ecomap**, termasuk garis hubungan dan arah interaksi yang digunakan secara benar.						
3. Perilaku Profesional Aspek ini menilai kemampuan peserta ujian dalam menunjukkan profesionalisme dengan baik sesuai prinsip etik dan legal, di antaranya memperkenalkan diri, meminta persetujuan tindakan, berkomunikasi terapeutik dengan keluarga, menjaga kenyamanan dan keamanan klien, menjaga privasi, serta melakukan tindakan dengan hati-hati, teliti, dan responsif. Perhatikan deskripsi performa untuk masing-masing skor.					2	

II. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
1. Komunikasi	Apabila peserta tidak melakukan komunikasi dengan klien atau komunikasi yang dilakukan sangat minimal sehingga tidak terjadi interaksi yang bermakna. Peserta tidak	Apabila peserta melakukan komunikasi, namun tidak bersifat terapeutik. Komunikasi cenderung satu arah, menggunakan bahasa yang kurang sesuai atau sulit	Apabila peserta telah melakukan komunikasi terapeutik, namun belum konsisten. Peserta sudah melakukan salam, perkenalan, dan menjelaskan tujuan, namun masih terdapat	apabila peserta mampu melakukan komunikasi terapeutik secara efektif, sistematis, dan konsisten. Peserta membuka interaksi dengan baik, menggunakan bahasa yang

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
	melakukan salam, tidak memperkenalkan diri, dan tidak menjelaskan tujuan tindakan.	dipahami, tidak menunjukkan empati, serta tidak mampu membangun hubungan dengan klien. Teknik komunikasi seperti pertanyaan terbuka, klarifikasi, atau refleksi tidak digunakan atau digunakan secara tidak tepat.	kekurangan seperti kurangnya eksplorasi, penggunaan teknik komunikasi yang terbatas, atau respons terhadap perasaan klien yang kurang mendalam. Hubungan dengan klien sudah terbentuk tetapi belum optimal.	jelas dan mudah dipahami, menunjukkan empati, serta mampu menggunakan teknik komunikasi seperti pertanyaan terbuka, klarifikasi, dan refleksi secara tepat. Peserta juga mampu membangun hubungan saling percaya dan menutup interaksi dengan baik.
2. Pengkajian Keperawatan	Peserta tidak melakukan pengkajian sama sekali atau tidak mampu menggali informasi yang relevan dengan kasus. Tidak ada data yang diperoleh dan tidak ada upaya untuk menyusun genogram atau ecomap	Peserta melakukan pengkajian, namun data yang diperoleh tidak sesuai dengan kebutuhan kasus atau sangat tidak lengkap. Peserta tidak mampu mengidentifikasi struktur keluarga atau hubungan dengan	Peserta telah melakukan pengkajian dan memperoleh sebagian data yang relevan, namun masih terdapat kekurangan dalam kelengkapan, kedalaman, atau sistematika. Peserta mampu menggambarkan genogram atau ecomap, tetapi masih	Peserta mampu melakukan pengkajian secara lengkap, sistematis, dan sesuai dengan kasus. Peserta berhasil menggali informasi yang relevan terkait struktur keluarga, hubungan emosional, riwayat penyakit, serta hubungan dengan sistem

KOMPETENSI	SKOR 0	SKOR 1	SKOR 2	SKOR 3
		lingkungan secara jelas, serta penggunaan simbol genogram/ecomap tidak tepat atau tidak sesuai standar.	terdapat kesalahan dalam hubungan, simbol, atau interpretasi data.	eksternal. Genogram atau ecomap yang dibuat jelas, tepat, dan menggunakan simbol sesuai standar.
3. Perilaku Profesional	Tidak menunjukkan perilaku profesional, tidak memperkenalkan diri, tidak meminta persetujuan, tidak menjaga privasi, dan tidak memperhatikan keamanan maupun kenyamanan pasien.	Menunjukkan sebagian kecil perilaku profesional, tetapi masih kurang dalam komunikasi terapeutik, persetujuan tindakan, privasi, atau keselamatan pasien.	Menunjukkan perilaku profesional yang cukup baik, komunikasi terapeutik cukup jelas, memperhatikan privasi, kenyamanan, dan keamanan pasien, namun masih ada kekurangan kecil dalam sikap atau sistematika tindakan.	Menunjukkan perilaku profesional secara konsisten, meliputi komunikasi terapeutik yang baik, memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menjaga privasi, memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak serta ibu, bersikap teliti, hati-hati, responsif, dan etis selama tindakan.

III. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
0	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
1	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
2	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
3	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)*

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pengkajian Keluarga : Penyusunan Genogram dan Ecomap

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga Kelolaan
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan mahasiswa dalam melakukan pengkajian keluarga dan menyusun genogram serta ecomap. Penilaian dilakukan secara real-time saat mahasiswa berinteraksi dengan klien standar, menggunakan instrumen yang terstruktur dan skala penilaian yang telah ditentukan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam melakukan komunikasi terapeutik, menggali data keluarga secara sistematis, serta menyusun genogram dan ecomap secara tepat. Selain itu, penilaian juga bertujuan untuk menilai sikap profesional mahasiswa dalam berinteraksi dengan klien.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Mahasiswa dihadapkan pada kasus keluarga Bapak Ahmad, seorang laki-laki usia 58 tahun dengan riwayat Diabetes Mellitus. Mahasiswa diminta melakukan pengkajian keluarga untuk mengidentifikasi struktur keluarga, hubungan antar anggota keluarga, serta hubungan keluarga dengan lingkungan eksternal. Data yang diperoleh kemudian digunakan

		untuk menyusun genogram dan ecomap.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Kemampuan mahasiswa dalam membuka komunikasi dengan klien, melakukan wawancara untuk menggali data keluarga, mengidentifikasi hubungan emosional dalam keluarga, serta mengeksplorasi hubungan keluarga dengan sistem eksternal. Selain itu, mahasiswa juga diamati dalam menyusun genogram dan ecomap berdasarkan data yang diperoleh, serta dalam menjelaskan hasil pengkajian kepada klien.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	komunikasi terapeutik, kelengkapan dan ketepatan pengkajian, kemampuan analisis hubungan keluarga dan lingkungan, ketepatan penggunaan simbol genogram dan ecomap, serta perilaku profesional. Penilaian dilakukan menggunakan skala 0–3 berdasarkan tingkat pencapaian kompetensi mahasiswa.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memfokuskan observasi pada proses interaksi mahasiswa dengan klien, termasuk cara mahasiswa membangun hubungan, menggali informasi secara sistematis, serta menginterpretasikan data yang diperoleh. Selain itu, pembimbing juga memperhatikan ketepatan mahasiswa dalam menyusun genogram dan ecomap serta konsistensi sikap profesional selama proses berlangsung.

Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Setelah kegiatan observasi, pembimbing memberikan umpan balik secara langsung kepada mahasiswa. Umpan balik diberikan secara spesifik, konstruktif, dan berimbang antara kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Mahasiswa juga didorong untuk melakukan refleksi terhadap performanya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Keputusan penilaian ditentukan berdasarkan akumulasi skor dari seluruh aspek yang dinilai. Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mencapai nilai sesuai standar yang telah ditetapkan (misalnya ≥80%). Apabila belum mencapai standar, mahasiswa diberikan kesempatan untuk perbaikan melalui latihan ulang atau remediasi.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Dalam kerangka Outcome-Based Education (OBE), DOPS berperan sebagai alat untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran secara langsung dan autentik. Penilaian ini memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkannya dalam praktik. Dengan demikian, DOPS mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang terukur, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan praktik keperawatan.

Portofolio

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga Kelolaan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Portofolio digunakan untuk mendokumentasikan kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian keluarga, khususnya dalam menyusun genogram dan ecomap. Portofolio tidak hanya menampilkan hasil akhir, tetapi juga proses belajar, refleksi diri, serta umpan balik dari pembimbing
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan pengkajian keluarga dan menyusun genogram dan ecomap, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan melakukan pengkajian, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada keluarga.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus keluarga dan membuat genogram dan ecomap.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko	Mahasiswa merefleksikan pentingnya melakukan pengkajian dalam keluarga, menyusun

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga Kelolaan
	keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	genogram untuk mengidentifikasi struktur, komposisi, dan masalah kesehatan internal keluarga, dan menyusun ecomap untuk mengidentifikasi hubungan keluarga dengan eksternal
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan keluarga, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menyusun genogram dan ecomap
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus tapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan anak secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian pada keluarga, melakukan komunikais terapeutik, serta menyusun genogram dan ecomap
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang	Dalam pendekatan Outcome-Based Education (OBE), portofolio ini menjadi bukti pencapaian capaian pembelajaran mahasiswa secara nyata. Portofolio memungkinkan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kemampuan mahasiswa,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga Kelolaan
	berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	tidak hanya dari aspek kognitif, tetapi juga keterampilan dan sikap. Dengan demikian, portofolio berperan penting dalam memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar praktik keperawatan.

H. Redflag

Red Flags	**Makna Klinis**	**Tindakan Eskalasi**
Data keluarga tidak lengkap atau tidak konsisten	Risiko kesalahan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan keluarga	Lakukan pengkajian ulang secara sistematis dan verifikasi data dengan anggota keluarga lain
Komunikasi terapeutik tidak optimal (klien tertutup/tidak nyaman)	Data yang diperoleh tidak valid dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya	Perbaiki teknik komunikasi terapeutik, gunakan pendekatan empatik dan lingkungan yang nyaman
Tidak menggali hubungan emosional keluarga	Masalah psikososial (konflik, stres) tidak teridentifikasi	Lakukan eksplorasi lebih mendalam menggunakan pertanyaan terbuka dan observasi
Bias atau asumsi dalam pengkajian	Diagnosis keperawatan berpotensi tidak akurat	Lakukan klarifikasi dan validasi data langsung kepada keluarga
Struktur keluarga dalam genogram tidak akurat	Kesalahan dalam memahami sistem keluarga	Perbaiki genogram dengan mengacu pada data valid dan konfirmasi ulang
Simbol genogram tidak sesuai standar	Interpretasi genogram menjadi salah	Gunakan standar simbol genogram dan lakukan pembimbingan

Hubungan emosional tidak tergambar dalam genogram	Konflik atau dukungan keluarga tidak teridentifikasi	Tambahkan simbol hubungan (harmonis, konflik, putus) sesuai data
Riwayat penyakit keluarga tidak dicantumkan	Risiko genetik/penyakit kronis tidak terdeteksi	Lengkapi data riwayat kesehatan keluarga minimal 3 generasi
Sistem eksternal pada ecomap tidak lengkap	Sumber daya dan dukungan tidak terpetakan	Identifikasi ulang hubungan dengan layanan kesehatan, tetangga, dan lingkungan
Arah dan kekuatan hubungan pada ecomap tidak jelas	Tidak dapat menentukan dukungan atau stresor utama	Gunakan garis hubungan (kuat, lemah, stres) secara tepat
Ketidaksesuaian antara data dan genogram/ecomap	Analisis tidak berbasis data → risiko kesalahan intervensi	Lakukan review dan sinkronisasi antara hasil pengkajian dan visualisasi
Tidak mengidentifikasi risiko dan kebutuhan keluarga	Intervensi keperawatan tidak tepat sasaran	Lakukan analisis data secara komprehensif (kesehatan, sosial, lingkungan)
Tidak memanfaatkan hasil genogram & ecomap untuk analisis	Alat hanya menjadi formalitas, tidak berdampak klinis	Diskusikan hasil dengan pembimbing dan gunakan untuk menentukan prioritas masalah

Form Checklist

Bab **Pengkajian Keluarga: Genogram, Ecomap, Risiko, dan Kebutuhan**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah mampu melakukan komunikasi terapeutik saat pengkajian keluarga	☐	☐	
2	Saya sudah mampu mengumpulkan data keluarga secara lengkap dan sistematis	☐	☐	
3	Saya sudah mampu mengidentifikasi struktur keluarga	☐	☐	
4	Saya sudah mampu mengidentifikasi peran dan fungsi anggota keluarga	☐	☐	
5	Saya sudah mampu menggali hubungan emosional antar anggota keluarga	☐	☐	
6	Saya sudah mampu mengidentifikasi masalah kesehatan dalam keluarga	☐	☐	
7	Saya sudah mampu mengidentifikasi faktor risiko (kesehatan, sosial, lingkungan)	☐	☐	
8	Saya sudah mampu menyusun genogram sesuai standar simbol	☐	☐	
9	Saya sudah mampu menggambarkan 3 generasi dalam genogram	☐	☐	
10	Saya sudah mampu menampilkan hubungan emosional dalam genogram	☐	☐	
11	Saya sudah mampu menyusun ecomap keluarga	☐	☐	
12	Saya sudah mampu mengidentifikasi sistem eksternal (layanan kesehatan, sosial, lingkungan)	☐	☐	
13	Saya sudah mampu menggambarkan kekuatan dan arah hubungan dalam ecomap	☐	☐	

14	Saya sudah mampu menginterpretasikan genogram dan ecomap untuk analisis masalah	☐	☐	
15	Saya sudah mampu menunjukkan sikap profesional (empati, etika, komunikasi efektif)	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Rangkuman Materi

Pengkajian keluarga merupakan tahap awal yang esensial dalam proses keperawatan komunitas yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi kesehatan, struktur, fungsi, serta dinamika dalam keluarga. Melalui pengkajian yang sistematis, perawat dapat mengidentifikasi masalah kesehatan aktual maupun potensial, serta faktor risiko yang memengaruhi kesejahteraan anggota keluarga. Proses ini menuntut kemampuan komunikasi terapeutik, observasi, dan analisis data yang komprehensif agar informasi yang diperoleh akurat dan relevan dengan kondisi nyata keluarga.

Dalam praktiknya, genogram dan ecomap menjadi alat bantu penting dalam memetakan struktur keluarga serta hubungan dengan lingkungan eksternal. Genogram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar anggota keluarga lintas generasi, termasuk aspek biologis, psikologis, dan sosial. Sementara itu, ecomap berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan keluarga dengan berbagai sistem eksternal seperti fasilitas kesehatan, lingkungan sosial, pekerjaan, dan sumber dukungan lainnya. Kedua alat ini membantu perawat memahami pola interaksi yang memengaruhi kesehatan keluarga secara lebih mendalam.

Melalui penggunaan genogram dan ecomap, perawat dapat memetakan relasi keluarga secara lebih jelas, termasuk hubungan harmonis, konflik, maupun keterbatasan dukungan. Selain itu, alat ini juga memungkinkan identifikasi sumber daya yang dimiliki keluarga, baik internal maupun eksternal, seperti dukungan keluarga besar, tetangga, maupun akses terhadap layanan kesehatan. Dengan demikian, perawat dapat melihat kekuatan dan kelemahan sistem keluarga secara komprehensif.

Berdasarkan data pengkajian yang diperoleh, perawat kemudian dapat mengidentifikasi berbagai risiko dan kebutuhan keluarga, baik dalam aspek kesehatan, sosial, maupun lingkungan. Misalnya, risiko penyakit kronis, keterbatasan akses layanan kesehatan, atau kurangnya dukungan sosial.

Identifikasi ini menjadi dasar dalam perencanaan intervensi keperawatan yang tepat, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan spesifik keluarga.

Dalam seluruh proses tersebut, perawat dituntut untuk menunjukkan perilaku profesional yang mencakup sikap empatik, menghargai privasi dan kerahasiaan klien, serta menjunjung tinggi etika profesi. Profesionalisme juga tercermin dalam kemampuan berkomunikasi secara efektif, bersikap objektif, dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan. Dengan mengintegrasikan pengkajian yang komprehensif, penggunaan genogram dan ecomap, serta perilaku profesional, perawat dapat memberikan asuhan keperawatan keluarga yang holistik dan berkualitas.

Sebagai penutup, mempelajari pengkajian keluarga beserta penggunaan genogram dan ecomap menjadi sangat penting, baik secara teori maupun praktik. Pemahaman teoretis memberikan landasan konseptual yang kuat, sementara keterampilan praktik memungkinkan mahasiswa mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Integrasi keduanya akan membentuk kompetensi yang utuh, sehingga calon perawat mampu memberikan asuhan yang tepat, efektif, dan berpusat pada keluarga dalam berbagai konteks pelayanan kesehatan.

J. Daftar Pustaka

Barbosa, N. G., Zanetti, A. C., & Souza, J. d. (2021). Genogram and ecomap as ludic strategies for teaching nursing in Primary Health Care. *Rev Bras Enferm. 2021;74(3):e20201106.*

Friedman, M. M. (2010). *Buku Ajar keperawatan keluarga Riset, teori, Praktik.* Jakarta: EGC.

Joseph, B., Dickenson, S., McCall, A., & Roga, E. (2023). Exploring the Therapeutic Effectiveness of Genograms in Family Therapy: A Literature Review. *The Family Journal, 31(1).*, 21-30.

Kaakinen, J. R., Coehlo, D. P., Steele, R., Tabacco, A., & Hanson, S. M. (2015). *Family Health Care Nursing : Theory, Practice, Research.* Philadelpia: FA Davis Company.

Mathiasen, M., Kjærgaard, S. S., & Piil, K. (2023). A PERSON-CENTRED PRACTICE: EXPLORING FAMILY STRENGTH BY USING GENOGRAMS AND ECOMAPS. *euro-Oncology, Volume 25, Issue Supplement_2, September 2023, Page ii133, https://doi.org/10.1093/neuonc/noad137.450*.

Shajani, Z., & Snell, D. (2023). *Wright & Leahey's Nurses and families : a Guide to family Assessment and Intervention.* Philadelpia: FA Davis.

Wright, L. M., & Leahey, M. (2019). *Nurses and Families : A Guide to Family Asessment and Intervention.* FA Davis Company: Philadelphia.

BAB 4

DIAGNOSA KEPERAWATAN KELUARGA DAN PERENCANAAN ASUHAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor.	CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi).	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menguasai konsep, ruang lingkup, peran perawat, serta prinsip etika-legal dan keselamatan dasar dalam keperawatan komunitas dan keluarga.
CPMK-2	Menganalisis PHC, determinan sosial kesehatan, dan equity untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan kebutuhan prioritas.
CPMK-3	Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi.
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian komunitas dan keluarga secara sistematis (data, pemetaan, risiko, genogram/ecomap) secara etis dan akurat.
CPMK-5	Merumuskan diagnosa keperawatan komunitas dan keluarga serta menetapkan prioritas masalah berbasis data dan partisipasi klien.
CPMK-6	Menyusun perencanaan intervensi/program dan asuhan keluarga (home visit, kemitraan, manajemen kasus, rujukan) yang terukur dan feasible.
CPMK-7	Melaksanakan implementasi–evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan outcome komunitas/keluarga untuk continuity of care dan perbaikan mutu.

Uraian Materi

A. Diagnosa Keperawatan Keluarga

Diagnosa keperawatan keluarga dirumuskan dari hasil pengkajian terhadap adanya masalah yang didapatkan dari hasil pengkajian keperawatan keluarga baik berasal dari tahap perkembangan keluarga, lingkungan keluarga, struktur keluarga, fungsi keluarga, dan koping keluarga.

Diagnosa keperawatan merupakan penilaian klinis terhadap pengalaman atau respon individu, keluarga, atau komunitas pada masalah Kesehatan , pada risiko Kesehatan atau pada proses kehidupan (SDKI, 2017). Diagnosa keperawatan memiliki tujuan mengidentifikasi respon klien (individu, keluarga, dan Masyarakat) terhadap situasi yang berkaitan dengan kesehatan

B. Langkah-Langkah Merumuskan Diagnosa Keperawatan Keluarga

Untuk dapat merumuskan diagnosa keperawatan keluarga, perawat perlu melakukan proses beberapa langkah yang harus dilakukan yaitu:

1. Pengkajian Keperawatan Keluarga
   a. Pengumpulan Data
      Langkah ini yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau pengkajian berupa data subjektif dan objektif
   b. Analisis Data
      Langkah selanjutnya mengelompokkan data yang relevan (data subjektif dan objektif) dengan mengidentifikasi adanya kesenjangan atau masalah (data abnormal)
   c. Validasi Data
      Langkah ini memastikan data yang dikumpulkan akurat dan relevan
2. Perumusan Diagnosa Keperawatan Keluarga
   a. Klasifikasi masalah
      Pada Langkah ini menentukan sifat masalah, yaitu actual, risiko tinggi, atau wellness/promosi kesehatan
   b. Identifikasi penyebab
      Langkah ini menemukan alas an ketidakmampuan keluarga dalam melaksanakan tugas Kesehatan misalnya ketidakmampuan mengenal masalah, mengambil Keputusan, kemampuan merawat, memodifikasi lingkungan , dan memanfaatkan fasilitas kesehatan

3. Perumusan Diagnosa

   Untuk memudahkan merumuskan diagnosa maka perawat membuat table sebagai berikut:

   Tabel: Analisa Data

No	Sign/Symptom	Problem
	Data Subjektif (DS) Data Objektif (DO)	

   Sign/Symptom : isilah dengan tanda atau gejala yang didukung data baik data subjektif atau data objektif

   Problem : isilah dengan rumusan diagnosa keperawatan berdasarkan NANDA atau SDKI

   Pada tahap akhir setelah mengisi seluruh kolom tersebut, maka gabungkanlah pernyataan tersebut menjadi rumusan diagnosa, mulai dari problem, etiologi dan sign/symptom

C. Jenis-Jenis diagnosa keperawatan keluarga:

1. Diagnosa keperawatan keluarga bersifat aktual

   Disagnosa ini menggambarkan respon keluarga terhadap kondisi kesehatan atau proses kehidupannya yang menyebabkan keluarga mengalami masalah kesehatan. Sign/Symptom (Tanda/gejala) ditemukan dan divalidasi pada keluarga

2. Diagnosa keperawatan keluarga bersifat risiko

   Diagnosa ini menggambarkan respons keluarga terhadap kondisi Kesehatan atau proses kehidupannya yang dapat menyebabkan klien berisiko mengalami masalah Kesehatan. Tidak ditemukan adanya Sign/Symptom (Tanda/gejala), namun klien atau keluarga memiliki factor risiko mengalami masalah kesehatan

3. Diagnosa keperawatan keluarga bersifat sejahtera

   Diagnosa ini menggambarkan adanya keinginan dan motivasi klien atau keluarga untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke Tingkat yang lebih baik atau optimal

D. Contoh Diagnosa Keperawatan Keluarga

Katagori	Subkatagori	Nomor Kode	Rumusan Diagnosa Keperawatan
Perilaku	Penyuluhan dan Pembelajaran	D.0115	Manajemen Kesehatan Keluarga Tidak Efektif
		D.0116	Manajemen Kesehatan Tidak Efektif
		D.0117	Pemeliharaan Kesehatan Tidak Efektif
Relasional	Interaksi sosial	D.0128	Risiko Proses Pengasuhan Tidak Efektif
		D.0123	Kesiapan Peningkatan Proses Keluarga
		D.0122	Kesiapan Peningkatan Menjadi Orang Tua
		D.0120	Gangguan Proses Keluarga
		D.0124	Ketegangan Peran Pemberi Asuhan Keperawatan
		D.0126	Pencapaian Peran Menjadi Orang Tua
		D.0128	Risiko Proses Pengasuhan Tidak Efektif
Psikologis	Integritas Ego	D.0093	Ketidakmampuan Koping Keluarga
		D.0097	Penurunan Koping Keluarga
		D.0090	Kesiapan Peningkatan Koping Keluarga

E. Perencanaan Keperawatan Keluarga

Perencanaan asuhan keperawatan keluarga adalah proses Menyusun rencana Tindakan keperawatan keluarga yang dilakukan oleh perawat keluarga setelah melakukan pengkajian asuhan keperawatan keluarga (Swanson et al., 2021). Perencanaan keperawatan keluarga merupakan Kumpulan Tindakan yang ditentukan oleh perawat Bersama-sama sasaran, yaitu keluarga untuk dilaksanakan sehingga masalah Kesehatan dan masalah keperawatan yang telah diidentifikasi dapat diselesaikan (Susanto, 2021). Perencanaan keperawatan merupakan rincian kegiatan yang disusun sesuai dengan rumusan diagnose keperawatan yang telah

dirumuskan untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan serta menilai kemajuan peningkatan Kesehatan keluarga

Tujuan Perencanaan Keperawatan

Tujuan perencanaan keperawatan menurut PPNI (2018) adalah:

1. Menjadi panduan atau acuan bagi perawat dalam Menyusun Tindakan keperawatan
2. Meningkatkan otonomi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan
3. Memudahkan komunikasi intraprofesional dan interprofessional dengan menggunakan istilah intervensi keperawatan yang seragam dan terstandarisasi
4. Meningkatkan mutu asuhan keperawatan

Tahapan Menyusun Perencanaan Keperawatan Keluarga

Dalam Menyusun perencanaan keperawatan keluarga ada beberapa tahanpan yang harus dilakukan oleh seorang perawat yaitu:

1. Menetapkan perioritas masalah keperawatan

   Langkah pertama dalam menyusun perencanaan keperawatan yaitu menetapkan perioritas masalah atau diagnose perioritas terlebih dahulu dengan menggunakan skala penyususnan perioritas dari Maglaya (2009), yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.1: Skala perioritas asuhan keperawatan keluarga

No	Kriteria	Skor	Bobot	Nilai	Pembenaran
1.	Sifat Masalah • Aktual • Risiko • Keadaan sejahtera	 3 2 1	1		
2.	Kemungkinan masalah dapat diubah • Mudah • Sebagian • Tidak dapat	 2 1 0	2		
3.	Potensi maslah untuk dicegah • Tinggi • Cukup • Rendah	 3 2 1	1		
4.	Menonjolnya masalah				

	• Masalah dirasakan dan harus segera ditangani • Ada masalah tetapi tidak perlu ditangani • Masalah tidak dirasakan	2 1 0	1		
Jumlah					

Sumber: Maglaya (2009)

Skoring

a. Tentukan skor untuk setiap kriteria
b. Skor di bagi dengan makna tertinggi dan dikalikan dengan bobot

$$\frac{\text{Skor}}{\text{Angka Tertinggi}} \text{ X bobot}$$

c. Jumlahkan untuk semua nilai kriteria
d. Tentukan skor, nilai tertinggi menentukan urutan nomor perioritas diagnosa keperawatan keluarga

2. Menetapkan Tujuan Keperawatan

Menetapkan tujuan yang diharapkan dalam perencanaan keperawatan dapat menentukan keberhasilan menyelesaikan diagnosa keperawatan.

Tujuan keperawatan harus mempunyai status yang diinginkan yang dapat dicapai atau dipertahankan melalui program intervensi keperawatan (mandiri)(Carpenito, 1988). Tujuan keperawatan adalah pernyataan yang bersifat spesifik tentang hasil yang akan diharapkan dari intervensi keperawatan.

Tujuan keperawatan keluarga terdiri dari tujuan jangka panjang/umum dan tujuan jangka pendek/khusus. Tujuan jangka panjang/umum menggambarkan hasil akhir yang diharapkan dari penyelesaian masalah keperawatan atau ketercapaian menyelesaikan diagnose keperawatan. Tujuan jangka pendek/khusus mengambarkan ketercapaian akhir dari kriteria hasil dari masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan.

3. Menyususn Rencana Evaluasi

Dalah perencanaan keperawatan keluarga ada satu kegiatan sebelum menyusun intervensi atau rencana tindakan keperawatan yaitu menyususn rencana evaluasi yang menjadi alat kriteria dan standar ukur untuk mengukur ketercapaian setelah melakukan Tindakan keperawatan, yaitu sebagai berikut:

a. Evaluasi kriteria: merupakan rencana evaluasi setelah melakukan tindakan keperawatan yang diukur menggunakan kemampuan keluarga dalam

mengungkapkan kemampuannya (verbal), kemampuan perubahan sikap keluarga yang disampaikannya (sikap), dan kemampuan keterampilan dalam melakukan Tindakan perawatan keluarga (psikomotor)

b. Evaluasi standar: merupakan rencana evaluasi setelah melakukan tindakan keperawatan yang diukur menggunakan standar yang ditetapkan oleh perawat/kemampuan keluarga/teori

4. Menyusun Intervensi Keperawatan Keluarga

Menyusun intervensi keperawatan keluarga ini merupakan kegiatan akhir dari penyusunan rencana tindakan keperawatan. Intervensi keperawatan keluarga adalah Tindakan terencana untuk meningkatkan keluarga dalam mengatasi masalah Kesehatan anggota keluarganya melalui pendekatan mandiri, kolaborasi, dan edukasi.

Intervensi keperawatan disusun berdasarkan target capaian yang ingin dicapai pada tujuan khusus. Fokus utama intervensi ini adalah meningkatkan 5 tugas kesehatan keluarga: mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat, memodifikasi lingkungan, dan menggunakan fasilitas Kesehatan.

Tabel. Format Perencanaan Keperawatan

No	Diagnosa Kperawatan	Tujuan		Evaluasi		Intervensi
		Umum	Khusus	Kriteria	Standar	

F. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Bp. M (46 th) mempunyai seorang istri, Ibu S (40 th) dan 2 orang anak berumur 19 th laki-laki
bernama H dan D (12 th) perempuan. Bp. M bekerja sebagai buruh pabrik dengan penghasilan 1,2 juta per bulan. Bp. M menderita TB Paru dan *drop out* pengobatan. Sekarang Bp. M mengeluh sesak napas, batuk berdahak dan kepala pusing. Ibu S tidak tahu bagaimana perawatan TB Paru. D saat ini baru menstruasi, karena malu D cenderung pendiam dan menarik diri. Komunikasi di keluarga Bp. M kurang terbuka karena tidak tahu bagaimana cara dan manfaat komunikasi terbuka. Rumah Bp. M berukuran 5 x 8 m2, di lingkungan padat penduduk, ventilasi hanya

dari jendela dan pintu depan, di samping dan belakang tidak ada ventilasi. Sumber air minum dari PDAM, tidak memiliki jamban, keluarga memanfaatkan WC umum yang tidak jauh dari rumahnya. Keluarga pasrah dengan kondisi sakit Bp. M. Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan

1. Buatlah analisa data berdasarkan kasus tersebut?
2. Rumuskan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil analisa tersebut?
3. Lakukan Skoring pada masing-masing diagnosa yang sudah dirumuskan
4. Susunlah perencanaan keperawatannya?

G. Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab kala II

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Kala II

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
  OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Hand hygiene & pencegahan infeksi
- Identifikasi ibu & privasi
- Penilaian kesiapan kala II
- Eskalasi bila red flags muncul

Cuplikan Rubrik

Kriteria	4	3	2	1
Keselamatan pasien	Aman & konsisten	Minor	Risiko kecil	Tidak aman

Kriteria	4	3	2	1
Asesmen & keputusan	Tepat & jelas	Cuk up	Ragu	Keliru
Komunikasi	Empatik & jelas	Baik	Kurang	Buruk

Catatan untuk penulis:

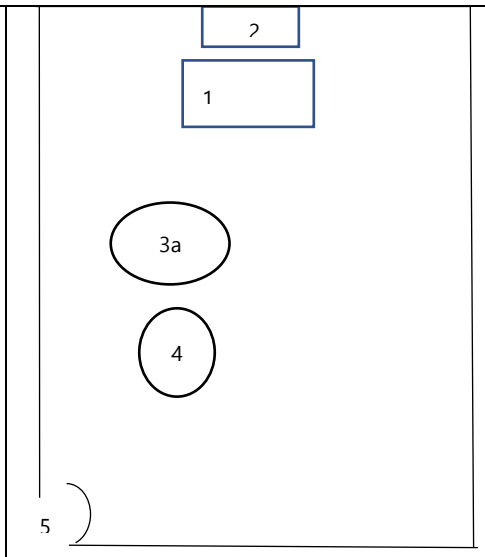
- Nilai tinggi tidak menutup kegagalan keselamatan

SOAL OSCE KEPERAWATAN
MK KELUARGA

1.	Nomor station	1
2.	Judul station	Kebutuhan Aman dan Nyaman Pada Kleuarga
3.	Waktu yang dibutuhkan	5 menit
4.	Tujuan station	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan pengkajian kemampuan keluarga, penegakkan diagnose keperawatan dan melakukan tindakan Pendidikan kesehatan tugas I
5.	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. **Pengkajian** 3. **Diagnosa dan Perencanaan** 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. **Perilaku Professional**
6.	Kategori	1. Oksigenasi 2. Sirkulasi 3. Cairan dan Elektrolit 4. Nutrisi **5. Aman dan nyaman** 6. Psikososial 7. Eliminasi 8. Aktivitas dan Istirahat 9. Seksual dan Reproduksi
7.	Instruksi untuk Peserta Ujian	**SKENARIO KLINIK:** Perawat melakukan kunjungan keluarga didapatkan seorang Ibu rumah tangga, umur 52 tahun, menderita Hipertensi sejak sebulan yang lalu, mengeluh sering sakit

		kepala sehingga tidurnya terganggu. Keluarga mengatakan sulit sekali mencegah Klien mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam, keluarga tidak memahami masalah kesehatan istrinya, keluarga hanya mengobati istrinya dengan membelikan obat sakit kepala di warung. Hasil Pemeriksaan: TD 150/80 mmHg, frekuensi nadi 98x/menit, skala nyeri 4 (dari 5 skala nyeri). **TUGAS :** 1. Sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan utama kasus tersebut 2. Susunlah dan sampaikan kepada penguji rencana keperawatan keluarga
8.	Instruksi untuk Penguji	Perawat melakukan kunjungan keluarga didapatkan seorang Ibu rumah tangga, umur 52 tahun, menderita Hipertensi sejak sebulan yang lalu, mengeluh sering sakit kepala sehingga tidurnya terganggu. Keluarga mengatakan sulit sekali mencegah Klien mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam, keluarga tidak memahami masalah kesehatan istrinya, keluarga hanya mengobati istrinya dengan membelikan obat sakit kepala di warung. Hasil Pemeriksaan: TD 150/80 mmHg, frekuensi nadi 98x/menit, skala nyeri 4 (dari 5 skala nyeri). **TUGAS :** 1. Sampaikan kepada penguji diagnosa keperawatan utama kasus tersebut 2. Susunlah dan sampaikan kepada penguji rencana keperawatan keluarga **INSTRUKSI PENGUJI:** 1. Menilai diagnosa keperawatan utama yang disampaikan peserta : - **Manajemen Kesehatan keluarga tidak efektif** 2. Penguji menilai penampilan peserta dalam melakukan Pendkes Hipertensi meliputi definisi, tanda dan gejala serta penyebab hipertensi

		3. Penguji tidak diperbolehkan melakukan intrupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan
9.	Instruksi untuk klien standar/ manekin	Pasien : KS Nama : sesuai KS Rentang usia : 52 tahun Jenis kelamin : Perempuan Pekerjaan : tidak bekerja Pendidikan terakhir : SMP Riwayat penyakit sekarang : Hipetensi sejak sebulan yang lalu - Keluhan utama : mengeluh sering sakit kepala - Keluhan lain : tidurnya sering terganggu gara gara sakit kepala - Kondisi fisik : klien terlihat lemah - Saat dilakukan pengkajian tugas I : Ks Hipertensi itu…yang saya ketahui tekanan darah tinggi ya?, gejalanya sakit kepala, suka kaku kuduk, klo penyebabnya sich katanya suka makan gorengan yang asin - Saat dilakukan Pengkajian tugas Ke 2 : KS Apay a?....saya tidak tahu - Saat dilakukan Pengkajian tugas Ke 3 : KS selama ini sich jika sakit kepala suka membeli obat di warung Yang tidak boleh dilakukan KS - Melakukan komunikasi dan berespon diluar skenario
10.	*Setting Station*:	**Setting ruangan** 1. Meja penguji 2. Kursi penguji 3a Kursi KS 4.Peserta ujian

		
11	Peralatan yang dibutuhkan	1. Setting ruangan tindakan 1 set 2. Meja dan kursi penguji 1 set 3. Meja /kursi KS 1 buah 4. Tensi meter dan stetoskop 1 buah
12.	Penulis	Tim OSCE
13.	Referensi	SDKI DPP PPNI 2016

H. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung asuhan kala II
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

I. Rangkuman Materi

Diagnosa keperawatan keluarga merupakan penilaian klinis yang disusun berdasarkan hasil pengkajian terhadap respons keluarga terhadap masalah kesehatan, risiko kesehatan, maupun proses kehidupan. Perumusannya harus didasarkan pada data subjektif dan objektif yang telah dikumpulkan, dianalisis, dan divalidasi. Selanjutnya, perawat mengidentifikasi masalah, penyebab, serta tanda dan gejala yang mendukung sehingga diagnosis yang ditetapkan benar-benar menggambarkan kondisi keluarga. Dalam proses tersebut, kemampuan keluarga dalam mengenali masalah, mengambil keputusan, melakukan perawatan, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam menentukan penyebab masalah keperawatan keluarga.

Diagnosa keperawatan keluarga dapat berupa diagnosis aktual, risiko, maupun sejahtera atau promosi kesehatan. Diagnosis aktual ditetapkan ketika telah ditemukan dan divalidasi tanda serta gejala, sedangkan diagnosis risiko digunakan apabila belum terdapat tanda dan gejala tetapi terdapat faktor yang meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah. Diagnosis sejahtera menunjukkan adanya motivasi keluarga untuk meningkatkan kondisi kesehatannya ke tingkat yang lebih optimal. Berbagai diagnosis dalam SDKI, seperti manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, gangguan proses keluarga, ketegangan peran pemberi asuhan, ketidakmampuan koping keluarga, dan kesiapan peningkatan koping keluarga, dapat digunakan sesuai hasil pengkajian dan kondisi yang ditemukan pada keluarga.

Setelah diagnosis ditetapkan, perawat menyusun perencanaan keperawatan keluarga secara sistematis bersama keluarga. Perencanaan dimulai dengan menentukan prioritas masalah berdasarkan sifat masalah, kemungkinan masalah dapat diubah, potensi masalah untuk dicegah, dan tingkat menonjolnya masalah. Setelah prioritas ditentukan, perawat menetapkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, menyusun kriteria serta standar evaluasi, kemudian menentukan intervensi keperawatan yang sesuai. Intervensi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam melaksanakan lima tugas kesehatan keluarga, yaitu mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Dengan perencanaan yang terstruktur, terukur, dan melibatkan keluarga secara aktif, asuhan keperawatan keluarga diharapkan mampu meningkatkan kemandirian keluarga, menyelesaikan masalah kesehatan secara lebih efektif, serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan keluarga secara berkelanjutan.

J. Daftar Pustaka

Friedman, M.F. 1998. Keperawatan keluarga. Teori dan praktik. Jakarta: EGC

Friedman, Marylin M. 2010. Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori, dan Praktik. EGC

Maglaya, A.S. 2009. Nursing Practice In the Community. Fifth edition : Tagayta City

Susanto. 2012. Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Aplikasi pada Praktik Keperawatan Keluarga. Jakarta: CV Trans Info Medika

Tim Pokja SDKI DPP PPNI, (2016), Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), Edisi 1, Jakarta, PersatuanPerawat Indonesia Tim Pokja SIKI DPP PPNI, (2018), Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI), Edisi 1, Jakarta, Persatuan Perawat Indonesia Tim Pokja SLKI DPP PPNI, (2018), Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI), Edisi 1, Jakarta, Persatuan Perawat Indonesia

BAB 5

HOME VISIT: KOMUNIKASI, EDUKASI, NEGOSIASI, DAN KESELAMATAN KUNJUNGAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor.
CPL-3	Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah.
CPL-4	Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian-diagnosa-perencanaan-implementasi-evaluasi).
CPL-5	Merancang intervensi promotif-preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan.
CPL-6	Melakukan dokumentasi, monitoring-evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga.

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-6	Menyusun perencanaan intervensi/program dan asuhan keluarga (home visit, kemitraan, manajemen kasus, rujukan) yang terukur dan feasible.

Uraian Materi

A. Definisi

Home visit adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara mengunjungi pasien langsung ke rumahnya, kunjungan ini bertujuan untuk menilai kondisi tempat tinggal, lingkungan sekitar, serta situasi keluarga pasien (Konlan et al., 2021). Melalui pendekatan ini, tenaga kesehatan dapat memahami kondisi pasien secara lebih menyeluruh karena dapat melihat langsung aspek fisik, psikologis, sosial, serta faktor lingkungan yang memengaruhi kesehatan pasien (Dobarrio-Sanz et al., 2023). Home visit menjadi bagian penting dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas, karena banyak masalah kesehatan berkaitan erat dengan kondisi rumah, kebiasaan hidup keluarga, dan dukungan sosial yang dimiliki pasien (Konlan et al., 2021). Dalam keperawatan komunitas, melakukan kunjungan rumah memungkinkan perawat melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi seperti kebersihan, sanitasi, ventilasi, serta hubungan antar anggota keluarga yang dapat berdampak pada kesehatan pasien (Dobarrio-Sanz et al., 2023).

Selain itu, kunjungan ini juga membantu tenaga kesehatan membangun hubungan terapeutik dengan pasien dan keluargnya, suasana rumah yang cenderung lebih nyaman membuat pasien dan keluarga lebih terbuka dalam menyampaikan masalah kesehatan, sehingga proses komunikasi dan edukasi kesehatan dapat berjalan lebih efektif (Soldado-Matoses et al., 2023). Hal ini membuat intervensi yang diberikan menjadi lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien.

Home visit sering digunakan untuk pemantauan pasien dengan penyakit kronis, lansia, ibu hamil, bayi dan balita, serta pasien dengan keterbatasan mobilitas yang sulit mengakses fasilitas kesehatan (Soldado-Matoses et al., 2023). Pelayanan ini juga digunakan untuk pemantauan kepatuhan pengobatan, pencegahan komplikasi penyakit, serta peningkatan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit (Kalhor et al., 2024). Komponen atau aspek penting yang harus diperhatikan oleh tenaga Kesehatan (misalnya perawat komunitas) saat melakukan kunjungan rumah, yaitu:

1. Komunikasi

Perawat memiliki peran penting sebagai edukator sekaligus fasilitator dalam komunikasi dengan keluarga pasien (Reblin et al., 2018). Perawat perlu memberikan penjelasan yang mudah dipahami kepada pasien dan keluarga

mengenai cara merawat pasien dengan aman, termasuk teknik perawatan, upaya pencegahan risiko, serta langkah yang harus dilakukan jika muncul masalah kesehatan. Komunikasi yang dilakukan sebaiknya bersifat dua arah dan berlangsung secara berkelanjutan (Höglander et al., 2020). Selain menyampaikan informasi, perawat juga perlu mendengarkan pengalaman, kendala, dan kebutuhan caregiver agar perawatan yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di rumah (Soldado-Matoses et al., 2023).

Kemampuan komunikasi yang baik sangat berpengaruh terhadap kualitas dan keselamatan perawatan. Dengan komunikasi yang efektif, pasien dan keluarganya akan lebih memahami prosedur perawatan sehingga dapat meminimalkan kesalahan maupun risiko cedera pada pasien (Soldado-Matoses et al., 2023). Perawat juga perlu menyesuaikan cara komunikasi dengan kondisi pasien dan lingkungan keluarga, seperti tingkat pendidikan, kondisi emosional, serta situasi sosial yang ada. Hal ini penting agar informasi yang diberikan benar-benar dipahami dan dapat diterapkan dengan baik (Soldado-Matoses et al., 2023).

2. Edukasi

Edukasi merupakan bagian penting dalam kunjungan rumah karena membantu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pasien serta keluarga dalam merawat kondisi kesehatan. Perawat tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membimbing caregiver agar mampu melakukan perawatan secara mandiri dan benar di rumah. Materi edukasi dapat meliputi cara perawatan pasien, penggunaan obat, pola makan, aktivitas fisik, serta tanda-tanda bahaya yang perlu diwaspadai. Edukasi yang dilakukan secara langsung di lingkungan rumah terbukti lebih efektif karena dapat disesuaikan dengan kondisi nyata yang dihadapi pasien dan keluarga (Day et al., 2018). Selain itu, edukasi dalam home visit juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan, mencegah komplikasi, serta memperkuat kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan jangka panjang (Shahriari et al., 2024).

3. Negosiasi (Shared Decision Making)

Pengambilan keputusan bersama atau shared decision making (SDM) menjadi bagian penting dalam kunjungan rumah karena melibatkan pasien dan keluarga dalam menentukan perawatan yang sesuai dengan kondisi dan preferensi mereka. Keputusan tidak hanya ditentukan oleh tenaga kesehatan, tetapi merupakan hasil diskusi antara perawat, pasien, dan keluarga (Oliver et al., 2019). Dengan adanya proses negosiasi ini, rencana perawatan yang

dihasilkan menjadi lebih realistis, dapat diterima oleh keluarga, serta lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Keselamatan Kunjungan (*Home Visit Safety*)

Keselamatan dalam kunjungan rumah merupakan upaya yang dilakukan tenaga kesehatan untuk melindungi diri sendiri, pasien, dan keluarga dari berbagai potensi risiko selama pelaksanaan pelayanan di rumah (Yoshimatsu & Nakatani, 2022). Berbeda dengan fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit, lingkungan rumah tidak sepenuhnya dapat dikendalikan sehingga perawat perlu mampu mengidentifikasi potensi bahaya serta melakukan manajemen risiko sebelum, selama, dan setelah kunjungan (Yoshimatsu & Nakatani, 2022).

Dalam praktik keperawatan komunitas, keselamatan kunjungan menjadi bagian penting dari upaya menjaga mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Perawat dituntut untuk mampu mengenali potensi risiko, mencegah terjadinya bahaya, serta mengambil tindakan yang tepat apabila terjadi insiden selama kunjungan (Yoshimatsu & Nakatani, 2022). Beberapa risiko yang sering ditemui selama home visit antara lain kondisi lingkungan yang kurang sehat, seperti kebersihan rumah yang buruk, ventilasi yang tidak memadai, adanya serangga, serta paparan asap rokok. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko infeksi maupun kecelakaan kerja. Selain itu, terdapat juga risiko terhadap keamanan pribadi, seperti lingkungan dengan tingkat kriminalitas tinggi atau keberadaan hewan peliharaan yang berpotensi membahayakan (Yoshimatsu & Nakatani, 2022).

B. Tujuan

Tujuan utama dari pelaksanaan *home visit* adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan pasien dan keluarganya melalui pelayanan yang diberikan langsung di rumah (Konlan et al., 2021). Dengan adanya kunjungan ini, tenaga kesehatan dapat melakukan pengkajian secara lebih menyeluruh terhadap kondisi pasien sekaligus melihat faktor lingkungan yang dapat memengaruhi kesehatannya, sehingga intervensi yang diberikan bisa lebih tepat sasaran (Dobarrio-Sanz et al., 2023).

Secara lebih rinci, *home visit* bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan pasien secara langsung, mengidentifikasi faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan, serta memberikan pelayanan dan perawatan di rumah. Selain itu, kunjungan rumah juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga, mendorong keterlibatan keluarga dalam proses

perawatan, serta mencegah terjadinya komplikasi melalui deteksi dini terhadap masalah kesehatan (Dobarrio-Sanz et al., 2023).

C. Indikasi

Home visit dilakukan pada kondisi pasien tertentu yaitu ketika pasien membutuhkan pemantauan kesehatan secara langsung di rumah atau mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan.

D. Kontraindikasi

Meskipun home visit memberikan banyak manfaat, terdapat beberapa kondisi yang menjadi kontraindikasi atau pertimbangan untuk menunda kunjungan rumah (Yoshimatsu & Nakatani, 2022), antara lain:

1. Lingkungan rumah yang tidak aman bagi tenaga kesehatan, seperti daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi atau adanya ancaman kekerasan.
2. Pasien atau keluarga menolak kunjungan rumah sehingga pelayanan kesehatan tidak dapat dilakukan.
3. Kondisi pasien membutuhkan perawatan intensif di rumah sakit sehingga tidak dapat ditangani melalui kunjungan rumah.
4. Tidak tersedianya sumber daya tenaga kesehatan yang memadai untuk melakukan kunjungan rumah.

Keselamatan tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam pelayanan kesehatan berbasis rumah karena lingkungan kerja di rumah pasien tidak dapat dikontrol sepenuhnya seperti di fasilitas kesehatan.

E. Alat dan Bahan

Peralatan yang digunakan dalam home visit harus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien. Beberapa alat yang umumnya digunakan antara lain: alat pelindung diri (masker, sarung tangan, *hand sanitizer*), alat pemeriksaan tanda vital, alat pemeriksaan tambahan sesuai kondisi pasien, media edukasi kesehatan (*leaflet, booklet*, poster), dan lembar pengkajian serta dokumentasi.

F. Persiapan Pasien, Perawat, dan Lingkungan

Sebelum melakukan kunjungan rumah, perawat harus melakukan persiapan yang matang untuk memastikan pelayanan kesehatan berjalan dengan baik, seperti mengkaji data pasien dari rekam medis, perawat memiliki tujuan melakukan home visit, menentukan waktu kunjungan, mempersiapkan alat dan bahan yang

dibutuhkan, serta mengidentifikasi potensi risiko keselamatan selama kunjungan. Pasien atau keluarga perlu diberi informasi mengenai rencana kunjungan rumah agar mereka dapat mempersiapkan diri menerima pelayanan kesehatan.

G. Hal yang Harus Diperhatikan

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan selama pelaksanaan home visit, seperti, menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pasien, menggunakan komunikasi yang efektif dan empatik, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh pasien, melibatkan keluarga dalam proses perawatan pasien, serta mengidentifikasi potensi risiko keselamatan selama kunjungan rumah. Komunikasi yang efektif antara perawat dan keluarga sangat penting untuk memastikan caregiver memahami cara merawat pasien dengan aman di rumah (Macías-Colorado et al., 2021).

H. Evaluasi Hasil

Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan pelayanan kesehatan yang diberikan selama kunjungan rumah. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan dapat membantu tenaga kesehatan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan berbasis rumah.

I. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan home visit karena berfungsi sebagai catatan resmi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien.

J. Aktivitas 1- Knows How

Mini-Case **(Diskusi kelompok)**

Setelah mengikuti aktivitas ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis situasi kunjungan rumah berdasarkan kasus yang diberikan.
2. Menentukan intervensi keperawatan komunitas yang tepat sesuai kondisi pasien dan keluarga.

Petunjuk Kegiatan:

1. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil
2. Setiap kelompok membaca dan menganalisis kasus yang diberikan.

3. Kelompok mendiskusikan pertanyaan yang tersedia dan menuliskan hasil diskusi.
4. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas.

Mini-Case

Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah kepada Ibu S (68 tahun) yang tinggal bersama anak perempuannya. Ibu S memiliki riwayat **hipertensi dan diabetes melitus** serta baru saja pulang dari rumah sakit setelah mengalami luka pada kaki akibat komplikasi diabetes. Selama kunjungan rumah, perawat menemukan beberapa kondisi berikut: Rumah pasien cukup sempit dan ventilasi kurang baik, pasien mengeluh nyeri pada luka di kaki dan tampak kurang memahami cara merawat luka, anak pasien terlihat cemas dan mengatakan bahwa ia belum pernah merawat luka sebelumnya, di dalam rumah terdapat beberapa hewan peliharaan yang sering berada di sekitar tempat tidur pasien, anak pasien mengatakan bahwa ia sulit mengikuti semua anjuran perawat karena harus bekerja di luar rumah. Perawat perlu melakukan pengkajian, memberikan edukasi, serta berdiskusi dengan pasien dan keluarga mengenai rencana perawatan yang dapat dilakukan di rumah.

Pertanyaan:

1. Identifikasi masalah kesehatan dan lingkungan yang ditemukan pada kasus di atas!
2. Edukasi apa saja yang perlu diberikan oleh perawat kepada pasien dan keluarga terkait kondisi pasien?

K. Aktivitas 2 - *Shows How*

Simulasi/*Skill Lab. Home Visit*

Setelah mengikuti kegiatan simulasi ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga selama kunjungan rumah.
2. Melakukan pengkajian kondisi kesehatan pasien dan lingkungan rumah.
3. Memberikan edukasi kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga.
4. Melakukan negosiasi atau pengambilan keputusan bersama mengenai rencana perawatan pasien.
5. Menerapkan prinsip keselamatan selama melakukan kunjungan rumah.

Metode Pembelajaran

Simulasi praktik dilakukan di laboratorium keterampilan (skills lab) menggunakan metode role play dengan melibatkan mahasiswa sebagai perawat, pasien, dan anggota keluarga.

Alat dan Bahan

Beberapa alat yang dapat digunakan dalam simulasi home visit antara lain:

1. Alat pemeriksaan tanda-tanda vital (tensimeter, stetoskop, termometer)
2. Sarung tangan medis dan masker
3. Media edukasi kesehatan (*leaflet* atau poster)
4. Lembar pengkajian kunjungan rumah
5. Peralatan perawatan luka sederhana (jika diperlukan dalam skenario)

Skenario Simulasi

Seorang mahasiswa berperan sebagai perawat komunitas yang melakukan kunjungan kepada Bapak A (60 tahun) yang mengalami hipertensi dan diabetes melitus. Bapak A tinggal bersama istrinya di rumah sederhana. Selama kunjungan rumah, dari hasil wawancara ditemukan beberapa kondisi bahwa pasien sering lupa minum obat secara teratur dan pola makan pasien tidak terkontrol karena sering mengonsumsi makanan tinggi gula serta istri pasien merasa kesulitan mengingatkan suaminya untuk mematuhi anjuran kesehatan. Selain itu, rumah pasien juga terlihat memiliki ventilasi yang kurang baik dan kondisi lingkungan kurang bersih.

Langkah Simulasi

1. **Persiapan**
    a. Mahasiswa mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk kunjungan rumah.
    b. Mahasiswa membaca skenarion kasus dan memahami tujuan kunjungan
2. **Pelaksanaan Simulasi**
    a. Mahasiswa memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarga.
    b. Menjelaskan tujuan kunjungan rumah.
    c. Melakukan pengkajian kondisi kesehatan pasien.
    d. Mengkaji kondisi lingkungan rumah yang dapat memengaruhi kesehatan.
    e. Memberikan edukasi kesehatan kepada pasien dan keluarga.
    f. Melakukan diskusi atau negosiasi mengenai rencana perawatan yang dapat dilakukan di rumah.
    g. Menutup kunjungan dengan menyimpulkan hasil kunjungan dan menjelaskan rencana tindak lanjut.

OSCE Keperawatan

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	.....
2	Judul station	Asuhan Keperawatan Komunitas pada lansia dengan penyakit kronis
3	Waktu yang dibutuhkan	13 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan komunikasi terapeutik, pengkajian fokus, serta edukasi Kesehatan terkait Hipertensi dan DM.
5	Kompetensi	1. **Komunikasi, edukasi, dan konseling** 2. **Pengkajian** 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. **Perilaku profesional**
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi **4. Aman dan nyaman** 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah kepada Ibu S (68 tahun) yang memiliki riwayat hiopertensi dan diabetes melitus. Ibu S tinggal bersama anak perempuannya. Saat kunjungan rumah, perawat menemukan beberapa kondisi yaitu pasien sering lupa minum obat secara teratur, pasien masih sering mengonsumsi makanan tinggi gula, rumah pasien memiliki ventilasi yang kurang baik serta anak pasien mengatakan bahwa ia kesulitan mengingatkan ibunya untuk mengikuti anjuran kesehatan.

		TUGAS: 1. Melakukan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga. 2. Melakukan pengkajian singkat kondisi pasien dan lingkungan rumah.
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah kepada Ibu S (68 tahun) yang memiliki riwayat hipertensi dan diabnetes melitus. Ibu S tinggal bersama anak perempuannya. Saat kunjungan rumah, perawat menemukan beberapa kondisi yaitu pasien sering lupa minum obat secara teratur, pasien masih sering mengonsumsi makanan tinggi gula, rumah pasien memiliki ventilasi yang kurang baik serta anak pasien mengatakan bahwa ia kesulitan mengingatkan ibunya untuk mengikuti anjuran kesehatan. TUGAS: 1. Melakukan komunikasi teraputik dengan pasien dan keluarga. 2. Melakukan pengkajian singkat kondisi pasien dan lingkungan rumah. INSTRUKSI PENGUJI: 1. Menilai kemampuan peserta dalam melakukan komunikasi terapeutik 2. Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian kondisi pasien 3. Monitor perilaku profesional peserta. 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Peran: perempuan pasien berumur 36 tahun. Duduk di samping pasien dengan terlihat sedikit cemas tetapi tetap kooperatif. Hal yang perlu disampaikan bila ditanya:

		- Ibu sering lupa minum obat - Ibu masih sering makan makanan manis - Saya bekerja sehingga tidak selalu bisa mengawasi ibu - Saya khawatir kondisi kesehatan ibu semakin memburuk Manikin dibutuhkan sebagai pasien
10	Setting station	Rumah pasien (simulasi di lab skill)
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Sarung tangan bersih 2. Kursi pasien dan keluarga 3. Alat pemeriksaan tanda vital 4. Leaflet edukasi Kesehatan 5. Hand sanitizer 6. Formulir pengkajian home visit Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	Aulya Kartini
13	Referensi	- Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI - Konlan, K. D., Vivor, N. K., Gegefe, I., Abdul-rasheed, I. A., Kornyo, B. E., & Kwao, I. P. (2021). The practice of home visiting by community health nurses as a primary healthcare intervention in a low-income rural Setting: A descriptive cross-sectional study in The Adaklu District of the Volta Region , Ghana. *The Scientific World Journal*, *2021*, 11. https://doi.org/10.1155/2021/8888845

Rubrik Penilaian

Kompetensi	SKOR (S)			
	0	1	2	3
Komunikasi, Edukasi, dan konseling	Tidak melakukan komunikasi verbal	Melakukan komunikasi verbal namun tidak tepat	Melakukan komunikasi tidak sistematis	Melakukan komunikasi dengan tepat dan sistematis
Pengkajian	Peserta ujian tidak melakukan sama sekali tindakan dari beberapa point secara keseluruhan	Peserta melakukan pengkajian 1-2 aspek dari point berikut: 1. Aspek kebersihan 2. Aspek ventilasi 3. Aspek sanitasi 4. Aspek potensi kesehatan	Peserta melakukan pengkajian 3-4 aspek dari point berikut: 1. Aspek kebersihan 2. Aspek ventilasi 3. Aspek sanitasi Aspek potensi kesehatan	Peserta melakukan pengkajian keseluruhan dari point berikut: 1. Aspek kebersihan 2. Aspek ventilasi 3. Aspek sanitasi Aspek potensi kesehatan
Sikap dan perilaku profesional:	Peserta ujian tidak meminta izin secara lisan dan sama sekali Tidak melakukan dari point keseluruhan.	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan 1-2 poin berikut: 1. Melakukan setiap 2. tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga 3. tidak membahayakan	Peserta ujian meminta izin secara lisan dan 3 poin berikut: 1. Melakukan setiap 2. tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga 3. tidak membahayakan klien dan diri sendiri 4. Memperhatikan	Peserta ujian meminta izin secara lisan dengan lengkap berikut: 1. Melakukan setiap 2. tindakan dengan berhati-hati dan teliti sehingga 3. tidak membahayakan

		klien dan diri sendiri 4. Memperhatikan kenyamanan klien 5. Melakukan tindakan sesuai prioritas 6. Menunjukan rasa hormat kepada klien 7. Menjaga privasi klien	kenyamanan klien 5. Melakukan tindakan sesuai prioritas 6. Menunjukan rasa hormat kepada klien 7. Menjaga privasi klien	klien dan diri sendiri 4. Memperhatikan kenyamanan klien 5. Melakukan tindakan sesuai prioritas 6. Menunjukan rasa hormat kepada klien 7. Menjaga privasi klien

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian anda secara umum terhadap kemampuan peserta ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skor}}{30} \times 100 =$$

L. Aktivitas 3 - DOES

DOPS di Lahan Praktik (*Home Visit)*

Komponen	Deskripsi	Home Visit
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan klinik nyata di lapangan. Penilaian dilakukan oleh dosen atau *Clinical Instructor* menggunakan checklist terstruktur dan dilanjutkan dengan umpan balik singkat.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan kunjungan rumah pada pasien dan keluarga yang mengalami masalah kesehatan atau membutuhkan edukasi kesehatan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam menerapkan keterampilan komunikasi terapeutik, edukasi kesehatan, dan negosiasi dalam konteks pelayanan kesehatan berbasis rumah (*home visit*).	Mahasiswa dinilai dari kemampuannya menjalin hubungan dengan keluarga, menggali masalah kesehatan, memberikan edukasi kesehatan, serta berdiskusi dengan keluarga mengenai rencana tindakan yang akan dilakukan.
Kasus praktik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di komunitas dan sesuai dengan capaian pembelajaran praktik keperawatan komunitas.	Mahasiswa melakukan home visit pada keluarga dengan balita yang sering mengalami diare. Ibu menyatakan anaknya sering BAB cair dan kurang nafsu makan.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan rangkaian kegiatan kunjungan rumah mulai dari membuka interaksi, melakukan pengkajian singkat, memberikan edukasi kesehatan, hingga melakukan diskusi rencana perawatan bersama keluarga.	Mahasiswa memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan home visit, menanyakan kondisi anak, memberikan edukasi tentang pencegahan diare dan pentingnya kebersihan tangan, serta mendiskusikan langkah yang dapat dilakukan keluarga

		untuk menjaga kesehatan anak.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi kemampuan komunikasi, kemampuan edukasi kesehatan, kemampuan negosiasi atau pengambilan keputusan bersama, sikap profesional, serta kemampuan membangun hubungan terapeutik dengan keluarga.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu berbicara dengan bahasa sederhana, mendengarkan keluhan keluarga, menjelaskan informasi kesehatan secara jelas, serta melibatkan keluarga dalam menentukan langkah perawatan yang dapat dilakukan di rumah.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa mahasiswa secara langsung selama kunjungan rumah, terutama pada aspek interaksi dengan pasien dan keluarga.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menciptakan komunikasi dua arah, memberikan edukasi yang mudah dipahami, serta melakukan negosiasi secara baik ketika keluarga memiliki pendapat atau kebiasaan yang berbeda terkait kesehatan.
Umpan balik	Setelah observasi selesai, pembimbing memberikan umpan balik yang bersifat singkat, spesifik, dan konstruktif untuk meningkatkan performa mahasiswa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah mampu membangun hubungan yang baik dengan keluarga, tetapi perlu meningkatkan kejelasan dalam menjelaskan langkah pencegahan diare atau memperdalam diskusi dengan keluarga mengenai kebiasaan sanitasi.
Keputusan penilaian	Hasil DOPS digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam melakukan home visit secara profesional dan aman.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan komunikasi efektif, memberikan edukasi yang benar, dan melakukan

		negosiasi dengan keluarga secara baik. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi masih membutuhkan arahan pada beberapa tahap kunjungan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.

Checklist DOPS

Nama Mahasiswa : _____

Tanggal : _____

Lokasi Home Visit : _____

Pembimbing/CI : _____

No	Aspek yang Dinilai	Ya	Tidak	Catatan
1	Mahasiswa memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan kunjungan rumah	☐	☐	
2	Mahasiswa menunjukkan sikap sopan, empati, dan menghargai keluarga	☐	☐	
3	Mahasiswa melakukan komunikasi dua arah dengan keluarga	☐	☐	
4	Mahasiswa menggali masalah kesehatan keluarga secara sistematis	☐	☐	
5	Mahasiswa memberikan edukasi kesehatan dengan bahasa yang mudah dipahami	☐	☐	
6	Mahasiswa memastikan keluarga memahami informasi yang diberikan	☐	☐	
7	Mahasiswa melibatkan keluarga dalam diskusi rencana perawatan	☐	☐	
8	Mahasiswa menunjukkan kemampuan negosiasi dengan keluarga	☐	☐	
9	Mahasiswa menjaga sikap profesional selama kunjungan	☐	☐	
10	Mahasiswa menutup kunjungan dengan merangkum informasi dan rencana tindak lanjut	☐	☐	

Keputusan Penilaian:

☐ Kompeten

☐ Perlu supervisi

☐ Remedial

M. Rangkuman Materi

Home visit merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan berbasis komunitas yang memungkinkan tenaga kesehatan, khususnya perawat, melakukan pengkajian dan intervensi secara langsung di lingkungan tempat tinggal pasien. Melalui kunjungan rumah, perawat dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi fisik, psikologis, sosial, keluarga, serta faktor lingkungan yang memengaruhi kesehatan pasien. Pendekatan ini sangat penting terutama bagi pasien dengan penyakit kronis, lansia, ibu hamil, bayi dan balita, pasien dengan keterbatasan mobilitas, maupun individu yang membutuhkan pemantauan berkelanjutan dan mengalami kesulitan mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

Keberhasilan *home visit* sangat dipengaruhi oleh kemampuan perawat dalam membangun komunikasi yang efektif, memberikan edukasi yang sesuai kebutuhan, serta melibatkan pasien dan keluarga dalam proses pengambilan keputusan. Komunikasi dua arah yang empatik membantu pasien dan keluarga lebih terbuka dalam menyampaikan kebutuhan dan hambatan, sedangkan edukasi yang diberikan secara langsung di rumah dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kepatuhan terapi, dan kemampuan *caregiver* dalam melakukan perawatan. Negosiasi melalui *shared decision making* juga penting agar rencana perawatan tidak hanya sesuai secara klinis, tetapi juga realistis, dapat diterima, serta dapat dilaksanakan sesuai kondisi, nilai, dan preferensi pasien serta keluarga.

Keselamatan kunjungan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan *home visit*. Lingkungan rumah tidak selalu dapat dikendalikan seperti fasilitas kesehatan sehingga perawat harus mampu melakukan identifikasi risiko sebelum, selama, dan setelah kunjungan. Potensi bahaya dapat berasal dari kondisi sanitasi dan ventilasi yang kurang baik, paparan asap rokok, keberadaan hewan, risiko infeksi, hingga ancaman terhadap keamanan tenaga kesehatan. Oleh karena itu, persiapan kunjungan harus mencakup penelaahan data pasien, penentuan tujuan kunjungan, kesiapan alat dan bahan, pemberitahuan kepada keluarga, serta pengkajian awal terhadap potensi risiko keselamatan.

Pelaksanaan *home visit* juga harus tetap memperhatikan privasi dan kerahasiaan pasien, penggunaan bahasa yang mudah dipahami, keterlibatan keluarga, evaluasi hasil, serta dokumentasi setiap pelayanan yang telah diberikan. Evaluasi diperlukan untuk menilai keberhasilan intervensi dan menentukan tindak lanjut, sedangkan dokumentasi menjadi bukti resmi sekaligus mendukung kesinambungan pelayanan. Dengan demikian, *home visit* bukan sekadar kunjungan ke rumah pasien, tetapi merupakan proses pelayanan keperawatan yang terencana, komunikatif, edukatif, kolaboratif, aman, dan berkesinambungan. Jika dilaksanakan secara tepat, kunjungan rumah dapat meningkatkan kemampuan pasien dan keluarga dalam merawat kesehatan, mencegah komplikasi, memperkuat hubungan terapeutik, serta meningkatkan mutu pelayanan keperawatan komunitas.

N. Daftar Pustaka

Day, C. B., Cristiane, C., Kottwitz, B., Oliveira, N., Mocellin, D., Predebon, M. L., Laís, F., Dal, F., Manganelli, L., & Paskulin, G. (2018). Nursing home care educational intervention for family caregivers of older adults post stroke (SHARE): Study protocol for a randomised trial. *BioMed Central*, *19*(96), 1–9. https://doi.org/10.1186/s13063-018-2454-5

Dobarrio-Sanz, I., Chica-p, A., Fern, C., Jim, M., & Ruiz-fern, M. D. (2023). Nurse Education Today Nursing students' experiences of a home visiting programme for older adults with multimorbidity (VISITAME project): A phenomenological study. *Nurse Education Today*, *128*(February). https://doi.org/10.1016/j.nedt.2023.105881

Höglander, J., Eklund, J. H., Spreeuwenberg, P., Eide, H., Sundler, A. J., Roter, D., & Holmström, I. K. (2020). Exploring patient-centered aspects of home care communication: A cross-sectional study. *BMC Nursing*, *19*(91), 1–10. https://doi.org/10.1186/s12912-020-00483-1

Kalhor, F., Shahzeydi, A., & Taghadosi, M. (2024). The impact of home care on individuals with failure: A comprehensive review. *ARYA Atheroscler*, *20*(3). https://doi.org/10.48305/arya.2024.42356.2931

Konlan, K. D., Vivor, N. K., Gegefe, I., Abdul-rasheed, I. A., Kornyo, B. E., & Kwao, I. P. (2021). The practice of home visiting by community health nurses as a primary healthcare intervention in a low-income rural Setting: A descriptive cross-sectional study in The Adaklu District of the Volta Region , Ghana. *The Scientific World Journal*, *2021*, 11. https://doi.org/10.1155/2021/8888845

Macías-Colorado, M. E., Rodríguez-Pérez, M., Rojas-Ocaña, M. J., & Teresa-Morales, C. (2021). Communication on safe caregiving between community nurse case managers and family caregivers. *Healthcare, 9*(2), 205.

Oliver, D. P., Washington, K., Demiris, G., Wallace, A., Propst, M. R., Uraizee, A. M., Craig, K., Clayton, M. F., Reblin, M., & Ellington, L. (2018). Shared decision making in home hospice nursing visits: A qualitative study. *Journal of Pain and Symptom Management, 55*(3), 922–929.

Reblin, M., Clayton, M. F., Xu, J., Hulett, J. M., Latimer, S., Gary, W., Ellington, L., City, S. L., & City, S. L. (2018). Caregiver, patient, and nurse visit communication patterns in cancer home hospice Maija. *Psychooncology*, *26*(12), 2285–2293. https://doi.org/10.1002/pon.4361.Caregiver

Shahriari, M., Nia, D. H., & Hashemi, M. S. (2024). Challenges of home care: A qualitative study. *BMC Nursing*, *23*, 215. https://doi.org/10.1186/s12912-024-01878-0

Soldado-Matoses, M. S., Caplliure-llopis, J., & Barrios, C. (2023). Effectiveness of a home health monitoring and education program for complex chronic patients, led by primary care nurses. *Frontiers in Public Health*, *November*, 1–13. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1281980

Yoshimatsu, K., & Nakatani, H. (2022). Attitudes of home-visiting nurses toward risk management of patient safety incidents in Japan. *BMC Nursing*, 1–11. https://doi.org/10.1186/s12912-022-00905-2

BAB 6

MANAJEMEN KASUS KELUARGA: KRONIK, KETERGANTUNGAN, DAN *CAREGIVER*

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor.	CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi).	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-5	Merumuskan diagnosa keperawatan komunitas dan keluarga serta menetapkan prioritas masalah berbasis data dan partisipasi klien.
CPMK-6	Menyusun perencanaan intervensi/program dan asuhan keluarga (home visit, kemitraan, manajemen kasus, rujukan) yang terukur dan feasible.
CPMK-7	Melaksanakan implementasi–evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan outcome komunitas/keluarga untuk continuity of care dan perbaikan mutu.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 13. Manajemen Kasus Keluarga (kronik, ketergantungan, caregiver)	13.1 Menyusun rencana manajemen kasus keluarga pada kondisi kronik/ketergantungan (goal, care plan, koordinasi).	13.2 Menyusun strategi dukungan caregiver (asesmen beban, peningkatan self-care, jejaring layanan).	CPMK-6	CPMK-5; CPMK-7

Tabel Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-5	Ujian kasus berbasis data (case-based test)	Diagnosa tepat (≥2) sesuai data; prioritas disusun dengan kriteria eksplisit; rasional didukung data/temuan pengkajian	15	Lembar diagnosa & prioritas + rasional
CPMK-6	Proyek perencanaan program/asuhan (proposal)	Tujuan SMART dan indikator jelas; intervensi sesuai prioritas dan sumber daya; rencana kemitraan/home visit/manajemen kasus tersusun operasional	15	Proposal program/asuhan + rencana kemitraan
CPMK-7	Laporan implementasi–evaluasi (mini-project/simulasi)	Monitoring proses terdokumentasi; evaluasi outcome menggunakan indikator; laporan memuat rekomendasi perbaikan dan rencana tindak lanjut/rujukan	15	Laporan Monev + format dokumentasi & rujukan

Tabel Rubrik CPMK (skala 1–4)

Rubrik CPMK-5

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan rumusan diagnosa	Tidak sesuai data/terlalu umum	Sebagian sesuai data namun masih ambigu	Sesuai data; rumusan jelas dan konsisten	Sangat tepat; membedakan masalah aktual/risiko; konsisten dengan terminologi
5.2 Penetapan prioritas & rasional berbasis data	Prioritas acak tanpa kriteria	Ada kriteria namun penerapan tidak konsisten	Prioritas logis dengan kriteria eksplisit dan data pendukung	Prioritas sangat kuat; mempertimbangkan equity, sumber daya, dan dampak; rasional meyakinkan

Rubrik CPMK-6

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Desain rencana intervensi/program/asuhan	Tujuan tidak jelas; indikator tidak ada	Tujuan cukup jelas; indikator/aktivitas belum selaras	Tujuan SMART; aktivitas dan indikator selaras; sumber daya teridentifikasi	Desain sangat kuat; ada mitigasi risiko, skenario alternatif, dan rencana keberlanjutan
6.2 Rencana kemitraan/home visit/manajemen kasus	Stakeholder tidak relevan; alur kerja tidak operasional	Stakeholder relevan namun pembagian peran kurang jelas	Stakeholder tepat; peran, koordinasi, dan alur kerja jelas	Kemitraan strategis; komunikasi-rujukan terintegrasi; keselamatan dan etika diantisipasi

Rubrik CPMK-7

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Monitoring proses & evaluasi outcome	Tidak ada indikator; evaluasi tidak berbasis data	Ada indikator namun pengukuran tidak konsisten	Monitoring dan evaluasi konsisten; outcome terukur	Evaluasi komprehensif; membandingkan baseline–hasil; menarik pelajaran untuk perbaikan
7.2 Dokumentasi, pelaporan, tindak lanjut/rujukan	Dokumentasi tidak lengkap; tindak lanjut tidak jelas	Dokumentasi cukup; tindak lanjut umum	Dokumentasi lengkap dan rapi; tindak lanjut/rujukan sesuai kriteria	Dokumentasi sangat baik; pelaporan komunikatif; ada umpan balik rujukan dan rencana continuity of care

Uraian Materi

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Manajemen Kasus Keluarga

Perubahan pola penyakit di masyarakat menyebabkan pelayanan kesehatan tidak lagi hanya berfokus pada penanganan penyakit akut, tetapi juga semakin diarahkan pada pengelolaan penyakit kronik dan kebutuhan perawatan jangka panjang. Berbagai kondisi seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, stroke, penyakit ginjal kronik, penyakit paru kronik, kanker, gangguan neurologis, dan penyakit degeneratif dapat berlangsung dalam waktu lama serta menimbulkan perubahan pada kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut sering kali tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelayanan di fasilitas kesehatan, karena sebagian besar proses perawatan berlangsung di rumah dan melibatkan keluarga secara langsung.

Penyakit kronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan penyakit akut. Pada penyakit akut, intervensi kesehatan umumnya diarahkan untuk mengatasi masalah dalam waktu relatif singkat. Sebaliknya, penyakit kronik membutuhkan pemantauan terus-menerus, pengobatan jangka panjang, perubahan gaya hidup, pengendalian faktor risiko, pencegahan komplikasi, serta kemampuan pasien dan keluarga dalam mempertahankan kondisi kesehatan. Dalam banyak kasus, pasien juga mengalami keterbatasan mobilitas, penurunan fungsi fisik, gangguan kognitif, atau ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi tersebut menyebabkan keluarga harus mengambil bagian yang semakin besar dalam proses perawatan.

Keluarga merupakan unit sosial terdekat yang memiliki peran penting dalam menjaga, mempertahankan, dan meningkatkan kesehatan anggotanya. Ketika salah satu anggota keluarga mengalami penyakit kronik atau ketergantungan, perubahan tidak hanya terjadi pada pasien, tetapi juga memengaruhi seluruh sistem keluarga. Pembagian peran dapat berubah, tanggung jawab anggota keluarga meningkat, kebutuhan ekonomi bertambah, waktu untuk bekerja atau beraktivitas dapat berkurang, dan hubungan antaranggota keluarga dapat mengalami penyesuaian. Oleh karena itu, penanganan pasien kronik tidak cukup jika hanya berorientasi pada kondisi klinis individu. Pendekatan yang digunakan perlu mempertimbangkan

kemampuan, kebutuhan, sumber daya, dan dinamika keluarga sebagai satu kesatuan.

Dalam konteks tersebut, manajemen kasus keluarga menjadi salah satu pendekatan penting dalam keperawatan komunitas. Manajemen kasus keluarga merupakan proses terorganisasi untuk mengidentifikasi kebutuhan kesehatan pasien dan keluarga, merencanakan pelayanan, mengoordinasikan berbagai sumber daya, melaksanakan intervensi, melakukan pemantauan, serta mengevaluasi keberhasilan pelayanan secara berkelanjutan. Pendekatan ini sangat relevan bagi keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit kronik, keterbatasan fungsi, ketergantungan tinggi, kebutuhan perawatan kompleks, atau memerlukan keterlibatan berbagai tenaga kesehatan dan layanan sosial.

Manajemen kasus keluarga tidak sekadar mengatur jadwal kunjungan atau merujuk pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan. Proses ini menuntut pengkajian yang komprehensif mengenai kondisi pasien, kemampuan keluarga, kebutuhan *caregiver*, lingkungan tempat tinggal, akses terhadap pelayanan kesehatan, dukungan sosial, kondisi ekonomi, hingga kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait kesehatan. Dengan demikian, intervensi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata keluarga dan tidak hanya berdasarkan diagnosis medis pasien.

Dalam praktik keperawatan komunitas, keluarga dapat menghadapi kebutuhan kesehatan yang sangat beragam. Seorang pasien stroke, misalnya, mungkin membutuhkan bantuan dalam berpindah posisi, makan, mandi, eliminasi, minum obat, latihan rentang gerak, dan pencegahan luka tekan. Pasien diabetes melitus membutuhkan pemantauan gula darah, kepatuhan terhadap pengobatan, pengaturan pola makan, aktivitas fisik, perawatan kaki, serta kemampuan mengenali tanda hipoglikemia atau hiperglikemia. Sementara itu, pasien dengan penyakit ginjal kronik dapat memerlukan pengaturan cairan, diet tertentu, pengobatan teratur, pemantauan kondisi fisik, dan kunjungan rutin ke fasilitas kesehatan. Setiap kondisi membutuhkan kemampuan perawatan yang berbeda dari keluarga.

Kompleksitas tersebut menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan keluarga harus direncanakan secara individual dan berkesinambungan. Tidak semua keluarga memiliki tingkat pengetahuan, keterampilan, sumber daya, dan dukungan sosial yang sama. Sebagian keluarga mampu menjalankan perawatan secara mandiri setelah mendapatkan pendidikan kesehatan, sedangkan keluarga lain membutuhkan pendampingan yang lebih intensif. Ada pula keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, tinggal jauh dari

fasilitas pelayanan kesehatan, memiliki anggota keluarga yang sedikit, atau tidak mempunyai individu yang mampu menjalankan peran sebagai *caregiver* utama.

Perawat komunitas memiliki posisi strategis dalam situasi tersebut karena berinteraksi langsung dengan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Perawat tidak hanya memberikan tindakan keperawatan, tetapi juga berperan sebagai pendidik, konselor, koordinator, advokat, fasilitator, dan pengelola kasus. Melalui kunjungan rumah, pemantauan berkala, pendidikan kesehatan, pemberdayaan keluarga, koordinasi pelayanan, serta kolaborasi dengan tenaga kesehatan dan sumber daya masyarakat, perawat dapat membantu keluarga meningkatkan kemampuan dalam merawat anggota keluarga yang mengalami penyakit kronik atau ketergantungan.

Manajemen kasus keluarga juga menjadi penting untuk mencegah terjadinya fragmentasi pelayanan. Pasien kronik sering memperoleh pelayanan dari berbagai pihak, seperti rumah sakit, Puskesmas, dokter, perawat, tenaga rehabilitasi, ahli gizi, apoteker, kader kesehatan, maupun pelayanan sosial. Tanpa koordinasi yang baik, keluarga dapat mengalami kebingungan terkait rencana perawatan, penggunaan obat, jadwal kontrol, perubahan diet, latihan fisik, atau tindakan yang harus dilakukan ketika muncul tanda bahaya. Manajemen kasus membantu memastikan bahwa berbagai pelayanan tersebut terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan pasien serta keluarga.

Dengan demikian, manajemen kasus keluarga merupakan pendekatan yang penting dalam mendukung keberlanjutan pelayanan kesehatan di komunitas. Pendekatan ini menempatkan pasien dan keluarga sebagai pusat pelayanan, sekaligus mengakui bahwa keberhasilan perawatan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam menjalankan peran kesehatan. Melalui manajemen kasus yang sistematis, keluarga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan perawatan, mencegah komplikasi, mempertahankan fungsi pasien, mengurangi penggunaan pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan, serta meningkatkan kualitas hidup pasien dan seluruh anggota keluarga.

2. Pentingnya Keluarga dalam Perawatan Jangka Panjang

Keluarga merupakan lingkungan utama tempat individu menjalani sebagian besar kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang mengalami penyakit kronik atau penurunan kemampuan fungsi, keluarga sering menjadi sumber dukungan utama dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Peran keluarga menjadi semakin penting ketika pasien membutuhkan

perawatan dalam waktu panjang, karena tenaga kesehatan tidak selalu berada bersama pasien selama dua puluh empat jam. Sebaliknya, anggota keluarga umumnya menjadi pihak yang paling sering berinteraksi dengan pasien dan mengetahui perubahan kondisi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Perawatan jangka panjang merupakan rangkaian pelayanan dan dukungan yang diberikan kepada individu yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akibat penyakit kronik, disabilitas, proses degeneratif, atau kondisi kesehatan lainnya. Perawatan tersebut dapat berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tujuannya tidak selalu untuk mencapai kesembuhan penuh, tetapi dapat berupa mempertahankan fungsi, mencegah komplikasi, meningkatkan kenyamanan, meningkatkan kemandirian, serta mempertahankan kualitas hidup pasien.

Dalam perawatan jangka panjang, keluarga berperan dalam membantu pasien menjalankan pengobatan dan perubahan gaya hidup. Keluarga dapat mengingatkan jadwal minum obat, membantu menyiapkan makanan sesuai kebutuhan pasien, menemani kontrol, mendukung aktivitas fisik yang dianjurkan, serta membantu memantau perubahan gejala. Dukungan tersebut sangat penting karena kepatuhan pasien terhadap rencana perawatan sering dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarga. Ketika keluarga memahami kondisi pasien dan terlibat secara positif, proses pengelolaan penyakit cenderung menjadi lebih terarah.

Keluarga juga berperan dalam melakukan observasi terhadap perubahan kondisi pasien. Dalam kehidupan sehari-hari, anggota keluarga dapat menjadi pihak pertama yang menyadari munculnya tanda atau gejala baru. Perubahan kesadaran, kelemahan mendadak, sesak napas, pembengkakan, penurunan nafsu makan, perubahan perilaku, peningkatan rasa nyeri, demam, atau penurunan kemampuan melakukan aktivitas merupakan contoh kondisi yang dapat dikenali oleh keluarga. Kemampuan keluarga mendeteksi perubahan tersebut dapat membantu mempercepat pengambilan keputusan untuk mencari pertolongan kesehatan sebelum kondisi berkembang menjadi lebih berat.

Selain dukungan fisik, keluarga memiliki peran besar dalam memenuhi kebutuhan emosional pasien. Penyakit kronik dapat menyebabkan pasien mengalami kecemasan, rasa takut, kehilangan peran, perubahan citra diri, frustrasi, ketidakberdayaan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Pasien yang sebelumnya mampu bekerja dan melakukan berbagai aktivitas secara mandiri dapat merasa menjadi beban ketika harus bergantung kepada orang

lain. Pada situasi tersebut, penerimaan, komunikasi yang positif, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan dukungan emosional keluarga dapat membantu pasien beradaptasi dengan perubahan kondisi kesehatan.

Perawatan yang diberikan keluarga sebaiknya tidak hanya berorientasi pada memenuhi seluruh kebutuhan pasien, tetapi juga diarahkan untuk mempertahankan kemampuan yang masih dimiliki pasien. Bantuan yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan ketergantungan semakin meningkat. Sebaliknya, membiarkan pasien melakukan semua aktivitas tanpa mempertimbangkan keterbatasannya dapat meningkatkan risiko kelelahan atau cedera. Oleh karena itu, keluarga perlu memahami keseimbangan antara memberikan bantuan dan mendorong kemandirian.

Sebagai contoh, pasien pascastroke yang masih mampu memegang sendok mungkin perlu diberikan kesempatan untuk mencoba makan secara mandiri meskipun membutuhkan waktu lebih lama. Pasien yang masih mampu berpindah dari tempat tidur ke kursi dengan bantuan minimal sebaiknya tetap dilibatkan dalam aktivitas tersebut. Pendekatan demikian dapat membantu mempertahankan fungsi fisik, rasa percaya diri, harga diri, dan motivasi pasien. Keluarga perlu memahami bahwa tujuan perawatan bukan hanya menyelesaikan aktivitas dengan cepat, tetapi juga membantu pasien mencapai tingkat kemandirian optimal sesuai kondisinya.

Keluarga juga berperan dalam menciptakan lingkungan rumah yang aman bagi pasien. Pasien dengan keterbatasan mobilitas atau gangguan keseimbangan memiliki risiko jatuh lebih tinggi. Lingkungan rumah perlu disesuaikan dengan kondisi pasien, misalnya dengan mengurangi benda yang menghalangi jalur berjalan, menjaga lantai tetap kering, menyediakan pencahayaan yang cukup, memasang pegangan di area tertentu jika diperlukan, dan memastikan alat bantu digunakan dengan benar. Pada pasien dengan ketergantungan tinggi, keluarga juga perlu memahami cara melakukan perubahan posisi, mobilisasi, perawatan kulit, dan pemenuhan kebutuhan dasar secara aman.

Dalam beberapa kondisi, keluarga juga berperan sebagai pengambil keputusan ketika pasien mengalami keterbatasan kemampuan dalam menentukan pilihan terkait kesehatannya. Namun, keterlibatan keluarga tetap harus menghormati hak, nilai, preferensi, dan kemampuan pasien dalam mengambil keputusan. Pasien yang masih mampu memahami informasi dan menentukan pilihan perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan perawatannya. Pendekatan ini penting untuk mempertahankan martabat dan otonomi pasien.

Perawatan jangka panjang juga menuntut keluarga untuk berinteraksi dengan sistem pelayanan kesehatan. Keluarga perlu mengetahui kapan pasien harus melakukan kontrol, kapan harus memperoleh pelayanan rehabilitasi, bagaimana menggunakan sistem rujukan, serta siapa yang dapat dihubungi ketika terjadi perubahan kondisi. Kemampuan keluarga dalam mengakses dan menggunakan pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dari keberhasilan manajemen kasus.

Namun, keterlibatan keluarga dalam perawatan tidak boleh dipandang sebagai kewajiban yang dapat dilakukan tanpa batas. Anggota keluarga yang memberikan perawatan juga memiliki kebutuhan pribadi, pekerjaan, hubungan sosial, serta kondisi kesehatan sendiri. Oleh karena itu, perawat perlu menilai kemampuan keluarga secara realistis dan tidak memberikan tanggung jawab yang melebihi kapasitasnya. Jika beban perawatan terlalu tinggi, diperlukan dukungan tambahan, baik dari anggota keluarga lain, lingkungan masyarakat, kader, kelompok pendukung, tenaga kesehatan, maupun pelayanan lain yang tersedia.

Keluarga pada akhirnya merupakan mitra utama dalam perawatan jangka panjang. Kemitraan antara tenaga kesehatan dan keluarga perlu dibangun melalui komunikasi terbuka, saling menghargai, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Tenaga kesehatan memberikan pengetahuan, keterampilan, pemantauan, serta dukungan profesional, sedangkan keluarga membawa pemahaman mendalam mengenai kebiasaan, nilai, kebutuhan, dan kondisi pasien sehari-hari. Kolaborasi kedua pihak menjadi dasar penting dalam menciptakan pelayanan yang berkesinambungan dan berpusat pada pasien.

3. Tantangan Penyakit Kronik, Ketergantungan, dan *Caregiver*

Penyakit kronik membawa berbagai tantangan karena berlangsung dalam jangka panjang dan sering disertai perubahan kondisi yang dinamis. Pasien mungkin mengalami periode stabil, kemudian mengalami perburukan, komplikasi, atau penurunan fungsi. Kondisi tersebut menyebabkan kebutuhan pelayanan dapat berubah dari waktu ke waktu. Rencana perawatan yang sesuai pada satu tahap belum tentu sesuai pada tahap berikutnya sehingga keluarga dan tenaga kesehatan perlu melakukan evaluasi secara berkala.

Salah satu tantangan utama penyakit kronik adalah kepatuhan terhadap pengobatan dan perubahan perilaku kesehatan. Pasien dapat mengalami kejenuhan karena harus mengonsumsi obat dalam jangka panjang, membatasi pola makan tertentu, melakukan kontrol secara rutin, atau mengubah kebiasaan yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selain itu, efek samping

obat, biaya pengobatan, jarak ke fasilitas kesehatan, keterbatasan transportasi, tingkat pemahaman kesehatan, maupun kepercayaan tertentu dapat memengaruhi kepatuhan pasien.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika penyakit kronik menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan menunjukkan kondisi ketika individu membutuhkan bantuan sebagian atau seluruhnya dalam memenuhi kebutuhan dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Tingkat ketergantungan dapat berbeda pada setiap pasien, mulai dari membutuhkan bantuan ringan hingga bergantung sepenuhnya pada orang lain. Ketergantungan dapat mencakup aktivitas dasar seperti makan, mandi, berpakaian, berpindah posisi, berjalan, dan eliminasi, maupun aktivitas yang lebih kompleks seperti menyiapkan makanan, menggunakan transportasi, mengelola obat, berbelanja, serta mengatur keuangan.

Pasien dengan tingkat ketergantungan tinggi membutuhkan perhatian lebih besar karena memiliki risiko mengalami berbagai komplikasi. Imobilitas yang berkepanjangan dapat meningkatkan risiko luka tekan, kekakuan sendi, kelemahan otot, gangguan pernapasan, trombosis, konstipasi, serta penurunan kemampuan fungsional. Pasien yang tidak mampu melakukan perawatan diri juga memiliki risiko mengalami gangguan kebersihan, infeksi, masalah nutrisi, dan gangguan integritas kulit. Oleh karena itu, keluarga perlu memiliki keterampilan perawatan dasar yang memadai.

Ketergantungan tidak hanya memengaruhi kondisi fisik pasien, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis. Kehilangan kemampuan untuk melakukan aktivitas yang sebelumnya dapat dilakukan secara mandiri dapat menimbulkan perasaan sedih, malu, marah, frustrasi, atau tidak berdaya. Sebagian pasien merasa kehilangan kontrol terhadap kehidupannya ketika setiap kebutuhan harus dibantu orang lain. Kondisi tersebut membutuhkan pendekatan yang sensitif dari keluarga dan tenaga kesehatan agar bantuan yang diberikan tetap menghormati martabat pasien.

Pada saat yang sama, anggota keluarga yang menjalankan peran sebagai *caregiver* menghadapi tuntutan yang besar. *Caregiver* merupakan individu yang memberikan bantuan dan dukungan kepada seseorang yang mengalami keterbatasan atau membutuhkan perawatan. Dalam konteks keluarga, *caregiver* biasanya merupakan pasangan, anak, orang tua, saudara, atau anggota keluarga lain yang bertanggung jawab terhadap perawatan sehari-hari pasien. Pada banyak keluarga, peran ini dijalankan tanpa pendidikan atau pelatihan formal mengenai cara merawat pasien.

Tanggung jawab seorang *caregiver* dapat meliputi membantu pasien memenuhi kebutuhan personal, menyiapkan makanan, memberikan atau mengingatkan obat, melakukan mobilisasi, mendampingi kontrol, memantau gejala, mengelola peralatan kesehatan, serta memberikan dukungan emosional. Jika pasien memiliki ketergantungan tinggi, tugas tersebut dapat dilakukan berulang sepanjang hari bahkan malam. Situasi tersebut berpotensi menyebabkan kelelahan fisik dan psikologis pada *caregiver*.

Beban yang dirasakan *caregiver* dikenal sebagai *caregiver burden*. Beban tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk. Secara fisik, *caregiver* dapat mengalami kelelahan, gangguan tidur, nyeri tubuh, atau penurunan kondisi kesehatan karena aktivitas perawatan yang intensif. Secara psikologis, *caregiver* dapat mengalami stres, kecemasan, kesedihan, frustrasi, rasa bersalah, atau merasa tidak memiliki kendali terhadap kehidupan pribadi. Secara sosial, aktivitas merawat pasien dapat membatasi kesempatan untuk bekerja, berinteraksi dengan teman, mengikuti kegiatan masyarakat, atau melakukan kegiatan rekreasi.

Dampak ekonomi juga menjadi tantangan yang penting. Keluarga dengan pasien kronik dapat menghadapi peningkatan biaya pengobatan, transportasi, pemeriksaan, alat kesehatan, kebutuhan nutrisi khusus, serta berbagai kebutuhan perawatan lainnya. Dalam beberapa kasus, *caregiver* harus mengurangi jam kerja atau bahkan berhenti bekerja untuk memberikan perawatan. Situasi tersebut dapat mengurangi pendapatan keluarga ketika pengeluaran justru meningkat.

Apabila beban berlangsung terus-menerus tanpa dukungan yang memadai, *caregiver* dapat mengalami kelelahan berat atau *caregiver burnout*. Kondisi ini dapat ditandai dengan kelelahan emosional dan fisik, menurunnya motivasi, irritabilitas, gangguan tidur, penurunan konsentrasi, serta perasaan tidak mampu melanjutkan perawatan. *Burnout* bukan hanya berdampak pada kesehatan *caregiver*, tetapi juga dapat menurunkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien.

Dalam kondisi tertentu, tekanan yang sangat berat juga dapat meningkatkan risiko terjadinya konflik, pengabaian kebutuhan pasien, bahkan perlakuan yang tidak sesuai. Oleh sebab itu, kesejahteraan *caregiver* harus menjadi bagian dari pengkajian keperawatan. Fokus pelayanan tidak boleh hanya ditujukan kepada pasien, tetapi perlu mencakup individu yang memberikan perawatan karena kemampuan *caregiver* sangat memengaruhi keberhasilan perawatan di rumah.

Tantangan lainnya berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan keterampilan keluarga. Tidak semua *caregiver* memahami cara memindahkan pasien dengan aman, mencegah luka tekan, memberikan makanan sesuai kondisi pasien, mengelola obat, mengenali tanda bahaya, atau menggunakan alat kesehatan. Kesalahan dalam melakukan perawatan dapat menimbulkan risiko baik bagi pasien maupun *caregiver*. Sebagai contoh, teknik mengangkat pasien yang tidak tepat dapat menyebabkan cedera punggung pada *caregiver*, sedangkan kesalahan penggunaan obat dapat membahayakan pasien.

Karena itu, pendidikan kesehatan menjadi komponen utama dalam manajemen kasus keluarga. Edukasi harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman, kemampuan, kondisi, dan kebutuhan keluarga. Informasi tidak cukup hanya diberikan secara lisan. Perawat perlu memastikan bahwa keluarga benar-benar memahami dan mampu mempraktikkan keterampilan yang diperlukan. Metode demonstrasi dan demonstrasi ulang dapat digunakan untuk memastikan keluarga mampu melakukan tindakan tertentu dengan aman.

Tantangan lain yang sering muncul adalah koordinasi antarpelayanan. Pasien dengan penyakit kronik dapat memperoleh pelayanan dari berbagai fasilitas dan profesi. Tanpa komunikasi yang baik, dapat terjadi ketidaksesuaian informasi mengenai obat, diet, aktivitas, jadwal kontrol, atau rencana tindak lanjut. Karena itu, manajemen kasus perlu menjamin adanya kesinambungan informasi antara pasien, keluarga, perawat komunitas, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tenaga profesional lainnya.

Kondisi sosial dan lingkungan juga dapat memengaruhi kemampuan keluarga dalam menjalankan perawatan. Rumah dengan ruang terbatas, fasilitas sanitasi yang kurang memadai, akses transportasi yang sulit, rendahnya dukungan sosial, atau keterbatasan sumber daya dapat menjadi hambatan. Dalam situasi demikian, intervensi keperawatan perlu mempertimbangkan kondisi riil keluarga agar rekomendasi yang diberikan dapat diterapkan secara praktis.

Perawat komunitas memiliki tanggung jawab penting untuk membantu keluarga menghadapi berbagai tantangan tersebut. Perawat perlu mengidentifikasi kebutuhan pasien dan keluarga secara komprehensif, menilai kemampuan *caregiver*, mengenali faktor risiko, serta menentukan sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pendekatan pemberdayaan perlu digunakan agar keluarga tidak menjadi penerima pelayanan yang pasif, melainkan mampu meningkatkan kemampuan dalam merawat anggota keluarganya.

Dukungan terhadap *caregiver* juga perlu menjadi bagian integral dari pelayanan. Perawat dapat membantu keluarga membagi tugas perawatan, mengembangkan strategi koping, menjaga waktu istirahat, mempertahankan kesehatan diri, serta mencari dukungan dari keluarga besar atau lingkungan sosial. Jika tersedia, keluarga dapat diarahkan untuk memanfaatkan layanan *respite care*, kelompok dukungan, layanan sosial, atau pelayanan kesehatan berbasis komunitas untuk mengurangi beban perawatan.

Manajemen kasus keluarga pada akhirnya bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pasien dan kemampuan keluarga. Keberhasilan perawatan tidak hanya diukur dari stabilnya kondisi penyakit, tetapi juga dari meningkatnya kemandirian pasien, kemampuan keluarga melakukan perawatan, terjaganya kesehatan *caregiver*, menurunnya risiko komplikasi, serta meningkatnya kualitas hidup seluruh anggota keluarga. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus bersifat holistik, berkesinambungan, kolaboratif, dan berpusat pada pasien serta keluarga.

Pemahaman mengenai penyakit kronik, ketergantungan, dan peran *caregiver* menjadi dasar penting bagi mahasiswa dan perawat komunitas sebelum melaksanakan manajemen kasus keluarga. Melalui pemahaman tersebut, perawat diharapkan mampu melihat pasien bukan hanya sebagai individu dengan diagnosis tertentu, tetapi sebagai bagian dari sebuah keluarga dengan struktur, peran, sumber daya, nilai, serta kemampuan yang berbeda-beda. Pendekatan inilah yang memungkinkan pelayanan keperawatan komunitas menjadi lebih manusiawi, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan pasien sehari-hari.

B. Konsep Dasar Manajemen Kasus Keluarga

1. Pengertian Manajemen Kasus Keluarga

Manajemen kasus keluarga merupakan suatu pendekatan pelayanan yang terstruktur untuk membantu individu dan keluarga yang memiliki kebutuhan kesehatan kompleks agar memperoleh pelayanan yang terkoordinasi, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam keperawatan komunitas, manajemen kasus tidak hanya berfokus pada penyakit atau masalah kesehatan individu, tetapi juga mempertimbangkan kondisi keluarga sebagai lingkungan utama tempat pasien menjalani kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kondisi fisik pasien, kemampuan fungsional, kondisi psikologis, dukungan sosial, ekonomi keluarga, lingkungan tempat tinggal, kemampuan *caregiver*, serta akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan menjadi bagian penting dalam proses manajemen kasus.

Manajemen kasus keluarga diperlukan terutama ketika suatu masalah kesehatan tidak dapat diselesaikan melalui satu kali kunjungan atau satu jenis pelayanan saja. Pasien dengan penyakit kronik, keterbatasan aktivitas, disabilitas, ketergantungan tinggi, atau kebutuhan perawatan jangka panjang sering memerlukan keterlibatan berbagai tenaga kesehatan dan sumber daya masyarakat. Pada kondisi tersebut, pelayanan yang diberikan perlu diatur secara sistematis agar tidak terfragmentasi. Perawat komunitas berperan membantu keluarga memahami kebutuhan pasien, menyusun prioritas perawatan, menghubungkan keluarga dengan pelayanan yang sesuai, melakukan pemantauan, serta mengevaluasi perkembangan kondisi pasien dan kemampuan keluarga.

Dalam manajemen kasus, pasien dan keluarga ditempatkan sebagai pusat pelayanan. Artinya, perencanaan tidak hanya dibuat berdasarkan diagnosis penyakit, tetapi juga berdasarkan kebutuhan, kemampuan, nilai, pilihan, dan sumber daya yang dimiliki keluarga. Dua pasien dengan diagnosis yang sama dapat membutuhkan strategi manajemen kasus yang berbeda. Sebagai contoh, dua orang pasien pascastroke mungkin sama-sama mengalami kelemahan anggota gerak, tetapi salah satunya tinggal bersama beberapa anggota keluarga yang mampu membantu perawatan, sedangkan pasien lainnya hanya tinggal bersama pasangan lanjut usia. Perbedaan kondisi keluarga tersebut akan memengaruhi kebutuhan bantuan, intensitas pemantauan, pendidikan kesehatan, dan koordinasi pelayanan.

Manajemen kasus keluarga juga dapat dipahami sebagai proses pengelolaan pelayanan yang terdiri atas beberapa tahap yang saling berhubungan. Proses tersebut dimulai dari identifikasi pasien atau keluarga yang membutuhkan manajemen kasus, pengkajian komprehensif, identifikasi masalah dan kebutuhan, penentuan prioritas, penyusunan rencana pelayanan, pelaksanaan intervensi, koordinasi dengan berbagai pihak, pemantauan perkembangan, evaluasi hasil, hingga tindak lanjut. Setiap tahap dilakukan secara dinamis karena kondisi pasien dan keluarga dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dalam konteks penyakit kronik, manajemen kasus sangat penting karena perjalanan penyakit dapat berlangsung lama dan disertai periode stabil maupun perburukan. Pasien mungkin mampu menjalankan aktivitas secara mandiri pada suatu periode, kemudian mengalami penurunan fungsi akibat komplikasi atau progresivitas penyakit. Ketika hal tersebut terjadi, kebutuhan keluarga terhadap bantuan perawatan akan meningkat. Oleh karena itu,

rencana manajemen kasus tidak bersifat tetap, tetapi perlu ditinjau kembali sesuai perubahan kondisi pasien dan kemampuan keluarga.

Pendekatan manajemen kasus juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemberdayaan keluarga. Perawat tidak mengambil alih seluruh tanggung jawab keluarga, tetapi membantu keluarga memiliki pengetahuan, keterampilan, kepercayaan diri, dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan fungsi perawatan. Pemberdayaan tersebut penting agar keluarga tidak selalu bergantung kepada tenaga kesehatan untuk setiap masalah yang muncul. Keluarga perlu mampu mengenali kondisi yang dapat ditangani di rumah, mengetahui tanda bahaya yang memerlukan pertolongan segera, memahami penggunaan obat, menjalankan perawatan dasar, serta mengetahui kapan harus mengakses fasilitas pelayanan kesehatan.

Dengan demikian, manajemen kasus keluarga dapat dipandang sebagai proses yang mengintegrasikan pelayanan kesehatan, pemberdayaan keluarga, koordinasi pelayanan, dan pemantauan berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi sangat relevan dalam keperawatan komunitas karena sebagian besar perawatan pasien kronik dan pasien dengan ketergantungan berlangsung di rumah. Keberhasilan pelayanan tidak hanya bergantung pada tindakan yang dilakukan tenaga kesehatan, tetapi juga pada kemampuan keluarga menerapkan rencana perawatan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Tujuan dan Prinsip Manajemen Kasus

Tujuan utama manajemen kasus keluarga adalah memastikan bahwa pasien dan keluarga memperoleh pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan secara tepat, terkoordinasi, efektif, dan berkesinambungan. Pelayanan yang terkoordinasi penting terutama bagi pasien dengan kondisi kompleks yang membutuhkan berbagai jenis intervensi. Tanpa koordinasi yang baik, pasien dapat menerima informasi yang berbeda, mengalami duplikasi pelayanan, tidak melakukan tindak lanjut yang diperlukan, atau bahkan kehilangan akses terhadap pelayanan yang seharusnya diperoleh.

Manajemen kasus juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi kesehatan. Keluarga diharapkan mampu mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan yang tepat, melakukan perawatan sederhana di rumah, mempertahankan lingkungan yang aman, memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan, serta memberikan dukungan kepada anggota keluarga yang sakit. Peningkatan kemampuan tersebut merupakan bagian penting dari keperawatan komunitas karena keluarga

merupakan pihak yang paling dekat dengan pasien dalam kehidupan sehari-hari.

Pada pasien penyakit kronik, salah satu tujuan manajemen kasus adalah mempertahankan kondisi kesehatan secara optimal dan mencegah komplikasi. Penyakit kronik sering kali tidak dapat disembuhkan sepenuhnya, sehingga tujuan perawatan lebih diarahkan pada pengendalian penyakit, mempertahankan fungsi, mengurangi gejala, mencegah perburukan, dan meningkatkan kualitas hidup. Sebagai contoh, pada pasien hipertensi, manajemen kasus dapat diarahkan pada kepatuhan pengobatan, perubahan gaya hidup, pemantauan tekanan darah, pengenalan tanda komplikasi, dan kontrol secara teratur. Pada pasien pascastroke, tujuan dapat berupa mempertahankan kemampuan mobilitas, mencegah luka tekan, mencegah jatuh, meningkatkan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, serta mendukung keluarga dalam memberikan perawatan.

Manajemen kasus juga bertujuan meningkatkan kemandirian pasien sesuai kemampuan yang dimiliki. Kemandirian tidak selalu berarti pasien harus mampu melakukan seluruh aktivitas tanpa bantuan. Pada pasien dengan keterbatasan berat, kemandirian dapat berarti mempertahankan kemampuan melakukan sebagian aktivitas atau berpartisipasi dalam keputusan yang berkaitan dengan dirinya. Pendekatan ini penting agar pasien tidak kehilangan rasa percaya diri dan martabat akibat kondisi ketergantungannya.

Selain berorientasi pada pasien, manajemen kasus keluarga memiliki tujuan untuk menjaga kemampuan dan kesejahteraan *caregiver*. Pelayanan yang hanya berfokus pada pasien tanpa mempertimbangkan kondisi orang yang memberikan perawatan dapat menyebabkan beban yang berlebihan. *Caregiver* yang mengalami kelelahan berat akan semakin sulit memberikan perawatan yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, penilaian beban *caregiver*, pendidikan kesehatan, pembagian tugas, waktu istirahat, dukungan emosional, dan akses terhadap sumber daya merupakan bagian dari tujuan manajemen kasus keluarga.

Pelaksanaan manajemen kasus didasarkan pada sejumlah prinsip yang perlu diterapkan secara konsisten. Prinsip pertama adalah berpusat pada pasien dan keluarga. Semua keputusan dan intervensi perlu mempertimbangkan kebutuhan, nilai, budaya, kebiasaan, preferensi, dan tujuan pasien serta keluarga. Perawat tidak semata-mata menentukan apa yang dianggap terbaik dari sudut pandang profesional, tetapi perlu melibatkan keluarga dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip berikutnya adalah pengkajian yang komprehensif. Masalah keluarga tidak dapat dipahami hanya melalui pemeriksaan fisik pasien. Kondisi psikologis, hubungan antaranggota keluarga, ekonomi, lingkungan rumah, dukungan sosial, pengetahuan kesehatan, kemampuan melakukan perawatan, hingga akses transportasi dapat memengaruhi keberhasilan rencana pelayanan. Pengkajian komprehensif membantu perawat memahami penyebab maupun faktor yang mempertahankan suatu masalah.

Prinsip individualisasi juga penting dalam manajemen kasus. Rencana pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Intervensi yang sama tidak selalu dapat diterapkan pada setiap keluarga karena kemampuan, sumber daya, nilai, dan lingkungan yang berbeda. Keluarga dengan sumber daya terbatas, misalnya, memerlukan rekomendasi yang realistis dan dapat dilaksanakan sesuai kondisi mereka.

Prinsip lain adalah koordinasi dan kolaborasi. Pasien dengan kebutuhan kompleks dapat melibatkan dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, pekerja sosial, kader kesehatan, serta tenaga lain. Perawat sebagai pengelola kasus perlu membantu memastikan bahwa pelayanan dari berbagai pihak memiliki tujuan yang selaras. Koordinasi yang baik dapat mengurangi duplikasi pelayanan, mencegah kesalahan komunikasi, dan memudahkan keluarga memahami rencana perawatan.

Manajemen kasus juga harus berkesinambungan. Pelayanan tidak berhenti setelah satu intervensi dilakukan. Perawat perlu melakukan pemantauan dan evaluasi untuk mengetahui apakah kondisi pasien membaik, stabil, atau memburuk; apakah keluarga mampu menjalankan perawatan; serta apakah terdapat kebutuhan baru. Jika hasil tidak sesuai tujuan, rencana perawatan perlu dimodifikasi.

Prinsip efisiensi juga perlu diperhatikan. Sumber daya kesehatan perlu digunakan secara tepat sesuai kebutuhan. Hal ini bukan berarti mengurangi pelayanan, tetapi memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi pasien dan keluarga. Penggunaan pelayanan yang berlebihan, pemeriksaan yang tidak diperlukan, atau rujukan yang tidak tepat dapat meningkatkan beban keluarga dan sistem pelayanan kesehatan.

Selain itu, keselamatan pasien dan keluarga harus menjadi prinsip utama. Semua tindakan perlu mempertimbangkan potensi risiko. Pendidikan tentang penggunaan obat, pencegahan jatuh, teknik mobilisasi, pencegahan luka tekan, penggunaan alat kesehatan, serta tanda bahaya merupakan bagian dari upaya menjaga keselamatan dalam perawatan di rumah.

3. Karakteristik Keluarga yang Membutuhkan Manajemen Kasus

Tidak setiap keluarga memerlukan intensitas manajemen kasus yang sama. Beberapa keluarga dapat menjalankan fungsi kesehatan dengan baik dan hanya membutuhkan pendidikan kesehatan sederhana. Sebaliknya, terdapat keluarga yang memiliki masalah kompleks sehingga membutuhkan pendampingan lebih intensif. Perawat perlu mengenali karakteristik keluarga yang memerlukan manajemen kasus agar sumber daya dapat digunakan secara tepat.

Keluarga dengan anggota yang mengalami penyakit kronik merupakan salah satu kelompok utama yang membutuhkan manajemen kasus. Penyakit kronik membutuhkan perawatan dalam waktu lama dan sering melibatkan pengobatan rutin, pemantauan gejala, pengaturan pola makan, aktivitas fisik, kontrol berkala, dan pencegahan komplikasi. Jika keluarga kurang memahami kondisi tersebut, risiko ketidakpatuhan dan perburukan penyakit akan meningkat.

Kebutuhan manajemen kasus semakin tinggi apabila pasien mengalami lebih dari satu penyakit kronik. Pasien lanjut usia, misalnya, dapat memiliki hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, dan gangguan muskuloskeletal secara bersamaan. Banyaknya kondisi kesehatan dapat menyebabkan penggunaan berbagai obat, kebutuhan kontrol ke beberapa pelayanan, diet khusus, dan keterbatasan aktivitas. Kompleksitas tersebut dapat membuat keluarga kesulitan menentukan prioritas perawatan.

Keluarga dengan anggota yang memiliki ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari juga membutuhkan perhatian khusus. Ketergantungan dapat terjadi setelah stroke, cedera, gangguan neurologis, penyakit degeneratif, disabilitas, atau akibat proses penuaan. Pasien mungkin memerlukan bantuan untuk makan, mandi, berpakaian, berjalan, berpindah posisi, buang air, atau menjalankan aktivitas lainnya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin besar pula kebutuhan keluarga terhadap keterampilan perawatan.

Pasien yang memiliki keterbatasan kognitif atau komunikasi juga dapat meningkatkan kompleksitas perawatan keluarga. Individu dengan demensia, gangguan neurologis, gangguan perkembangan, atau kondisi tertentu mungkin tidak mampu menyampaikan kebutuhan secara jelas. Keluarga perlu memahami perubahan perilaku, menjaga keselamatan, membantu aktivitas, serta melakukan pengawasan yang lebih intensif.

Karakteristik lain adalah adanya *caregiver* dengan beban tinggi. Keluarga mungkin hanya memiliki satu orang yang bertanggung jawab merawat pasien sepanjang hari. Jika *caregiver* juga bekerja, memiliki anak yang harus diasuh,

mengalami penyakit, atau tidak memperoleh bantuan dari anggota keluarga lain, risiko kelelahan akan meningkat. Dalam situasi demikian, manajemen kasus tidak boleh hanya menilai kondisi pasien, tetapi juga harus menilai kesehatan dan kemampuan *caregiver*.

Keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas juga dapat menghadapi kesulitan dalam menjalankan perawatan. Biaya obat, transportasi, pemeriksaan, alat kesehatan, makanan khusus, dan kebutuhan lainnya dapat menjadi beban. Ketika sumber daya finansial terbatas, keluarga mungkin menunda kontrol, mengurangi obat, atau tidak mengikuti rekomendasi perawatan. Manajemen kasus perlu membantu keluarga menentukan prioritas dan mengakses sumber daya yang tersedia.

Akses terhadap fasilitas kesehatan juga menjadi faktor penting. Keluarga yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan, memiliki keterbatasan transportasi, atau kesulitan memperoleh layanan mungkin memerlukan strategi khusus. Pemanfaatan kunjungan rumah, pelayanan berbasis komunitas, komunikasi jarak jauh, kader kesehatan, atau sistem rujukan dapat menjadi bagian dari rencana manajemen kasus.

Hubungan dan komunikasi keluarga juga perlu dinilai. Konflik keluarga, pembagian peran yang tidak jelas, kurangnya dukungan, atau perbedaan pandangan mengenai perawatan dapat menghambat pelayanan. Sebagai contoh, satu anggota keluarga mungkin menyetujui rencana pengobatan, sedangkan anggota lain lebih memilih pendekatan yang berbeda. Perawat perlu membantu memfasilitasi komunikasi dan menemukan kesepakatan yang tetap menghormati hak pasien.

Keluarga juga memerlukan manajemen kasus apabila mengalami transisi perawatan. Masa setelah pasien pulang dari rumah sakit merupakan periode yang berisiko karena keluarga harus mengambil alih sebagian besar tanggung jawab perawatan. Keluarga perlu memahami obat yang digunakan, diet, aktivitas yang diperbolehkan, perawatan luka, jadwal kontrol, penggunaan alat, serta tanda bahaya. Ketidaksiapan keluarga pada masa transisi dapat meningkatkan risiko komplikasi dan kunjungan ulang ke fasilitas kesehatan.

Dengan demikian, kebutuhan manajemen kasus dipengaruhi oleh kombinasi berbagai faktor, bukan hanya beratnya penyakit. Tingkat ketergantungan, kemampuan keluarga, kondisi *caregiver*, ekonomi, dukungan sosial, lingkungan, dan akses pelayanan harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Semakin kompleks masalah yang dihadapi keluarga, semakin besar kebutuhan terhadap koordinasi, pemantauan, dan pendampingan.

4. Pendekatan *Family-Centered Care*

Family-centered care merupakan pendekatan pelayanan yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai mitra dalam proses perawatan. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa keluarga memiliki pengetahuan, pengalaman, nilai, dan peran penting dalam kehidupan pasien. Dalam pelayanan komunitas, pendekatan ini sangat relevan karena keluarga merupakan bagian utama dari lingkungan tempat pasien menjalani perawatan sehari-hari.

Penerapan *family-centered care* dimulai dengan sikap menghargai keluarga. Tenaga kesehatan perlu memahami bahwa setiap keluarga memiliki budaya, keyakinan, kebiasaan, struktur, dan cara pengambilan keputusan yang berbeda. Perbedaan tersebut perlu dihormati selama tidak membahayakan pasien. Perawat tidak seharusnya memaksakan pola perawatan tanpa terlebih dahulu memahami sudut pandang dan kemampuan keluarga.

Komunikasi yang terbuka merupakan unsur penting dalam *family-centered care*. Pasien dan keluarga perlu memperoleh informasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami mengenai kondisi kesehatan, tujuan perawatan, manfaat dan risiko tindakan, serta tanda bahaya yang harus diperhatikan. Informasi harus disampaikan sesuai kemampuan pemahaman keluarga dan tidak menggunakan istilah teknis secara berlebihan.

Keterlibatan keluarga dalam pengambilan keputusan juga merupakan bagian utama pendekatan ini. Perawat perlu mengajak keluarga mendiskusikan tujuan perawatan dan pilihan yang memungkinkan. Namun, keterlibatan keluarga tidak berarti menghilangkan hak pasien. Selama pasien masih memiliki kemampuan mengambil keputusan, preferensinya tetap harus menjadi pertimbangan utama.

Pendekatan *family-centered care* juga menekankan pembagian tanggung jawab yang realistis. Keluarga perlu dilibatkan dalam perawatan, tetapi perawat harus menilai apakah mereka benar-benar mampu melakukan tugas yang diberikan. Keluarga tidak boleh diberikan tanggung jawab yang melebihi kemampuan fisik, pengetahuan, atau sumber dayanya. Jika keluarga belum mampu, perawat perlu memberikan pendidikan, demonstrasi, pendampingan, dan evaluasi kemampuan.

Sebagai contoh, pada pasien yang membutuhkan perawatan luka, keluarga tidak cukup hanya diberikan instruksi verbal. Perawat dapat mendemonstrasikan langkah perawatan, kemudian meminta keluarga melakukan demonstrasi ulang. Melalui cara tersebut, perawat dapat

memastikan bahwa keluarga benar-benar memahami prosedur dan mampu melakukannya dengan aman.

Pendekatan ini juga memperhatikan kebutuhan anggota keluarga lain. Keberadaan pasien dengan penyakit kronik dapat mengubah kehidupan seluruh keluarga. Anak mungkin memperoleh perhatian lebih sedikit, pasangan mungkin harus mengambil peran baru, dan *caregiver* utama dapat mengalami kelelahan. Oleh karena itu, perawat perlu melihat dampak masalah kesehatan terhadap sistem keluarga secara keseluruhan.

Pemberdayaan menjadi salah satu hasil yang diharapkan dari *family-centered care*. Keluarga perlu dibantu agar semakin percaya diri dalam merawat pasien, mengenali perubahan kondisi, mengatasi masalah sederhana, dan mengakses bantuan ketika diperlukan. Dengan meningkatnya kemampuan tersebut, keluarga dapat menjadi mitra aktif dalam mempertahankan kesehatan pasien.

Hubungan antara perawat dan keluarga dalam pendekatan ini didasarkan pada kemitraan, bukan hubungan yang sepenuhnya satu arah. Perawat memiliki pengetahuan profesional, sedangkan keluarga memiliki pengalaman langsung mengenai kehidupan pasien. Keduanya memiliki informasi yang sama-sama penting. Ketika kedua sumber pengetahuan tersebut digunakan bersama, rencana perawatan menjadi lebih realistis dan sesuai kebutuhan pasien.

5. Pendekatan Holistik dan Berkesinambungan

Pendekatan holistik merupakan cara pandang yang melihat individu sebagai kesatuan yang terdiri atas aspek biologis, psikologis, sosial, spiritual, budaya, dan lingkungan. Dalam manajemen kasus keluarga, penyakit tidak dapat dipahami hanya dari gejala fisik atau diagnosis medis. Kondisi kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berhubungan, sehingga intervensi juga perlu memperhatikan berbagai dimensi kehidupan pasien dan keluarga.

Aspek fisik merupakan bagian yang paling mudah terlihat. Perawat perlu menilai kondisi penyakit, gejala, kemampuan mobilitas, status nutrisi, pola tidur, eliminasi, penggunaan obat, risiko komplikasi, dan kebutuhan aktivitas sehari-hari. Namun, kondisi fisik tersebut sering berinteraksi dengan keadaan psikologis. Pasien yang mengalami nyeri kronik, misalnya, dapat mengalami kecemasan, gangguan tidur, mudah marah, atau kehilangan motivasi. Jika intervensi hanya berfokus pada nyeri tanpa memperhatikan kondisi emosional, hasil perawatan mungkin tidak optimal.

Aspek sosial juga perlu dinilai karena pasien hidup dalam hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Dukungan sosial yang kuat dapat membantu pasien menghadapi penyakit, sedangkan isolasi sosial dapat memperburuk kondisi psikologis. Kehilangan pekerjaan atau peran sosial akibat penyakit dapat memengaruhi harga diri dan kondisi ekonomi keluarga. Karena itu, perawat perlu memahami bagaimana penyakit memengaruhi kehidupan sosial pasien.

Aspek spiritual memiliki arti berbeda bagi setiap individu. Pada sebagian pasien, keyakinan spiritual menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi penyakit. Pada pasien lain, penyakit justru dapat menimbulkan pertanyaan, kesedihan, atau konflik spiritual. Perawat perlu memberikan ruang bagi pasien dan keluarga untuk mengekspresikan kebutuhan tersebut dan, apabila diperlukan, membantu menghubungkan mereka dengan sumber dukungan spiritual yang sesuai.

Kondisi lingkungan juga memiliki pengaruh besar terhadap kesehatan. Rumah yang sempit, lantai licin, ventilasi buruk, pencahayaan kurang, akses air bersih terbatas, atau fasilitas sanitasi yang tidak memadai dapat menimbulkan risiko. Pada pasien dengan gangguan mobilitas, kondisi rumah yang tidak aman dapat meningkatkan risiko jatuh. Karena itu, pengkajian lingkungan menjadi bagian dari manajemen kasus keluarga.

Pendekatan holistik juga berarti mempertimbangkan hubungan antara kebutuhan pasien dan kemampuan keluarga. Intervensi yang secara klinis ideal belum tentu dapat diterapkan jika keluarga tidak memiliki sumber daya yang diperlukan. Perawat perlu menyesuaikan rekomendasi agar tetap aman, efektif, dan realistis dalam konteks kehidupan pasien.

Selain holistik, manajemen kasus harus dilaksanakan secara berkesinambungan. Pelayanan yang berkesinambungan berarti adanya keterhubungan antara satu tahap pelayanan dengan tahap berikutnya. Pasien yang pulang dari rumah sakit, misalnya, tetap membutuhkan tindak lanjut di rumah atau fasilitas kesehatan primer. Informasi mengenai diagnosis, obat, tindakan, rekomendasi aktivitas, diet, dan jadwal kontrol perlu dipahami oleh pasien dan keluarga.

Kesinambungan juga berarti adanya pemantauan dari waktu ke waktu. Kondisi pasien dengan penyakit kronik dapat berubah. Kemampuan keluarga yang awalnya baik dapat menurun jika *caregiver* mengalami kelelahan atau muncul masalah baru. Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara periodik. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk mempertahankan, menambah, mengurangi, atau mengubah intervensi.

Pendekatan berkesinambungan membutuhkan komunikasi yang baik antarpetugas dan antarjenjang pelayanan. Informasi penting mengenai pasien perlu tersedia bagi tenaga kesehatan yang terlibat sehingga keluarga tidak harus mengulang informasi yang sama atau menerima rekomendasi yang berbeda. Dokumentasi yang jelas membantu menjaga kontinuitas tersebut.

Perawat komunitas memiliki posisi penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan karena dapat menghubungkan keluarga dengan fasilitas kesehatan, program komunitas, kader, pelayanan rehabilitasi, maupun sumber daya sosial lainnya. Peran ini sangat penting terutama bagi pasien dengan kebutuhan kompleks atau keterbatasan akses.

Pada akhirnya, pendekatan holistik dan berkesinambungan membantu memastikan bahwa manajemen kasus tidak hanya berfokus pada penyelesaian satu masalah, tetapi pada upaya mempertahankan kualitas hidup pasien dan keluarga dalam jangka panjang. Keberhasilan pelayanan tidak hanya diukur dari membaiknya indikator klinis, tetapi juga dari kemampuan pasien mempertahankan fungsi, meningkatnya kemampuan keluarga dalam merawat, berkurangnya beban *caregiver*, meningkatnya rasa aman, dan terpeliharanya kualitas kehidupan keluarga.

Dengan memahami konsep dasar manajemen kasus keluarga, perawat komunitas dapat mengembangkan pelayanan yang lebih sistematis, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan yang berpusat pada keluarga, holistik, individual, kolaboratif, dan berkesinambungan menjadi dasar penting untuk mengelola pasien dengan penyakit kronik, ketergantungan, serta kebutuhan perawatan jangka panjang secara lebih efektif.

C. Manajemen Keluarga dengan Anggota yang Mengalami Penyakit Kronik

1. Konsep dan Karakteristik Penyakit Kronik

Penyakit kronik merupakan kondisi kesehatan yang berlangsung dalam jangka panjang, umumnya berkembang secara perlahan, memerlukan pengelolaan berkelanjutan, dan sering kali tidak dapat disembuhkan sepenuhnya. Kondisi ini berbeda dengan penyakit akut yang biasanya memiliki onset lebih cepat, durasi lebih singkat, dan sering kali dapat diselesaikan melalui pengobatan tertentu. Pada penyakit kronik, tujuan pelayanan kesehatan lebih banyak diarahkan pada pengendalian penyakit, pencegahan komplikasi, mempertahankan fungsi tubuh, meningkatkan kemandirian, serta menjaga kualitas hidup pasien.

Penyakit kronik mencakup berbagai kondisi, seperti hipertensi, diabetes melitus, penyakit jantung, penyakit paru kronik, penyakit ginjal kronik, kanker, stroke, gangguan neurologis, penyakit muskuloskeletal degeneratif, dan berbagai penyakit lain yang membutuhkan pemantauan jangka panjang. Dalam banyak kasus, pasien dapat mengalami lebih dari satu penyakit kronik secara bersamaan. Kondisi ini disebut multimorbiditas dan dapat meningkatkan kompleksitas pengelolaan karena pasien harus menjalani berbagai terapi, mengonsumsi beberapa jenis obat, melakukan pemeriksaan rutin, mengatur pola makan, dan beradaptasi terhadap keterbatasan fungsi.

Karakteristik utama penyakit kronik adalah berlangsung dalam waktu yang lama dan membutuhkan pengelolaan secara terus-menerus. Perjalanan penyakit tidak selalu stabil. Pasien dapat mengalami periode tanpa keluhan yang berarti, kemudian mengalami eksaserbasi atau perburukan. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap pengobatan, gaya hidup, stres, infeksi, faktor lingkungan, perkembangan penyakit, serta munculnya komplikasi baru. Oleh karena itu, pasien dan keluarga perlu memahami bahwa pengelolaan penyakit kronik bukan kegiatan sementara, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari.

Karakteristik lain adalah perlunya keterlibatan aktif pasien dalam proses perawatan. Pada penyakit kronik, keberhasilan terapi tidak hanya bergantung pada tindakan tenaga kesehatan. Pasien perlu menjalankan rekomendasi perawatan di rumah, seperti mengonsumsi obat secara teratur, mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, memantau gejala, melakukan pemeriksaan berkala, serta mengenali tanda bahaya. Jika pasien mengalami keterbatasan, keluarga akan mengambil peran yang lebih besar dalam membantu menjalankan kegiatan tersebut.

Penyakit kronik juga sering berdampak terhadap kemampuan fungsional. Pasien mungkin mengalami penurunan stamina, kelemahan, nyeri, keterbatasan mobilitas, gangguan penglihatan, gangguan keseimbangan, atau gangguan kognitif. Akibatnya, aktivitas yang sebelumnya dapat dilakukan secara mandiri menjadi lebih sulit. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kemampuan pasien bekerja, menjalankan peran dalam keluarga, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial.

Dalam konteks keluarga, penyakit kronik bukan hanya masalah individu. Penyakit dapat memengaruhi pola kehidupan seluruh anggota keluarga. Waktu keluarga dapat berubah karena harus digunakan untuk merawat pasien, biaya rumah tangga dapat meningkat, pembagian tugas dapat bergeser, dan hubungan antaranggota keluarga dapat mengalami penyesuaian. Oleh karena

itu, manajemen penyakit kronik dalam keperawatan komunitas perlu menggunakan perspektif keluarga agar perawatan yang diberikan lebih komprehensif.

Perawat komunitas perlu memandang penyakit kronik sebagai kondisi yang membutuhkan pendekatan jangka panjang, bukan sebagai episode pelayanan yang berdiri sendiri. Pengkajian harus dilakukan secara berkala karena kebutuhan pasien dan keluarga dapat berubah sesuai perjalanan penyakit. Rencana pelayanan juga harus fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan perubahan kondisi, tingkat kemandirian, kemampuan keluarga, serta sumber daya yang tersedia.

2. Dampak Penyakit Kronik terhadap Individu dan Keluarga

Penyakit kronik dapat menimbulkan dampak luas terhadap individu, baik secara fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun spiritual. Dampak fisik dapat berupa nyeri berkepanjangan, kelemahan, kelelahan, keterbatasan aktivitas, gangguan tidur, sesak napas, perubahan berat badan, penurunan kemampuan melakukan aktivitas sehari-hari, serta munculnya komplikasi. Keluhan tersebut dapat berlangsung lama dan memengaruhi kemampuan pasien menjalani kehidupan secara normal.

Dampak psikologis juga cukup besar. Pasien dapat mengalami kecemasan karena penyakit yang tidak kunjung sembuh, rasa takut terhadap komplikasi, kekhawatiran terhadap kematian, atau perasaan kehilangan kontrol terhadap kehidupannya. Sebagian pasien dapat merasa sedih, frustrasi, marah, atau tidak berdaya ketika harus bergantung pada orang lain. Perubahan kemampuan fisik juga dapat memengaruhi harga diri dan citra diri.

Penyakit kronik juga dapat menyebabkan perubahan kehidupan sosial pasien. Pasien mungkin mengurangi aktivitas di luar rumah, berhenti bekerja, atau membatasi interaksi sosial karena kondisi fisik. Jika situasi berlangsung lama, risiko isolasi sosial dapat meningkat. Hilangnya kesempatan bekerja dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat juga dapat menurunkan rasa percaya diri dan rasa bermakna dalam kehidupan.

Dari sisi ekonomi, penyakit kronik dapat menimbulkan beban yang cukup besar. Pengeluaran dapat meningkat karena kebutuhan obat, pemeriksaan, transportasi, kontrol, alat kesehatan, rehabilitasi, makanan tertentu, atau kebutuhan perawatan di rumah. Pada saat yang sama, pendapatan keluarga dapat berkurang jika pasien tidak lagi mampu bekerja atau anggota keluarga harus mengurangi aktivitas kerja untuk memberikan perawatan.

Dampak penyakit tidak berhenti pada pasien. Seluruh keluarga dapat mengalami perubahan karena harus menyesuaikan kehidupan dengan kondisi anggota yang sakit. Pasangan mungkin harus mengambil alih pekerjaan rumah tangga, anak dapat memperoleh tanggung jawab tambahan, atau anggota keluarga tertentu menjadi *caregiver* utama. Situasi ini dapat memengaruhi keseimbangan peran dalam keluarga.

Secara emosional, anggota keluarga dapat mengalami rasa khawatir, sedih, takut, atau tidak pasti mengenai masa depan. Mereka mungkin merasa cemas terhadap kemungkinan perburukan penyakit dan terbebani oleh tanggung jawab perawatan. Jika komunikasi keluarga kurang baik, tekanan tersebut dapat memicu konflik.

Penyakit kronik juga dapat memengaruhi pola hubungan antaranggota keluarga. Dalam keluarga yang mampu beradaptasi, kondisi penyakit dapat meningkatkan solidaritas dan kerja sama. Namun, dalam keluarga lain, penyakit dapat menjadi sumber ketegangan jika beban perawatan tidak dibagi secara adil atau terdapat perbedaan pendapat mengenai keputusan perawatan.

Perawat komunitas perlu memahami berbagai dampak tersebut karena fokus pelayanan bukan hanya mengurangi gejala klinis. Keberhasilan perawatan juga perlu dilihat dari kemampuan pasien dan keluarga menjalani kehidupan sehari-hari, mempertahankan fungsi sosial, menjaga kesehatan mental, serta menyesuaikan diri terhadap perubahan yang muncul.

3. Perubahan Peran dan Fungsi Keluarga

Penyakit kronik sering menyebabkan perubahan peran dalam keluarga. Seseorang yang sebelumnya menjadi pencari nafkah dapat kehilangan kemampuan bekerja, sementara anggota keluarga lain harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi. Individu yang sebelumnya bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangga dapat menjadi pasien yang membutuhkan bantuan. Perubahan tersebut membutuhkan proses penyesuaian agar fungsi keluarga tetap berjalan.

Perubahan peran dapat bersifat sementara maupun permanen. Pada penyakit yang masih dapat dikendalikan, pasien mungkin kembali menjalankan sebagian fungsi setelah kondisi stabil. Namun, pada penyakit degeneratif atau kondisi dengan kecacatan permanen, pembagian peran dapat berubah dalam waktu lama. Keluarga perlu menemukan pola baru yang realistis agar tidak ada anggota yang mengalami beban berlebihan.

Fungsi kesehatan keluarga juga dapat berubah. Keluarga perlu meningkatkan kemampuan dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, mempertahankan lingkungan sehat, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Jika sebelumnya tugas tersebut tidak begitu menonjol, penyakit kronik dapat membuat fungsi kesehatan menjadi bagian utama kehidupan keluarga.

Perubahan fungsi ekonomi juga sering terjadi. Pengeluaran bertambah, sementara pendapatan dapat berkurang. Keluarga mungkin harus mengatur ulang prioritas keuangan. Dalam situasi tertentu, kebutuhan pengobatan bersaing dengan kebutuhan pendidikan, pangan, atau biaya rumah tangga lainnya. Kondisi ini dapat menyebabkan stres berkepanjangan apabila sumber daya keluarga terbatas.

Fungsi sosial keluarga juga dapat terpengaruh. Anggota keluarga mungkin mengurangi aktivitas sosial karena harus menemani pasien. Kesempatan untuk mengikuti kegiatan masyarakat, berkumpul dengan kerabat, atau berekreasi dapat berkurang. Jika situasi ini berlangsung terlalu lama, keluarga berisiko mengalami isolasi sosial.

Fungsi emosional dan afektif keluarga juga mengalami tantangan. Pasien membutuhkan dukungan, tetapi anggota keluarga yang merawat juga membutuhkan perhatian. Jika kebutuhan emosional *caregiver* tidak terpenuhi, dapat muncul kelelahan, frustrasi, dan kejenuhan. Oleh karena itu, perawat perlu memastikan bahwa perawatan tidak hanya berpusat pada pasien, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan keluarga.

Perubahan fungsi keluarga perlu dikaji secara menyeluruh. Perawat dapat menilai siapa yang menjadi pengambil keputusan, siapa yang menjadi *caregiver* utama, bagaimana pembagian tugas dilakukan, siapa yang mendukung kebutuhan ekonomi, serta bagaimana anggota keluarga berkomunikasi. Informasi ini penting untuk menentukan apakah keluarga mampu menjalankan perawatan atau membutuhkan dukungan tambahan.

4. Adaptasi Keluarga terhadap Penyakit Kronik

Adaptasi keluarga adalah proses penyesuaian terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh penyakit kronik. Setiap keluarga memiliki kemampuan yang berbeda dalam beradaptasi. Sebagian keluarga dapat menerima kondisi dengan cepat dan mampu mengembangkan strategi baru, sedangkan keluarga lain membutuhkan waktu lebih panjang.

Tahap awal penyakit sering ditandai dengan kebingungan, penolakan, kecemasan, atau ketidakpercayaan. Diagnosis penyakit kronik dapat menjadi

peristiwa besar yang mengubah rencana hidup pasien dan keluarga. Informasi mengenai prognosis, kemungkinan komplikasi, serta kebutuhan pengobatan jangka panjang dapat menimbulkan tekanan emosional.

Seiring berjalannya waktu, keluarga mulai belajar memahami kondisi penyakit. Mereka mulai mengenali jadwal terapi, tanda bahaya, kebutuhan diet, aktivitas yang dapat dilakukan, dan berbagai tindakan perawatan. Tahap ini membutuhkan pendidikan dan pendampingan dari tenaga kesehatan.

Adaptasi yang baik ditandai dengan kemampuan keluarga menerima realitas penyakit, melakukan pembagian peran secara fleksibel, berkomunikasi dengan terbuka, mencari informasi yang benar, serta menggunakan sumber daya yang tersedia. Keluarga juga mampu mempertahankan kehidupan sosial dan emosional meskipun harus menjalani perawatan jangka panjang.

Sebaliknya, adaptasi yang kurang efektif dapat ditandai dengan konflik berkepanjangan, penolakan terhadap pengobatan, ketergantungan berlebihan, ketidakmampuan membagi tanggung jawab, atau isolasi sosial. Dalam kondisi seperti ini, perawat perlu mengidentifikasi hambatan yang menyebabkan keluarga sulit beradaptasi.

Strategi koping keluarga menjadi bagian penting dari adaptasi. Koping dapat berupa mencari dukungan sosial, berbagi tugas, mencari informasi, melakukan kegiatan spiritual, mempertahankan komunikasi, atau menggunakan layanan kesehatan. Strategi koping yang efektif dapat membantu keluarga mempertahankan keseimbangan.

Perawat komunitas dapat membantu proses adaptasi melalui edukasi, konseling, komunikasi terapeutik, dan pemberdayaan. Dukungan perawat dapat meningkatkan rasa percaya diri keluarga bahwa mereka mampu menghadapi perubahan. Keluarga juga perlu dibantu menetapkan harapan yang realistis agar tidak mengalami frustrasi akibat tujuan yang terlalu tinggi.

5. Kebutuhan Perawatan Jangka Panjang

Perawatan jangka panjang diperlukan ketika pasien mengalami kondisi yang membutuhkan pemantauan dan bantuan dalam waktu lama. Tujuannya bukan hanya mengatasi gejala, tetapi juga mempertahankan fungsi, mencegah komplikasi, meningkatkan kemandirian, dan menjaga kualitas hidup.

Kebutuhan perawatan sangat bergantung pada kondisi masing-masing pasien. Pasien yang masih mandiri mungkin hanya membutuhkan pemantauan dan edukasi. Pasien dengan ketergantungan sedang membutuhkan bantuan pada beberapa aktivitas. Pasien dengan ketergantungan berat membutuhkan bantuan hampir sepanjang waktu.

Perawatan jangka panjang dapat mencakup pengelolaan obat, pemantauan tanda vital, pemenuhan nutrisi, perawatan kebersihan, latihan fisik, perawatan kulit, pengaturan eliminasi, dukungan mobilitas, dan pencegahan jatuh. Pada pasien tertentu, perawatan luka, penggunaan alat bantu, atau pemantauan alat kesehatan juga diperlukan.

Pemenuhan nutrisi menjadi komponen penting. Banyak penyakit kronik membutuhkan pengaturan diet khusus. Keluarga perlu memahami rekomendasi diet tanpa mengabaikan kebiasaan dan kemampuan ekonomi. Perawat perlu memberikan saran yang realistis dan dapat diterapkan.

Perawatan jangka panjang juga mencakup pemantauan kondisi psikologis. Pasien dapat mengalami kejenuhan karena harus menjalani terapi dalam waktu lama. Perasaan tidak berdaya dan kehilangan motivasi perlu dikenali sejak dini.

Lingkungan rumah juga harus diperhatikan. Penyesuaian sederhana dapat meningkatkan keamanan pasien, seperti memperbaiki pencahayaan, menghilangkan hambatan, menjaga lantai tidak licin, serta menempatkan barang yang sering digunakan dalam jangkauan.

Kebutuhan perawatan jangka panjang tidak bersifat statis. Kondisi pasien dapat membaik, stabil, atau menurun. Oleh karena itu, pengkajian perlu dilakukan secara berkala agar rencana perawatan tetap sesuai.

6. Dukungan terhadap *Self-Management* Pasien

Self-management merupakan kemampuan pasien dalam mengelola penyakit dan kehidupan sehari-hari secara aktif. Pada penyakit kronik, kemampuan ini menjadi sangat penting karena sebagian besar keputusan dan aktivitas perawatan dilakukan di luar fasilitas kesehatan.

Self-management mencakup kemampuan memahami penyakit, menggunakan obat dengan benar, memantau gejala, mengatur pola makan, melakukan aktivitas fisik, mengelola stres, serta menentukan kapan harus mencari pertolongan. Tujuan utamanya adalah meningkatkan keterlibatan pasien dan mempertahankan kontrol atas kehidupannya.

Dukungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap *self-management*. Keluarga dapat membantu pasien mengingat jadwal obat, menyediakan makanan sesuai kebutuhan, menemani kontrol, dan memberikan motivasi. Namun, dukungan sebaiknya tidak berubah menjadi kontrol berlebihan yang mengurangi kemandirian pasien.

Perawat perlu mendorong pasien melakukan sebanyak mungkin aktivitas yang masih mampu dilakukan. Pasien dengan keterbatasan tidak selalu harus

sepenuhnya bergantung pada keluarga. Setiap kemampuan yang masih ada perlu dipertahankan.

Pendidikan kesehatan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Informasi yang terlalu banyak dalam satu waktu dapat sulit dipahami. Perawat dapat memberikan edukasi secara bertahap dan mengevaluasi pemahaman melalui diskusi atau demonstrasi ulang.

Penetapan tujuan sederhana juga dapat meningkatkan keberhasilan *self-management*. Pasien dapat menetapkan target realistis, seperti berjalan selama beberapa menit, mengurangi makanan tinggi garam, atau minum obat sesuai jadwal. Pencapaian kecil dapat meningkatkan motivasi.

Pemantauan mandiri juga dapat diajarkan sesuai kondisi penyakit. Pasien hipertensi dapat melakukan pemantauan tekanan darah, pasien diabetes dapat memantau gula darah apabila memiliki alat dan kemampuan, sedangkan pasien gagal jantung dapat mengamati perubahan berat badan, sesak, atau edema.

Perawat juga perlu memperhatikan hambatan terhadap *self-management*, seperti rendahnya literasi kesehatan, kesulitan ekonomi, depresi, keterbatasan fisik, atau kurangnya dukungan keluarga. Intervensi perlu disesuaikan dengan hambatan tersebut.

7. Pencegahan Komplikasi dan Kekambuhan

Pencegahan komplikasi merupakan bagian utama dalam manajemen penyakit kronik. Komplikasi dapat menyebabkan penurunan fungsi, meningkatkan ketergantungan, memperpanjang perawatan, dan meningkatkan risiko rawat inap. Karena itu, pasien dan keluarga harus mampu mengenali faktor risiko dan tanda awal perburukan.

Pencegahan dimulai dengan kepatuhan terhadap pengobatan. Pasien perlu memahami tujuan penggunaan obat, jadwal konsumsi, serta pentingnya tidak menghentikan terapi tanpa konsultasi. Keluarga dapat membantu mengatur obat dan memastikan jadwal dipatuhi.

Kontrol terhadap faktor risiko juga penting. Pasien hipertensi perlu menjaga tekanan darah, pasien diabetes perlu mengendalikan glukosa, dan pasien penyakit jantung perlu memperhatikan aktivitas, diet, dan gejala yang mengarah pada perburukan. Perubahan gaya hidup menjadi bagian integral dari pencegahan.

Nutrisi sehat, aktivitas fisik sesuai kemampuan, tidur cukup, berhenti merokok, dan pengelolaan stres dapat membantu menjaga kondisi.

Rekomendasi harus disesuaikan dengan kemampuan pasien dan tidak boleh dipaksakan secara tidak realistis.

Pencegahan komplikasi juga mencakup perawatan terhadap risiko akibat ketergantungan. Pasien dengan mobilitas terbatas perlu dicegah dari luka tekan, kontraktur, jatuh, dan infeksi. Perubahan posisi, latihan, perawatan kulit, dan lingkungan aman menjadi bagian penting.

Deteksi dini tanda bahaya harus diajarkan kepada keluarga. Tanda seperti sesak yang memburuk, nyeri dada, penurunan kesadaran, kelemahan mendadak, kejang, demam tinggi, muntah terus-menerus, atau perubahan kondisi yang signifikan membutuhkan perhatian segera.

Keluarga perlu mengetahui ke mana harus mencari pertolongan. Informasi mengenai fasilitas pelayanan terdekat, nomor kontak, sistem rujukan, dan jadwal kontrol perlu tersedia.

Pencegahan kekambuhan juga memerlukan evaluasi terhadap faktor pencetus. Jika perburukan terjadi setelah pasien tidak minum obat, maka intervensi perlu diarahkan pada kepatuhan. Jika kekambuhan berhubungan dengan pola makan atau aktivitas, aspek tersebut perlu dibahas kembali.

Setiap episode kekambuhan dapat menjadi kesempatan belajar. Setelah kondisi stabil, perawat bersama pasien dan keluarga dapat mengevaluasi apa yang terjadi, faktor apa yang berkontribusi, dan perubahan apa yang perlu dilakukan. Pendekatan ini membantu keluarga menjadi semakin mampu mengelola penyakit.

Pada akhirnya, manajemen keluarga dengan anggota yang mengalami penyakit kronik membutuhkan keterlibatan aktif pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Penyakit kronik bukan hanya masalah medis, tetapi juga memengaruhi kehidupan sehari-hari, peran keluarga, kemampuan ekonomi, kondisi psikologis, dan kualitas hubungan antaranggota keluarga. Oleh karena itu, pelayanan perlu dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kemampuan keluarga. Melalui dukungan terhadap adaptasi, perawatan jangka panjang, *self-management*, serta pencegahan komplikasi dan kekambuhan, keluarga dapat menjadi mitra utama dalam mempertahankan kondisi kesehatan dan kualitas hidup pasien.

D. Ketergantungan dan Kebutuhan Perawatan dalam Keluarga

1. Konsep dan Tingkat Ketergantungan

Ketergantungan dalam konteks kesehatan merupakan kondisi ketika seseorang membutuhkan bantuan dari orang lain untuk memenuhi sebagian atau seluruh kebutuhan sehari-hari akibat keterbatasan fisik, kognitif,

psikologis, atau sosial. Ketergantungan dapat bersifat sementara maupun menetap, bergantung pada penyebab, tingkat keparahan penyakit, respons terhadap terapi, usia, serta kemampuan individu untuk melakukan proses pemulihan. Dalam keperawatan komunitas, kondisi ketergantungan menjadi perhatian penting karena sebagian besar kebutuhan perawatan pasien berlangsung di rumah dan melibatkan keluarga sebagai pemberi dukungan utama.

Ketergantungan tidak selalu berarti seseorang kehilangan seluruh kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Sebagian pasien masih mampu melakukan beberapa aktivitas secara mandiri, tetapi memerlukan bantuan untuk aktivitas lain. Sebagai contoh, seorang pasien pascastroke mungkin masih mampu makan sendiri tetapi membutuhkan bantuan untuk mandi, berpakaian, berpindah tempat, atau menggunakan toilet. Pasien lain dapat memiliki kemampuan fisik yang cukup baik, tetapi mengalami gangguan kognitif sehingga membutuhkan pengawasan dalam penggunaan obat, pengelolaan keuangan, atau aktivitas yang berhubungan dengan keselamatan. Oleh karena itu, tingkat ketergantungan harus dipahami sebagai suatu spektrum dan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan diagnosis penyakit.

Secara umum, tingkat ketergantungan dapat digambarkan mulai dari kondisi mandiri, ketergantungan ringan, ketergantungan sedang, hingga ketergantungan berat atau total. Pada individu yang mandiri, sebagian besar aktivitas sehari-hari dapat dilakukan tanpa bantuan orang lain. Individu dengan ketergantungan ringan mungkin membutuhkan bantuan pada aktivitas tertentu, misalnya mandi atau menggunakan transportasi. Pada ketergantungan sedang, bantuan biasanya dibutuhkan untuk beberapa aktivitas dasar secara teratur. Sementara itu, pada ketergantungan berat, pasien memerlukan bantuan hampir dalam seluruh aktivitas sehari-hari dan mungkin membutuhkan pengawasan terus-menerus.

Tingkat ketergantungan dapat berubah dari waktu ke waktu. Pada pasien yang menjalani rehabilitasi, ketergantungan dapat berkurang seiring meningkatnya kekuatan, keseimbangan, dan keterampilan fungsional. Sebaliknya, pada penyakit degeneratif atau progresif, tingkat ketergantungan dapat meningkat secara bertahap. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penilaian ketergantungan perlu dilakukan secara berkala dan tidak cukup hanya pada awal perawatan.

Dalam konteks keluarga, penilaian tingkat ketergantungan diperlukan untuk menentukan jenis dan jumlah bantuan yang dibutuhkan pasien, menentukan beban perawatan yang mungkin muncul, serta membantu

keluarga mempersiapkan sumber daya yang diperlukan. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin besar kemungkinan pasien membutuhkan bantuan dalam mobilitas, kebersihan diri, nutrisi, eliminasi, pengobatan, pemantauan kondisi, hingga pengambilan keputusan.

Pemahaman mengenai tingkat ketergantungan juga penting untuk mencegah dua kondisi yang sama-sama tidak diharapkan, yaitu kurangnya bantuan dan bantuan yang berlebihan. Kurangnya bantuan dapat meningkatkan risiko jatuh, cedera, malnutrisi, kesalahan penggunaan obat, atau komplikasi lain. Sebaliknya, memberikan bantuan secara berlebihan pada aktivitas yang masih mampu dilakukan pasien dapat mempercepat penurunan fungsi dan meningkatkan ketergantungan. Karena itu, perawatan ideal diarahkan pada pemberian bantuan sesuai kebutuhan sekaligus mempertahankan kemampuan pasien semaksimal mungkin.

2. Faktor Penyebab Ketergantungan

Ketergantungan dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi. Penyakit kronik merupakan salah satu penyebab yang paling sering ditemukan. Kondisi seperti stroke, penyakit jantung, penyakit paru kronik, penyakit ginjal kronik, diabetes melitus dengan komplikasi, kanker, gangguan neurologis, dan penyakit degeneratif dapat menurunkan kemampuan pasien dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Semakin berat komplikasi yang terjadi, semakin tinggi pula risiko terjadinya ketergantungan.

Gangguan pada sistem saraf sering menyebabkan ketergantungan karena dapat memengaruhi kemampuan motorik, koordinasi, keseimbangan, komunikasi, dan fungsi kognitif. Pasien pascastroke dapat mengalami hemiparesis, gangguan bicara, kesulitan menelan, atau gangguan keseimbangan yang menyebabkan kebutuhan bantuan meningkat. Pada gangguan neurodegeneratif, penurunan fungsi dapat berlangsung progresif sehingga kebutuhan terhadap dukungan keluarga bertambah dari waktu ke waktu.

Gangguan muskuloskeletal juga dapat menjadi penyebab ketergantungan. Osteoartritis berat, osteoporosis dengan komplikasi fraktur, nyeri kronik, deformitas sendi, atau kondisi pascaoperasi dapat menghambat kemampuan berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Hambatan mobilitas tidak hanya berdampak pada aktivitas fisik, tetapi dapat memengaruhi kemampuan pasien pergi ke kamar mandi, menyiapkan makanan, membersihkan diri, dan melakukan aktivitas sosial.

Proses penuaan juga dapat meningkatkan risiko ketergantungan. Penuaan normal dapat disertai penurunan kekuatan otot, keseimbangan, kecepatan berjalan, fungsi sensorik, serta cadangan fisiologis. Jika perubahan tersebut disertai penyakit kronik, risiko penurunan kemandirian akan semakin besar. Namun, usia lanjut tidak secara otomatis berarti ketergantungan. Banyak lansia tetap mampu menjalankan aktivitas secara mandiri apabila kondisi kesehatan, lingkungan, dan dukungan sosial memadai.

Faktor kognitif juga sangat memengaruhi tingkat kemandirian. Pasien yang mengalami gangguan memori, orientasi, perhatian, atau kemampuan mengambil keputusan mungkin secara fisik masih mampu melakukan aktivitas, tetapi tidak dapat melakukannya dengan aman. Pasien dengan gangguan kognitif dapat lupa mematikan kompor, mengonsumsi obat berulang kali, tersesat ketika keluar rumah, atau gagal mengenali tanda bahaya. Kondisi seperti ini membutuhkan pengawasan dari keluarga meskipun kemampuan motorik relatif baik.

Gangguan psikologis juga dapat menyebabkan atau memperberat ketergantungan. Depresi, kecemasan berat, kehilangan motivasi, atau rasa takut melakukan aktivitas dapat membuat pasien membatasi diri secara berlebihan. Pada sebagian pasien, ketergantungan meningkat bukan semata-mata karena ketidakmampuan fisik, tetapi karena rasa takut jatuh, takut mengalami nyeri, atau merasa tidak mampu. Pendekatan keperawatan perlu membedakan antara keterbatasan nyata dan keterbatasan yang dipengaruhi faktor psikologis.

Lingkungan juga berperan terhadap ketergantungan. Rumah dengan banyak tangga, lantai licin, kamar mandi yang sulit diakses, pencahayaan kurang, atau ruang gerak sempit dapat membuat pasien lebih bergantung pada orang lain. Sebaliknya, lingkungan yang dimodifikasi dengan baik dapat meningkatkan kemandirian. Sebagai contoh, pemasangan pegangan, penggunaan kursi mandi, penempatan benda yang sering digunakan dalam jangkauan, serta penataan jalur berjalan yang aman dapat membantu pasien melakukan aktivitas secara lebih mandiri.

Selain itu, faktor sosial dan ekonomi dapat memengaruhi tingkat ketergantungan. Keterbatasan biaya dapat menghambat akses terhadap alat bantu, rehabilitasi, transportasi, atau pelayanan kesehatan. Kurangnya dukungan keluarga juga dapat menyebabkan kebutuhan pasien tidak terpenuhi secara optimal. Karena itu, ketergantungan perlu dipandang sebagai kondisi multidimensional yang tidak hanya ditentukan oleh penyakit, tetapi juga oleh lingkungan dan sumber daya keluarga.

3. Ketergantungan Fisik, Psikologis, Sosial, dan Fungsional

Ketergantungan dapat muncul dalam berbagai dimensi. Ketergantungan fisik merupakan bentuk yang paling mudah dikenali karena berkaitan langsung dengan kemampuan tubuh melakukan aktivitas. Pasien dengan kelemahan, gangguan keseimbangan, nyeri, kelumpuhan, atau keterbatasan gerak dapat memerlukan bantuan untuk berpindah posisi, berjalan, mandi, berpakaian, makan, atau menggunakan toilet. Kondisi tersebut sering ditemukan pada pasien pascastroke, lansia dengan keterbatasan mobilitas, pasien dengan cedera berat, atau individu dengan penyakit degeneratif.

Ketergantungan psikologis dapat muncul ketika pasien merasa tidak mampu menjalani kehidupan tanpa dukungan orang lain meskipun sebagian kemampuan fisiknya masih baik. Ketergantungan ini dapat berkembang akibat kecemasan, depresi, rasa takut, pengalaman kegagalan, atau terlalu sering dibantu oleh keluarga. Pasien mungkin menjadi enggan mencoba melakukan aktivitas sendiri karena merasa lebih aman jika selalu didampingi.

Dalam kondisi seperti ini, keluarga perlu memahami pentingnya memberikan dukungan tanpa mengambil alih seluruh aktivitas. Dorongan yang tepat dapat membantu pasien membangun kembali rasa percaya diri. Perawat dapat membantu keluarga mengenali kemampuan yang masih dimiliki pasien dan mendorong keterlibatan pasien secara bertahap.

Ketergantungan sosial berkaitan dengan kebutuhan terhadap orang lain dalam mempertahankan interaksi, hubungan, dan partisipasi sosial. Penyakit kronik atau kecacatan dapat menyebabkan pasien kehilangan pekerjaan, mengurangi aktivitas masyarakat, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Ketergantungan sosial juga dapat muncul ketika pasien hanya bergantung pada satu anggota keluarga untuk memperoleh informasi, akses pelayanan, transportasi, atau hubungan dengan dunia luar.

Ketergantungan fungsional merujuk pada keterbatasan dalam melakukan aktivitas yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari-hari secara mandiri. Ketergantungan fungsional dapat mencakup aktivitas dasar maupun aktivitas yang lebih kompleks. Pasien yang mengalami ketergantungan fungsional mungkin masih mampu berbicara dan mengambil keputusan, tetapi tidak mampu melakukan aktivitas tertentu tanpa bantuan.

Keempat dimensi ketergantungan tersebut sering kali saling berkaitan. Keterbatasan fisik dapat menyebabkan penurunan partisipasi sosial. Penurunan partisipasi sosial dapat memicu masalah psikologis. Masalah psikologis kemudian dapat menurunkan motivasi untuk melakukan aktivitas

fisik sehingga ketergantungan semakin berat. Karena itu, pendekatan terhadap pasien dengan ketergantungan tidak boleh hanya berfokus pada aspek fisik.

4. Penilaian *Activities of Daily Living* (ADL)

Penilaian *Activities of Daily Living* atau ADL digunakan untuk mengetahui kemampuan individu dalam melakukan aktivitas dasar sehari-hari. Penilaian ini sangat penting dalam keperawatan karena memberikan gambaran tentang tingkat kemandirian pasien dan kebutuhan bantuan yang diperlukan. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun rencana perawatan, menentukan kebutuhan *caregiver*, serta mengevaluasi perubahan kemampuan pasien dari waktu ke waktu.

Aktivitas dasar sehari-hari mencakup kegiatan yang berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan pribadi. Kemampuan makan merupakan salah satu aspek yang dinilai, termasuk kemampuan pasien mengambil makanan, membawa makanan ke mulut, mengunyah, dan menelan secara aman. Pasien yang memiliki gangguan motorik atau gangguan menelan mungkin membutuhkan bantuan khusus selama makan.

Kemampuan mandi juga menjadi bagian penting dalam ADL. Aktivitas ini memerlukan kemampuan berdiri atau duduk dengan stabil, menjangkau bagian tubuh, menggunakan perlengkapan mandi, dan menjaga keselamatan di lingkungan yang berpotensi licin. Pasien dengan keterbatasan keseimbangan mungkin dapat melakukan sebagian aktivitas mandi sendiri tetapi tetap membutuhkan pengawasan.

Kemampuan berpakaian menilai apakah pasien dapat memilih pakaian, mengenakan pakaian, menggunakan kancing atau ritsleting, serta melepas pakaian tanpa bantuan. Aktivitas ini membutuhkan koordinasi motorik yang cukup baik dan dapat menjadi indikator kemampuan fungsi anggota gerak.

Kemampuan menggunakan toilet juga dinilai karena berkaitan dengan privasi, martabat, dan kemandirian pasien. Penilaian mencakup kemampuan menuju toilet, menggunakan toilet dengan aman, membersihkan diri, serta mengatur pakaian. Gangguan mobilitas atau inkontinensia dapat meningkatkan kebutuhan bantuan.

Perpindahan atau transfer merupakan kemampuan pasien berpindah dari satu posisi atau tempat ke tempat lain, misalnya dari tempat tidur ke kursi. Kemampuan transfer sangat penting karena berkaitan dengan mobilitas dan risiko jatuh. Pasien yang tidak mampu melakukan transfer dengan aman membutuhkan bantuan atau alat bantu yang sesuai.

Mobilitas juga menjadi bagian penilaian ADL. Kemampuan berjalan, menggunakan kursi roda, atau bergerak di dalam rumah perlu dinilai. Perawat tidak hanya melihat apakah pasien mampu bergerak, tetapi juga apakah aktivitas tersebut dapat dilakukan secara aman.

Penilaian ADL memberikan informasi penting mengenai tingkat ketergantungan. Jika pasien mengalami ketergantungan pada banyak aktivitas dasar, kebutuhan bantuan akan semakin tinggi. Hasil penilaian dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan intervensi, kebutuhan rehabilitasi, modifikasi lingkungan, serta pendidikan bagi keluarga.

Penilaian juga harus dilakukan secara berkala karena kemampuan pasien dapat berubah. Peningkatan skor kemandirian dapat menjadi indikator keberhasilan rehabilitasi. Sebaliknya, penurunan kemampuan dapat menunjukkan adanya perburukan penyakit, komplikasi baru, atau masalah lain yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

5. Penilaian *Instrumental Activities of Daily Living* (IADL)

Jika ADL berfokus pada aktivitas dasar, *Instrumental Activities of Daily Living* atau IADL digunakan untuk menilai kemampuan individu melakukan aktivitas yang lebih kompleks dan diperlukan untuk menjalani kehidupan secara mandiri di masyarakat. Penilaian IADL sangat berguna terutama pada lansia, pasien dengan penyakit kronik, serta individu dengan gangguan kognitif ringan.

Kemampuan menggunakan telepon atau sarana komunikasi merupakan salah satu aspek IADL. Kemampuan ini penting karena pasien perlu dapat menghubungi keluarga, tenaga kesehatan, atau layanan darurat ketika membutuhkan bantuan. Gangguan penglihatan, pendengaran, atau kognitif dapat menghambat kemampuan tersebut.

Kemampuan berbelanja juga dapat dinilai. Aktivitas ini membutuhkan kemampuan membuat keputusan, mengingat kebutuhan, mengatur uang, melakukan perjalanan, dan membawa barang. Pasien yang mengalami gangguan mobilitas atau kognitif mungkin memerlukan bantuan meskipun masih mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri.

Persiapan makanan merupakan aktivitas kompleks yang membutuhkan kemampuan merencanakan menu, menyiapkan bahan, menggunakan peralatan, menjaga keamanan, dan memahami kebutuhan diet. Pada pasien dengan penyakit kronik, kemampuan ini menjadi penting karena pola makan merupakan bagian dari pengelolaan penyakit.

Kemampuan melakukan pekerjaan rumah tangga juga dapat memberikan gambaran fungsi seseorang. Membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menjaga lingkungan membutuhkan kekuatan, koordinasi, stamina, dan kemampuan mengorganisasi aktivitas. Penurunan kemampuan melakukan pekerjaan rumah dapat menjadi tanda awal penurunan fungsi.

Penggunaan transportasi merupakan bagian penting dari kemandirian. Pasien perlu mampu bepergian ke fasilitas kesehatan, berbelanja, atau mengikuti kegiatan sosial. Ketidakmampuan menggunakan transportasi dapat membuat pasien semakin bergantung pada keluarga.

Pengelolaan obat juga merupakan salah satu aspek penting IADL. Pasien perlu mampu mengenali obat, memahami jadwal, mengambil dosis yang tepat, dan mengetahui aturan penggunaan. Pada pasien yang menggunakan banyak obat, kesalahan dapat terjadi jika kemampuan kognitif menurun.

Pengelolaan keuangan juga sering digunakan untuk menilai kemandirian. Kemampuan membayar kebutuhan, mengatur pengeluaran, mengenali nilai uang, dan mengambil keputusan finansial membutuhkan fungsi kognitif yang cukup baik. Penurunan kemampuan ini dapat menjadi salah satu tanda awal gangguan kognitif.

Penilaian IADL memberikan gambaran tentang kemampuan seseorang hidup secara mandiri di komunitas. Seorang pasien dapat memiliki ADL yang baik tetapi mengalami ketergantungan pada IADL. Sebagai contoh, pasien masih mampu mandi dan makan sendiri tetapi tidak mampu mengelola obat atau melakukan perjalanan ke fasilitas kesehatan. Karena itu, penggunaan penilaian ADL dan IADL secara bersama dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap.

6. Dampak Ketergantungan terhadap Pasien dan Keluarga

Ketergantungan dapat memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan pasien. Salah satu dampak utama adalah berkurangnya rasa kemandirian. Individu yang sebelumnya mampu memenuhi kebutuhan sendiri dapat mengalami kesulitan menerima kenyataan bahwa dirinya membutuhkan bantuan. Situasi ini dapat memicu rasa malu, sedih, marah, kecewa, atau kehilangan harga diri.

Ketergantungan juga dapat memengaruhi privasi pasien. Aktivitas seperti mandi, berpakaian, atau eliminasi merupakan aktivitas yang sangat pribadi. Ketika pasien membutuhkan bantuan, rasa malu atau tidak nyaman dapat muncul. Oleh karena itu, keluarga dan tenaga kesehatan perlu menjaga privasi dan martabat pasien selama memberikan perawatan.

Dampak lainnya adalah penurunan partisipasi sosial. Pasien yang sulit berjalan atau membutuhkan bantuan dapat menjadi enggan keluar rumah. Keterbatasan tersebut dapat menyebabkan rasa kesepian dan isolasi sosial. Jika tidak ditangani, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental.

Ketergantungan juga dapat menimbulkan risiko komplikasi fisik. Pasien yang kurang bergerak memiliki risiko luka tekan, kelemahan otot, kekakuan sendi, gangguan sirkulasi, gangguan pernapasan, dan konstipasi. Pasien yang membutuhkan bantuan makan juga berisiko mengalami gangguan nutrisi apabila kebutuhan tidak dipenuhi dengan baik.

Bagi keluarga, ketergantungan pasien meningkatkan kebutuhan waktu, tenaga, dan perhatian. Anggota keluarga mungkin harus menyesuaikan jadwal kerja, kegiatan sosial, atau waktu istirahat untuk memberikan perawatan. Jika tanggung jawab terpusat pada satu orang, risiko kelelahan dan *caregiver burden* dapat meningkat.

Tekanan ekonomi juga dapat muncul akibat kebutuhan perawatan. Keluarga mungkin membutuhkan alat bantu, transportasi, obat, bahan perawatan, atau modifikasi rumah. Pada saat bersamaan, penghasilan dapat berkurang jika pasien atau *caregiver* tidak dapat bekerja seperti sebelumnya.

Hubungan keluarga juga dapat mengalami perubahan. Ketergantungan dapat mempererat hubungan jika anggota keluarga saling bekerja sama. Namun, kondisi ini juga dapat menjadi sumber konflik apabila pembagian tanggung jawab dianggap tidak adil. Perawat komunitas perlu menilai dinamika tersebut dan membantu keluarga membangun komunikasi yang lebih efektif.

7. Kebutuhan Perawatan Pasien dengan Ketergantungan

Pasien dengan ketergantungan membutuhkan perawatan yang disesuaikan dengan kemampuan yang masih dimiliki. Tujuan utama bukan sekadar memenuhi seluruh kebutuhan pasien, tetapi juga mempertahankan fungsi, mencegah komplikasi, meningkatkan kenyamanan, serta mendukung kemandirian optimal.

Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan prioritas. Nutrisi dan hidrasi perlu dipastikan sesuai kondisi. Pasien yang mengalami gangguan menelan membutuhkan perhatian khusus untuk mencegah aspirasi. Posisi saat makan, tekstur makanan, dan kecepatan pemberian perlu disesuaikan dengan kemampuan pasien.

Kebersihan diri juga merupakan bagian penting. Bantuan mandi, perawatan mulut, perawatan rambut, dan perawatan kulit perlu dilakukan

dengan tetap melibatkan pasien sebanyak mungkin. Kegiatan ini tidak hanya menjaga kebersihan, tetapi juga membantu mempertahankan kenyamanan dan harga diri.

Mobilisasi menjadi kebutuhan penting pada pasien dengan ketergantungan. Pasien yang terlalu lama berada dalam satu posisi berisiko mengalami berbagai komplikasi. Perubahan posisi, latihan rentang gerak, latihan duduk, berdiri, atau berjalan perlu dilakukan sesuai kemampuan dan kondisi medis.

Pencegahan luka tekan harus mendapat perhatian pada pasien yang banyak berbaring. Perawat dan keluarga perlu memperhatikan kondisi kulit, area yang mendapat tekanan, kelembapan, status nutrisi, dan frekuensi perubahan posisi. Identifikasi dini kemerahan atau perubahan integritas kulit dapat mencegah perkembangan luka yang lebih berat.

Keselamatan merupakan komponen utama. Risiko jatuh harus dinilai pada pasien dengan kelemahan, gangguan keseimbangan, atau gangguan penglihatan. Lingkungan perlu diatur agar aman. Alat bantu berjalan perlu digunakan dengan benar dan keluarga perlu memahami cara mendampingi pasien.

Pengelolaan obat juga penting. Pasien dengan ketergantungan mungkin tidak mampu mengingat atau mengambil obat sendiri. Keluarga perlu memahami nama, dosis, jadwal, dan cara penggunaan obat. Kesalahan pemberian obat harus dicegah dengan sistem pencatatan atau pengorganisasian yang sederhana.

Pemantauan tanda dan gejala juga perlu dilakukan sesuai kondisi penyakit. Keluarga harus mampu mengenali perubahan penting seperti sesak, penurunan kesadaran, demam, nyeri baru, perubahan pola makan, perubahan eliminasi, atau penurunan kemampuan aktivitas. Temuan yang mencurigakan perlu segera dikonsultasikan.

Dukungan psikologis tidak boleh diabaikan. Pasien perlu dilibatkan dalam percakapan, keputusan, dan aktivitas sesuai kemampuan. Mengabaikan pendapat pasien dapat memperkuat rasa tidak berdaya. Sebaliknya, keterlibatan pasien dapat membantu mempertahankan identitas dan rasa bermakna.

Kebutuhan sosial juga perlu dijaga. Pasien yang memiliki keterbatasan mobilitas tetap membutuhkan interaksi dengan keluarga, tetangga, atau lingkungan sosial. Apabila memungkinkan, pasien perlu didukung untuk tetap mengikuti aktivitas yang sesuai kemampuan.

Perawatan spiritual dapat diberikan sesuai nilai dan keyakinan pasien. Aktivitas spiritual dapat menjadi sumber ketenangan dan harapan. Keluarga perlu memberikan kesempatan kepada pasien untuk menjalankan praktik spiritual sesuai keinginan.

Kebutuhan *caregiver* juga merupakan bagian dari perawatan pasien. Perawatan yang baik hanya dapat berlangsung jika orang yang merawat juga berada dalam kondisi yang cukup sehat. Karena itu, pembagian tugas, waktu istirahat, dukungan sosial, serta pendidikan mengenai teknik perawatan perlu diberikan.

Perawat komunitas memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kebutuhan tersebut terpenuhi secara seimbang. Perawat perlu membantu keluarga memahami kondisi pasien, mengajarkan keterampilan perawatan, mengevaluasi keamanan lingkungan, memantau perkembangan kemampuan, serta menghubungkan keluarga dengan layanan yang dibutuhkan.

Pada akhirnya, ketergantungan harus dipahami tidak hanya sebagai keterbatasan, tetapi sebagai kondisi yang membutuhkan pengelolaan terencana agar pasien dapat mempertahankan kualitas hidup. Pendekatan yang tepat dapat membantu mengurangi komplikasi, mempertahankan fungsi yang masih ada, meningkatkan rasa aman, dan mengurangi beban keluarga. Melalui pengkajian ADL dan IADL yang teratur, pemahaman terhadap berbagai dimensi ketergantungan, serta pemberian perawatan yang berpusat pada pasien dan keluarga, perawat komunitas dapat membantu keluarga menjalankan perawatan secara lebih efektif, aman, dan manusiawi.

E. *Caregiver* dan *Caregiver Burden* dalam Keluarga

1. Pengertian dan Jenis *Caregiver*

Caregiver merupakan individu yang memberikan bantuan, pendampingan, pengawasan, dan perawatan kepada seseorang yang mengalami keterbatasan akibat penyakit, disabilitas, proses penuaan, gangguan kognitif, atau kondisi lain yang menyebabkan kebutuhan terhadap bantuan dalam kehidupan sehari-hari. Peran *caregiver* menjadi sangat penting pada pasien dengan penyakit kronik dan ketergantungan karena sebagian besar proses perawatan tidak berlangsung di rumah sakit, melainkan di rumah dan lingkungan keluarga. Dalam konteks tersebut, *caregiver* menjadi pihak yang paling sering berinteraksi dengan pasien dan memiliki peran besar dalam mempertahankan kontinuitas perawatan.

Secara umum, *caregiver* dapat dibedakan menjadi *formal caregiver* dan *informal caregiver*. *Formal caregiver* merupakan individu yang memberikan

perawatan sebagai bagian dari pekerjaan atau profesinya dan umumnya memperoleh pendidikan, pelatihan, serta kompensasi atas pelayanan yang diberikan. Tenaga kesehatan, pendamping profesional, atau tenaga perawatan di rumah dapat termasuk dalam kelompok ini sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Sebaliknya, *informal caregiver* memberikan perawatan bukan sebagai pekerjaan profesional, melainkan karena hubungan keluarga, kedekatan emosional, tanggung jawab sosial, atau komitmen pribadi terhadap pasien.

Dalam kehidupan keluarga, bentuk *informal caregiver* yang paling sering ditemukan adalah *family caregiver*. *Family caregiver* dapat berupa pasangan, anak, orang tua, saudara kandung, menantu, atau anggota keluarga lain yang mengambil tanggung jawab dalam merawat pasien. Peran ini sering terbentuk secara alami ketika salah satu anggota keluarga mengalami penyakit atau keterbatasan. Pada banyak kasus, tidak terdapat proses pemilihan formal mengenai siapa yang menjadi *caregiver*. Seseorang dapat mengambil peran tersebut karena tinggal serumah dengan pasien, memiliki waktu lebih banyak, dianggap paling mampu, memiliki hubungan paling dekat dengan pasien, atau karena tidak ada anggota keluarga lain yang dapat menjalankan perawatan.

Terdapat pula *caregiver* utama dan *caregiver* pendamping. *Caregiver* utama adalah orang yang memikul sebagian besar tanggung jawab perawatan dan biasanya menjadi pihak yang paling sering mendampingi pasien. Sementara itu, *caregiver* pendamping dapat membantu pada waktu atau tugas tertentu, misalnya mengantar kontrol, membeli obat, membantu kebutuhan ekonomi, atau menggantikan *caregiver* utama ketika beristirahat. Pembagian peran seperti ini sangat penting karena perawatan pasien dengan ketergantungan tinggi dapat menjadi terlalu berat apabila seluruh tanggung jawab hanya diberikan kepada satu orang.

Peran *caregiver* dapat bersifat sementara maupun jangka panjang. Pada pasien yang mengalami cedera atau kondisi pemulihan tertentu, kebutuhan terhadap *caregiver* dapat menurun setelah fungsi pasien membaik. Sebaliknya, pada penyakit degeneratif, penyakit neurologis kronik, gangguan kognitif, atau kondisi dengan kecacatan permanen, peran *caregiver* dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Lamanya periode perawatan akan memengaruhi beban yang dirasakan sehingga kebutuhan dukungan terhadap *caregiver* harus dinilai sejak awal.

Tidak semua *caregiver* memiliki kesiapan yang sama. Ada individu yang menerima peran perawatan dengan kesiapan yang cukup baik, tetapi ada pula yang harus menjalankannya secara mendadak setelah anggota keluarga

mengalami stroke, kecelakaan, atau penyakit berat. Perubahan yang terjadi secara tiba-tiba dapat menimbulkan kebingungan karena *caregiver* belum memahami cara memberikan perawatan, belum siap secara emosional, dan belum menyesuaikan aktivitas kehidupan sehari-hari.

Dalam keperawatan komunitas, *caregiver* tidak seharusnya hanya dipandang sebagai sumber tenaga yang membantu pasien. *Caregiver* merupakan bagian dari sistem keluarga yang juga memiliki kebutuhan kesehatan, psikologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, pengkajian terhadap keluarga harus mencakup kondisi *caregiver*, kapasitasnya dalam memberikan perawatan, sumber dukungan yang dimiliki, serta risiko munculnya beban perawatan.

2. Peran dan Tanggung Jawab *Family Caregiver*

Peran *family caregiver* sangat luas dan dapat berubah sesuai kondisi pasien. Pada pasien dengan ketergantungan ringan, *caregiver* mungkin hanya membantu mengingatkan obat, mendampingi kontrol, menyiapkan makanan, atau membantu transportasi. Namun, pada pasien dengan ketergantungan berat, *caregiver* dapat terlibat hampir dalam seluruh aktivitas pasien, mulai dari kebersihan diri, nutrisi, eliminasi, mobilisasi, pengobatan, hingga pemantauan tanda dan gejala.

Salah satu peran dasar *family caregiver* adalah membantu pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pasien yang mengalami keterbatasan mungkin membutuhkan bantuan mandi, berpakaian, makan, menggunakan toilet, berpindah posisi, atau berjalan. Bantuan harus diberikan sesuai tingkat kemampuan pasien. Tujuannya bukan menggantikan seluruh aktivitas pasien, tetapi membantu pada bagian yang tidak mampu dilakukan agar kemandirian yang masih tersisa tetap terpelihara.

Family caregiver juga memiliki peran dalam pengelolaan pengobatan. Pada pasien yang menggunakan obat dalam jangka panjang, *caregiver* dapat membantu memastikan bahwa obat dikonsumsi sesuai waktu, dosis, dan petunjuk. Jika pasien mengonsumsi beberapa jenis obat, pengorganisasian menjadi lebih penting untuk mencegah dosis terlewat, penggunaan berulang, atau kesalahan obat. *Caregiver* juga perlu mengetahui apabila terdapat efek samping tertentu yang perlu dikonsultasikan kepada tenaga kesehatan.

Pemantauan kondisi pasien merupakan tanggung jawab lain yang sering dilakukan oleh *caregiver*. Karena berada bersama pasien dalam kehidupan sehari-hari, *caregiver* dapat menjadi pihak pertama yang mengetahui perubahan kondisi. Perubahan pola makan, kemampuan bergerak, tidur,

perilaku, kesadaran, nyeri, pernapasan, suhu tubuh, eliminasi, atau kondisi kulit dapat memberikan informasi penting mengenai perkembangan penyakit.

Pada pasien tertentu, *caregiver* dapat membantu melakukan pemantauan sederhana di rumah, misalnya mengukur tekanan darah, berat badan, atau kadar glukosa darah jika memang dibutuhkan dan sudah diberikan pelatihan. Hasil pemantauan dapat dicatat untuk membantu evaluasi ketika pasien melakukan kontrol. Namun, *caregiver* perlu memahami batas kemampuannya dan tidak menggantikan penilaian profesional ketika terjadi perubahan yang membutuhkan pemeriksaan tenaga kesehatan.

Peran penting lainnya adalah memberikan dukungan emosional. Pasien dengan penyakit kronik sering menghadapi perubahan besar dalam kehidupan. Kehilangan kemandirian, keterbatasan aktivitas, perubahan pekerjaan, ketidakpastian penyakit, atau rasa takut terhadap komplikasi dapat menyebabkan tekanan psikologis. Kehadiran *caregiver* yang mampu mendengarkan, memberikan dukungan, dan mempertahankan komunikasi yang baik dapat membantu pasien menghadapi kondisi tersebut.

Family caregiver juga menjadi penghubung antara pasien dan fasilitas pelayanan kesehatan. *Caregiver* sering bertugas mengatur jadwal kontrol, menyiapkan dokumen, menyampaikan perkembangan kondisi, menerima edukasi, dan memastikan rekomendasi tenaga kesehatan diterapkan di rumah. Dengan demikian, kualitas komunikasi antara *caregiver* dan tenaga kesehatan sangat memengaruhi kesinambungan perawatan.

Dalam beberapa situasi, *caregiver* juga terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun, keputusan mengenai perawatan tetap perlu mempertimbangkan kemampuan pasien dalam menentukan pilihannya sendiri. Jika pasien masih mampu memahami informasi dan mengambil keputusan, keinginan pasien harus dihormati. *Caregiver* sebaiknya mendukung proses tersebut, bukan mengambil alih secara otomatis.

Perawat komunitas perlu membantu keluarga membagi tanggung jawab secara proporsional. Tidak semua kebutuhan harus dipenuhi oleh *caregiver* utama. Tugas dapat dibagi sesuai kemampuan anggota keluarga, misalnya satu anggota bertanggung jawab mengantar kontrol, anggota lain membantu kebutuhan rumah tangga, dan anggota lainnya menggantikan *caregiver* utama pada waktu tertentu. Pembagian tersebut dapat mengurangi risiko kelelahan dan mempertahankan keberlanjutan perawatan.

3. Kebutuhan Pengetahuan dan Keterampilan *Caregiver*

Kemampuan memberikan perawatan tidak muncul secara otomatis hanya karena seseorang menjadi anggota keluarga pasien. Banyak *caregiver* harus melakukan berbagai tugas yang sebelumnya tidak pernah mereka lakukan. Oleh karena itu, pengetahuan dan keterampilan menjadi kebutuhan dasar agar perawatan di rumah dapat dilakukan dengan aman.

Pengetahuan pertama yang dibutuhkan adalah pemahaman mengenai kondisi pasien. *Caregiver* perlu mengetahui secara sederhana penyakit yang dialami, kemungkinan perjalanan penyakit, tujuan pengobatan, kebutuhan perawatan, dan komplikasi yang dapat muncul. Informasi tersebut membantu *caregiver* memahami alasan suatu tindakan perlu dilakukan dan mengurangi ketidakpastian.

Caregiver juga perlu memiliki pengetahuan mengenai tanda bahaya. Pada penyakit kronik tertentu, perubahan kondisi dapat terjadi secara mendadak. *Caregiver* harus mengetahui kapan suatu keluhan masih dapat dipantau di rumah dan kapan pasien harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kemampuan mengenali tanda bahaya dapat mencegah keterlambatan penanganan.

Keterampilan dalam membantu aktivitas sehari-hari sangat dibutuhkan pada pasien dengan ketergantungan. *Caregiver* perlu mempelajari cara membantu mandi, berpakaian, makan, eliminasi, atau berpindah posisi dengan tetap menjaga keamanan dan kenyamanan. Bantuan yang tidak tepat dapat menyebabkan cedera pada pasien maupun *caregiver*.

Teknik mobilisasi merupakan contoh keterampilan yang penting. Mengangkat atau memindahkan pasien dengan teknik yang salah dapat menyebabkan cedera punggung pada *caregiver*. Sebaliknya, menarik pasien secara tidak tepat dapat menyebabkan nyeri atau cedera pada pasien. Perawat perlu mengajarkan cara menggunakan posisi tubuh yang aman, memanfaatkan kemampuan pasien, dan menggunakan alat bantu apabila tersedia.

Perawatan kulit juga perlu dipahami, khususnya pada pasien yang banyak berbaring. *Caregiver* perlu mengetahui pentingnya perubahan posisi, menjaga kulit tetap bersih dan kering, melakukan observasi area yang tertekan, serta mengenali kemerahan atau kerusakan kulit sejak dini. Pencegahan jauh lebih mudah dibandingkan menangani luka tekan yang sudah berkembang.

Kemampuan memberikan makanan juga perlu disesuaikan dengan kondisi pasien. Pada pasien dengan gangguan menelan, *caregiver* harus memahami posisi yang aman saat makan, tekstur makanan yang sesuai, serta

tanda yang mengarah pada aspirasi. Pemberian makanan tidak dapat dilakukan secara terburu-buru karena dapat meningkatkan risiko tersedak.

Pengetahuan mengenai pengobatan juga sangat diperlukan. *Caregiver* sebaiknya memahami aturan penggunaan obat, jadwal, cara penyimpanan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika pasien memiliki banyak obat, *caregiver* dapat menggunakan metode pengorganisasian yang sederhana dan jelas.

Kebutuhan pengetahuan lain berkaitan dengan komunikasi. Pasien dengan gangguan bicara, gangguan kognitif, atau perubahan perilaku membutuhkan cara komunikasi yang berbeda. *Caregiver* perlu belajar berkomunikasi dengan sabar, menggunakan kalimat sederhana bila diperlukan, memberikan waktu kepada pasien untuk merespons, dan menghindari komunikasi yang merendahkan.

Perawat komunitas memiliki peran besar dalam memberikan pendidikan kepada *caregiver*. Pendidikan sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai prioritas, tidak terlalu banyak dalam satu waktu, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Demonstrasi langsung sangat diperlukan untuk keterampilan tertentu. Setelah demonstrasi, *caregiver* dapat diminta melakukan demonstrasi ulang untuk memastikan keterampilan benar-benar dipahami.

Evaluasi kemampuan *caregiver* juga penting karena memahami teori belum tentu berarti mampu melakukan tindakan. Perawat perlu mengamati praktik secara langsung dan memberikan koreksi bila diperlukan. Pendidikan harus dilakukan secara berulang jika kebutuhan berubah atau jika *caregiver* mengalami kesulitan.

4. Konsep *Caregiver Burden*

Caregiver burden atau beban *caregiver* merupakan kondisi ketika tuntutan perawatan yang dijalankan oleh *caregiver* menimbulkan tekanan terhadap kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun kehidupan pribadinya. Beban ini dapat muncul secara perlahan sehingga terkadang tidak segera disadari oleh *caregiver* maupun anggota keluarga lain.

Beban *caregiver* tidak hanya ditentukan oleh banyaknya tugas. Dua orang yang merawat pasien dengan tingkat ketergantungan yang sama dapat merasakan beban yang berbeda. Persepsi mengenai tanggung jawab, kemampuan koping, kondisi kesehatan, dukungan keluarga, hubungan dengan pasien, dan kondisi ekonomi dapat memengaruhi pengalaman *caregiver*.

Secara konseptual, beban *caregiver* dapat dilihat dari aspek objektif dan subjektif. Beban objektif berkaitan dengan tuntutan yang dapat diamati, seperti jumlah waktu yang digunakan untuk merawat, banyaknya aktivitas yang harus dibantu, gangguan terhadap pekerjaan, biaya yang dikeluarkan, atau kurangnya waktu tidur. Sementara itu, beban subjektif berkaitan dengan pengalaman emosional, seperti merasa tertekan, khawatir, frustrasi, sedih, atau merasa kehilangan kebebasan.

Caregiver burden perlu dipahami sebagai masalah penting dalam manajemen kasus keluarga karena kondisi *caregiver* berhubungan erat dengan kualitas perawatan pasien. Apabila *caregiver* mengalami kelelahan berat, kemampuan untuk memberikan perawatan dapat menurun. Kesalahan penggunaan obat, keterlambatan mengenali perubahan kondisi, atau komunikasi yang tidak baik dapat lebih mudah terjadi.

Beban yang berkepanjangan juga dapat memengaruhi hubungan antara *caregiver* dan pasien. Pada awalnya, perawatan mungkin dilakukan dengan sabar dan penuh perhatian. Namun, jika tekanan terus bertambah tanpa dukungan, *caregiver* dapat menjadi mudah marah, frustrasi, atau menarik diri. Oleh karena itu, pengkajian *caregiver burden* seharusnya menjadi bagian rutin dalam pelayanan kepada keluarga dengan pasien kronik dan ketergantungan.

Perawat perlu menanyakan bagaimana pengalaman *caregiver* dalam memberikan perawatan, apakah terdapat kesulitan tertentu, bagaimana pola tidur, kondisi kesehatan, dukungan yang tersedia, serta apakah masih memiliki waktu untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Pengkajian tidak boleh dilakukan dengan nada menghakimi karena banyak *caregiver* merasa bersalah jika mengakui bahwa dirinya lelah atau terbebani.

5. Faktor Risiko Beban *Caregiver*

Beban *caregiver* dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tingkat ketergantungan pasien merupakan salah satu faktor utama. Semakin banyak bantuan yang dibutuhkan, semakin besar waktu dan energi yang harus diberikan. Pasien yang membutuhkan bantuan sepanjang hari atau pengawasan pada malam hari dapat meningkatkan beban secara signifikan.

Durasi perawatan juga berpengaruh. Tugas perawatan yang berat tetapi berlangsung singkat mungkin masih dapat ditoleransi. Namun, tuntutan yang berlangsung selama bertahun-tahun dapat menyebabkan akumulasi kelelahan.

Gangguan kognitif dan perubahan perilaku pada pasien dapat menambah beban. Pasien dengan demensia atau gangguan neurologis

tertentu dapat mengalami kebingungan, agitasi, perubahan pola tidur, atau perilaku berulang. *Caregiver* mungkin harus melakukan pengawasan lebih intensif dibandingkan pasien dengan keterbatasan fisik saja.

Kurangnya dukungan keluarga merupakan faktor risiko penting. Ketika hanya satu orang yang menjalankan hampir semua tugas, beban akan lebih berat. Sebaliknya, pembagian tugas dapat membantu mengurangi tekanan. Konflik keluarga mengenai siapa yang seharusnya merawat atau bagaimana perawatan dilakukan juga dapat memperberat keadaan.

Kondisi kesehatan *caregiver* sendiri perlu diperhatikan. *Caregiver* yang sudah lanjut usia, memiliki penyakit kronik, atau keterbatasan fisik mungkin kesulitan menjalankan tugas seperti mengangkat pasien atau terjaga pada malam hari.

Keterbatasan ekonomi juga menjadi faktor risiko. Biaya perawatan dapat meningkat pada saat kesempatan bekerja berkurang. Tekanan ekonomi dapat memperburuk stres dan menyebabkan konflik dalam keluarga.

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan juga dapat meningkatkan beban. *Caregiver* yang tidak memahami apa yang harus dilakukan akan lebih mudah merasa cemas dan tidak percaya diri. Pendidikan yang memadai dapat mengurangi sebagian tekanan dengan meningkatkan rasa mampu.

Hubungan antara *caregiver* dan pasien juga memengaruhi beban. Hubungan yang baik dapat memberikan makna positif terhadap aktivitas perawatan. Sebaliknya, konflik yang telah ada sebelumnya dapat menyebabkan tugas perawatan dirasakan lebih berat.

Faktor lain adalah kurangnya waktu untuk diri sendiri. Jika seluruh waktu digunakan untuk merawat tanpa kesempatan beristirahat, berinteraksi sosial, atau melakukan aktivitas pribadi, risiko kelelahan akan meningkat.

6. Beban Fisik, Psikologis, Sosial, dan Ekonomi

Beban fisik pada *caregiver* sering muncul akibat aktivitas berulang seperti membantu pasien berpindah posisi, memindahkan dari tempat tidur ke kursi, membantu mandi, membersihkan pasien, atau terbangun pada malam hari. Keluhan dapat berupa nyeri punggung, nyeri otot, sakit kepala, kelelahan, atau gangguan tidur. Jika berlangsung lama, kondisi kesehatan *caregiver* dapat menurun.

Kurangnya tidur merupakan masalah yang cukup sering terjadi. Pasien mungkin memerlukan bantuan pada malam hari karena nyeri, kebutuhan eliminasi, perubahan posisi, atau gangguan tidur. *Caregiver* yang berulang kali

terbangun dapat mengalami kelelahan pada siang hari dan penurunan konsentrasi.

Beban psikologis mencakup berbagai respons emosional. *Caregiver* dapat merasa sedih melihat penurunan kondisi pasien, takut terhadap masa depan, atau cemas ketika kondisi pasien berubah. Ada pula rasa bersalah ketika merasa kurang mampu memberikan perawatan terbaik atau ketika membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri.

Frustrasi dapat muncul apabila pasien sulit bekerja sama atau kondisi tidak membaik meskipun perawatan sudah dilakukan dengan maksimal. *Caregiver* juga dapat merasa kehilangan kehidupan pribadinya karena hampir seluruh perhatian harus diberikan kepada pasien.

Beban sosial dapat terlihat dari berkurangnya kesempatan berinteraksi dengan orang lain. *Caregiver* mungkin jarang mengikuti kegiatan keluarga, masyarakat, atau rekreasi karena tidak dapat meninggalkan pasien. Jika berlangsung lama, kondisi ini dapat menimbulkan rasa terisolasi.

Hubungan dengan pasangan dan anggota keluarga lain juga dapat terdampak. Waktu untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas bersama berkurang. Konflik dapat muncul jika anggota keluarga lain dianggap tidak cukup membantu.

Beban ekonomi dapat berasal dari biaya pengobatan, transportasi, alat kesehatan, kebutuhan nutrisi, perawatan rumah, atau berbagai kebutuhan tambahan. Pada waktu yang sama, *caregiver* dapat mengurangi jam kerja atau berhenti bekerja sehingga pendapatan berkurang.

Berbagai bentuk beban tersebut saling berhubungan. Tekanan ekonomi dapat meningkatkan kecemasan, kecemasan dapat mengganggu tidur, kurang tidur dapat memperburuk kelelahan fisik, dan kelelahan dapat menurunkan kemampuan berinteraksi secara positif. Oleh karena itu, intervensi tidak cukup jika hanya diarahkan pada satu aspek.

7. Stres, Kelelahan, dan *Caregiver Burnout*

Stres merupakan respons yang dapat muncul ketika tuntutan perawatan dirasakan lebih besar daripada kemampuan atau sumber daya yang dimiliki. Stres tidak selalu bersifat negatif. Dalam tingkat tertentu, stres dapat mendorong seseorang untuk beradaptasi. Namun, stres yang berlangsung lama dan tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi kelelahan yang lebih berat.

Tanda awal stres dapat berupa mudah marah, sulit berkonsentrasi, merasa tegang, sering khawatir, perubahan pola tidur, atau keluhan fisik.

Sebagian *caregiver* mengabaikan tanda tersebut karena merasa bahwa perhatian harus sepenuhnya diberikan kepada pasien.

Kelelahan dapat bersifat fisik maupun emosional. Kelelahan fisik muncul ketika tubuh tidak memiliki waktu pemulihan yang cukup. Kelelahan emosional muncul ketika *caregiver* merasa terkuras secara mental akibat tanggung jawab yang berlangsung terus-menerus.

Jika stres dan kelelahan terus berkembang, *caregiver* dapat mengalami *burnout*. *Caregiver burnout* merupakan kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang berat akibat tuntutan perawatan yang berkepanjangan. Kondisi ini dapat ditandai oleh hilangnya motivasi, perasaan tidak mampu melanjutkan tugas, mudah marah, menarik diri, gangguan tidur, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, dan penurunan kualitas hubungan dengan pasien.

Burnout dapat memberikan dampak serius. Kemampuan *caregiver* dalam mengambil keputusan dapat menurun. Kesabaran berkurang dan risiko kesalahan dalam perawatan meningkat. Pada kondisi berat, *caregiver* dapat mengabaikan kebutuhan kesehatannya sendiri.

Pencegahan *burnout* harus dimulai sebelum tanda berat muncul. Perawat perlu melakukan pengkajian secara berkala terhadap kesejahteraan *caregiver*. Percakapan sederhana mengenai kelelahan, waktu istirahat, dan dukungan keluarga dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini.

Perawat juga perlu menormalisasi kebutuhan untuk beristirahat. Banyak *caregiver* merasa bersalah jika tidak selalu berada bersama pasien. Padahal, istirahat merupakan bagian penting dalam mempertahankan kemampuan perawatan. *Caregiver* yang menjaga kesehatannya cenderung lebih mampu memberikan dukungan secara konsisten.

8. *Self-Care* dan *Respite Care* bagi *Caregiver*

Self-care merupakan berbagai tindakan yang dilakukan *caregiver* untuk mempertahankan kesehatan fisik, psikologis, sosial, dan emosional dirinya sendiri. *Self-care* bukan tindakan egois atau bentuk pengabaian terhadap pasien. Sebaliknya, menjaga kesehatan *caregiver* merupakan bagian penting dari keberlanjutan perawatan.

Kebutuhan dasar seperti tidur, nutrisi, aktivitas fisik, dan pemeriksaan kesehatan tetap harus dipenuhi. *Caregiver* sebaiknya tidak terus-menerus mengorbankan waktu tidur atau makan karena kondisi tersebut dapat menyebabkan penurunan kesehatan.

Waktu istirahat perlu direncanakan. Waktu tersebut tidak harus lama. Kesempatan singkat untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan, berjalan, membaca, berbicara dengan teman, atau menjalankan aktivitas spiritual dapat membantu mengurangi tekanan.

Caregiver juga perlu mempertahankan hubungan sosial. Dukungan dari keluarga, teman, komunitas, atau kelompok dukungan dapat membantu mengurangi rasa terisolasi. Berbagi pengalaman dengan orang lain yang memiliki situasi serupa dapat memberikan rasa dipahami dan membantu menemukan strategi baru.

Kemampuan meminta bantuan juga merupakan bagian dari *self-care*. Seorang *caregiver* tidak harus melakukan semuanya sendiri. Pembagian tugas dapat dilakukan dengan anggota keluarga lain. Bahkan bantuan sederhana, seperti membeli kebutuhan rumah atau menemani pasien selama beberapa jam, dapat memberikan waktu istirahat yang berarti.

Dalam konteks ini, *respite care* memiliki fungsi penting. *Respite care* merupakan bentuk pelayanan atau dukungan sementara yang memberikan kesempatan kepada *caregiver* utama untuk beristirahat dari tugas perawatan. Dukungan dapat diberikan oleh anggota keluarga lain, tenaga pendamping, pelayanan komunitas, atau bentuk layanan lain yang tersedia.

Tujuan *respite care* bukan menggantikan *caregiver* secara permanen, tetapi memberikan jeda agar *caregiver* dapat memulihkan tenaga, menyelesaikan kebutuhan pribadi, atau melakukan aktivitas lain. Waktu istirahat tersebut dapat mencegah akumulasi kelelahan.

Pelaksanaan *respite care* membutuhkan perencanaan. Informasi mengenai kondisi pasien, obat, makanan, jadwal aktivitas, tanda bahaya, dan kontak darurat perlu disampaikan kepada orang yang menggantikan *caregiver*. Dengan demikian, *caregiver* utama dapat beristirahat tanpa rasa khawatir yang berlebihan.

Apabila pelayanan *respite care* formal tidak tersedia, konsep istirahat sementara tetap dapat diterapkan melalui pembagian peran keluarga. Anggota keluarga dapat menyusun jadwal bergantian agar *caregiver* utama memiliki waktu untuk beristirahat.

Perawat komunitas berperan membantu *caregiver* menyusun strategi *self-care* yang realistis. Strategi harus disesuaikan dengan kondisi keluarga dan tidak menambah beban. Perawat juga dapat membantu mengidentifikasi anggota keluarga atau sumber daya masyarakat yang dapat memberikan dukungan.

Dukungan psikologis juga penting. *Caregiver* perlu memiliki ruang untuk mengekspresikan rasa lelah, takut, marah, sedih, atau frustrasi tanpa merasa dihakimi. Pada kondisi tertentu, dukungan profesional dapat diperlukan jika tekanan psikologis mulai mengganggu kehidupan sehari-hari.

Dalam proses manajemen kasus keluarga, perhatian terhadap *caregiver* perlu diberikan secara setara dengan perhatian terhadap kebutuhan pasien. Kemampuan pasien bertahan dalam perawatan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh kesehatan dan kapasitas orang yang memberikan perawatan. Oleh karena itu, *caregiver* perlu dipandang sebagai mitra sekaligus individu yang juga membutuhkan pelayanan kesehatan.

Pada akhirnya, keberadaan *caregiver* merupakan salah satu komponen utama dalam keberhasilan perawatan pasien dengan penyakit kronik dan ketergantungan di rumah. Perannya tidak hanya mencakup membantu kebutuhan dasar, tetapi juga mengelola pengobatan, memantau perubahan kondisi, memberikan dukungan emosional, menghubungkan pasien dengan pelayanan kesehatan, dan menjaga kesinambungan perawatan. Tuntutan yang besar tersebut dapat menyebabkan *caregiver burden* apabila tidak diimbangi dengan pengetahuan, keterampilan, dukungan, waktu istirahat, dan pembagian tanggung jawab yang memadai. Melalui pengkajian yang komprehensif, pendidikan kesehatan, dukungan *self-care*, pembagian peran, serta pemanfaatan *respite care*, perawat komunitas dapat membantu menjaga kesejahteraan *caregiver* sekaligus mempertahankan kualitas perawatan pasien dan keberfungsian keluarga secara keseluruhan.

F. Pengkajian dan Proses Manajemen Kasus Keluarga

1. Identifikasi dan Seleksi Keluarga Berisiko

Identifikasi dan seleksi keluarga berisiko merupakan tahap awal dalam proses manajemen kasus keluarga. Tahap ini bertujuan menemukan keluarga yang memiliki masalah kesehatan kompleks, kebutuhan perawatan berkelanjutan, keterbatasan sumber daya, atau risiko tinggi mengalami perburukan kondisi apabila tidak memperoleh pendampingan yang memadai. Dalam keperawatan komunitas, tidak semua keluarga memerlukan intensitas manajemen kasus yang sama. Sebagian keluarga mampu mengelola masalah kesehatan secara mandiri setelah memperoleh edukasi, sedangkan keluarga lain membutuhkan pendampingan, koordinasi pelayanan, dan pemantauan dalam jangka waktu tertentu.

Keluarga berisiko dapat diidentifikasi melalui berbagai sumber. Informasi dapat diperoleh dari kunjungan rumah, pelayanan Puskesmas, Posyandu,

Posbindu, data program penyakit tidak menular, rujukan dari fasilitas kesehatan, laporan kader, hasil surveilans, maupun informasi dari masyarakat. Perawat komunitas perlu mengembangkan kemampuan untuk mengenali indikator yang menunjukkan adanya kebutuhan manajemen kasus. Indikator tersebut tidak hanya berkaitan dengan diagnosis penyakit, tetapi juga kondisi fungsional pasien, kemampuan keluarga, situasi sosial, dan akses terhadap pelayanan.

Keluarga dengan anggota yang mengalami penyakit kronik dan komplikasi merupakan salah satu kelompok yang perlu mendapatkan perhatian. Risiko juga meningkat apabila pasien mengalami multimorbiditas, sering mengalami kekambuhan, berulang kali dirawat di rumah sakit, tidak teratur melakukan kontrol, atau mengalami kesulitan mengikuti rencana terapi. Kondisi semacam ini menunjukkan bahwa kebutuhan pasien tidak dapat diselesaikan hanya dengan pelayanan episodik.

Keluarga yang memiliki anggota dengan ketergantungan sedang hingga berat juga perlu dipertimbangkan sebagai prioritas. Pasien pascastroke, individu dengan disabilitas, lansia dengan keterbatasan fungsi, pasien dengan gangguan neurologis, atau individu dengan penyakit degeneratif dapat membutuhkan bantuan dalam aktivitas sehari-hari. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin besar kebutuhan terhadap perawatan, pengawasan, dan dukungan keluarga.

Selain kondisi pasien, perawat perlu menilai faktor dalam keluarga. Keluarga dengan *caregiver* tunggal, *caregiver* lanjut usia, atau *caregiver* yang memiliki penyakit kronik sendiri dapat mengalami keterbatasan dalam memberikan perawatan. Demikian pula keluarga dengan konflik internal, kemampuan ekonomi terbatas, rendahnya literasi kesehatan, atau kurangnya dukungan sosial. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah perawatan di rumah.

Seleksi keluarga berisiko perlu dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan dan kompleksitas masalah. Dalam situasi sumber daya terbatas, keluarga dengan risiko tertinggi perlu memperoleh prioritas. Perawat dapat mempertimbangkan tingkat keparahan penyakit, ketergantungan pasien, risiko komplikasi, kondisi *caregiver*, frekuensi penggunaan layanan kesehatan, serta kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi perawatan.

Proses seleksi sebaiknya dilakukan secara objektif dan terdokumentasi. Tujuannya agar keluarga yang benar-benar membutuhkan manajemen kasus dapat memperoleh pelayanan yang sesuai. Dokumentasi juga membantu perawat dalam memantau perkembangan dan menentukan apakah keluarga

masih membutuhkan pendampingan intensif atau sudah mampu meningkatkan kemandiriannya.

2. Pengkajian Struktur dan Fungsi Keluarga

Setelah keluarga teridentifikasi sebagai kelompok yang memerlukan manajemen kasus, tahap berikutnya adalah melakukan pengkajian struktur dan fungsi keluarga. Pengkajian ini penting karena masalah kesehatan individu selalu berada dalam konteks keluarga. Cara keluarga berkomunikasi, membagi peran, mengambil keputusan, dan memberikan dukungan dapat memengaruhi keberhasilan perawatan.

Struktur keluarga menggambarkan susunan anggota keluarga serta hubungan di antara mereka. Perawat perlu mengetahui siapa yang tinggal dalam satu rumah, hubungan antara anggota keluarga, siapa yang menjadi kepala keluarga, siapa yang menjadi pengambil keputusan, siapa yang memiliki peran utama dalam perawatan, serta apakah terdapat anggota keluarga lain yang terlibat meskipun tinggal terpisah. Informasi ini membantu menentukan siapa yang perlu dilibatkan dalam proses perencanaan.

Selain struktur formal, perawat juga perlu memahami struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan. Dalam beberapa keluarga, keputusan kesehatan dibuat oleh kepala keluarga. Pada keluarga lain, keputusan dapat diambil bersama. Ada pula keluarga yang lebih banyak bergantung pada satu anggota tertentu karena dianggap memiliki pengetahuan lebih baik atau memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar. Pola tersebut perlu dipahami agar komunikasi dan intervensi dapat dilakukan secara efektif.

Struktur peran juga perlu dikaji. Setiap anggota keluarga biasanya memiliki tanggung jawab tertentu, misalnya sebagai pencari nafkah, pengelola rumah tangga, pengasuh anak, atau *caregiver*. Penyakit kronik dapat menyebabkan perubahan besar dalam pembagian peran. Pasien yang sebelumnya menjadi pencari nafkah mungkin tidak lagi mampu bekerja, sementara pasangan harus mengambil alih tanggung jawab ekonomi dan perawatan sekaligus.

Fungsi keluarga mencakup fungsi afektif, sosial, ekonomi, reproduksi, dan fungsi pemeliharaan kesehatan. Dalam konteks manajemen kasus, fungsi pemeliharaan kesehatan menjadi perhatian utama, tetapi fungsi lain tetap perlu dinilai karena saling berkaitan. Keluarga yang memiliki hubungan emosional baik biasanya lebih mudah bekerja sama dalam perawatan. Sebaliknya, konflik atau komunikasi yang buruk dapat menghambat pelaksanaan rencana.

Pengkajian fungsi kesehatan mencakup kemampuan keluarga mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Perawat perlu mengetahui sejauh mana keluarga memahami penyakit pasien, apakah keluarga mampu mengenali tanda bahaya, apakah pengobatan dijalankan dengan benar, dan apakah keluarga mengetahui kapan harus mencari pertolongan.

Pola komunikasi juga sangat penting. Perawat perlu menilai apakah komunikasi berlangsung terbuka atau tertutup, apakah pasien dapat menyampaikan kebutuhan, dan apakah anggota keluarga saling mendengarkan. Komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam pembagian tugas, ketidakpatuhan terhadap perawatan, atau konflik dalam pengambilan keputusan.

Pengkajian struktur dan fungsi keluarga membantu perawat memahami kekuatan dan kelemahan keluarga. Fokus pengkajian tidak hanya mencari masalah, tetapi juga mengidentifikasi potensi yang dapat digunakan sebagai sumber daya. Keluarga yang memiliki hubungan kuat, komunikasi baik, dan pembagian tugas fleksibel biasanya memiliki kapasitas adaptasi lebih baik.

3. Pengkajian Kondisi Kesehatan Anggota Keluarga

Pengkajian kondisi kesehatan anggota keluarga dilakukan secara komprehensif, tidak hanya terhadap pasien utama, tetapi juga terhadap anggota keluarga lain yang memiliki masalah kesehatan atau berisiko terdampak. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip keperawatan keluarga yang memandang keluarga sebagai satu kesatuan.

Pada pasien utama, perawat perlu mengkaji diagnosis, riwayat penyakit, durasi sakit, terapi yang sedang dijalani, kondisi terkini, komplikasi, riwayat rawat inap, serta frekuensi kunjungan ke fasilitas kesehatan. Informasi ini membantu menentukan kompleksitas masalah dan risiko perburukan.

Pengkajian juga mencakup keluhan fisik, status nutrisi, pola tidur, eliminasi, mobilitas, nyeri, kemampuan aktivitas, kondisi kulit, serta kemampuan komunikasi. Pada pasien kronik, perubahan kecil dapat menjadi tanda awal perburukan sehingga data dasar perlu dicatat dengan baik.

Selain kondisi fisik, perawat perlu menilai aspek psikologis. Penyakit kronik dan ketergantungan dapat memicu kecemasan, depresi, frustrasi, atau rasa tidak berdaya. Kondisi psikologis dapat memengaruhi kepatuhan terhadap pengobatan dan motivasi pasien untuk melakukan perawatan mandiri.

Aspek sosial juga perlu dikaji. Perawat dapat menilai apakah pasien masih bekerja, berinteraksi dengan masyarakat, mengikuti kegiatan sosial, atau mengalami isolasi. Penurunan partisipasi sosial dapat berdampak pada kualitas hidup.

Anggota keluarga lain juga perlu diperhatikan. *Caregiver* dapat mengalami kelelahan, hipertensi, gangguan muskuloskeletal, gangguan tidur, atau masalah psikologis akibat beban perawatan. Jika kesehatan *caregiver* menurun, kemampuan keluarga merawat pasien juga akan terpengaruh.

Pengkajian kesehatan keluarga harus dilakukan secara berkala karena kondisi dapat berubah. Data awal menjadi dasar untuk membandingkan perkembangan dari waktu ke waktu.

4. Pengkajian Tingkat Ketergantungan Pasien

Tingkat ketergantungan pasien merupakan komponen penting dalam manajemen kasus karena menentukan jumlah dan jenis bantuan yang dibutuhkan. Ketergantungan dapat terjadi pada aktivitas dasar, aktivitas instrumental, maupun kebutuhan pengawasan.

Perawat dapat menggunakan penilaian ADL untuk mengidentifikasi kemampuan pasien dalam makan, mandi, berpakaian, menggunakan toilet, berpindah posisi, dan mobilitas. Penilaian IADL dapat digunakan untuk melihat kemampuan pasien dalam mengelola obat, menggunakan transportasi, berbelanja, mengatur keuangan, menyiapkan makanan, dan aktivitas lain yang lebih kompleks.

Pengkajian tidak hanya mencatat apakah pasien mampu atau tidak mampu melakukan aktivitas. Perawat perlu mengetahui apakah pasien membutuhkan bantuan minimal, bantuan sebagian, bantuan penuh, atau hanya pengawasan. Informasi ini penting untuk menentukan pembagian tugas *caregiver*.

Aspek keselamatan juga harus dinilai. Pasien mungkin secara teknis masih mampu berjalan, tetapi memiliki risiko jatuh tinggi. Dalam kondisi tersebut, pengawasan tetap diperlukan. Demikian pula pasien dengan gangguan kognitif mungkin secara fisik mampu melakukan aktivitas, tetapi tidak aman jika dibiarkan tanpa pengawasan.

Perawat juga perlu mengidentifikasi kemampuan yang masih dapat dipertahankan atau ditingkatkan. Tujuan perawatan tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi menjaga kemandirian pasien semaksimal mungkin. Karena itu, penilaian tingkat ketergantungan juga menjadi dasar untuk menentukan target rehabilitasi.

5. Pengkajian Kemampuan Keluarga dalam Melakukan Perawatan

Kemampuan keluarga dalam melakukan perawatan perlu dinilai secara realistis. Keluarga tidak dapat diasumsikan otomatis mampu merawat hanya karena tinggal bersama pasien. Perawatan pasien kronik membutuhkan pengetahuan, keterampilan, waktu, tenaga, dan kesiapan emosional.

Perawat perlu menilai pemahaman keluarga mengenai penyakit, tujuan pengobatan, diet, aktivitas, tanda bahaya, dan jadwal kontrol. Pengetahuan yang kurang dapat menyebabkan kesalahan dalam perawatan.

Keterampilan praktis juga perlu dinilai. Keluarga mungkin perlu membantu pasien berpindah posisi, merawat kulit, mengukur tekanan darah, mengatur obat, atau membantu makan. Perawat dapat meminta keluarga melakukan demonstrasi ulang untuk memastikan kemampuan.

Kemampuan keluarga juga dipengaruhi oleh kondisi fisik *caregiver*. Seorang pasangan lanjut usia mungkin tidak mampu mengangkat pasien meskipun memahami teknik. Karena itu, rencana harus disesuaikan dengan kapasitas aktual.

Ketersediaan waktu juga menjadi faktor penting. Anggota keluarga yang bekerja penuh waktu mungkin tidak dapat mendampingi pasien sepanjang hari. Perawat perlu memahami jadwal keluarga dan membantu mencari solusi yang realistis.

Pengkajian juga perlu melihat kesiapan emosional. Sebagian keluarga dapat menerima kondisi pasien dengan baik, sementara yang lain masih mengalami penolakan atau konflik. Kesiapan emosional memengaruhi kemampuan menjalankan perawatan.

6. Pengkajian Kebutuhan dan Beban *Caregiver*

Pengkajian *caregiver* merupakan bagian penting dalam manajemen kasus. *Caregiver* perlu dinilai bukan hanya sebagai sumber bantuan, tetapi sebagai individu yang memiliki kebutuhan sendiri.

Perawat perlu mengetahui siapa yang menjadi *caregiver* utama, berapa lama waktu yang digunakan untuk merawat, jenis tugas yang dilakukan, dan apakah terdapat anggota keluarga lain yang membantu. Informasi ini memberikan gambaran tentang intensitas beban.

Kondisi fisik *caregiver* perlu dikaji. Keluhan nyeri punggung, kelelahan, sakit kepala, gangguan tidur, atau penyakit kronik dapat menurunkan kapasitas perawatan.

Aspek psikologis juga perlu diperhatikan. *Caregiver* dapat merasa cemas, frustrasi, sedih, marah, atau tertekan. Perawat perlu memberikan ruang untuk mengungkapkan perasaan tanpa menghakimi.

Beban sosial dapat muncul ketika *caregiver* kehilangan waktu untuk bekerja, bersosialisasi, atau menjalankan kegiatan pribadi. Perawat perlu menanyakan apakah perawatan menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan.

Aspek ekonomi juga penting. Biaya obat, transportasi, alat kesehatan, dan berkurangnya pendapatan dapat menjadi sumber tekanan.

Pengkajian terhadap beban *caregiver* membantu menentukan kebutuhan dukungan, pembagian tugas, edukasi, atau kemungkinan penggunaan *respite care*.

7. Pengkajian Sumber Daya dan Dukungan Sosial

Sumber daya keluarga mencakup segala sesuatu yang dapat membantu keluarga menjalankan perawatan. Sumber daya dapat berupa kemampuan ekonomi, pengetahuan, hubungan keluarga, dukungan tetangga, fasilitas kesehatan, kader, organisasi sosial, dan layanan komunitas.

Perawat perlu mengetahui apakah keluarga memiliki anggota lain yang dapat membantu, apakah ada tetangga yang dapat dimintai bantuan, dan apakah pasien terdaftar dalam program kesehatan tertentu.

Dukungan sosial dapat bersifat emosional, instrumental, informasional, maupun finansial. Dukungan emosional berupa perhatian dan empati. Dukungan instrumental berupa bantuan langsung seperti mengantar kontrol atau menjaga pasien. Dukungan informasional berupa informasi tentang pelayanan. Dukungan finansial dapat berupa bantuan biaya.

Pengkajian juga mencakup akses terhadap fasilitas kesehatan. Jarak, transportasi, biaya, jam pelayanan, dan kemampuan keluarga menggunakan teknologi dapat memengaruhi akses.

Selain sumber formal, sumber informal perlu dinilai. Tokoh masyarakat, kader, kelompok keagamaan, atau kelompok pendukung dapat menjadi bagian penting dalam membantu keluarga.

8. Penggunaan Genogram dan Ecomap

Genogram dan ecomap merupakan alat yang membantu perawat memahami struktur keluarga dan hubungan dengan lingkungan.

Genogram menggambarkan struktur keluarga dalam beberapa generasi. Melalui genogram, perawat dapat melihat hubungan kekerabatan, pola

penyakit, anggota yang tinggal bersama, serta hubungan penting dalam keluarga. Genogram dapat membantu mengidentifikasi siapa yang berpotensi menjadi sumber dukungan atau siapa yang memiliki riwayat penyakit serupa.

Genogram juga dapat memberikan gambaran pola kesehatan antargenerasi. Misalnya, adanya beberapa anggota keluarga dengan hipertensi atau diabetes dapat menunjukkan pentingnya edukasi pencegahan kepada anggota lain.

Ecomap digunakan untuk menggambarkan hubungan keluarga dengan lingkungan luar. Hubungan dapat mencakup Puskesmas, rumah sakit, sekolah, tempat kerja, tetangga, organisasi sosial, komunitas agama, atau kelompok dukungan.

Melalui ecomap, perawat dapat melihat apakah keluarga memiliki jaringan dukungan kuat atau justru mengalami keterbatasan akses. Hubungan yang kuat dapat dimanfaatkan dalam rencana manajemen kasus.

Penggunaan genogram dan ecomap tidak hanya bersifat administratif, tetapi menjadi alat analisis. Keduanya membantu perawat memahami konteks keluarga secara visual sehingga intervensi dapat dirancang lebih tepat.

9. Identifikasi dan Penetapan Prioritas Masalah

Setelah data terkumpul, perawat melakukan identifikasi masalah. Masalah dapat berasal dari kondisi pasien, kemampuan keluarga, beban *caregiver*, lingkungan, atau akses pelayanan.

Tidak semua masalah dapat diselesaikan sekaligus sehingga perlu ditetapkan prioritas. Prioritas dapat ditentukan berdasarkan tingkat ancaman terhadap keselamatan, urgensi, kemungkinan komplikasi, dampak terhadap fungsi, serta kemampuan keluarga.

Masalah yang mengancam keselamatan harus diprioritaskan. Contohnya adalah risiko jatuh, kesalahan obat, risiko aspirasi, atau luka tekan.

Masalah yang berpotensi memperburuk kondisi juga perlu mendapat perhatian. Ketidakpatuhan terhadap pengobatan, nutrisi buruk, atau ketidakmampuan mengenali tanda bahaya dapat menjadi prioritas.

Perawat perlu melibatkan keluarga dalam menetapkan prioritas. Masalah yang dianggap penting oleh tenaga kesehatan belum tentu menjadi prioritas keluarga. Diskusi perlu dilakukan agar tujuan yang ditetapkan dapat diterima dan dijalankan.

Penetapan prioritas juga mempertimbangkan sumber daya. Target harus realistis dan sesuai kemampuan keluarga.

10. Penyusunan Tujuan dan Rencana Manajemen Kasus

Tujuan disusun berdasarkan masalah yang telah diprioritaskan. Tujuan harus jelas, realistis, dapat diukur, dan memiliki batas waktu yang sesuai.

Tujuan dapat berorientasi pada pasien, keluarga, atau *caregiver*. Contohnya adalah mempertahankan tekanan darah dalam rentang target, meningkatkan kemampuan pasien melakukan aktivitas tertentu, atau menurunkan beban *caregiver*.

Rencana manajemen kasus kemudian disusun untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana dapat mencakup edukasi, intervensi keperawatan, modifikasi lingkungan, koordinasi rujukan, pemantauan, dan dukungan keluarga.

Rencana sebaiknya menjelaskan siapa yang melakukan tindakan, kapan dilakukan, dan bagaimana hasil dievaluasi. Kejelasan ini mencegah kebingungan.

Rencana juga perlu fleksibel. Jika kondisi berubah, rencana harus disesuaikan.

11. Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi

Pelaksanaan merupakan tahap ketika rencana diterapkan. Intervensi dapat berupa edukasi, kunjungan rumah, pelatihan keterampilan, pemantauan gejala, koordinasi pelayanan, dan dukungan *caregiver*.

Pelaksanaan harus melibatkan keluarga secara aktif. Perawat tidak mengambil alih semua tanggung jawab, tetapi mendampingi keluarga agar mampu menjalankan perawatan secara mandiri.

Pemantauan dilakukan untuk melihat apakah intervensi berjalan sesuai rencana. Perawat perlu menilai perubahan kondisi pasien, kepatuhan terhadap terapi, kemampuan keluarga, dan beban *caregiver*.

Pemantauan dapat dilakukan melalui kunjungan rumah, komunikasi jarak jauh, atau kunjungan fasilitas kesehatan. Frekuensi pemantauan disesuaikan dengan tingkat risiko.

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jika tujuan tercapai, intervensi dapat dipertahankan atau dikurangi secara bertahap. Jika belum tercapai, penyebab perlu dianalisis.

Evaluasi juga harus melihat dampak terhadap keluarga secara keseluruhan. Perbaikan kondisi pasien tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesehatan *caregiver*. Karena itu, keberhasilan manajemen kasus harus dilihat secara seimbang.

Dokumentasi menjadi bagian penting dari proses. Semua hasil pengkajian, intervensi, perubahan kondisi, dan keputusan harus dicatat. Dokumentasi membantu kontinuitas pelayanan.

Dalam praktik keperawatan komunitas, proses manajemen kasus keluarga bersifat dinamis. Pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tidak berjalan secara kaku, tetapi dapat berulang sesuai kebutuhan. Setiap perubahan kondisi pasien, keluarga, *caregiver*, atau lingkungan dapat memerlukan pengkajian ulang.

Pada akhirnya, pengkajian dan proses manajemen kasus keluarga bertujuan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar sesuai kebutuhan nyata pasien dan keluarga. Melalui identifikasi keluarga berisiko, pengkajian menyeluruh, penggunaan genogram dan ecomap, penetapan prioritas, penyusunan rencana, serta evaluasi berkelanjutan, perawat komunitas dapat membantu keluarga mengelola penyakit kronik, ketergantungan, dan kebutuhan perawatan secara lebih terstruktur, aman, dan berkesinambungan.

G. Intervensi Keperawatan dan Pemberdayaan Keluarga

Intervensi keperawatan pada keluarga dengan anggota yang mengalami penyakit kronik dan ketergantungan tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasien, tetapi juga untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi perawatan secara mandiri. Dalam konteks keperawatan komunitas, keluarga dipandang sebagai mitra utama karena sebagian besar proses perawatan berlangsung di rumah. Oleh karena itu, intervensi yang diberikan harus mampu memperkuat pengetahuan, keterampilan, kemampuan mengambil keputusan, serta kesiapan keluarga dalam menghadapi perubahan kondisi pasien.

Pemberdayaan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari intervensi keperawatan. Pemberdayaan berarti membantu keluarga mengenali kekuatan yang dimiliki, memahami masalah kesehatan, menentukan pilihan yang tepat, menggunakan sumber daya yang tersedia, serta meningkatkan kemampuan dalam merawat anggota keluarga. Pendekatan ini berbeda dengan pola pelayanan yang sepenuhnya berpusat pada tenaga kesehatan. Dalam pemberdayaan, keluarga tidak ditempatkan sebagai penerima pasif, tetapi sebagai pihak yang aktif dalam proses perawatan.

Intervensi yang efektif harus disesuaikan dengan kondisi pasien, tingkat ketergantungan, kemampuan *caregiver*, sumber daya keluarga, lingkungan rumah, serta akses terhadap pelayanan kesehatan. Setiap keluarga memiliki kebutuhan

yang berbeda. Oleh karena itu, perawat perlu menghindari pendekatan yang seragam dan lebih menekankan pada intervensi individual sesuai hasil pengkajian.

1. Pendidikan Kesehatan Keluarga

Pendidikan kesehatan merupakan salah satu intervensi utama dalam manajemen kasus keluarga. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan keluarga dalam memahami kondisi kesehatan, mengenali masalah, melakukan perawatan, mencegah komplikasi, serta menentukan kapan harus mencari pertolongan profesional. Pendidikan kesehatan yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri keluarga dan mengurangi kecemasan akibat ketidakpastian.

Materi pendidikan harus disesuaikan dengan penyakit dan kondisi pasien. Keluarga dengan anggota yang mengalami diabetes melitus, misalnya, perlu memahami pengaturan pola makan, penggunaan obat, pemantauan kadar glukosa, perawatan kaki, serta tanda hipoglikemia dan hiperglikemia. Pada keluarga dengan pasien pascastroke, materi dapat mencakup mobilisasi, latihan rentang gerak, pencegahan aspirasi, pencegahan jatuh, dan pengenalan tanda stroke berulang.

Pendidikan tidak seharusnya diberikan sekaligus dalam jumlah besar. Informasi yang terlalu banyak dapat membuat keluarga sulit memahami dan mengingat. Perawat perlu menentukan prioritas sesuai kebutuhan paling mendesak. Materi dapat diberikan secara bertahap dan diperkuat pada kunjungan berikutnya.

Bahasa yang digunakan juga perlu disesuaikan dengan tingkat pemahaman keluarga. Istilah medis yang kompleks sebaiknya dijelaskan dalam bahasa sederhana. Perawat perlu memastikan bahwa keluarga tidak hanya mengangguk atau menyatakan memahami, tetapi benar-benar mampu menjelaskan kembali informasi yang diberikan.

Salah satu metode yang efektif adalah meminta keluarga mengulang kembali dengan bahasa mereka sendiri mengenai apa yang telah dipelajari. Teknik ini membantu perawat menilai apakah informasi sudah dipahami dengan benar.

Selain penjelasan verbal, pendidikan dapat menggunakan demonstrasi langsung, gambar, leaflet, video, atau media lain yang sesuai. Pada keterampilan praktis, seperti perawatan luka, mobilisasi, pemberian obat, atau pengukuran tekanan darah, demonstrasi dan demonstrasi ulang lebih efektif dibandingkan penjelasan verbal saja.

Pendidikan kesehatan juga perlu memperhatikan keyakinan dan budaya keluarga. Beberapa keluarga memiliki praktik kesehatan tertentu yang sudah

berlangsung lama. Perawat perlu menghargai nilai tersebut sambil tetap memastikan bahwa praktik yang dilakukan tidak membahayakan pasien.

Pendidikan yang baik pada akhirnya membantu keluarga menjadi lebih siap menghadapi kondisi sehari-hari. Keluarga dapat mengenali perubahan kondisi, mengambil tindakan awal, dan menghindari keterlambatan mencari pertolongan.

2. Peningkatan Kemampuan Perawatan di Rumah

Perawatan di rumah menjadi bagian penting dalam pengelolaan pasien kronik dan ketergantungan. Peningkatan kemampuan keluarga dilakukan agar perawatan dapat berlangsung aman, efektif, dan sesuai kebutuhan pasien.

Perawat perlu mengajarkan keterampilan dasar yang paling sering dibutuhkan. Pada pasien dengan mobilitas terbatas, keluarga perlu memahami cara membantu perubahan posisi, berpindah dari tempat tidur ke kursi, atau mendampingi pasien berjalan. Teknik yang benar dapat mencegah cedera pada pasien dan *caregiver*.

Perawatan kebersihan diri juga perlu diajarkan. Keluarga perlu memahami cara membantu mandi, membersihkan mulut, merawat rambut, menjaga kebersihan genital, dan mempertahankan kulit tetap bersih serta kering. Aktivitas ini penting untuk kenyamanan sekaligus pencegahan infeksi dan gangguan kulit.

Kemampuan menjaga nutrisi juga perlu diperkuat. Keluarga harus memahami kebutuhan makan sesuai kondisi pasien, tekstur makanan, jadwal makan, serta cara mengamati masalah seperti kesulitan menelan, kehilangan nafsu makan, atau penurunan berat badan.

Lingkungan rumah juga perlu disesuaikan. Perawat dapat membantu keluarga mengidentifikasi bagian rumah yang berisiko, seperti lantai licin, pencahayaan kurang, jalur berjalan sempit, atau kamar mandi tanpa pegangan. Penyesuaian sederhana dapat meningkatkan keselamatan dan kemandirian pasien.

Keluarga juga perlu memahami cara menggunakan alat bantu seperti tongkat, *walker*, kursi roda, atau alat lain jika diperlukan. Penggunaan yang salah dapat meningkatkan risiko jatuh dan cedera.

Peningkatan kemampuan perawatan di rumah perlu dilakukan melalui praktik langsung. Perawat dapat mengobservasi bagaimana keluarga melakukan tindakan, kemudian memberikan koreksi apabila terdapat teknik yang kurang tepat.

Tujuan akhirnya bukan membuat keluarga bergantung pada tenaga kesehatan, melainkan meningkatkan kemampuan agar perawatan sehari-hari dapat dilakukan secara mandiri dalam batas yang aman.

3. Manajemen Obat dan Kepatuhan Terapi

Pengelolaan obat merupakan komponen yang sangat penting pada pasien penyakit kronik. Kesalahan penggunaan obat dapat menyebabkan terapi tidak efektif, memperburuk kondisi, atau menimbulkan efek yang tidak diinginkan.

Keluarga perlu memahami nama obat, tujuan penggunaan, waktu pemberian, dosis, cara penggunaan, serta hal-hal yang perlu diperhatikan. Jika pasien menggunakan banyak jenis obat, keluarga perlu memiliki sistem yang mudah dipahami agar risiko tertukar dapat dikurangi.

Perawat dapat membantu keluarga menyusun jadwal penggunaan obat. Jadwal dapat dibuat dalam bentuk tabel atau catatan sederhana dan ditempatkan di lokasi yang mudah terlihat. Kotak obat harian juga dapat digunakan apabila sesuai kondisi keluarga.

Kepatuhan terapi tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan. Faktor ekonomi, efek samping, kejenuhan, kesulitan menelan, lupa, atau keyakinan tertentu dapat menyebabkan pasien tidak menggunakan obat secara teratur. Karena itu, ketika ditemukan ketidakpatuhan, perawat perlu mencari penyebab sebelum memberikan edukasi.

Perawat juga perlu mengingatkan keluarga agar tidak mengubah dosis atau menghentikan obat tanpa konsultasi. Banyak pasien menghentikan obat ketika merasa sudah membaik. Pada penyakit kronik, tindakan ini dapat memicu perburukan.

Pemantauan efek samping juga perlu diajarkan. Keluarga tidak harus memahami seluruh aspek farmakologi, tetapi perlu mengetahui gejala tertentu yang harus dilaporkan.

Selain obat, kepatuhan terhadap terapi mencakup diet, aktivitas, rehabilitasi, kontrol rutin, dan pemeriksaan penunjang. Perawat perlu membantu keluarga memahami bahwa pengelolaan penyakit kronik merupakan kombinasi berbagai tindakan.

4. Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas Sehari-hari

Pemenuhan kebutuhan aktivitas sehari-hari perlu dilakukan dengan prinsip mempertahankan kemampuan pasien semaksimal mungkin. Pasien

tidak seharusnya dibantu secara total apabila masih mampu melakukan sebagian aktivitas.

Aktivitas seperti makan, mandi, berpakaian, menggunakan toilet, berpindah posisi, dan berjalan perlu dinilai secara individual. Bantuan diberikan sesuai tingkat ketergantungan. Pendekatan ini penting untuk mencegah *learned dependency*, yaitu kondisi ketika pasien menjadi semakin bergantung karena terlalu sering dibantu.

Sebagai contoh, pasien yang masih mampu makan sendiri tetapi lambat sebaiknya tetap diberikan kesempatan makan mandiri. *Caregiver* dapat membantu menyiapkan makanan atau memotong makanan jika diperlukan.

Pada aktivitas berpakaian, pasien yang masih mampu memasukkan tangan ke lengan baju perlu diberi kesempatan melakukan bagian tersebut. Prinsipnya adalah mempertahankan keterlibatan pasien sebanyak mungkin.

Aktivitas sehari-hari juga dapat digunakan sebagai bentuk latihan. Aktivitas sederhana seperti duduk, berdiri, menyisir rambut, atau berjalan jarak pendek dapat membantu mempertahankan kekuatan dan koordinasi.

Namun, keselamatan tetap menjadi prioritas. Pasien yang berisiko jatuh perlu didampingi. Aktivitas tidak boleh dipaksakan jika pasien mengalami nyeri berat, sesak, atau kondisi lain yang tidak stabil.

Pemenuhan kebutuhan sehari-hari juga harus memperhatikan privasi dan martabat. Bantuan mandi atau eliminasi perlu dilakukan dengan menjaga area tubuh yang tidak sedang dirawat tetap tertutup.

5. Pencegahan Komplikasi, Jatuh, dan Cedera

Pasien dengan penyakit kronik dan ketergantungan memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi. Pencegahan harus menjadi bagian rutin dalam perawatan keluarga.

Pada pasien dengan mobilitas terbatas, risiko luka tekan perlu diperhatikan. Perubahan posisi secara teratur, pemeriksaan kulit, pemenuhan nutrisi, dan menjaga kulit tetap bersih dan kering merupakan langkah penting.

Risiko kontraktur dan kelemahan otot dapat dikurangi melalui latihan rentang gerak dan mobilisasi sesuai kemampuan. Perawat dapat mengajarkan keluarga latihan sederhana yang aman.

Jatuh merupakan salah satu risiko penting, terutama pada lansia dan pasien dengan gangguan keseimbangan. Lingkungan rumah perlu dievaluasi. Lantai licin, kabel berserakan, karpet mudah bergeser, pencahayaan buruk, atau tangga tanpa pegangan dapat meningkatkan risiko.

Keluarga dapat melakukan penyesuaian dengan menyediakan pencahayaan cukup, memasang pegangan jika memungkinkan, menjaga jalur berjalan bebas hambatan, dan menempatkan barang penting dalam jangkauan.

Pasien juga perlu menggunakan alas kaki yang aman dan alat bantu yang sesuai. Penggunaan tongkat atau *walker* perlu diajarkan dengan benar.

Cedera dapat pula terjadi saat proses transfer. Karena itu, *caregiver* harus memahami teknik memindahkan pasien agar tidak menarik secara kasar atau menggunakan posisi tubuh yang dapat mencederai dirinya sendiri.

Pencegahan komplikasi juga mencakup deteksi dini. Keluarga harus mengetahui perubahan yang perlu segera dilaporkan, seperti kesulitan bernapas, penurunan kesadaran, demam, kelemahan mendadak, kejang, nyeri dada, atau kondisi lain yang mengarah pada kegawatan.

6. Dukungan Psikologis, Sosial, dan Spiritual

Penyakit kronik dan ketergantungan sering membawa perubahan besar dalam kehidupan pasien. Oleh karena itu, intervensi tidak cukup hanya berfokus pada kebutuhan fisik.

Dukungan psikologis bertujuan membantu pasien menghadapi rasa takut, sedih, frustrasi, atau kehilangan peran. Perawat dan keluarga perlu memberikan ruang kepada pasien untuk mengungkapkan perasaan.

Mendengarkan secara aktif dapat memberikan efek yang sangat berarti. Pasien sering kali membutuhkan kesempatan untuk didengar tanpa segera diberi nasihat.

Keluarga perlu dilibatkan dalam memberikan dukungan emosional. Komunikasi yang hangat, tidak menyalahkan, dan tidak merendahkan dapat membantu mempertahankan harga diri pasien.

Dukungan sosial juga penting. Pasien tetap perlu memiliki kesempatan berinteraksi dengan keluarga besar, tetangga, teman, atau kelompok masyarakat sesuai kemampuan. Isolasi sosial dapat memperburuk kondisi emosional.

Jika pasien tidak mampu keluar rumah, interaksi sosial dapat difasilitasi melalui kunjungan keluarga, komunikasi telepon, atau media digital.

Aspek spiritual perlu dihargai sebagai bagian dari pendekatan holistik. Aktivitas spiritual dapat memberikan makna, harapan, dan ketenangan. Keluarga dapat membantu pasien menjalankan aktivitas spiritual sesuai keyakinannya.

Perawat juga dapat menghubungkan pasien dengan tokoh agama atau sumber dukungan spiritual jika pasien menghendaki.

Dukungan psikologis, sosial, dan spiritual menjadi penting karena kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh kondisi fisik, tetapi juga oleh rasa bermakna, hubungan dengan orang lain, dan kemampuan menerima kondisi.

7. Peningkatan Kemandirian Pasien

Peningkatan kemandirian merupakan salah satu tujuan penting dalam perawatan pasien dengan ketergantungan. Kemandirian tidak harus berarti mampu melakukan semua aktivitas tanpa bantuan.

Pada pasien dengan keterbatasan berat, peningkatan kemandirian dapat berupa kemampuan melakukan sebagian aktivitas, menyampaikan kebutuhan, atau mengambil keputusan terkait perawatan.

Perawat perlu membantu keluarga mengenali kemampuan yang masih dimiliki pasien. Kemampuan tersebut harus dipertahankan dan dilatih.

Terlalu banyak membantu dapat menyebabkan pasien kehilangan kesempatan berlatih. Sebaliknya, menuntut terlalu banyak dapat menyebabkan kelelahan atau cedera. Oleh karena itu, tingkat bantuan harus disesuaikan.

Peningkatan kemandirian dapat dilakukan melalui latihan bertahap. Target sebaiknya realistis dan spesifik. Sebagai contoh, pasien yang sebelumnya hanya mampu duduk di tempat tidur dapat diarahkan untuk duduk di kursi dengan bantuan.

Kemajuan kecil perlu dihargai karena dapat meningkatkan motivasi. Keluarga juga perlu menghindari komentar yang membuat pasien merasa tidak mampu.

Alat bantu dapat digunakan untuk meningkatkan kemandirian, seperti pegangan, kursi mandi, tongkat, atau peralatan makan yang dimodifikasi sesuai kebutuhan.

Peningkatan kemandirian memiliki dampak positif terhadap rasa percaya diri, harga diri, dan kualitas hidup pasien.

8. Pelatihan Keterampilan *Caregiver*

Pelatihan *caregiver* merupakan intervensi penting karena banyak tugas perawatan membutuhkan keterampilan khusus. Pelatihan harus berorientasi pada praktik.

Perawat dapat mengajarkan cara membantu mobilisasi, perubahan posisi, pemberian makan, perawatan kulit, penggunaan alat bantu, pengelolaan obat, serta pemantauan tanda dan gejala.

Setiap keterampilan perlu dijelaskan mengenai tujuan, langkah, risiko, serta kesalahan yang harus dihindari.

Demonstrasi langsung menjadi metode utama. Setelah melihat contoh, *caregiver* perlu diminta melakukan tindakan secara mandiri di bawah pengawasan.

Perawat kemudian memberikan umpan balik agar teknik menjadi lebih aman dan efektif.

Pelatihan juga harus memperhatikan keselamatan *caregiver*. Teknik mengangkat pasien yang salah dapat menyebabkan cedera punggung. Karena itu, prinsip mekanika tubuh perlu diajarkan.

Selain keterampilan teknis, *caregiver* perlu dilatih berkomunikasi dengan pasien. Kesabaran, kemampuan mendengarkan, dan penggunaan bahasa yang sesuai sangat penting.

Caregiver juga perlu memahami kapan harus menghentikan tindakan dan mencari pertolongan. Tidak semua masalah dapat ditangani di rumah.

Pelatihan harus dievaluasi secara berkala karena kebutuhan dapat berubah seiring perkembangan kondisi pasien.

9. Penguatan Mekanisme Koping Keluarga

Mekanisme koping merupakan cara keluarga menghadapi stres dan perubahan akibat penyakit. Penyakit kronik dapat memengaruhi kondisi emosional, ekonomi, dan hubungan keluarga.

Koping yang adaptif membantu keluarga tetap berfungsi meskipun menghadapi tekanan. Bentuknya dapat berupa komunikasi terbuka, pembagian tugas, mencari informasi, memanfaatkan dukungan sosial, atau aktivitas spiritual.

Perawat perlu membantu keluarga mengenali strategi yang selama ini digunakan. Strategi yang efektif dapat dipertahankan.

Keluarga juga perlu dibantu menghindari koping maladaptif, seperti menyangkal kondisi secara terus-menerus, mengisolasi diri, saling menyalahkan, atau mengabaikan kebutuhan pasien.

Komunikasi menjadi salah satu dasar koping keluarga. Anggota keluarga perlu memiliki ruang untuk menyampaikan perasaan dan keterbatasan.

Pembagian tugas juga penting. Beban yang terpusat pada satu orang dapat meningkatkan konflik. Tugas dapat dibagi sesuai kemampuan.

Keluarga perlu memahami bahwa meminta bantuan bukan tanda kegagalan. Dukungan dari keluarga besar, tetangga, kader, atau fasilitas kesehatan dapat digunakan.

Aktivitas yang memberikan relaksasi juga dapat membantu. Waktu istirahat, kegiatan keagamaan, atau interaksi sosial dapat menjadi bagian dari strategi koping.

Perawat dapat membantu keluarga memandang masalah secara realistis, mengidentifikasi hal-hal yang masih dapat dikendalikan, dan menetapkan tujuan yang dapat dicapai.

10. Peningkatan Kemampuan Keluarga dalam Pengambilan Keputusan

Kemampuan mengambil keputusan kesehatan merupakan bagian penting dari pemberdayaan keluarga. Keluarga sering dihadapkan pada pilihan mengenai pengobatan, kontrol, rehabilitasi, penggunaan alat bantu, atau kebutuhan rujukan.

Pengambilan keputusan sebaiknya didasarkan pada informasi yang memadai. Perawat perlu membantu keluarga memahami kondisi pasien, pilihan yang tersedia, manfaat, risiko, dan konsekuensi.

Informasi harus diberikan secara netral dan mudah dipahami. Tujuannya bukan menentukan keputusan untuk keluarga, tetapi membantu mereka membuat pilihan yang sesuai.

Hak pasien tetap menjadi pertimbangan utama. Jika pasien masih mampu mengambil keputusan, pendapatnya harus dihormati.

Keluarga juga perlu memiliki kemampuan mengenali situasi kegawatdaruratan. Dalam kondisi tertentu, keputusan harus diambil cepat.

Peningkatan kemampuan mengambil keputusan dapat dilakukan melalui diskusi kasus. Perawat dapat menanyakan apa yang akan dilakukan keluarga jika pasien mengalami kondisi tertentu.

Pendekatan ini membantu keluarga melatih kemampuan berpikir dan mengenali batas perawatan di rumah.

Pengambilan keputusan juga perlu mempertimbangkan sumber daya. Rencana yang secara klinis ideal tetapi tidak mungkin dilakukan keluarga perlu disesuaikan agar tetap realistis.

Dalam jangka panjang, keluarga yang mampu mengambil keputusan secara mandiri akan lebih percaya diri dalam mengelola kondisi pasien. Ketergantungan terhadap tenaga kesehatan untuk masalah sederhana juga dapat berkurang.

Pemberdayaan keluarga pada akhirnya merupakan proses yang berlangsung terus-menerus. Keluarga tidak langsung mampu mengelola seluruh kebutuhan hanya setelah satu kali edukasi. Pengetahuan, keterampilan, dan rasa percaya diri berkembang melalui pengalaman, pendampingan, evaluasi, dan keberhasilan dalam melakukan perawatan.

Perawat komunitas memiliki peran penting dalam memfasilitasi proses tersebut. Perawat tidak hanya memberikan instruksi, tetapi membantu keluarga memahami situasi, mengenali kekuatan, mengembangkan keterampilan, memanfaatkan sumber daya, dan mengambil keputusan yang tepat. Pendekatan ini membuat keluarga semakin mampu menjalankan fungsi kesehatannya.

Keberhasilan intervensi keperawatan dapat dilihat ketika keluarga mampu melakukan perawatan secara lebih aman, mengenali tanda bahaya, menjalankan terapi secara tepat, mempertahankan kemampuan pasien, dan mengurangi risiko komplikasi. Keberhasilan juga terlihat ketika *caregiver* merasa lebih siap, pembagian tugas menjadi lebih baik, dan keluarga memiliki mekanisme koping yang lebih adaptif.

Dengan demikian, intervensi keperawatan dan pemberdayaan keluarga merupakan inti dari manajemen kasus pada penyakit kronik dan ketergantungan. Pelayanan yang efektif tidak hanya menyelesaikan masalah sesaat, tetapi meningkatkan kemampuan keluarga untuk menghadapi kebutuhan kesehatan dalam jangka panjang. Melalui pendidikan kesehatan, peningkatan keterampilan, manajemen obat, pencegahan komplikasi, dukungan psikososial, pelatihan *caregiver*, penguatan koping, dan peningkatan kemampuan mengambil keputusan, keluarga dapat berkembang menjadi mitra yang aktif, mandiri, dan kompeten dalam mendukung kesehatan anggotanya.

H. Koordinasi, Kontinuitas Pelayanan, dan Peran Perawat Komunitas

Koordinasi dan kontinuitas pelayanan merupakan bagian yang sangat penting dalam manajemen kasus keluarga, terutama pada keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit kronik, ketergantungan, atau kebutuhan perawatan jangka panjang. Pasien dengan kondisi tersebut umumnya tidak hanya menerima pelayanan dari satu tenaga kesehatan atau satu fasilitas pelayanan. Dalam perjalanan perawatannya, pasien dapat berinteraksi dengan rumah sakit, Puskesmas, dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, tenaga rehabilitasi, kader kesehatan, maupun sumber daya masyarakat lainnya. Tanpa koordinasi yang

baik, pelayanan dapat menjadi terfragmentasi, informasi dapat terputus, dan keluarga berisiko mengalami kebingungan dalam mengikuti rencana perawatan.

Dalam keperawatan komunitas, perawat memiliki posisi strategis untuk menghubungkan berbagai layanan tersebut agar pelayanan tetap terarah, konsisten, dan sesuai kebutuhan pasien serta keluarga. Perawat tidak hanya berperan ketika pasien berada dalam kondisi sakit, tetapi juga mendampingi keluarga dalam masa transisi dari rumah sakit ke rumah, melakukan pemantauan di komunitas, memberikan edukasi, mengidentifikasi perubahan kondisi, dan membantu menentukan tindak lanjut. Dengan demikian, koordinasi pelayanan tidak dapat dipisahkan dari fungsi perawat komunitas sebagai pengelola kasus.

1. Konsep *Continuity of Care*

Continuity of care atau kontinuitas pelayanan merupakan konsep pelayanan kesehatan yang menekankan kesinambungan hubungan, informasi, dan intervensi kesehatan dari satu tahap pelayanan ke tahap berikutnya. Tujuan utama kontinuitas pelayanan adalah memastikan bahwa pasien tidak kehilangan arah dalam proses perawatan, terutama ketika berpindah dari satu fasilitas ke fasilitas lain atau ketika kembali ke rumah setelah menjalani perawatan.

Kontinuitas pelayanan menjadi sangat penting pada pasien dengan penyakit kronik karena kebutuhan perawatan berlangsung dalam jangka panjang. Pasien mungkin memerlukan kontrol rutin, pemeriksaan laboratorium, rehabilitasi, pemantauan gejala, pengelolaan obat, dan dukungan keluarga. Jika setiap pelayanan dilakukan secara terpisah tanpa adanya hubungan informasi, risiko terjadinya kesalahan, duplikasi, atau kelalaian akan meningkat.

Kontinuitas pelayanan dapat dilihat dari beberapa aspek. Kontinuitas informasi berkaitan dengan tersedianya informasi yang konsisten mengenai kondisi pasien, riwayat penyakit, terapi, alergi, hasil pemeriksaan, dan rencana tindak lanjut. Informasi tersebut perlu dapat diteruskan kepada tenaga kesehatan yang terlibat dalam perawatan.

Kontinuitas relasional berkaitan dengan hubungan berkelanjutan antara pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan. Hubungan yang terjaga dapat meningkatkan rasa percaya dan memudahkan komunikasi. Pasien lebih nyaman menyampaikan keluhan atau kesulitan kepada tenaga kesehatan yang sudah mengenal kondisi keluarganya.

Sementara itu, kontinuitas manajemen berkaitan dengan konsistensi rencana perawatan. Rencana yang dibuat di rumah sakit perlu diteruskan

dalam pelayanan primer dan perawatan di rumah. Bila terdapat perubahan terapi atau kondisi, perubahan tersebut perlu dikomunikasikan agar keluarga memperoleh informasi yang sama.

Dalam praktik keperawatan komunitas, kontinuitas pelayanan diwujudkan melalui komunikasi terstruktur, dokumentasi yang baik, kunjungan tindak lanjut, koordinasi rujukan, serta pemantauan kondisi pasien di rumah. Perawat komunitas dapat menjadi penghubung yang memastikan informasi dari rumah sakit dapat dipahami dan dilaksanakan oleh keluarga.

Keberhasilan kontinuitas pelayanan dapat terlihat ketika pasien memperoleh pelayanan sesuai kebutuhannya tanpa mengalami kesenjangan. Keluarga mengetahui siapa yang harus dihubungi, kapan harus kontrol, bagaimana melanjutkan terapi, dan apa yang harus dilakukan jika kondisi berubah.

2. *Discharge Planning* Berbasis Keluarga

Discharge planning merupakan proses perencanaan yang dilakukan sebelum pasien pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan agar perawatan dapat dilanjutkan dengan aman di rumah. Pada pasien dengan penyakit kronik atau ketergantungan, proses ini sangat penting karena perubahan lingkungan dari rumah sakit ke rumah sering kali disertai perubahan tanggung jawab. Di rumah sakit, sebagian besar kebutuhan pasien ditangani tenaga profesional, sedangkan setelah pulang, tanggung jawab tersebut sebagian besar beralih kepada pasien dan keluarga.

Discharge planning berbasis keluarga berarti bahwa proses persiapan pulang tidak hanya memberikan informasi kepada pasien, tetapi juga melibatkan keluarga yang akan melakukan perawatan. Keluarga perlu memahami kondisi pasien, terapi yang harus dilanjutkan, jadwal kontrol, aktivitas yang diperbolehkan, kebutuhan diet, cara menggunakan alat kesehatan, serta tanda bahaya yang harus segera ditindaklanjuti.

Proses ini sebaiknya dimulai sejak awal perawatan, bukan hanya beberapa jam sebelum pasien pulang. Dengan persiapan yang lebih awal, keluarga memiliki waktu untuk belajar dan mempersiapkan kebutuhan di rumah. Bila pasien membutuhkan kursi roda, tempat tidur khusus, alat bantu, atau modifikasi lingkungan, keluarga dapat mempersiapkannya sebelum pasien pulang.

Perawat perlu menilai kesiapan keluarga. Tidak semua keluarga siap menerima pasien dengan kebutuhan kompleks. Kesiapan mencakup pemahaman, keterampilan, waktu, dukungan, dan kemampuan ekonomi. Jika

terdapat keterbatasan, perawat perlu membantu mencari solusi sebelum pasien dipulangkan.

Edukasi dalam *discharge planning* harus diberikan secara jelas dan sederhana. Keluarga perlu mengetahui jadwal obat, cara penyimpanan, efek samping, serta langkah yang harus dilakukan jika obat terlupa. Jika terdapat perawatan luka, keluarga harus memahami teknik yang aman.

Perawat juga perlu memastikan keluarga memahami tanda bahaya. Informasi tidak cukup diberikan dalam bentuk daftar; keluarga harus memahami makna setiap tanda dan tindakan yang perlu dilakukan.

Keterampilan khusus perlu diajarkan melalui demonstrasi. Misalnya, pada pasien dengan mobilitas terbatas, keluarga perlu berlatih memindahkan pasien. Pada pasien dengan kebutuhan tertentu, keluarga mungkin perlu belajar mengukur tekanan darah, melakukan perawatan kulit, atau menggunakan alat bantu.

Aspek lain yang penting adalah rencana tindak lanjut. Keluarga perlu mengetahui kapan dan di mana pasien harus kontrol, siapa yang dapat dihubungi, serta apakah diperlukan kunjungan rumah.

Discharge planning yang baik dapat mengurangi risiko komplikasi, kesalahan obat, keterlambatan mencari pertolongan, dan rawat ulang. Lebih dari itu, proses ini membantu keluarga merasa lebih siap dan percaya diri menjalankan perawatan di rumah.

3. Kunjungan Rumah dan Pemantauan Berkelanjutan

Kunjungan rumah merupakan salah satu bentuk intervensi khas dalam keperawatan komunitas. Melalui kunjungan rumah, perawat dapat melihat secara langsung kondisi pasien dalam lingkungan sehari-hari. Informasi yang diperoleh sering kali lebih lengkap dibandingkan pengkajian di fasilitas kesehatan karena perawat dapat memahami bagaimana keluarga menerapkan perawatan, kondisi rumah, pola interaksi, serta hambatan yang dihadapi.

Kunjungan rumah memungkinkan perawat mengevaluasi apakah rencana perawatan benar-benar dapat dijalankan. Misalnya, keluarga mungkin memahami anjuran pencegahan jatuh, tetapi kondisi rumah masih memiliki banyak hambatan. Perawat dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret setelah melihat situasi langsung.

Pada pasien dengan penyakit kronik, kunjungan rumah dapat digunakan untuk memantau gejala, kepatuhan obat, pola makan, aktivitas, kondisi kulit, dan kemampuan fungsional. Pada pasien dengan ketergantungan, perawat

dapat mengamati bagaimana *caregiver* membantu pasien dan apakah teknik yang digunakan sudah aman.

Kunjungan rumah juga memberikan kesempatan untuk mengevaluasi *caregiver*. Perawat dapat mengamati tanda kelelahan, kesulitan komunikasi, atau pembagian tugas yang tidak seimbang.

Frekuensi kunjungan disesuaikan dengan kebutuhan. Keluarga dengan risiko tinggi dapat membutuhkan pemantauan lebih sering, sedangkan keluarga yang sudah mandiri dapat dikunjungi dengan interval lebih panjang.

Pemantauan berkelanjutan tidak selalu harus berupa kunjungan tatap muka. Komunikasi melalui telepon atau media digital dapat digunakan untuk follow-up tertentu apabila sesuai kondisi.

Pemantauan bertujuan mendeteksi perubahan sedini mungkin. Perawat perlu membandingkan kondisi terbaru dengan data sebelumnya dan menilai apakah tujuan perawatan tercapai.

Kunjungan rumah juga menjadi sarana membangun hubungan terapeutik. Keluarga yang merasa didampingi cenderung lebih terbuka menyampaikan masalah.

4. Sistem Rujukan dan Rujuk Balik

Sistem rujukan merupakan mekanisme untuk memastikan pasien memperoleh pelayanan sesuai tingkat kebutuhannya. Pasien yang membutuhkan pemeriksaan atau tindakan yang tidak tersedia di pelayanan primer perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih sesuai.

Perawat komunitas perlu memahami indikasi rujukan dan membantu keluarga dalam proses tersebut. Rujukan tidak hanya terkait kegawatdaruratan, tetapi juga kebutuhan pemeriksaan lanjutan, rehabilitasi, konsultasi spesialis, atau pelayanan lain.

Rujukan yang baik harus disertai informasi yang jelas mengenai kondisi pasien, tindakan yang sudah dilakukan, obat yang digunakan, serta alasan rujukan. Informasi ini membantu fasilitas penerima memahami kebutuhan pasien.

Rujuk balik sama pentingnya. Setelah pasien mendapatkan pelayanan di fasilitas rujukan, informasi mengenai diagnosis, terapi, dan rencana tindak lanjut perlu diteruskan kembali ke pelayanan primer atau perawat komunitas.

Tanpa rujuk balik yang baik, keluarga dapat memperoleh informasi yang tidak lengkap. Akibatnya, terapi dapat terputus atau keluarga tidak mengetahui tindak lanjut.

Perawat dapat membantu memastikan bahwa rekomendasi dari fasilitas rujukan diterapkan di rumah. Bila ada perubahan obat atau diet, keluarga perlu memperoleh penjelasan ulang.

Sistem rujukan dan rujuk balik yang efektif memperkuat kontinuitas pelayanan dan mengurangi fragmentasi.

5. Kolaborasi Interprofesional

Pasien dengan penyakit kronik dan ketergantungan sering membutuhkan pelayanan multidisiplin. Satu profesi tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan.

Kolaborasi interprofesional merupakan kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan dengan tujuan yang sama, yaitu memberikan pelayanan yang aman dan sesuai kebutuhan pasien. Tim dapat terdiri atas dokter, perawat, ahli gizi, fisioterapis, apoteker, psikolog, pekerja sosial, atau tenaga lainnya.

Perawat komunitas sering menjadi pihak yang memiliki gambaran menyeluruh mengenai kondisi keluarga. Informasi dari kunjungan rumah dapat membantu profesi lain memahami hambatan yang tidak terlihat di fasilitas kesehatan.

Kolaborasi memerlukan komunikasi yang jelas. Setiap profesi perlu mengetahui tujuan, tanggung jawab, dan intervensi yang dilakukan pihak lain. Hal ini penting untuk mencegah duplikasi atau rekomendasi yang bertentangan.

Sebagai contoh, pada pasien stroke, fisioterapis dapat fokus pada rehabilitasi, ahli gizi pada kebutuhan nutrisi, dokter pada terapi medis, sedangkan perawat komunitas membantu keluarga mengintegrasikan seluruh rekomendasi ke dalam kehidupan sehari-hari.

Kolaborasi juga membantu mengatasi masalah yang berada di luar kompetensi perawat. Bila ditemukan depresi, masalah sosial, atau masalah nutrisi kompleks, perawat dapat berkoordinasi dengan profesi terkait.

Kolaborasi yang baik meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan karena keputusan dibuat berdasarkan perspektif yang lebih luas.

6. Pemanfaatan Puskesmas, Kader, dan Sumber Daya Masyarakat

Puskesmas memiliki peran penting sebagai fasilitas pelayanan kesehatan primer yang dekat dengan masyarakat. Dalam manajemen kasus keluarga, Puskesmas dapat menjadi pusat koordinasi pelayanan, pemantauan penyakit kronik, edukasi, kunjungan rumah, dan rujukan.

Perawat komunitas dapat memanfaatkan berbagai program Puskesmas untuk mendukung keluarga. Pasien dengan penyakit kronik dapat terhubung dengan kegiatan pemantauan kesehatan atau program yang relevan.

Kader kesehatan juga memiliki potensi besar. Sebagai bagian dari masyarakat, kader sering memiliki kedekatan dengan keluarga dan memahami kondisi lingkungan. Kader dapat membantu mengingatkan jadwal kegiatan, memantau kondisi sederhana, memberikan dukungan, atau menyampaikan informasi kepada tenaga kesehatan.

Peran kader harus tetap disesuaikan dengan kemampuan dan kewenangannya. Kader bukan pengganti tenaga profesional, tetapi mitra dalam kegiatan promotif, preventif, dan pemantauan sederhana.

Sumber daya masyarakat lain juga dapat dimanfaatkan. Kelompok lansia, organisasi sosial, kelompok keagamaan, atau komunitas lokal dapat memberikan dukungan sosial dan emosional.

Perawat perlu memetakan sumber daya yang tersedia. Tidak semua keluarga membutuhkan layanan formal; sebagian dapat dibantu melalui jaringan sosial.

Pemanfaatan sumber daya masyarakat dapat mengurangi beban keluarga dan memperkuat dukungan sosial.

7. Pemanfaatan *Telehealth* dan Teknologi Kesehatan

Perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam pelayanan komunitas. *Telehealth* memungkinkan komunikasi dan pemantauan dilakukan tanpa selalu bertemu secara langsung.

Dalam manajemen kasus keluarga, *telehealth* dapat digunakan untuk konsultasi sederhana, pemantauan gejala, edukasi, pengingat kontrol, atau evaluasi kepatuhan.

Perawat dapat menggunakan komunikasi jarak jauh untuk menanyakan kondisi pasien, memantau perubahan, atau memberikan instruksi lanjutan. Hal ini bermanfaat terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan akses transportasi.

Teknologi juga dapat digunakan untuk pencatatan sederhana, misalnya pencatatan tekanan darah, kadar gula, atau berat badan. Data tersebut dapat membantu evaluasi.

Aplikasi pengingat obat juga dapat membantu pasien yang sering lupa.

Namun, pemanfaatan teknologi perlu mempertimbangkan literasi digital. Tidak semua pasien atau keluarga mampu menggunakan aplikasi kompleks. Solusi harus disesuaikan.

Privasi dan keamanan informasi juga perlu diperhatikan. Data pasien tidak boleh disebarkan melalui media yang tidak aman.

Teknologi sebaiknya menjadi pelengkap, bukan menggantikan seluruh interaksi tatap muka. Pada pasien dengan kondisi kompleks, penilaian langsung tetap diperlukan.

8. Perawat sebagai *Case Manager*

Sebagai *case manager*, perawat bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagai kebutuhan pasien dan keluarga. Peran ini mencakup pengkajian, perencanaan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.

Perawat perlu memahami kondisi pasien secara utuh. Informasi medis, fungsional, psikologis, sosial, dan lingkungan perlu diintegrasikan.

Setelah pengkajian, perawat membantu menyusun prioritas dan rencana. Rencana harus realistis dan sesuai kemampuan keluarga.

Perawat juga menghubungkan keluarga dengan pelayanan yang diperlukan. Jika pasien membutuhkan fisioterapi, rujukan, atau bantuan sosial, perawat dapat membantu koordinasi.

Sebagai *case manager*, perawat harus memastikan bahwa informasi tidak terputus. Perubahan terapi perlu dikomunikasikan kepada keluarga dan tim.

Perawat juga memantau apakah layanan benar-benar diterima. Rujukan saja tidak cukup jika keluarga tidak mampu datang karena masalah transportasi.

Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah tujuan tercapai dan apakah rencana perlu diubah.

Peran ini membutuhkan kemampuan organisasi, komunikasi, pengambilan keputusan, dan kolaborasi.

9. Perawat sebagai Edukator, Konselor, dan Advokat

Sebagai edukator, perawat membantu pasien dan keluarga memahami kondisi kesehatan dan perawatan. Edukasi harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman.

Perawat perlu memastikan bahwa keluarga mampu menerapkan informasi, bukan hanya mendengarkan.

Sebagai konselor, perawat membantu keluarga menghadapi masalah emosional, konflik, atau kebingungan dalam mengambil keputusan. Konseling tidak berarti memberi keputusan, tetapi membantu keluarga memahami situasi dan menemukan pilihan.

Kemampuan mendengarkan menjadi sangat penting. Banyak keluarga membutuhkan kesempatan untuk mengungkapkan rasa takut, lelah, atau kecewa.

Sebagai advokat, perawat membantu memastikan hak pasien dihormati. Pasien tetap memiliki hak memperoleh informasi, menentukan pilihan, menjaga privasi, dan mendapatkan pelayanan yang aman.

Perawat juga dapat membantu keluarga berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain ketika mengalami kesulitan.

Advokasi menjadi penting terutama pada pasien yang memiliki keterbatasan komunikasi atau ketergantungan tinggi. Perawat perlu memastikan bahwa kebutuhan pasien tidak diabaikan.

10. Evaluasi Keberhasilan Manajemen Kasus Keluarga

Evaluasi merupakan proses menentukan apakah intervensi yang diberikan berhasil mencapai tujuan. Evaluasi tidak hanya dilakukan pada kondisi pasien, tetapi juga pada kemampuan keluarga.

Aspek pertama adalah perubahan status kesehatan. Perawat menilai apakah kondisi stabil, membaik, atau memburuk.

Kedua, perawat menilai fungsi pasien. Apakah tingkat kemandirian meningkat atau menurun? Apakah pasien mampu melakukan aktivitas yang sebelumnya tidak mampu dilakukan?

Ketiga, evaluasi mencakup kemampuan keluarga. Apakah keluarga mampu memberikan obat, mengenali tanda bahaya, atau melakukan perawatan dengan benar?

Keempat, kondisi *caregiver* perlu dinilai. Keberhasilan tidak dapat dikatakan optimal jika kondisi pasien membaik tetapi *caregiver* mengalami kelelahan berat.

Kelima, penggunaan pelayanan kesehatan juga dapat menjadi indikator. Berkurangnya kunjungan gawat darurat atau rawat inap yang sebenarnya dapat dicegah dapat menunjukkan perbaikan pengelolaan di rumah.

Keenam, kualitas hidup perlu dipertimbangkan. Pasien yang memiliki kondisi stabil tetapi mengalami isolasi sosial berat tetap membutuhkan intervensi.

Evaluasi perlu dilakukan secara berkala dan dibandingkan dengan tujuan awal.

Jika hasil belum tercapai, perawat perlu mencari penyebab. Mungkin intervensi tidak sesuai, keluarga mengalami hambatan, atau kondisi pasien berubah.

11. Perencanaan Tindak Lanjut Pelayanan

Tindak lanjut merupakan tahap yang memastikan bahwa keberhasilan perawatan dapat dipertahankan. Perencanaan tindak lanjut perlu dilakukan sebelum intensitas pelayanan dikurangi.

Perawat perlu menentukan kebutuhan pemantauan berikutnya. Keluarga berisiko tinggi mungkin membutuhkan kunjungan lebih sering.

Jadwal kontrol perlu dipastikan. Keluarga harus mengetahui waktu dan tempat pelayanan.

Tindak lanjut juga mencakup pemantauan kepatuhan obat dan terapi.

Jika pasien telah lebih mandiri, perawat dapat mengurangi intensitas pendampingan secara bertahap. Namun, keluarga tetap perlu mengetahui bagaimana menghubungi pelayanan jika muncul masalah.

Pada pasien yang mengalami penurunan fungsi, tindak lanjut dapat memerlukan peningkatan dukungan.

Rencana tindak lanjut harus fleksibel. Kondisi penyakit kronik dapat berubah dan kebutuhan pelayanan dapat meningkat kembali.

Terminasi manajemen kasus sebaiknya dilakukan ketika tujuan utama tercapai dan keluarga memiliki kemampuan cukup untuk melanjutkan perawatan. Terminasi bukan berarti hubungan pelayanan berhenti sepenuhnya, tetapi intensitas dapat disesuaikan.

Keluarga perlu mengetahui tanda atau kondisi yang mengharuskan kembali berkonsultasi. Informasi tersebut memberikan rasa aman.

Dokumentasi tindak lanjut juga penting agar pelayanan berikutnya memiliki informasi yang jelas.

Secara keseluruhan, koordinasi dan kontinuitas pelayanan merupakan fondasi penting dalam manajemen kasus keluarga. Pasien dengan penyakit kronik dan ketergantungan membutuhkan pelayanan yang tidak terputus, terarah, dan terintegrasi antara fasilitas kesehatan, keluarga, serta sumber daya masyarakat. Perawat komunitas memiliki posisi strategis sebagai penghubung yang memastikan bahwa kebutuhan pasien dapat diterjemahkan menjadi rencana pelayanan yang nyata dan dapat dilaksanakan.

Melalui *continuity of care*, *discharge planning*, kunjungan rumah, sistem rujukan, kolaborasi interprofesional, pemanfaatan Puskesmas dan kader, serta penggunaan teknologi kesehatan, perawat dapat menjaga kesinambungan pelayanan. Peran sebagai *case manager*, edukator, konselor, dan advokat semakin memperkuat kemampuan perawat dalam mendampingi keluarga.

Keberhasilan manajemen kasus tidak hanya dinilai dari membaiknya kondisi penyakit, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan keluarga,

terpeliharanya kemandirian pasien, berkurangnya beban *caregiver*, meningkatnya kualitas hidup, serta kemampuan keluarga mempertahankan perawatan secara berkelanjutan. Dengan koordinasi yang baik dan tindak lanjut yang terencana, keluarga dapat menjadi lebih siap, mandiri, dan mampu menghadapi perubahan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.

I. Latihan Soal

Soal 1

Seorang perawat komunitas melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan seorang laki-laki berusia 68 tahun yang mengalami stroke sejak 6 bulan lalu. Pasien mengalami kelemahan ekstremitas kanan dan membutuhkan bantuan untuk mandi, berpakaian, berpindah dari tempat tidur, dan menggunakan toilet. Istri pasien berusia 65 tahun menjadi satu-satunya *caregiver*. Hasil pengkajian menunjukkan istri sering mengeluh nyeri punggung, tidur hanya 4–5 jam setiap malam, mudah marah, serta sudah jarang mengikuti kegiatan sosial karena tidak ada anggota keluarga lain yang menggantikannya merawat pasien. Kondisi pasien relatif stabil.

Apakah masalah yang paling diprioritaskan oleh perawat pada keluarga tersebut?

A. Isolasi sosial pasien
B. Gangguan mobilitas pasien
C. Ketidakpatuhan terhadap terapi
D. Risiko *caregiver burden* pada istri
E. Ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan

Kunci Jawaban: d. Risiko *caregiver burden* pada istri

Kata kunci jawaban: satu-satunya *caregiver*, nyeri punggung, kurang tidur, mudah marah, kehilangan aktivitas sosial, dan perawatan berlangsung lama.

Pembahasan:

Jawaban **d. Risiko *caregiver burden* pada istri** merupakan jawaban yang paling tepat. Data kasus menunjukkan adanya akumulasi beban fisik, psikologis, dan sosial pada istri sebagai *caregiver* utama. Keluhan nyeri punggung menunjukkan beban fisik akibat aktivitas perawatan, sedangkan waktu tidur yang hanya 4–5 jam menggambarkan kurangnya kesempatan untuk beristirahat. Kondisi mudah marah mengarah pada tekanan psikologis, sementara berkurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial menunjukkan bahwa tanggung jawab perawatan telah memengaruhi kehidupan sosial *caregiver*. Apabila kondisi tersebut berlangsung terus-menerus tanpa dukungan, risiko berkembang menjadi *caregiver burnout* akan semakin meningkat.

Opsi **a. Isolasi sosial pasien** kurang tepat karena tidak terdapat data yang menunjukkan bahwa pasien mengalami isolasi sosial. Justru istri pasien yang mulai kehilangan kesempatan untuk mengikuti aktivitas sosial akibat tanggung jawab perawatan.

Opsi **b. Gangguan mobilitas pasien** memang sesuai dengan kondisi pasien pascastroke, tetapi masalah tersebut telah berlangsung selama enam bulan dan kondisi pasien saat ini relatif stabil. Data yang paling menonjol dalam kasus adalah masalah yang dialami *caregiver*.

Opsi **c. Ketidakpatuhan terhadap terapi** tidak tepat karena tidak terdapat informasi bahwa pasien tidak minum obat, tidak mengikuti rehabilitasi, atau tidak mematuhi rencana terapi.

Opsi **e. Ketidakmampuan keluarga menggunakan fasilitas kesehatan** juga tidak sesuai karena tidak terdapat data mengenai hambatan keluarga dalam mengakses atau memanfaatkan pelayanan kesehatan.

Soal 2

Seorang perempuan berusia 72 tahun tinggal bersama anak perempuannya. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan osteoartritis. Hasil kunjungan rumah menunjukkan pasien mampu makan, mandi, berpakaian, menggunakan toilet, dan berjalan di dalam rumah secara mandiri. Namun, pasien sering lupa jadwal obat, tidak mampu berbelanja sendiri, kesulitan menggunakan transportasi umum, dan beberapa kali salah menghitung uang ketika membayar kebutuhan rumah tangga. Anak pasien mengatakan bahwa ibunya masih dianggap mandiri karena dapat melakukan seluruh perawatan diri tanpa bantuan.

Apakah pengkajian tambahan yang paling tepat dilakukan oleh perawat?

A. Pengkajian nyeri akut
B. Pengkajian risiko infeksi
C. Pengkajian tingkat kesadaran
D. Pengkajian *Activities of Daily Living*
E. Pengkajian *Instrumental Activities of Daily Living*

Kunci Jawaban: e. Pengkajian *Instrumental Activities of Daily Living*

Kata kunci jawaban: ADL dasar masih mandiri, kesulitan mengelola obat, berbelanja, menggunakan transportasi, dan mengelola keuangan.

Pembahasan:

Jawaban **e. Pengkajian *Instrumental Activities of Daily Living*** merupakan jawaban yang paling tepat. Pasien masih mampu melakukan aktivitas dasar sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, menggunakan toilet, dan berjalan. Namun, pasien mengalami kesulitan dalam aktivitas yang lebih kompleks, yaitu mengelola

obat, menggunakan transportasi, berbelanja, dan mengelola keuangan. Aktivitas tersebut merupakan komponen dalam penilaian IADL. Pengkajian IADL diperlukan untuk mengetahui sejauh mana seseorang mampu hidup secara mandiri di komunitas meskipun kemampuan aktivitas dasarnya masih baik.

Opsi **a. Pengkajian nyeri akut** kurang tepat. Pasien memang memiliki osteoartritis, tetapi tidak terdapat data bahwa nyeri akut menjadi masalah utama pada saat kunjungan.

Opsi **b. Pengkajian risiko infeksi** tidak sesuai karena tidak ditemukan tanda atau kondisi yang menunjukkan adanya risiko infeksi sebagai masalah utama.

Opsi **c. Pengkajian tingkat kesadaran** kurang tepat karena tidak terdapat perubahan kesadaran. Kesulitan pasien lebih berkaitan dengan aktivitas instrumental dan kemungkinan fungsi kognitif yang memengaruhi kemandiriannya.

Opsi **d. Pengkajian *Activities of Daily Living*** kurang tepat sebagai pengkajian tambahan utama karena kemampuan ADL pasien sudah tergambar dalam kasus dan pasien masih mampu melakukan aktivitas dasar secara mandiri.

Soal 3

Seorang laki-laki berusia 64 tahun dengan diabetes melitus dan riwayat stroke akan pulang setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Pasien mengalami kelemahan ekstremitas kiri dan membutuhkan bantuan saat berpindah dari tempat tidur ke kursi. Istri pasien mengatakan, "Saya belum pernah merawat orang sakit seperti ini. Saya takut salah memindahkan suami, dan saya juga belum mengerti obat mana yang harus diminum pagi atau malam." Rumah pasien memiliki kamar mandi dengan lantai licin dan belum memiliki pegangan. Jadwal kontrol pasien adalah satu minggu setelah pulang.

Apakah tindakan perawat yang paling tepat sebelum pasien pulang?

A. Menyerahkan seluruh perawatan kepada istri pasien
B. Menjadwalkan kunjungan rumah setelah pasien mengalami keluhan
C. Meminta keluarga mempelajari perawatan secara mandiri di rumah
D. Memberikan daftar obat dan jadwal kontrol tanpa demonstrasi
E. Melaksanakan *discharge planning* berbasis keluarga disertai demonstrasi perawatan

Kunci Jawaban: e. Melaksanakan *discharge planning* berbasis keluarga disertai demonstrasi perawatan

Kata kunci jawaban: pasien akan pulang, keluarga belum siap, belum memahami obat, belum mampu melakukan transfer pasien, dan terdapat risiko lingkungan rumah.

Pembahasan:

Jawaban **e. Melaksanakan *discharge planning* berbasis keluarga disertai demonstrasi perawatan** merupakan jawaban yang paling tepat. Kasus menunjukkan bahwa pasien akan mengalami transisi dari rumah sakit ke rumah, sementara keluarga belum memiliki kesiapan pengetahuan maupun keterampilan. Istri belum mampu melakukan transfer pasien dengan aman, belum memahami pengelolaan obat, dan lingkungan rumah masih memiliki faktor risiko jatuh. Oleh karena itu, sebelum pasien pulang, perawat perlu melakukan *discharge planning* yang melibatkan keluarga, mencakup pendidikan mengenai obat, aktivitas, tanda bahaya, jadwal kontrol, modifikasi lingkungan, serta demonstrasi keterampilan perawatan yang diperlukan.

Opsi **a. Menyerahkan seluruh perawatan kepada istri pasien** tidak tepat karena istri secara jelas menyatakan belum siap dan belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan.

Opsi **b. Menjadwalkan kunjungan rumah setelah pasien mengalami keluhan** kurang tepat karena pemantauan dan tindak lanjut harus direncanakan sebelum masalah terjadi. Menunggu sampai muncul keluhan dapat meningkatkan risiko komplikasi.

Opsi **c. Meminta keluarga mempelajari perawatan secara mandiri di rumah** tidak aman karena terdapat keterampilan khusus yang harus dikuasai, terutama dalam memindahkan pasien.

Opsi **d. Memberikan daftar obat dan jadwal kontrol tanpa demonstrasi** belum memadai. Informasi tertulis memang bermanfaat, tetapi keluarga juga perlu memperoleh pelatihan langsung untuk memastikan keterampilan dapat dilakukan dengan benar.

Soal 4

Seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada laki-laki berusia 70 tahun yang mengalami stroke dan sebagian besar waktunya berada di tempat tidur. Pasien membutuhkan bantuan saat berpindah posisi. Hasil pemeriksaan menunjukkan kulit di daerah sakrum mulai tampak kemerahan dan tidak memucat ketika ditekan. Istri pasien mengatakan bahwa posisi pasien biasanya diubah hanya pagi dan sore karena ia takut pasien merasa nyeri. Pasien juga sering mengeluh tidak nyaman ketika berbaring terlalu lama.

Apakah intervensi keperawatan yang paling diprioritaskan?

A. Menganjurkan pasien tidur lebih lama
B. Membatasi mobilisasi untuk mengurangi nyeri
C. Meminta keluarga meningkatkan asupan cairan saja

D. Mengajarkan perubahan posisi dan pemantauan kondisi kulit
E. Menganjurkan keluarga membawa pasien berjalan tanpa bantuan

Kunci Jawaban: d. Mengajarkan perubahan posisi dan pemantauan kondisi kulit

Kata kunci jawaban: imobilisasi, kemerahan sakrum, perubahan posisi jarang, dan risiko luka tekan.

Pembahasan:

Jawaban **d. Mengajarkan perubahan posisi dan pemantauan kondisi kulit** merupakan jawaban yang paling tepat. Pasien mengalami keterbatasan mobilitas dan menghabiskan sebagian besar waktu di tempat tidur. Kemerahan pada area sakrum yang tidak memucat ketika ditekan menunjukkan adanya kerusakan jaringan akibat tekanan yang perlu segera mendapatkan perhatian. Keluarga juga hanya mengubah posisi pasien dua kali sehari, sehingga risiko terjadinya luka tekan semakin besar. Intervensi utama adalah mengajarkan perubahan posisi secara teratur, memantau kondisi kulit, menjaga kulit tetap bersih dan kering, serta mendukung mobilisasi sesuai toleransi pasien.

Opsi **a. Menganjurkan pasien tidur lebih lama** tidak tepat karena akan meningkatkan durasi tekanan pada area tubuh tertentu dan memperbesar risiko kerusakan kulit.

Opsi **b. Membatasi mobilisasi untuk mengurangi nyeri** tidak tepat karena imobilisasi yang berkepanjangan justru dapat meningkatkan risiko luka tekan, kelemahan otot, kekakuan sendi, dan penurunan fungsi.

Opsi **c. Meminta keluarga meningkatkan asupan cairan saja** tidak cukup untuk mengatasi masalah utama. Pemenuhan cairan memang penting sesuai kondisi pasien, tetapi bukan tindakan utama untuk mengurangi tekanan pada area sakrum.

Opsi **e. Menganjurkan keluarga membawa pasien berjalan tanpa bantuan** tidak aman karena pasien membutuhkan bantuan saat berpindah posisi dan kemampuan berjalannya belum diketahui.

Soal 5

Seorang perempuan berusia 59 tahun menderita hipertensi dan diabetes melitus selama 8 tahun. Saat kunjungan rumah, pasien mengatakan sering tidak minum obat ketika merasa tubuhnya sehat. Anak pasien biasanya langsung menyiapkan semua obat, makanan, dan kebutuhan sehari-hari tanpa melibatkan pasien karena khawatir ibunya salah. Pasien sebenarnya masih mampu membaca label obat, berjalan sendiri, dan menyiapkan makanan sederhana. Hasil wawancara menunjukkan pasien belum memahami tujuan pengobatan jangka panjang dan tidak mengetahui tanda bahaya penyakitnya.

Apakah intervensi perawat yang paling tepat untuk meningkatkan *self-management* pasien?

A. Meminta anak tetap mengambil alih seluruh perawatan
B. Membatasi seluruh aktivitas pasien agar tidak mengalami komplikasi
C. Memberikan semua keputusan kesehatan kepada keluarga
D. Melakukan kunjungan hanya ketika pasien mengalami kekambuhan
E. Memberikan edukasi bertahap dan melibatkan pasien dalam pengelolaan obat serta perawatan

Kunci Jawaban: e. Memberikan edukasi bertahap dan melibatkan pasien dalam pengelolaan obat serta perawatan

Kata kunci jawaban: masih mampu melakukan aktivitas, belum memahami terapi, tidak patuh ketika merasa sehat, dan keluarga terlalu mengambil alih perawatan.

Pembahasan:

Jawaban **e. Memberikan edukasi bertahap dan melibatkan pasien dalam pengelolaan obat serta perawatan** merupakan jawaban yang paling tepat. Pasien masih memiliki kemampuan membaca label obat, berjalan, dan menyiapkan makanan sederhana. Artinya, pasien masih memiliki potensi untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan penyakitnya. Namun, kurangnya pemahaman mengenai tujuan pengobatan menyebabkan pasien menghentikan obat ketika merasa sehat. Pada saat yang sama, keluarga terlalu banyak mengambil alih aktivitas pasien. Kondisi tersebut dapat mengurangi kemandirian dan kemampuan *self-management*. Perawat perlu memberikan edukasi bertahap mengenai penyakit, tujuan pengobatan, tanda bahaya, dan pengelolaan sehari-hari sekaligus melibatkan pasien sesuai kemampuan yang masih dimilikinya.

Opsi **a. Meminta anak tetap mengambil alih seluruh perawatan** tidak tepat karena dapat meningkatkan ketergantungan pasien dan menghambat pengembangan kemampuan *self-management*.

Opsi **b. Membatasi seluruh aktivitas pasien agar tidak mengalami komplikasi** kurang tepat karena pasien masih mampu melakukan beberapa aktivitas secara mandiri. Kemandirian yang masih ada justru perlu dipertahankan.

Opsi **c. Memberikan semua keputusan kesehatan kepada keluarga** tidak tepat karena pasien masih mampu berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Hak dan otonomi pasien perlu tetap dihormati.

Opsi **d. Melakukan kunjungan hanya ketika pasien mengalami kekambuhan** tidak sesuai dengan prinsip manajemen penyakit kronik. Pasien membutuhkan pemantauan, pendidikan, dan pencegahan secara berkelanjutan, bukan hanya ketika mengalami perburukan.

J. Rangkuman Materi

Manajemen kasus keluarga merupakan pendekatan penting dalam keperawatan komunitas untuk membantu keluarga yang memiliki anggota dengan penyakit kronik, ketergantungan, atau kebutuhan perawatan jangka panjang. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kondisi klinis pasien, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan fungsional, kondisi psikologis, lingkungan rumah, sumber daya keluarga, dukungan sosial, serta kapasitas *caregiver*. Pelaksanaan manajemen kasus dilakukan secara terstruktur melalui identifikasi keluarga berisiko, pengkajian komprehensif, penetapan prioritas masalah, penyusunan tujuan dan rencana pelayanan, pelaksanaan intervensi, pemantauan, evaluasi, serta tindak lanjut. Pendekatan yang berpusat pada pasien dan keluarga, holistik, individual, kolaboratif, serta berkesinambungan menjadi dasar agar pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata setiap keluarga.

Penyakit kronik dan ketergantungan dapat menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan pasien maupun keluarga, termasuk perubahan peran, penurunan kemandirian, peningkatan kebutuhan perawatan, beban ekonomi, serta munculnya tekanan psikologis dan sosial. Tingkat ketergantungan pasien perlu dinilai melalui kemampuan melakukan aktivitas dasar dan instrumental sehari-hari sehingga bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan tanpa menghilangkan kemampuan yang masih dimiliki pasien. Pada saat yang sama, keberadaan *caregiver* menjadi bagian penting dalam keberhasilan perawatan. *Caregiver* dapat mengalami beban fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi apabila tanggung jawab perawatan berlangsung lama tanpa dukungan yang memadai. Oleh karena itu, kesejahteraan *caregiver* harus menjadi bagian dari pengkajian dan intervensi, termasuk melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pembagian tanggung jawab, penerapan *self-care*, serta dukungan *respite care* apabila diperlukan.

Perawat komunitas memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan keluarga melalui pendidikan kesehatan, pelatihan keterampilan perawatan di rumah, manajemen obat, pencegahan komplikasi, peningkatan kemandirian pasien, penguatan mekanisme koping, serta peningkatan kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Perawat juga berperan menjaga kontinuitas pelayanan melalui *discharge planning*, kunjungan rumah, sistem rujukan dan rujuk balik, kolaborasi interprofesional, pemanfaatan Puskesmas dan kader, serta penggunaan teknologi kesehatan. Keberhasilan manajemen kasus keluarga pada akhirnya tidak hanya ditandai oleh membaik atau stabilnya kondisi penyakit, tetapi juga oleh meningkatnya kemandirian pasien, kemampuan keluarga dalam memberikan perawatan yang aman, berkurangnya beban *caregiver*, terpeliharanya kualitas hidup, serta kemampuan keluarga mempertahankan perawatan secara mandiri dan berkelanjutan.

K. Daftar Pustaka

Alqarawi, N., & Alhalal, E. (2024). Factors affecting family-centered care practice by nurses: A systematic review. *Journal of Pediatric Nursing, 78*, 158–171. doi:10.1016/j.pedn.2024.06.008

Bakas, T., McCarthy, M. J., & Miller, E. L. (2022). Systematic review of the evidence for stroke family caregiver and dyad interventions. *Stroke, 53*(6), 2093–2102. doi:10.1161/STROKEAHA.121.034090

Burch, P., Walter, A., Stewart, S., & Bower, P. (2024). Patient reported measures of continuity of care and health outcomes: A systematic review. *BMC Primary Care, 25*, 309. doi:10.1186/s12875-024-02545-8

Chartrand, J., Shea, B., Hutton, B., Dingwall, O., Kakkar, A., Chartrand, M., Poulin, A., & Backman, C. (2023). Patient- and family-centred care transition interventions for adults: A systematic review and meta-analysis of RCTs. *International Journal for Quality in Health Care, 35*(4), mzad102. doi:10.1093/intqhc/mzad102

Choi, J. Y., Lee, S. H., & Yu, S. (2024). Exploring factors influencing caregiver burden: A systematic review of family caregivers of older adults with chronic illness in local communities. *Healthcare, 12*(10), 1002. doi:10.3390/healthcare12101002

Ghanbari-Jahromi, M., Kharazmi, E., Bastani, P., Shams, M., Ahmadi Marzaleh, M., & Bahrami, M. A. (2024). Factors disrupting the continuity of care for patients with chronic disease during the pandemics: A systematic review. *Health Science Reports, 7*(2), e1881. doi:10.1002/hsr2.1881

Gow, K., Rashidi, A., & Whithead, L. (2024). Factors influencing medication adherence among adults living with diabetes and comorbidities: A qualitative systematic review. *Current Diabetes Reports, 24*(2), 19–25. doi:10.1007/s11892-023-01532-0

Graven, L. J., Glueckauf, R. L., Regal, R. A., Merbitz, N. K., Lustria, M. L. A., & James, B. A. (2021). Telehealth interventions for family caregivers of persons with chronic health conditions: A systematic review of randomized controlled trials. *International Journal of Telemedicine and Applications, 2021*, 3518050. doi:10.1155/2021/3518050

Katz, S., Ford, A. B., Moskowitz, R. W., Jackson, B. A., & Jaffe, M. W. (1963). Studies of illness in the aged: The index of ADL: A standardized measure of biological and psychosocial function. *JAMA, 185*(12), 914–919. doi:10.1001/jama.1963.03060120024016

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024a). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024b). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Lawton, M. P., & Brody, E. M. (1969). Assessment of older people: Self-maintaining and instrumental activities of daily living. *The Gerontologist, 9*(3), 179–186. doi:10.1093/geront/9.3_Part_1.179

Ramadia, A., Fadhli, R., Astuti, V. W., Novera, M., Purwaningsih, Khairani, A. I., Nofrel, V., Suharto, Khariroh, S., Wulandini, P., & Siregar, Y. H. (2023). *Konsep asuhan keperawatan keluarga*. Penerbit Tahta Media.

Robinson, M., Coehlo, D. P., & Smith, P. S. (2022). *Family health care nursing: Theory, practice, and research* (7th ed.). F. A. Davis.

Stanhope, M., & Lancaster, J. (2024). *Public health nursing: Population-centered health care in the community* (11th ed.). Elsevier.

Wang, L., Liu, J., Wu, L., Zhang, J., & Fang, H. (2023). Caregiving experiences of stroke caregivers: A systematic review and meta-synthesis of qualitative studies. *Medicine, 102*(13), e33392. doi:10.1097/MD.0000000000033392

World Health Organization. (2023). *Package of interventions for rehabilitation: Module 1: Introduction*. World Health Organization.

World Health Organization. (2023). *Package of interventions for rehabilitation: Module 3: Neurological conditions*. World Health Organization.

World Health Organization. (2025). *Integrated care for older people (ICOPE): Guidance for person-centred assessment and pathways in primary care* (2nd ed.). World Health Organization.

Zarit, S. H., Reever, K. E., & Bach-Peterson, J. (1980). Relatives of the impaired elderly: Correlates of feelings of burden. *The Gerontologist, 20*(6), 649–655. doi:10.1093/geront/20.6.649

Zhu, L., Xing, Y., Jia, H., Xu, W., Wang, X., & Ding, Y. (2024). Effects of telehealth interventions on the caregiver burden and mental health for caregivers of people with dementia: A systematic review and meta-analysis. *Aging & Mental Health, 28*(11), 1427–1439. doi:10.1080/13607863.2024.2371480

L. Glosarium

- **Activities of Daily Living (ADL)**
  Kemampuan individu dalam melakukan aktivitas dasar sehari-hari secara mandiri, seperti makan, mandi, berpakaian, menggunakan toilet, berpindah posisi, dan mobilitas. Penilaian ADL digunakan untuk menentukan tingkat kemandirian dan kebutuhan bantuan pasien.
- **Caregiver**
  Individu yang memberikan bantuan, pendampingan, pengawasan, dan perawatan kepada seseorang yang mengalami keterbatasan akibat penyakit, disabilitas, proses penuaan, gangguan kognitif, atau kondisi lainnya. *Caregiver* dapat bersifat formal maupun informal.
- **Caregiver Burden**
  Beban yang dialami *caregiver* akibat tuntutan perawatan yang berdampak pada kondisi fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun kehidupan pribadinya. Beban ini dapat meningkat apabila perawatan berlangsung lama tanpa dukungan yang memadai.
- **Continuity of Care**
  Kesinambungan pelayanan kesehatan yang memastikan keterhubungan informasi, hubungan terapeutik, dan rencana perawatan dari satu tahap atau fasilitas pelayanan ke tahap berikutnya.
- **Discharge Planning**
  Proses perencanaan sebelum pasien pulang dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk memastikan bahwa kebutuhan perawatan dapat dilanjutkan secara aman di rumah, termasuk pengelolaan obat, aktivitas, diet, penggunaan alat kesehatan, tanda bahaya, dan tindak lanjut.
- **Ecomap**
  Alat pengkajian berbentuk visual yang menggambarkan hubungan keluarga dengan lingkungan dan sumber daya eksternal, seperti fasilitas kesehatan, tetangga, tempat kerja, organisasi sosial, komunitas keagamaan, dan kelompok pendukung.
- **Family-Centered Care**
  Pendekatan pelayanan yang menempatkan pasien dan keluarga sebagai mitra aktif dalam proses perawatan dengan mempertimbangkan kebutuhan, nilai, pengalaman, budaya, kemampuan, dan preferensi pasien serta keluarga.
- **Instrumental Activities of Daily Living (IADL)**
  Kemampuan individu dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang lebih kompleks dan diperlukan untuk hidup mandiri di masyarakat, seperti mengelola obat, berbelanja, menyiapkan makanan, menggunakan transportasi, mengelola keuangan, dan menggunakan sarana komunikasi.
- **Manajemen Kasus Keluarga**
  Pendekatan pelayanan terstruktur yangmencakup identifikasi kebutuhan pasien dan keluarga, pengkajian, perencanaan, koordinasi pelayanan,

pelaksanaan intervensi, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut untuk memenuhi kebutuhan kesehatan keluarga secara berkesinambungan.

- **Respite Care**
  Bentuk pelayanan atau dukungan sementara yang memungkinkan *caregiver* utama memperoleh waktu istirahat dari tanggung jawab perawatan. Tujuannya adalah membantu memulihkan kondisi fisik dan psikologis *caregiver* serta mencegah akumulasi kelelahan.

BAB 7

EVALUASI ASUHAN KELUARGA, CONTINUITY OF CARE, DAN RUJUKAN

Tabel CPL

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan kepatuhan aspek legal dalam praktik keperawatan komunitas dan keluarga.	CPMK-1; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, edukasi, dan kolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, serta lintas sektor.	CPMK-3; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan, PPI, K3, dan manajemen risiko dalam pelayanan komunitas serta kunjungan rumah.	CPMK-1; CPMK-4; CPMK-6; CPMK-7
CPL-4	Melaksanakan proses keperawatan komunitas dan keluarga berbasis clinical reasoning (pengkajian–diagnosa–perencanaan–implementasi–evaluasi).	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-5	Merancang intervensi promotif–preventif berbasis PHC, determinan sosial kesehatan, equity, dan pemberdayaan.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Melakukan dokumentasi, monitoring–evaluasi, pelaporan outcome, dan perbaikan mutu berkelanjutan pada level komunitas/keluarga.	CPMK-4; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7

Tabel CPMK

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menguasai konsep, ruang lingkup, peran perawat, serta prinsip etika-legal dan keselamatan dasar dalam keperawatan komunitas dan keluarga.
CPMK-2	Menganalisis PHC, determinan sosial kesehatan, dan equity untuk mengidentifikasi kesenjangan layanan dan kebutuhan prioritas.
CPMK-3	Menganalisis komunitas/keluarga sebagai klien (struktur, budaya, modal sosial, dinamika) untuk merancang pendekatan pemberdayaan dan komunikasi.
CPMK-4	Melaksanakan pengkajian komunitas dan keluarga secara sistematis (data, pemetaan, risiko, genogram/ecomap) secara etis dan akurat.
CPMK-5	Merumuskan diagnosa keperawatan komunitas dan keluarga serta menetapkan prioritas masalah berbasis data dan partisipasi klien.
CPMK-6	Menyusun perencanaan intervensi/program dan asuhan keluarga (home visit, kemitraan, manajemen kasus, rujukan) yang terukur dan feasible.
CPMK-7	Melaksanakan implementasi–evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan outcome komunitas/keluarga untuk continuity of care dan perbaikan mutu.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab 14. Evaluasi Asuhan Keluarga, Continuity of Care, dan Rujukan	14.1 Melaksanakan evaluasi asuhan dan follow-up keluarga untuk menjamin continuity of care berbasis outcome.	14.2 Menetapkan rujukan dan koordinasi layanan (kriteria, alur, komunikasi, umpan balik) secara aman.	CPMK-7	CPMK-6; CPMK-5; CPMK-1

Tujuan Instruksional Umum

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan menerapkan konsep evaluasi asuhan keluarga, *continuity of care,* dan sistem rujukan dalam praktik keperawatan keluarga secara tepat, berkesinambungan, dan sesuai kebutuhan keluarga.

Tujuan Instruksional Khusus

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian evaluasi asuhan keluarga.
2. Menjelaskan tujuan dan fungsi evaluasi dalam asuhan keperawatan keluarga.
3. Mengidentifikasi komponen dan kriteria evaluasi asuhan keluarga.
4. Membedakan evaluasi formatif dan sumatif dalam keperawatan keluarga.
5. Menentukan indikator keberhasilan asuhan keperawatan keluarga.
6. Menyusun evaluasi hasil berdasarkan tujuan dan intervensi yang telah dilakukan.
7. Menjelaskan pengertian *continuity of care* dalam pelayanan kesehatan keluarga.
8. Menjelaskan tujuan, manfaat, dan prinsip *continuity of care*.
9. Mengidentifikasi peran perawat dalam pelaksanaan *continuity of care*.
10. Menjelaskan tahapan continuity of care pada keluarga dengan masalah kesehatan.
11. Menganalisis dampak continuity of care terhadap keberhasilan asuhan keluarga.
12. Menjelaskan pengertian dan tujuan sistem rujukan.
13. Membedakan jenis-jenis rujukan dalam pelayanan kesehatan.
14. Mengidentifikasi kondisi keluarga atau pasien yang memerlukan rujukan.
15. Menjelaskan prosedur pelaksanaan rujukan dalam keperawatan keluarga.
16. Menyusun format atau dokumen rujukan secara benar.
17. Menjelaskan peran perawat dalam proses rujukan dan tindak lanjut setelah rujukan.
18. Menganalisis hubungan antara evaluasi, continuity of care, dan rujukan dalam menjamin mutu pelayanan keperawatan keluarga.
19. Menerapkan evaluasi, *continuity of care*, dan rujukan pada studi kasus keperawatan keluarga.
20. Menyusun rekomendasi tindak lanjut asuhan keluarga berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan rujukan.

Capaian Pembelajaran

Ranah Kognitif

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep evaluasi asuhan keluarga, *continuity of care*, dan rujukan.
2. Menganalisis tujuan, prinsip, dan tahapan evaluasi asuhan keluarga.

3. Membedakan jenis evaluasi, bentuk *continuity of care*, dan jenis rujukan.
4. Mengidentifikasi masalah keluarga yang memerlukan *continuity of care* dan rujukan.
5. Menganalisis hubungan antara evaluasi, *continuity of care*, dan rujukan dalam meningkatkan mutu pelayanan.
6. Menentukan tindak lanjut yang tepat berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan keluarga.

Ranah Afektif

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Menunjukkan sikap peduli, empati, dan tanggung jawab terhadap keluarga yang mendapatkan asuhan.
2. Menghargai pentingnya kesinambungan pelayanan dan kerja sama antar tenaga kesehatan.
3. Menunjukkan sikap teliti, disiplin, dan objektif dalam melakukan evaluasi.
4. Menunjukkan sikap terbuka dan menghargai keputusan keluarga dalam proses rujukan.
5. Menunjukkan komitmen untuk memberikan pelayanan yang aman, etis, dan berpusat pada keluarga.

Ranah Psikomotor

Setelah mengikuti pembelajaran, mahasiswa mampu:

1. Melakukan evaluasi asuhan keperawatan keluarga sesuai format dan prosedur.
2. Mengidentifikasi kebutuhan continuity of care pada keluarga.
3. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi.
4. Melakukan komunikasi dan edukasi kepada keluarga mengenai *continuity of care*.
5. Menentukan kebutuhan rujukan dan melaksanakan prosedur rujukan secara benar.
6. Mengisi dokumen atau formulir rujukan dengan tepat.
7. Mendemonstrasikan tindak lanjut pascarujukan melalui simulasi atau studi kasus.

Pendahuluan

Pelayanan keperawatan keluarga merupakan bagian penting dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat karena keluarga menjadi unit terkecil yang berperan dalam membentuk perilaku, menjaga kesehatan, dan menentukan keberhasilan perawatan anggota keluarga. Dalam praktik keperawatan keluarga, perawat tidak hanya berfokus pada individu yang sakit, tetapi juga pada kemampuan keluarga dalam mengenali masalah kesehatan, mengambil keputusan, melakukan tindakan perawatan, memanfaatkan fasilitas kesehatan, serta menciptakan lingkungan yang sehat.

Agar proses keperawatan keluarga berjalan efektif, diperlukan evaluasi asuhan keluarga. Evaluasi merupakan tahap akhir dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan dan intervensi yang telah direncanakan dapat tercapai. Melalui evaluasi, perawat dapat mengetahui perubahan kondisi keluarga, tingkat keberhasilan tindakan, hambatan yang masih dihadapi, serta kebutuhan tindak lanjut yang diperlukan. Evaluasi juga menjadi dasar untuk menentukan apakah rencana asuhan perlu dipertahankan, dimodifikasi, atau dihentikan.

Dalam pelayanan kesehatan modern, keberhasilan asuhan keluarga tidak hanya ditentukan oleh intervensi sesaat, tetapi juga oleh kesinambungan pelayanan atau *continuity of care. Continuity of care* merupakan pelayanan yang dilakukan secara berkelanjutan, terpadu, dan konsisten sejak individu atau keluarga pertama kali mendapatkan pelayanan sampai masalah kesehatannya teratasi atau dapat dikendalikan. Pendekatan ini penting karena banyak masalah kesehatan keluarga, terutama penyakit kronis, penyakit tidak menular, masalah tumbuh kembang, kesehatan ibu dan anak, serta gangguan kesehatan lansia, memerlukan pemantauan dan pendampingan dalam jangka panjang.

Melalui *continuity of care*, keluarga memperoleh pelayanan yang terintegrasi antar tenaga kesehatan, antar fasilitas pelayanan, dan antar waktu pelayanan. Perawat berperan sebagai koordinator yang memastikan bahwa keluarga tetap memperoleh informasi, dukungan, pemantauan, dan tindak lanjut yang dibutuhkan. Dengan demikian, risiko terjadinya putus pelayanan, kesalahan informasi, keterlambatan penanganan, maupun kekambuhan penyakit dapat diminimalkan.

Selain evaluasi dan *continuity of care*, sistem rujukan juga menjadi bagian penting dalam asuhan keperawatan keluarga. Tidak semua masalah kesehatan dapat diselesaikan pada tingkat keluarga atau pelayanan primer. Apabila ditemukan kondisi yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, penanganan khusus, fasilitas yang lebih lengkap, atau tenaga ahli tertentu, maka keluarga perlu dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

Rujukan merupakan pelimpahan tanggung jawab pelayanan kesehatan dari satu fasilitas atau tenaga kesehatan ke fasilitas atau tenaga kesehatan lain yang memiliki kemampuan lebih sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Sistem rujukan yang baik harus dilakukan secara tepat, cepat, aman, dan disertai komunikasi yang jelas agar pelayanan kesehatan tetap berkesinambungan. Dalam keperawatan keluarga, perawat memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan rujukan, memberikan edukasi kepada keluarga, menyiapkan dokumen yang diperlukan, serta melakukan tindak lanjut setelah keluarga memperoleh pelayanan rujukan.

Pemahaman mengenai evaluasi asuhan keluarga, *continuity of care*, dan rujukan sangat penting bagi mahasiswa dan tenaga kesehatan karena ketiga aspek tersebut saling berkaitan dalam menjamin mutu pelayanan. Evaluasi memastikan keberhasilan tindakan, continuity of care menjaga kesinambungan pelayanan, sedangkan rujukan menjamin keluarga memperoleh pelayanan sesuai tingkat kebutuhannya. Dengan memahami ketiga konsep tersebut, diharapkan pelayanan keperawatan keluarga dapat berlangsung lebih efektif, komprehensif, dan berpusat pada kebutuhan keluarga.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Asuhan Keluarga

1. Definisi dan konsep dasar keluarga

Definisi dan konsep dasar menjelaskan mengapa keluarga dipandang sebagai unit utama intervensi dalam praktik keperawatan keluarga, serta prinsip-prinsip teori yang sering digunakan. Keperawatan keluarga dipahami sebagai pendekatan yang melihat keluarga sebagai unit perawatan dan target intervensi untuk memperbaiki fungsi kognitif, afektif, dan psikomotor keluarga dalam menghadapi penyakit anggota keluarga (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020). *Family-centered care* menekankan kemitraan antara keluarga dan tenaga kesehatan, menghargai peran keluarga dalam pengambilan keputusan dan perawatan sehari-hari (Foster et al., 1989)

Teori sistem keluarga dan kerangka ekologi sering menjadi landasan konseptual untuk memahami dinamika, sumber daya, dan adaptasi keluarga terhadap penyakit (Broekema et al., 2020) Asuhan keperawatan keluarga memandang keluarga sebagai unit perawatan yang melibatkan anggota, konteks, dan sistem sosial untuk mencapai kesehatan bersama. Praktik didasarkan pada filosofi keluarga-sentris, teori sistem keluarga, dan intervensi kolaboratif yang memberdayakan keluarga. Dalam keperawatan keluarga, keluarga dipahami bukan sekadar individu tetapi sebagai unit perawatan yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh kesehatan anggotanya; peran ini meliputi fungsi dukungan, pengasuhan, dan pengambilan keputusan dalam konteks sosial dan budaya (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020). Konsep ini meluas pada praktik yang memadukan penilaian keluarga, intervensi dan evaluasi untuk meningkatkan kesehatan keluarga secara menyeluruh (Foster et al., 1989)

2. Tujuan asuhan keluarga

Tujuan menjelaskan outcome yang diharapkan dari intervensi keperawatan keluarga dan bagaimana tujuan tersebut selaras dengan kebutuhan keluarga dan pasien. Tujuan ini menjadi acuan untuk menyusun diagnosis keluarga, rencana, dan evaluasi hasil. Menguatkan coping keluarga untuk menghadapi stres dan perubahan terkait penyakit, termasuk kemampuan problem solving dan adaptasi(Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020) Meningkatkan pemahaman dan kemampuan keluarga dalam perawatan, edukasi, dan kepatuhan terapi pasien melalui intervensi pengajaran dan

konseling Memperbaiki komunikasi dan hubungan keluarga sehingga mendukung keputusan bersama dan perawatan berkelanjutan (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020)

3. Ruang lingkup Keluarga

a. Keluarga sebagai fokus perawatan Keluarga dapat menjadi objek utama intervensi keperawatan ketika kebutuhan kesehatan lebih baik ditangani pada tingkat keluarga daripada individu (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020)

b. Ruang lingkup praktik Perawatan keluarga mencakup pencegahan, promosi kesehatan, manajemen penyakit kronik, krisis akut, dan dukungan pada transisi hidup keluarga (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020)

4. Filosofi dan prinsip dasar

Filosofi utama adalah menghargai keluarga sebagai mitra dalam perawatan, mempromosikan partisipasi aktif keluarga, serta mengedepankan keberagaman dan kekuatan keluarga sebagai dasar intervensi (Broekema et al., 2020).Prinsip praktis meliputi kolaborasi, respek budaya, komunikasi terbuka, dan penekanan pada pemberdayaan keluarga untuk mencapai hasil kesehatan yang berkelanjutan (Gonçalves et al., 2017)

a. **Prinsip kolaborasi** Perawat bekerja bersama keluarga untuk menyusun rencana perawatan dan membuat keputusan klinis secara bersama-sama(Broekema et al., 2020)

b. **Prinsip pemberdayaan** Intervensi diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat dan mengelola kondisi kesehatan di rumah (Gonçalves et al., 2017)

c. **Prinsip humanisasi** melibatkan emosional, informasi jelas, dan dukungan psikososial untuk keluarga selama perawatan intensif atau krisis adalah bagian dari pendekatan keluarga-sentris (Gonçalves et al., 2017)

5. Keluarga sebagai unit klien konteks sistem

Pendekatan keperawatan keluarga mengenali tiga peran keluarga dalam praktik: keluarga sebagai klien, keluarga sebagai konteks bagi individu sakit, dan keluarga sebagai sistem yang memiliki dinamika internal yang memengaruhi kesehatan (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020) Pendekatan ini menentukan metode penilaian dan intervensi yang berbeda tergantung tujuan perawatan dan tingkat intervensi.

a. **Sebagai klien** Fokus intervensi diarahkan pada kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, misalnya program pencegahan keluarga untuk mengurangi kejadian penyakit tertentu (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020)
b. **Sebagai konteks** Keluarga dipandang sebagai lingkungan yang memengaruhi pemulihan individu; contohnya, dukungan keluarga meningkatkan kepatuhan pengobatan pasien kronik(Foster et al., 1989)
c. **Sebagai sistem** Dinamika hubungan, peran, dan pola komunikasi dianalisis untuk memahami bagaimana stres atau penyakit diproses bersama dalam keluarga (Leal & Franco, 2024)

Contoh praktis

- **Pasien stroke** Perawat menilai kebutuhan fisioterapi pasien (individu) sekaligus kapasitas keluarga sebagai pengasuh utama (konteks) dan pola komunikasi keluarga untuk perencanaan discharge (sistem) (Leal & Franco, 2024)

6. Teori dasar dan aplikasi praktik

Teori-teori keluarga yang sering menjadi dasar praktik mencakup perspektif sistemik, kerangka ekologi dan model adaptasi yang menjelaskan interaksi antar anggota dan lingkungan; Family Systems Nursing menekankan intervensi yang memodifikasi relasi keluarga untuk memperbaiki hasil kesehatan (Eggenberger & Sanders, 2016)

Teori-teori ini memberikan alat penilaian dan strategi intervensi yang dapat diterapkan di rumah, rumah sakit, dan komunitas.

a. **Teori sistem keluarga** Menjelaskan keluarga sebagai keseluruhan yang lebih dari sekadar jumlah individu; perubahan pada satu anggota memengaruhi sistem keseluruhan (Foster et al., 1989)
    1) Contoh: Mengatasi konflik komunikasi agar semua anggota terlibat dalam rencana perawatan pasien kronik (Foster et al., 1989)
b. **Model adaptasi dan stres keluarga** Fokus pada bagaimana keluarga menanggapi stres kesehatan dan sumber daya untuk adaptasi (Eggenberger & Sanders, 2016)
    1) Contoh: Mengidentifikasi sumber daya keluarga saat menghadapi penyakit kronik dan memperkuat koping keluarga (Eggenberger & Sanders, 2016)
c. **Family Systems Nursing** Intervensi diarahkan pada pola relasi dan makna bersama, menggunakan pertemuan keluarga untuk meningkatkan pemahaman dan tindakan bersama(Leal & Franco, 2024)

1) Contoh: Sesi keluarga terstruktur untuk meningkatkan dukungan emosional dan kepatuhan terapi setelah diagnosis berat (Leal & Franco, 2024)

d. **Penilaian keluarga terstruktur** Gunakan pendekatan berorientasi sistem untuk mengidentifikasi masalah, sumber daya, dan pola interaksi sebelum merancang intervensi (Foster et al., 1989)

e. **Percakapan keluarga terfokus** Teknik komunikasi terstruktur yang telah diimplementasikan dalam praktik home care untuk menyesuaikan intervensi pada kebutuhan nyata keluarga (Denham et al., 2015)

7. Struktur fungsi tahap tugas kesehatan

Struktur keluarga merujuk pada komposisi, peran, dan batasan hubungan; fungsi keluarga mencakup biologis, afektif, sosio-ekonomi, sosialisasi dan perlindungan kesehatan—semua ini menentukan kapasitas keluarga untuk memenuhi tugas kesehatan pada tiap tahap perkembangan keluarga (Eggenberger & Sanders, 2016)

Tugas kesehatan keluarga meliputi promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan saat sakit, rehabilitasi, serta adaptasi psikososial dan perencanaan sumber daya.

a. **Struktur keluarga**

1) **Anggota dan peran** Siapa pengasuh utama, siapa pengambil keputusan, dan siapa pendukung ekonomi sangat berpengaruh pada rencana perawatan keluarga(Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020)

2) **Batas dan jaringan sosial** Hubungan keluarga dengan masyarakat dan layanan kesehatan memengaruhi akses dan dukungan (Eggenberger & Sanders, 2016)

b. **Fungsi keluarga**

1) **Pemenuhan kebutuhan dasar** Makanan, tempat tinggal, dan pengawasan kesehatan bagi anggota rentan (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020)

2) **Peran emosional** Dukungan afektif, pengelolaan stres, dan perawatan akhir hayat (Eggenberger & Sanders, 2016)

8. Tahap perkembangan keluarga

a. **Transisi utama** Pembentukan pasangan, kelahiran, pengasuhan anak, pelepasan anak, dan lanjut usia—setiap tahap membawa risiko dan kebutuhan kesehatan spesifik (Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020)

b. **Contoh praktis** Keluarga baru membutuhkan pendidikan antenatal dan dukungan menyusui; keluarga dengan lansia memerlukan perencanaan perawatan jangka panjang(Lise, Schwartz, Dall'Agnol, et al., 2020)

9. Tugas kesehatan keluarga

a. **Promosi dan pencegahan** Advokasi imunisasi, edukasi gizi, dan modifikasi lingkungan rumah untuk pencegahan kecelakaan (Vaughan-Cole, 1997)

b. **Perawatan dan rehabilitasi** Pelatihan pengasuh keluarga untuk perawatan sehari-hari pasien pascaoperasi atau kronik (Silveira & Angelo, 2006)

c. **Dukungan psikososial** Fasilitasi komunikasi keluarga, konseling krisis, **dan** rujukan layanan mental saat diperlukan (Silveira & Angelo, 2006)

10. Contoh langkah keperawatan praktis

a. **Penilaian** Lakukan assessment keluarga yang mencakup struktur, fungsi, sumber daya, dan tahap perkembangan (Foster et al., 1989)

b. **Rencana bersama** Susun rencana perawatan bersama keluarga yang mencakup tujuan, peran tiap anggota, dan tindak lanjut (Broekema et al., 2020)

c. **Intervensi** Edukasi **perawatan** di rumah, dukungan emosional, koordinasi rujukan, dan evaluasi hasil secara berkala; intervensi ini telah terbukti mengurangi beban keluarga dan meningkatkan coping (Silveira & Angelo, 2006)

B. Proses Asuhan Keluarga

1. Pengkajian keluarga

Pengkajian keluarga dimulai dengan pengumpulan data menyeluruh menggunakan wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik untuk memahami konteks kesehatan keluarga dan dinamika internal. Hasil pengkajian memandu diagnosis keluarga dan rencana intervensi yang berfokus pada kekuatan dan kebutuhan keluarga.

a. **Metode pengkajian** wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik digunakan secara terpadu untuk menangkap aspek kognitif, afektif, dan perilaku keluarga (Lise, Schwartz, de Moura Spagnolo, et al., 2020)

b. **Data yang dikaji** meliputi: struktur keluarga (anggota, relasi), fungsi keluarga (peran dan pola komunikasi), tahap perkembangan keluarga, tugas kesehatan sehari-hari, stressor dan koping, sumber daya

sosial/ekonomi, serta kondisi lingkungan rumah (Lise, Schwartz, de Moura Spagnolo, et al., 2020)

c. **Instrumen pengkajian** beragam; literatur melaporkan penggunaan model dan instrumen terstandar untuk menilai fungsi dan kebutuhan keluarga serta alat skoring/penilaian keluarga dalam penelitian tinjauan sistematik (Foster et al., 1989)

   1) **Contoh konkret**

      - Wawancara singkat: **Pertanyaan** "Siapa yang utama merawat anggota yang sakit dan apa rutinitas harian mereka" untuk mengungkap tugas kesehatan dan beban care.
      - Observasi: **Checklist**—interaksi antar anggota saat diskusi perawatan, kebersihan lingkungan, akses obat.

Pemeriksaan fisik lingkungan: **Catatan** tentang keamanan rumah (mis. penerangan, akses kamar mandi) dan peralatan medis di rumah. (Foster et al., 1989)

2. Diagnosis keluarga

Diagnosis keluarga dirumuskan sebagai pernyataan yang menghubungkan masalah keluarga dengan penyebab dan tanda/gejala yang dapat diamati, agar dapat ditargetkan oleh intervensi keperawatan. Penggunaan format masalah—etiologi—tanda/gejala membantu tim merumuskan intervensi yang spesifik dan terukur.

a. Cara merumuskan: identifikasi masalah utama keluarga, nyatakan etiologi/penyebab yang dapat diubah oleh intervensi keperawatan, lalu lampirkan tanda dan gejala yang mendukung diagnosis (Broekema et al., 2020)

b. Komponen diagnosis meliputi **masalah** (mis. beban caregiver berlebih), **etiologi** (mis. kurangnya pengetahuan/praktis dukungan), dan **tanda/gejala** (mis. keluhan lelah, konflik keluarga, pengabaian tugas kesehatan) (Broekema et al., 2020)

3. Tipologi diagnosis keluarga

Dapat mengkategorikan masalah menurut struktur (mis. keluarga terpisah), perkembangan (mis. transisi peran), dan fungsi (mis. komunikasi buruk atau koping maladaptif) sebagai cara memahami level intervensi (Broekema et al., 2020)

Prioritas masalah ditetapkan berdasarkan tingkat ancaman kesehatan/keberfungsian keluarga, kesiapan keluarga untuk perubahan, dan ketersediaan sumber daya; skoring prioritas dipakai dalam praktik untuk

mempermudah pemilihan masalah utama yang harus ditangani dulu (Broekema et al., 2020)

a. **Contoh konkret**
    1) Diagnosis terformulasi: "Beban perawatan keluarga berlebih berhubungan dengan kurangnya dukungan eksternal dan pengetahuan tentang pengelolaan penyakit kronis, ditunjukkan oleh keluhan kelelahan kronis pada primary caregiver dan keterlambatan pemberian obat."

Prioritas: tetapkan masalah **utama** (beban caregiver) sebagai fokus awal karena berdampak langsung pada kepatuhan pengobatan dan keselamatan pasien. (Broekema et al., 2020)

4. Perencanaan keluarga

Perencanaan menetapkan tujuan jangka pendek dan panjang yang spesifik, kriteria hasil terukur, dan rencana intervensi keluarga yang berbasis bukti dan kekuatan keluarga. Rencana harus disepakati bersama keluarga dan fleksibel menyesuaikan kebutuhan serta konteks budaya.

a. Menetapkan tujuan
    1) **Jangka pendek** fokus pada perubahan cepat yang dapat dicapai dalam hari-minggu (mis. caregiver memahami jadwal obat).
    2) **Jangka panjang** menargetkan adaptasi fungsional keluarga (mis. penurunan beban caregiver dan kemampuan pengelolaan kondisi kronis secara mandiri) (Gonçalves et al., 2017)

b. Kriteria hasil harus observable dan terukur, mis. **kriteria** "caregiver menunjukkan teknik pemberian obat yang benar pada 3/3 kesempatan" atau "keluhan kelelahan menurun menurut skala subjektif keluarga" (Gonçalves et al., 2017)

c. Rencana intervensi keperawatan keluarga menyusun kombinasi pendidikan, latihan praktis, pengorganisasian dukungan sosial, rujukan, dan pengaturan lingkungan agar tujuan tercapai (Silveira & Angelo, 2006)

d. Contoh konkret
    1) Tujuan jangka pendek: caregiver dapat menjelaskan 5 langkah pemberian obat pada akhir sesi pendidikan.
    2) Intervensi: sesi pendidikan 30 menit dengan demonstrasi, lembar tugas rumah, dan rujukan ke kelompok dukungan keluarga.(Silveira & Angelo, 2006)

5. Implementasi keluarga

Implementasi melibatkan pelaksanaan intervensi yang telah disepakati dengan keluarga menggunakan strategi pendidikan, konseling, fasilitasi layanan, dan advokasi, disertai komunikasi terapeutik yang efektif. Pelaksanaan harus sensitif budaya dan memberdayakan keluarga sebagai peserta aktif.

a. Strategi intervensi

1) **Pendidikan kesehatan** materi step-by-step untuk tugas perawatan di rumah (Gonçalves et al., 2017)
2) **Konseling keluarga** sesi untuk memfasilitasi komunikasi dan pemecahan masalah bersama (Eggenberger & Sanders, 2016)
3) **Fasilitasi** penghubungan keluarga ke sumber daya komunitas dan layanan sosial (Silveira & Angelo, 2006)
4) **Advokasi** dalam sistem layanan kesehatan untuk mendapatkan dukungan atau akses yang diperlukan(Gonçalves et al., 2017)

b. Teknik komunikasi terapeutik yang aplikatif mencakup mendengarkan aktif, refleksi perasaan, merangkum poin penting, pertanyaan terbuka, dan mengundang partisipasi keluarga dalam pengambilan keputusan—komponen ini dikonstruksi dalam percakapan keperawatan keluarga terstruktur (Leal & Franco, 2024)

c. Contoh konkret

1) Sesi pendidikan: perawat demonstrasi pemberian inhaler, lalu mengamati caregiver mempraktekkan rutinitas; beri umpan balik konstruktif.
2) Konseling keluarga: perawat memfasilitasi pertemuan keluarga 30–45 menit dengan agenda mengidentifikasi sumber stres, menyusun pembagian tugas, dan membuat rencana dukungan mingguan.
3) Kalimat terapeutik: **"Saya mendengar bahwa Anda merasa lelah setiap hari; bolehkah Anda ceritakan aktivitas yang paling membebani?"** sebagai teknik membuka dan memvalidasi emosi (Leal & Franco, 2024)

6. Evaluasi dan dokumentasi

Evaluasi menilai perubahan struktur (komposisi/peran), proses (cara keluarga menjalankan perawatan), dan hasil (kesehatan anggota, kesejahteraan keluarga) serta didokumentasikan untuk kontinuitas perawatan. Evaluasi bersifat berkelanjutan, melibatkan keluarga, dan menginformasikan revisi rencana perawatan.

a. Evaluasi struktur proses hasil

1) **Struktur** cek apakah ada perubahan peran anggota, atau dukungan tambahan terpasang.
2) **Proses** nilai kepatuhan pada rencana, komunikasi keluarga, dan pelaksanaan tugas perawatan.

Hasil ukur domain kognitif, afektif, dan perilaku seperti pemahaman keluarga, kesejahteraan emosional, dan perilaku perawatan sehari-hari (Foster et al., 1989)

1) **Dokumentasi asuhan** harus mencatat ringkasan pengkajian, diagnosis keluarga, tujuan, intervensi yang dilaksanakan, respons keluarga, dan hasil evaluasi untuk memudahkan tindak lanjut dan kolaborasi antarprofesional (Broekema et al., 2020)

b. Contoh konkret

1) Evaluasi mingguan: gunakan checklist hasil—pemahaman obat (ya/tidak), adanya bantuan sosial (ya/tidak), tingkat stres caregiver (self-report skala sederhana).
2) Dokumentasi: catat dalam rekam medik atau catatan keperawatan keluarga format singkat: pengkajian ringkas → diagnosis → rencana → implementasi → evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut (Broekema et al., 2020)

c. Pendekatan dan model

Berbagai model menawarkan fokus dan teknik berbeda; tabel berikut membandingkan beberapa model yang sering dipakai untuk memilih pendekatan yang sesuai dengan konteks keluarga dan setting perawatan. Pemilihan model harus mempertimbangkan tujuan, setting, dan kapasitas tim keperawatan.

Tabel 7.1: Pemilihan model harus mempertimbangkan tujuan, setting, dan kapasitas tim keperawatan

Model	Fokus utama	Contoh intervensi	Bukti ringkas
Family Systems Nursing	Keluarga sebagai sistem interaktif dan adaptif	Family meetings, genogram, intervensi komunikasi	Intervensi sistemik menunjukkan perbaikan pemahaman, coping, dan hubungan

			emosional keluarga (Lise, Schwartz, de Moura Spagnolo, et al., 2020)
Family-centered care	Kemitraan keluarga-tenaga kesehatan, humanisasi perawatan	Memberikan informasi, melibatkan keluarga dalam perawatan harian	Ditekankan sebagai filosofi praktik terutama di pediatri dan NICU untuk meningkatkan keterlibatan dan kepuasan keluarga (Foster et al., 1989)
Family Health Conversations (FamHC)	Dialog terstruktur untuk membuka komunikasi keluarga	Sesi terfokus membantu pengungkapan emosi, dukungan pengambilan keputusan	Kasus klinis melaporkan perbaikan hubungan dan dukungan terhadap pengobatan pada konteks stigma sosial (Calaguas, 2022)
Person-family-culture centered	Integrasi kebutuhan individu, keluarga, dan budaya	Penyesuaian intervensi berdasarkan nilai budaya dan preferensi	Diusulkan sebagai model yang menggabungkan family-centered dan kompetensi budaya untuk praktik yang lebih kontekstual (Luttik, 2020)

7. Peran dan tantangan perawat

Peran perawat meliputi pemberi edukasi, fasilitator komunikasi, dan koordinator intervensi keluarga; namun pelaksanaannya menghadapi kendala praktis dan sistemik yang perlu diatasi untuk praktik berbasis bukti. Bagian ini memberi contoh peran klinis, hambatan yang dilaporkan, dan rekomendasi berbasis bukti untuk mitigasi.

a. Peran perawat

Fasilitator komunikasi antara keluarga dan tim, termasuk memfasilitasi diskusi keputusan dan memberi informasi terapeutik

Pendidik dan coach untuk meningkatkan kemampuan perawatan di rumah melalui pengajaran terstruktur dan dukungan praktis (Foster et al., 1989)

b. Pemimpin intervensi keluarga seperti memimpin family meeting atau sesi FamHC untuk mereduksi penderitaan dan meningkatkan coping keluarga (Vaughan-Cole, 1997)

c. Tantangan dalam praktik

Keterbatasan keterampilan dan kepercayaan diri: Perawat kadang mengubah atau menghilangkan komponen intervensi karena penilaian klinis, keterampilan praktis, atau kurangnya pengalaman (Gonçalves et al., 2017)

Keterbatasan organisasi: Dukungan kelembagaan, kebijakan kunjungan, dan waktu perawat sering menjadi penghambat implementasi konsisten family nursing (Calaguas, 2022)

Keterbatasan bukti kuantitatif: Meskipun banyak studi kualitatif dan beberapa kuasi-eksperimental menunjukkan manfaat, literatur masih memerlukan penelitian eksperimental berkualitas tinggi untuk memperkuat rekomendasi praktik pada beberapa setting (Foster et al., 1989)

d. Rekomendasi berbasis bukti praktis

- **Pelatihan formal** untuk komponen percakapan keluarga dan confidence building pada perawat memperbaiki penerapan intervensi keluarga di ICU dan setting lain (Leal & Franco, 2024)

Gunakan intervensi terstruktur (mis. family meetings, program komunikasi ICU, FamHC) yang telah dilaporkan meningkatkan kepuasan keluarga dan mengurangi distress pada beberapa studi sebagai starting point untuk adaptasi lokal (Calaguas, 2022)Evaluasi dan dokumentasi hasil dalam domain kognitif, afektif, dan perilaku untuk menilai efektivitas dan proses implementasi secara berkelanjutan (Foster et al., 1989)

C. Konsep Evaluasi Asuhan Keluarga

1. Evaluasi Asuhan keperawatan keluarga

Evaluasi asuhan keperawatan keluarga adalah bagian dari proses keperawatan yang menilai apakah intervensi dan rencana memenuhi kebutuhan keluarga dan tujuan kesehatan yang ditetapkan; evaluasi ini digunakan untuk mengarahkan modifikasi rencana dan keputusan selanjutnya. Prinsip praktik family nursing menekankan pendekatan sistemik, kemitraan dengan keluarga, dan integrasi pengkajian—perencanaan—evaluasi dalam rangka meningkatkan fungsi keluarga dan hasil kesehatan anggota keluarga (Lise, Schwartz, de Moura Spagnolo, et al., 2020)

Definisi inti Pengukuran kemajuan dan efek intervensi terhadap keluarga berdasarkan data yang dikumpulkan selama proses keperawatan (Lise, Schwartz, de Moura Spagnolo, et al., 2020)

Tujuan evaluasi: menilai efektivitas intervensi, memvalidasi diagnosis dan prioritas, memutuskan modifikasi rencana, dan memastikan partisipasi keluarga dalam keputusan kesehatan (Foster et al., 1989)

Prinsip utama: pendekatan berpusat pada keluarga, penggunaan bukti dan penilaian sistemik, serta penyesuaian rencana berdasarkan hasil dan penilaian klinis oleh perawat (Broekema et al., 2020)

2. Jenis evaluasi dan fokus penilaian

Evaluasi asuhan keluarga dapat diarahkan pada aspek struktur, proses, dan hasil untuk memberi gambaran komprehensif tentang kualitas asuhan dan perubahan keluarga. Literatur family nursing menempatkan evaluasi sebagai tahap lanjutan dari proses keperawatan yang menghubungkan intervensi dengan outcome keluarga dan memungkinkan penyesuaian rencana (Foster et al., 1989)

a. Evaluasi struktur

Fokus: ketersediaan sumber daya keluarga dan fasilitas, serta kompetensi perawat dan dukungan layanan; model dan standar praktik keluarga dibahas sebagai kerangka yang memengaruhi kualitas asuhan (Broekema et al., 2020)

b. Evaluasi proses

Fokus: ketepatan pelaksanaan langkah proses keperawatan (pengkajian, perumusan diagnosis, perencanaan, implementasi) dan penggunaan pendekatan family-centered saat berinteraksi dengan keluarga (Eggenberger & Sanders, 2016)

c. Evaluasi hasil/outcome

Fokus: perubahan status kesehatan, peningkatan kemampuan self-care keluarga, pencapaian tujuan intervensi yang diukur dengan instrumen atau observasi berulang; studi kasus melaporkan penggunaan ukuran pre/post untuk menilai perubahan pengetahuan dan perilaku keluarga (Denham et al., 2015)

3. Metode evaluasi dan instrumen yang dipakai

Pendekatan evaluasi pada praktik family nursing mengombinasikan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif serta penggunaan alat yang terstandar; studi dan laporan kasus melaporkan penggunaan wawancara, observasi, checklist, dan kuesioner teruji untuk mengevaluasi hasil intervensi keluarga. Laporan kasus klinik keluarga di lingkungan layanan primer menggunakan data subjektif dan objektif sebagai dasar evaluasi serta instrumen skor/pra-pasca untuk menilai perubahan (Leal & Franco, 2024)

a. Metode kuantitatif

Contoh: kuesioner terstandar untuk self-management atau pengetahuan (mis. instrumen manajemen diabetes atau hipertensi) yang dipakai untuk membandingkan skor pra- dan pasca-intervensi (Denham et al., 2015)

b. Metode kualitatif

Contoh: wawancara evaluatif, observasi interaksi keluarga, dan Family Nursing Conversations untuk menilai dinamika keluarga dan kebutuhan non-biomedis (Eggenberger & Sanders, 2016)

c. Instrumen yang dilaporkan

Temuan studi: tinjauan integratif mengidentifikasi sejumlah instrumen evaluasi/intervensi keluarga yang dipakai dalam penelitian pediatrik dan keluarga, menunjukkan ketersediaan beragam alat penilaian keluarga (Gonçalves et al., 2017)

d. Catatan tentang format SOAP dan kategori evaluasi

Insufficient evidence Untuk klaim penggunaan format SOAP secara eksplisit dalam studi yang ada di korpus ini karena tidak ada rujukan langsung pada penggunaan SOAP dalam dokumen yang disediakan.

Insufficient evidence Untuk pembagian eksplisit evaluasi menjadi formatif vs sumatif pada serangkaian studi dalam korpus ini meskipun praktik penilaian berulang (pra/pasca) pada studi kasus menunjukkan karakter evaluasi formatif dan penilaian akhir menunjukkan karakter sumatif (Denham et al., 2015)

4. Kriteria evaluasi dokumentasi dan tindak lanjut

Evaluasi harus memakai indikator keberhasilan yang jelas, dokumentasi perkembangan yang terstruktur, serta mekanisme tindak lanjut yang mencakup modifikasi rencana atau terminasi asuhan bila tujuan tercapai atau tidak relevan lagi. Buku dan tinjauan family nursing menekankan bahwa hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyesuaikan intervensi dan peran klinis perawat dalam pengambilan keputusan (Broekema et al., 2020)

Kriteria evaluasi

a. **Indikator keberhasilan**: perubahan klinis terukur, peningkatan pengetahuan/perilaku self-care, dan pencapaian tujuan yang disepakati keluarga dan tim keperawatan (Denham et al., 2015)
b. **Skala penilaian**: beberapa laporan kasus menggunakan skor pra/pasca untuk mengukur perubahan; namun **insufficient evidence** dalam korpus ini mengenai penggunaan standar kategori "teratasi penuh/teratasi sebagian/belum teratasi" sebagai format yang distandarkan di studi yang tersedia (Gonçalves et al., 2017)

Instrumen evaluatif

a. **Contoh nyata**: penggunaan kuesioner manajemen penyakit kronik dan pengukuran objektif (mis. tekanan darah, gula darah), serta checklist dan observasi terstruktur yang dilaporkan dalam studi kasus keperawatan keluarga (Leal & Franco, 2024)

Dokumentasi evaluasi

a. **Praktik dilaporkan**: pengumpulan data melalui wawancara, pemeriksaan fisik, dan dokumentasi tertulis yang menjadi sumber evaluasi dan catatan perkembangan keluarga (Leal & Franco, 2024)

Tindak lanjut

Modifikasi rencana: hasil evaluasi digunakan untuk merevisi prioritas, menambah atau menghentikan intervensi, dan merencanakan tindak lanjut yang sesuai berdasarkan kebutuhan keluarga (Eggenberger & Sanders, 2016)

Terminasi asuhan: **insufficient evidence** untuk kriteria terminasi terstandar dalam korpus ini; keputusan terminasi diuraikan sebagai hasil penilaian klinis dan kesepakatan bersama antara keluarga dan tim perawatan menurut prinsip family-centered care (Lise, Schwartz, de Moura Spagnolo, et al., 2020)

Tabel 7.2: contoh yang disusun berdasarkan praktik pengukuran pra/pasca dan data subjektif/objektif yang dilaporkan dalam studi kasus dan tinjauan alat keluarga

No	Indikator atau masalah	Data awal (baseline)	Tujuan/ target	Hasil evaluasi	Status dan tindak lanjut
1	Pengetahuan hipertensi keluarga	Skor pra: 2/10	Skor ≥8/10 dalam 4 minggu	Skor pasca: 10/10	**Jika tercapai**: lanjutkan monitoring; **jika belum**: ulang intervensi edukasi
2	Kepatuhan obat pasien	Jadwal, evidence objektif	Kepatuhan harian ≥90%	Observasi/ wawancara	Ubah frekuensi kunjungan edukasi atau rujuk ke layanan lain

(Tabel di atas adalah format contoh yang disusun berdasarkan praktik pengukuran pra/pasca dan data subjektif/objektif yang dilaporkan dalam studi kasus dan tinjauan alat keluarga (Leal & Franco, 2024)

5. Contoh praktis langkah evaluasi dan catatan perkembangan

Berikut urutan praktis untuk evaluasi yang selaras dengan proses keperawatan keluarga, diambil dari pola laporan kasus dan pedoman family nursing dalam korpus:

a. Kumpulkan data evaluatif: ulangi pengkajian subjektif dan objektif yang relevan dengan diagnosis keluarga (Leal & Franco, 2024)
b. Bandingkan hasil dengan tujuan yang telah disepakati (mis. skor pengetahuan, parameter klinis) dan catat perubahan numerik atau kualitatif (Denham et al., 2015)

c. Analisis hasil untuk memutuskan apakah diagnosis/prioritas masih valid dan apakah intervensi perlu dimodifikasi (Eggenberger & Sanders, 2016)
d. Dokumentasikan temuan dan rencana tindak lanjut dalam catatan perkembangan pasien/keluarga; sertakan tanggal evaluasi, hasil, dan keputusan perawat/family (Leal & Franco, 2024)

Implementasikan modifikasi rencana atau terminasi asuhan berdasarkan kesepakatan dan kebutuhan lanjutan (Lise, Schwartz, de Moura Spagnolo, et al., 2020)

D. Konsep Dasar Continuity of Care

1. **Continuity of care** dalam konteks keperawatan komunitas merujuk pada pengalaman perawatan yang terkoordinasi dan seamless yang diterima pasien saat berpindah antar berbagai setting pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, rumah) dan antar berbagai provider kesehatan (Haggerty et al., 2003).

2. **Tiga Dimensi Continuity of Care:**
   a. **Informational Continuity** - Ketersediaan dan penggunaan informasi medis pasien yang konsisten di semua titik pelayanan
   b. **Management Continuity** - Pendekatan perawatan yang konsisten dan terkoordinasi sesuai kebutuhan pasien
   c. **Relational Continuity** - Hubungan terapeutik berkelanjutan antara pasien dan provider kesehatan (Freeman et al., 2001)

3. **Peran Perawat Komunitas**

   Perawat komunitas memiliki peran sentral dalam memastikan continuity of care:
   a. **Care Coordinator**: Mengkoordinasikan berbagai layanan kesehatan dan sosial
   b. **Case Manager**: Mengelola kasus kompleks dengan kebutuhan multi-disiplin
   c. **Patient Advocate**: Memastikan kebutuhan pasien terpenuhi dalam sistem
   d. **Health Educator**: Memberikan edukasi untuk self-management
   e. **Liaison**: Penghubung antara rumah sakit, primary care, dan komunitas (Brooten et al., 2001)

4. **Model dan Strategi Implementasi**
   a. Discharge Planning
   - Perencanaan pemulangan terstruktur dari rumah sakit

- Melibatkan pasien dan keluarga dalam perencanaan
- Koordinasi dengan layanan komunitas sebelum discharge (Parkes & Shepperd, 2000)

b. Transitional Care

- Program khusus untuk periode transisi (rumah sakit ke rumah)
- Kunjungan rumah dalam 24-72 jam post-discharge
- Follow-up telepon dan monitoring berkelanjutan (Jack et al., 2009)

c. Integrated Care Pathways

- Protokol standar untuk kondisi spesifik
- Melibatkan multi-disiplin dengan peran yang jelas
- Dokumentasi terintegrasi (D. Allen et al., 2009)

d. Community Health Nursing Programs

- Home visits reguler untuk populasi berisiko tinggi
- Chronic disease management programs
- Health promotion dan preventive care (MacDonald & Jakubec, 2021)

5. Manfaat yang Terbukti

Penelitian menunjukkan bahwa continuity of care yang efektif menghasilkan:

a. Pengurangan readmisi: 20-30% penurunan rehospitalisasi dalam 30 hari (Leppin et al., 2014)

b. Peningkatan kepuasan pasien: Skor kepuasan lebih tinggi dengan continuity yang baik (Saultz & Lochner, 2005)

c. Outcome kesehatan lebih baik: Kontrol penyakit kronis yang lebih baik, kepatuhan pengobatan meningkat (Barker et al., 2017)

d. Efisiensi biaya: Pengurangan utilisasi emergency department dan hospitalisasi (Albertson et al., 2022)

e. Keselamatan pasien: Mengurangi medication errors dan komplikasi [21]

6. Tantangan dan Hambatan

Tantangan Sistem:

a. Fragmentasi sistem pelayanan kesehatan
b. Kurangnya sistem informasi terintegrasi
c. Keterbatasan komunikasi antar provider(Hesselink et al., 2012)

Tantangan Praktis:

a. Beban kerja perawat yang tinggi
b. Keterbatasan waktu untuk koordinasi
c. Sumber daya komunitas yang terbatas (Goodwin et al., 2014)

Tantangan Pasien:

a. Health literacy yang rendah
b. Keterbatasan akses transportasi
c. Kompleksitas kebutuhan pasien (Neter & Brainin, 2019)

7. Rekomendasi untuk Praktik

a. **Standardisasi komunikasi**: Gunakan tools seperti SBAR untuk handover
b. **Teknologi**: Implementasi electronic health records yang terintegrasi
c. **Kolaborasi**: Bangun partnership dengan berbagai provider dan layanan komunitas
d. **Patient-centered approach**: Libatkan pasien dan keluarga dalam semua keputusan
e. **Continuing education**: Pelatihan berkelanjutan untuk perawat tentang care coordination (Naylor, 2006)

E. Sistem Rujukan Di Keperawatan Komunitas

Sistem rujukan keperawatan komunitas adalah mekanisme terorganisir untuk mengarahkan klien ke layanan yang paling tepat guna menjamin kontinuitas dan kualitas perawatan. Peningkatan efektivitas memerlukan pedoman rujukan, komunikasi antarprofesi, sistem informasi, dan model terpusat atau terstandar.

1. Definisi sistem rujukan

Sistem rujukan dalam konteks keperawatan komunitas merujuk pada mekanisme terkoordinasi yang menghubungkan klien antara tingkat layanan (mis. perawatan rumah, puskesmas, rumah sakit, layanan spesialis) sehingga kebutuhan klinis dan sosial dapat ditangani oleh pihak yang tepat. Peran ini sejalan dengan fungsi community health nurse yang bersifat koordinatif, promotif, dan memastikan akses terhadap layanan lanjutan untuk populasi dan individu (King, 2020). Panduan rujukan juga berfungsi sebagai alat operasional untuk menentukan kapan dan bagaimana perawat merujuk klien ke layanan lain guna mencapai hasil perawatan optimal (J. Allen et al., 2011)

2. Tujuan dan fungsi sistem rujukan

Sistem rujukan bertujuan memastikan klien menerima tingkat layanan yang sesuai serta menjaga kesinambungan perawatan antara layanan primer dan lanjutan. Secara spesifik fungsi utamanya meliputi pengalihan pasien ke layanan yang lebih tepat, pengurangan duplikasi layanan, dan peningkatan outcome melalui koordinasi interprofesional (King, 2020).Selain itu, pedoman rujukan membantu mendefinisikan peran masing-masing penyedia (mis.

district nurse) sehingga keputusan rujukan menjadi konsisten dan berorientasi hasil klinis (J. Allen et al., 2011)

3. Jenis rujukan

Sistem rujukan mencakup berbagai jenis rujukan yang umum di praktik komunitas. Pembagian berikut memudahkan pemahaman perbedaan fungsi dan aktor yang terlibat.

Tabel 7.3: Jenis Rujukan

Tipe rujukan	Deskripsi singkat	Bukti terkait
Rujukan oleh pasien atau keluarga	Klien meminta diteruskan ke layanan yang lebih tinggi atau berbeda; sering terjadi dalam implementasi NHI di beberapa daerah	Masalah rujukan yang dipicu permintaan pasien tercatat sebagai hambatan implementasi di praktik lokal (Annells et al., 2011)
Rujukan primer ke spesialis	Fasilitas primer atau perawat merujuk pasien ke dokter spesialis atau rumah sakit untuk diagnosis/penatalaksanaan lanjutan	Komunikasi dan follow-up ke dokter umum/spesialis sering menjadi tantangan praktis dalam jalur rujukan klinis (Hirst & Fixsen, 2024)
Rujukan berbasis jalur klinis atau screening	Rujukan yang dihasilkan dari pathway atau alat skrining terstandar (mis. screening kesehatan mental) untuk memastikan deteksi dan tindak lanjut	Pathway dengan alat terstandar dapat meningkatkan deteksi dan kepuasan pasien tetapi memerlukan adaptasi praktik dan komunikasi lintas profesi (Combs, 1976)
Rujukan terpusat atau hub	Sistem rujukan yang dikelola melalui pusat rujukan terintegrasi untuk menghubungkan banyak penyedia dan sumber daya komunitas	Model hub terpusat (REACH) dapat meningkatkan jumlah mitra rujukan dan rasio rujuk-menjadi-enroll sampai 37% dalam pilot lokal (Hirst & Fixsen, 2024)

4. Prosedur alur rujukan dan peran perawat komunitas

Alur rujukan idealnya mengikuti langkah-langkah terstruktur yang memudahkan penilaian, keputusan rujuk, dokumentasi, komunikasi, dan tindak lanjut. Perawat komunitas memainkan peran sentral di setiap tahap untuk menjaga kontinuitas dan kualitas layanan.

a. Langkah alur rujukan umum
    1) Identifikasi kebutuhan melalui assessment klinis dan/atau alat skrining yang valid; studi menunjukkan embedding alat skrining dalam pathway membantu identifikasi masalah kesehatan mental pada klien komunitas (Combs, 1976)
    2) Triage dan keputusan rujuk berdasarkan pedoman atau kriteria rujukan yang disepakati; inovasi seperti call handlers yang menggunakan algoritme klinis dapat membantu triase awal sebelum triase oleh perawat komunitas 7
    3) Dokumentasi rujukan menggunakan template rujukan standar dan rekam medis elektronik untuk memastikan informasi yang lengkap dikirim ke penyedia tujuan; sistem informasi rujukan yang baik mengikat pedoman, prosedur, dan pola rujukan menjadi satu kesatuan operasional (Bowers & Cook, 2012)
    4) Komunikasi lintas penyedia termasuk pemberitahuan ke pihak tujuan, konsultasi jika perlu, dan pengaturan janji tindak lanjut; masalah komunikasi antara perawat dan dokter umum diidentifikasi sebagai hambatan yang sering muncul (Hirst & Fixsen, 2024)
    5) Tindak lanjut dan umpan balik untuk menutup siklus rujukan—perawat komunitas melacak hasil rujukan dan memberikan penguatan atau intervensi lanjutan di komunitas bila diperlukan (King, 2020)

5. Peran perawat komunitas dalam sistem rujukan

a. Koordinator rujukan: menginisiasi dan mengatur proses rujukan sehingga klien mendapatkan layanan yang tepat waktu dan sesuai (King, 2020)
b. Triase dan penilai klinis: menggunakan pedoman, algoritme atau pathway untuk menentukan kebutuhan rujukan
c. Penghubung komunikasi: menjembatani informasi antara klien, keluarga, dan penyedia lain serta memastikan data rujukan lengkap (Bowers & Cook, 2012)
d. Pengawal kontinuitas perawatan: melakukan tindak lanjut pasca-rujukan untuk memantau outcome dan ketaatan klien terhadap rencana perawatan (King, 2020)
e. Pendidik dan advokat: menjelaskan alasan rujukan kepada klien dan mendorong kepatuhan serta akses layanan yang diperlukan (King, 2020)

6. Tantangan hambatan dan strategi peningkatan efektivitas

Pembenahan sistem rujukan memerlukan identifikasi hambatan nyata dan penerapan strategi berbasis bukti untuk mengatasinya.

a. Hambatan umum
    1) Kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat sehingga rujukan sering berbasis permintaan pasien bukan kebutuhan klinis (Annells et al., 2011)
    2) Kekurangan sumber daya primer (dokter, fasilitas, peralatan) yang membatasi kemampuan layanan primer menjadi gatekeeper efektif (Annells et al., 2011)
    3) Komunikasi lintas profesi yang lemah mengakibatkan referral tidak lengkap atau tindak lanjut tidak konsisten (Hirst & Fixsen, 2024)
    4) Sistem informasi rujukan yang tidak memadai termasuk template rujukan yang tidak standar dan kurang integrasi data (Bowers & Cook, 2012)

b. Strategi yang terbukti membantu atau direkomendasikan
    1) Mengembangkan dan mensosialisasikan pedoman rujukan yang jelas untuk perawat komunitas dan pihak pengirim sehingga keputusan rujukan konsisten dan berbasis kebutuhan klinis (J. Allen et al., 2011)
    2) Menyederhanakan pathway dan alat klinis agar mudah dipakai dalam praktik lapangan; evaluasi pathway mental health merekomendasikan penyederhanaan dan panduan komunikasi yang lebih baik (Hirst & Fixsen, 2024)
    3) Membangun pusat rujukan terpusat atau hub untuk mengkoordinasi mitra rujukan dan meningkatkan enroll klien ke layanan komunitas, terbukti efektif pada pilot REACH dengan peningkatan rasio refer-to-enroll sebesar 37%. (Hirst & Fixsen, 2024)
    4) Menguatkan sistem informasi dan template rujukan sehingga data yang dikirim lengkap, dapat ditelusuri, dan mendukung tindak lanjut
    5) Pelatihan triase dan penggunaan algoritme klinis termasuk peran call handlers/triage berbasis algoritme yang dianiayai oleh perawat komunitas untuk mempercepat dan menstandarkan proses rujukan
    6) Kampanye edukasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga untuk meningkatkan pemahaman fungsi puskesmas sebagai gatekeeper dan mendorong penggunaan jalur rujukan yang tepat (J. Allen et al., 2011)
    7) Mekanisme umpan balik terstruktur (feedback loop) antara penyedia tujuan dan perawat komunitas untuk memantau outcome rujukan dan memperbaiki proses secara berkelanjutan (Hirst & Fixsen, 2024)

F. Konsep Integrasi antara evaluasi, continuity of care, dan sistem rujukan

Integrasi antara evaluasi, continuity of care, dan sistem rujukan bermakna menyusun mekanisme, informasi, dan tata kelola sehingga pasien mengalami alur perawatan yang koheren antarprofesional dan antar fasilitas. Konsep ini menekankan koordinasi manajemen, kontinuitas informasi, dan relasi klinis berkelanjutan sebagai pilar integrasi yang saling melengkapi (Espinel-Flores et al., 2022)

1. Penjelasan komponen utama

Continuity of care menjelaskan tiga dimensi: kontinuitas relasi (hubungan pasien-provider), kontinuitas informasi (transfer data dan catatan), dan kontinuitas manajemen (keterpaduan rencana perawatan antarlevel) (Espinel-Flores et al., 2022)

Sistem rujukan adalah mekanisme formal untuk memindahkan tanggung jawab klinis antarlevel (mis. primer → spesialis → lanjutan) yang membutuhkan formulir, jalur komunikasi, dan tracking untuk menutup loop rujukan.

Evaluasi berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran dan akuntabilitas: mengukur proses rujukan, kepatuhan informasi, hasil klinis dan pengalaman pasien untuk memberi umpan balik perbaikan layanan (Espinel-Flores et al., 2022)

2. Prinsip integrasi praktis

- Sinkronisasi data elektronik dan format rujukan standar agar informasi klinis bergerak silang lembaga
- Peran fasilitator/koordinator klinis untuk mengelola alur rujukan dan menindaklanjuti pasien yang "terhenti" dalam sistem
- Pengukuran proses dan outcome dijadikan bahan kebijakan dan perbaikan operasional secara berkala (Murofushi et al., 2026)

3. Peran evaluasi dalam continuity dan rujukan

Evaluasi menyediakan bukti terukur tentang apakah alur rujukan berjalan, informasi diteruskan, dan pasien menerima tindak lanjut yang dibutuhkan; hasilnya memandu pembenahan proses dan sumber daya. Pendekatan evaluasi praktik yang dapat dipakai meliputi pengukuran fitur proses dari

catatan medis, audit rujukan, serta evaluasi implementasi intervensi koordinasi klinis

Metode evaluasi yang terbukti berguna

- **Chart review terstruktur** untuk menilai fitur transisi (mis. adanya rencana pulang, informasi rujukan lengkap) dan dapat mengungkap variasi penerapan proses transisi
- **Evaluasi implementasi** untuk menilai kelayakan dan hambatan model rujukan yang diubah (mis. intervensi rujukan nutrisi dari rumah sakit ke komunitas) serta efek pada cakupan layanan setelah keluar rumah sakit (Ai et al., 2025)
- **Penilaian partisipatif** melibatkan tim klinis untuk menguji intervensi koordinasi lintas-level melalui siklus tindakan (action research) sehingga penyesuaian praktik kontekstual dapat dilakukan (Ai et al., 2025)

4. Indikator proses evaluasi (ringkasan)

- **Kelengkapan rujukan**: persentase rujukan dengan informasi klinis esensial yang diisi lengkap (Barrios & Méndez, 2025)
- **Keterlaksanaan tindak lanjut**: proporsi pasien yang tersambung ke layanan tujuan dalam jangka waktu terstandar (Ai et al., 2025)
- **Kualitas komunikasi antarprovider**: dokumentasi komunikasi langsung atau konferensi lintas-level (Barrios & Méndez, 2025)

5. Continuity dan efektivitas rujukan

Continuity of care memperkuat efektivitas rujukan karena hubungan berkelanjutan, informasi lengkap, dan koordinasi manajemen mengurangi duplikasi, keterlambatan, dan kejadian buruk. Bukti empiris menunjukkan kontinuitas yang lebih baik berkaitan dengan pengurangan kunjungan rawat inap, readmisi, dan kejadian perburukan penyakit pada kondisi kronis

Bagaimana continuity meningkatkan hasil rujukan

- **Mempercepat waktu akses spesialis** melalui gatekeeper yang konsisten dan peran koordinasi yang jelas, sehingga rujukan berjalan lebih efisien
- **Mengurangi fragmentasi layanan** dengan menjamin transfer informasi dan pelaksanaan rencana perawatan, sehingga mencegah komplikasi dan kunjungan darurat (Brown & Menec, 2021)
- **Meningkatkan kepuasan pasien dan kepatuhan** karena keterlibatan kontinu dari penyedia yang mengenal riwayat pasien, yang juga mempermudah tindak lanjut rujukan.

Contoh efek klinis terukur

- **Outcome klinis dan utilitas layanan**: penelitian kohort terhadap pasien IBD menunjukkan COC rendah terkait risiko flare, rawat inap, dan operasi lebih tinggi, sehingga menjadi indikator valid keberhasilan integrasi rujukan dan kontinuitas (Brown & Menec, 2021)
- **Proses layanan**: jaringan layanan yang lebih terintegrasi menunjukkan skor manajemen kontinuitas lebih baik pada peran koordinasi dan kejelasan tugas antar klinik (Brown & Menec, 2021)

6. Model indikator implementasi

Penggabungan model, indikator evaluasi, strategi, tantangan, dan praktik terbaik membentuk peta implementasi yang dapat diadaptasi oleh layanan kesehatan. Kerangka yang berguna menggabungkan level makro/meso/mikro, pengukuran proses dan outcome, serta tata kelola dan SDM sebagai penggerak perubahan (Murofushi et al., 2026)

Rekomendasi indikator terukur

Tabel 7.4: indikator inti

Domain	**Indikator contoh**	**Kegunaan**
Proses rujukan	**Persentase rujukan lengkap** dalam catatan elektronik (Barrios & Méndez, 2025)	Menilai kualitas transfer informasi
Akses dan waktu	**Waktu dari rujukan ke konsultasi** (hari)	Mengukur kelancaran jalur rujukan
Kontinuitas	**COC index** atau proporsi kunjungan pada provider utama	Menilai kestabilan relasi klinis
Outcome klinis	**Readmisi 30 hari / fluktuasi kondisi kronis** (Brown & Menec, 2021)	Menilai dampak pasien dari integrasi

Domain	Indikator contoh	Kegunaan
Pengalaman pasien	**Skor persepsi kontinuitas/koordinasi**	Menangkap persepsi pasien terhadap koherensi perawatan
Implementasi	**Tingkat adopsi formulir elektronik/konferensi klinis** (Barrios & Méndez, 2025)	Menilai uptake alat integrasi

7. Strategi implementasi praktis

a. **Bangun standar rujukan dan format data** untuk memastikan kelengkapan informasi klinis
b. **Kembangkan peran koordinator/liaison klinis** khusus untuk pasien kompleks agar tidak "terhenti" pada lintasan rujukan
c. **Gunakan evaluasi implementasi siklik** (audit–umpan balik–perbaikan) dan libatkan tim multiprofesional dalam perbaikan berkelanjutan
d. **Manfaatkan teknologi digital yang terintegrasi** untuk menautkan catatan rumah sakit dan komunitas serta memfasilitasi pelacakan rujukan (Khatri et al., 2023)

8. Tantangan umum dan mitigasi

a. **Fragmentasi sistem dan tata kelola** menghambat koordinasi lintas penyedia; solusi meliputi regulasi insentif dan struktur akuntabilitas regional (Aditya et al., 2026)
b. **Kualitas catatan dan kepatuhan pengisian** rendah mengganggu pengukuran otomatis; perlu pelatihan dan desain sistem yang memudahkan input (Aditya et al., 2026)
c. **Kekurangan sumber daya di komunitas** membuat rujukan gagal; strategi overflow dan penataan jalur layanan lokal perlu direncanakan sesuai konteks (Khatri et al., 2023)

9. **Best practices yang didukung bukti**
    a. **Desain model tiga-level** (macro/meso/micro) yang memanfaatkan infrastruktur eksisting dan menyesuaikan alur rujukan lokal (Khatri et al., 2023)
    b. **Pengukuran fitur proses dari catatan** sebagai cara praktis untuk melihat implementasi per hari-hari pelayanan dan targetkan perbaikan pada item dengan capaian rendah (Barrios & Méndez, 2025)
    c. **Intervensi terarah untuk transisi rumah sakit-ke-komunitas** yang menyertakan sharing data elektronik dan follow-up oleh penyedia komunitas dapat meningkatkan penawaran layanan dan hasil pasien
    d. **Pendekatan klinis terpimpin dan tim interprofesional** untuk menilai pasien "stuck" menimbulkan rencana tindakan individual yang efektif untuk menutup kelom-pok rujukan (Barrios & Méndez, 2025)

10. ***Insufficient evidence***

Untuk beberapa aspek spesifik adaptasi model di konteks negara tertentu atau evaluasi cost-effectiveness detail, tersedia beberapa model konseptual namun bukti empiris lintas-konteks masih terbatas sehingga membutuhkan studi implementasi lokal sebelum skala penuh (Murofushi et al., 2026)

G. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Soal kasus

Seorang perawat keluarga di Puskesmas Sehat Sejahtera. Anda telah memberikan asuhan keperawatan kepada keluarga Bapak Amin selama 4 minggu terakhir. Hari ini Anda akan melakukan evaluasi hasil asuhan keperawatan yang telah diberikan.

Pertanyaan:

Jelaskan bagaimana cara perawat melakukan evaluasi terhadap intervensi yang telah diberikan pada kasus tersebut.

1. Review catatan asuhan keperawatan keluarga Bapak Amin
2. Lakukan wawancara singkat dengan Bapak Amin dan istrinya untuk mengevaluasi hasil intervensi
3. Interpretasikan data tekanan darah dan self-care behavior
4. Buat kesimpulan evaluasi: apakah asuhan efektif atau perlu modifikasi
5. Berikan rekomendasi tindak lanjut
6. Dokumentasikan hasil evaluasi pada lembar yang disediakan

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

H. Aktivitas 2 — Shows How

SOAL OSCE KEPERAWATAN KOMUNITAS

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	……
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada keluarga dengan Hipertensi
3	Waktu yang dibutuhkan	15 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan evaluasi asuhan keluarga hipertensi secara sistematis, komunikatif, dan aman.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Menggali data kepatuhan diet, aktivitas, dan dukungan keluarga 3. Mengidentifikasi perubahan kondisi pasien
6	Kategori	1. Cairan dan elektrolit 2. Eliminasi 3. Nutrisi 4. Aman dan nyaman 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Anda melakukan kunjungan rumah pada keluarga Ny. S (58 tahun) dengan riwayat hipertensi. Ny. S (58 tahun), hipertensi. Sudah diberikan: • Edukasi diet rendah garam • Anjuran olahraga • Monitoring tekanan darah Evaluasi minggu ke-2: • Terdiagnosis hipertensi sejak 7 tahun yang lalu • Obat: Ramipril 5 mg 1×1 pagi hari • Riwayat: sering lupa minum obat, diet tinggi garam, merokok ringan (5 batang/hari), jarang olahraga • Tekanan darah: 165/100 mmHg • Kepatuhan minum obat: 40% (sering lupa) • Konsumsi garam: tinggi (>6 gram/hari) • Aktivitas fisik: jarang (1×/minggu jalan santai) • Merokok: 5 batang/hari • Pengetahuan keluarga tentang hipertensi: rendah TUGAS: 1 Lakukan evaluasi asuhan keluarga dengan langkah:

No.	Komponen	Isi
		• Membuka interaksi dengan benar • Mengkaji hasil intervensi • Menentukan hasil (tercapai/sebagian/belum) • Mengidentifikasi masalah • Menentukan tindak lanjut • Memberikan edukasi • Menutup dengan aman
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Ny. S (55 tahun), hipertensi. Sudah diberikan: • Edukasi diet rendah garam • Anjuran olahraga • Monitoring tekanan darah Evaluasi minggu ke-2: • TD: 150/95 mmHg (sebelumnya 160/100 mmHg) • Masih konsumsi asin • Olahraga 2x/minggu • Keluarga belum konsisten . TUGAS: 1. Lakukan evaluasi asuhan keluarga dengan langkah: 1. Membuka interaksi dengan benar 2. Mengkaji hasil intervensi 3. Menentukan hasil (tercapai/sebagian/belum) 4. Mengidentifikasi masalah 5. Menentukan tindak lanjut 6. Memberikan edukasi 7. Menutup dengan aman INSTRUKSI PENGUJI: 1. Observasi pasif (tidak berinteraksi dengan peserta kecuali untuk memberikan informasi hasil pengukuran BP) 2. Catat setiap item checklist secara real-time 3. Berikan skor rubrik setelah peserta selesai 4. Tandai kesalahan kritikal jika terjadi
9	Instruksi untuk klien standar	**Peran SP:** • Bapak Amin: Menunjukkan sikap kooperatif, dapat menjelaskan perubahan yang telah dilakukan, menunjukkan lembar monitoring BP yang terisi

No.	Komponen	Isi
		• Ibu Siti: Mendukung, menjelaskan perubahan pola memasak, mengungkapkan kekhawatiran tentang kesulitan Bapak Amin untuk berhenti merokok sepenuhnya **Respons SP terhadap Pertanyaan:** • Jika ditanya tentang kepatuhan obat: "Sekarang sudah lebih teratur Pak/Bu, saya pakai kotak obat dan alarm HP seperti yang diajarkan" • Jika ditanya tentang diet: "Istri saya sekarang masak pakai garam lebih sedikit, awalnya hambar tapi sekarang sudah terbiasa" • Jika ditanya tentang aktivitas: "Sekarang saya jalan pagi 3 kali seminggu, kadang sama istri" • Jika ditanya tentang merokok: "Sudah berkurang jadi 2 batang sehari, tapi masih susah berhenti total" • Jika ditanya tentang keluhan: "Pusing sudah jarang, tidur juga lebih nyenyak"
10	Setting station	Ruang konsultasi puskesmas atau ruang kunjungan keluarga. - Susunan ruangan: • 1 meja dan 2 kursi berhadapan • Mahasiswa duduk di depan pasien • Penguji duduk di sudut ruangan dan tidak ikut berbicara • Tensimeter, stetoskop, lembar observasi, dan alat tulis tersedia di meja Tata letak ruang: 1. Tempat tidur 2. Kursi KS 3. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Tensimeter dan stetoskop 2. Rekam medis sederhana berisi identitas pasien 3. Kartu obat bertuliskan “Amlodipin 5 mg 1x1” 4. Lembar hasil tanda vital:

No.	Komponen	Isi
		5. TD: 160/100 mmHg 6. Nadi: 88 x/menit 7. RR: 20 x/menit 8. Suhu: 36,7°C 9. Kursi untuk anggota keluarga (boleh kosong bila tidak diperankan) 10. Lembar jawaban pesertaLaboran ada. Peran laboran: merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.
12	Penulis	. ...
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EVALUASI HASIL ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Pembukaan dan Identifikasi				
1	Memperkenalkan diri dengan jelas				
2	Menjelaskan tujuan kunjungan evaluasi				
3	Memverifikasi identitas pasien (nama, usia)				
4	Meminta persetujuan untuk melakukan evaluasi				
B	Review catatan Asuhan				
5	Membaca catatan asuhan dengan sistematis				
6	Mengidentifikasi data baseline dengan benar				
7	Mengidentifikasi intervensi yang telah diberikan				
8	Mengidentifikasi tujuan asuhan yang ditetapkan				
C	Wawancara dan evaluasi				
9	Menanyakan kepatuhan minum obat				
10	Menanyakan perubahan pola makan/diet garam				
11	Menanyakan aktivitas fisik				
12	Menanyakan kebiasaan merokok				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
13	Menanyakan keluhan yang dirasakan saat ini				
14	Mereview lembar monitoring BP yang diisi keluarga				
15	Melakukan/simulasi pengukuran tekanan darah				
D	Intervertasi dan Evaluasi				
16	Membandingkan data baseline dengan data evaluasi				
17	Menginterpretasi perubahan tekanan darah dengan benar				
18	Menginterpretasi perubahan self-care behavior				
19	Mengidentifikasi aspek yang berhasil				
20	Mengidentifikasi aspek yang masih perlu perbaikan				
21	Membuat kesimpulan evaluasi yang tepat (efektif/perlu modifikasi)				
E	Rekomendasi tindak lanjut				
22	Menyampaikan hasil evaluasi kepada keluarga dengan jelas				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
23	Memberikan reinforcement positif untuk perubahan yang dicapai				
24	Memberikan rekomendasi untuk aspek yang perlu perbaikan				
25	Merencanakan jadwal evaluasi lanjutan				
26	Memberikan motivasi untuk mempertahankan perubahan positif				
F	Komunikasi dan Profesionalisme				
27	Menggunakan bahasa yang mudah dipahami				
28	Menunjukkan sikap empati dan menghargai keluarga				
29	Memberikan kesempatan keluarga untuk bertanya				
30	Memverifikasi pemahaman keluarga (teach-back)				
G	Dokumentasi				
31	Mencatat data evaluasi dengan lengkap				
32	Mencatat interpretasi dan kesimpulan evaluasi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
33	Mencatat rekomendasi tindak lanjut				
34	Dokumentasi dapat dibaca dan terstruktur				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

FORM PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: Evaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga

1. Form Penilaian

No.	KOMPETENSI	INDIKATOR PENILAIAN	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S x B)
1	**Penilaian Klinis**	Kemampuan melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik terfokus, dan interpretasi data klinis keluarga					1	
2	**Pengambilan Keputusan Keperawatan**	Kemampuan merumuskan diagnosa keperawatan, menetapkan prioritas, dan membuat keputusan klinis yang tepat					2	
3	**Perencanaan dan Implementasi**	Kemampuan menyusun rencana asuhan, melaksanakan intervensi, dan mengadaptasi tindakan sesuai konteks keluarga					5	
4	**Evaluasi dan Tindak Lanjut**	Kemampuan mengevaluasi outcome, merencanakan kontinuitas perawatan, dan membuat rujukan yang tepat					2	
5	**Komunikasi Terapeutik**	Kemampuan berkomunikasi efektif, memberikan edukasi, dan memberdayakan keluarga					10	
6	**Profesionalisme dan Etika**	Kemampuan menunjukkan sikap profesional, menghormati nilai keluarga, dan menjaga kerahasiaan						
7	**Dokumentasi**	Kemampuan mendokumentasikan asuhan keperawatan secara lengkap dan akurat						

Keterangan skor:

- 0 = tidak dilakukan
- 1 = dilakukan tetapi tidak tepat/tidak lengkap
- 2 = dilakukan cukup tepat namun masih kurang lengkap
- 3 = dilakukan dengan tepat, lengkap, dan sistematis

RUBRIK PENILAIAN OSCE KEPERAWATAN

STATION: Evaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga

2. Rubrik

KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT (B)	NILAI (S X B)
1. Pengkajian dan Review Data					1	
2. Wawancara Evaluasi					2	
3. Interpretasi dan Analisis Data					3	
4. Kesimpulan Evaluasi					2	
5. Rekomendasi Tindak Lanjut					2	
6. Komunikasi Terapeutik					3	
7. Dokumentasi					3	

3. Deskripsi Performa Tiap Skor

KOMPETENSI	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
1. Pengkajian dan Review Data	Melakukan review catatan secara sistematis dan lengkap; mengidentifikasi semua data baseline, intervensi, dan tujuan dengan akurat	Review cukup sistematis; mengidentifikasi sebagian besar data penting dengan beberapa detail terlewat	Review kurang sistematis; beberapa data penting terlewat atau tidak akurat	Review tidak sistematis; banyak data penting terlewat atau salah interpretasi
2. Wawancara Evaluasi	Wawancara terstruktur dan komprehensif; menggali semua aspek self-care behavior dengan pertanyaan yang tepat; review lembar	Wawancara cukup terstruktur; menggali sebagian besar aspek penting dengan beberapa aspek kurang mendalam	Wawancara kurang terstruktur; beberapa aspek penting tidak ditanyakan; review lembar monitoring kurang teliti	Wawancara tidak terstruktur; banyak aspek penting tidak ditanyakan; tidak review lembar monitoring

KOMPETENSI	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
	monitoring dengan teliti			
3. Interpretasi dan Analisis Data	Interpretasi data sangat akurat; perbandingan baseline vs evaluasi jelas dan logis; identifikasi aspek berhasil dan perlu perbaikan tepat	Interpretasi data cukup akurat; perbandingan cukup jelas dengan beberapa aspek kurang detail	Interpretasi data kurang akurat; perbandingan kurang jelas; identifikasi aspek tidak lengkap	Interpretasi data tidak akurat; tidak dapat membandingkan data dengan benar; kesimpulan tidak tepat
4. Kesimpulan Evaluasi	Kesimpulan evaluasi sangat tepat dan berbasis data; menyatakan dengan jelas apakah asuhan efektif atau perlu modifikasi dengan alasan yang kuat	Kesimpulan cukup tepat dengan alasan yang memadai; beberapa aspek kurang detail	Kesimpulan kurang tepat; alasan tidak cukup kuat atau tidak berbasis data	Kesimpulan tidak tepat atau tidak dapat membuat kesimpulan yang jelas
5. Rekomendasi Tindak Lanjut	Rekomendasi sangat relevan, spesifik, dan dapat dilaksanakan; memberikan reinforcement positif yang kuat; merencanakan follow-up dengan jelas	Rekomendasi cukup relevan dan spesifik; memberikan reinforcement positif; rencana follow-up cukup jelas	Rekomendasi kurang spesifik atau kurang relevan; reinforcement positif minimal; rencana follow-up tidak jelas	Rekomendasi tidak relevan atau tidak diberikan; tidak ada reinforcement positif; tidak ada rencana follow-up
6. Komunikasi Terapeutik	Komunikasi sangat efektif; bahasa mudah dipahami;	Komunikasi cukup efektif; bahasa cukup jelas;	Komunikasi kurang efektif; bahasa kurang jelas; empati	Komunikasi tidak efektif; bahasa sulit dipahami; tidak

KOMPETENSI	Sangat Baik (4)	Baik (3)	Cukup (2)	Kurang (1)
	empati tinggi; verifikasi pemahaman dengan teach-back; memberikan kesempatan bertanya	menunjukkan empati; verifikasi pemahaman dilakukan	minimal; verifikasi pemahaman tidak dilakukan	menunjukkan empati; tidak ada verifikasi pemahaman
7. Dokumentasi	Dokumentasi sangat lengkap, akurat, terstruktur, dan dapat dibaca dengan jelas; mencakup semua aspek evaluasi	Dokumentasi cukup lengkap dan terstruktur dengan beberapa detail kurang	Dokumentasi kurang lengkap; beberapa aspek penting tidak tercatat; kurang terstruktur	Dokumentasi tidak lengkap; banyak aspek tidak tercatat; tidak terstruktur atau tidak dapat dibaca

4. Keterangan Skor

Skor	Keterangan
1	Tidak dilakukan / seluruh tindakan tidak sesuai
2	Dilakukan tetapi sangat kurang tepat, tidak lengkap, atau tidak sistematis
3	Dilakukan cukup tepat dan cukup lengkap, tetapi masih ada kekurangan
4	Dilakukan dengan tepat, lengkap, sistematis, aman, dan sesuai tujuan

5. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$$

(Kota), ...

.....

Penguji :.....

I. DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan keluarga
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Evaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga dengan Hipertensi
Judul Keterampilan	Keterampilan yang dinilai melalui DOPS..	Evaluasi asuhan keperawatan keluarga pada pasien hipertensi di rumah.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan evaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga secara langsung.	Mahasiswa dinilai apakah mampu mengevaluasi kepatuhan obat, perubahan gaya hidup, dan dukungan keluarga pada pasien hipertensi. ibu pasien.
Tempat/Setting	Lokasi pelaksanaan observasi.	Dilakukan di ruang simulasi rumah keluarga atau ruang OSCE puskesmas.
Waktu	Lama observasi dan umpan balik.	Observasi 10 menit, dilanjutkan umpan balik 5 menit.
Observasi / penguji	Orang yang melakukan penilaian.	Dosen keperawatan komunitas mengamati langsung mahasiswa selama interaksi dengan keluarga.
Klien	Pasien dan keluarga yang menjadi objek penilaian	Bapak Ahmad, 55 tahun, hipertensi sejak 3 tahun, tinggal bersama istri dan 2 anak.
Persiapan	Kesiapan mahasiswa sebelum memulai tindakan.	Mahasiswa mencuci tangan, menyiapkan tensimeter,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga dengan Hipertensi
		format evaluasi, lalu memperkenalkan diri kepada keluarga.
Komunikasi awal	Cara mahasiswa membuka interaksi dan membangun hubungan terapeutik	Mahasiswa berkata, "Selamat pagi Pak Ahmad, saya akan mengevaluasi kondisi Bapak dan keluarga setelah edukasi minggu lalu."
Evaluasi keluhan	Mahasiswa menanyakan perubahan keluhan pasien setelah intervensi sebelumnya.	Mahasiswa bertanya apakah pasien masih pusing atau tengkuk terasa berat. Pasien menjawab pusing berkurang tetapi kadang masih muncul saat lupa minum obat
Evaluasi tekanan darah	Mahasiswa meminta atau mengukur tekanan darah dan menginterpretasikannya.	Tekanan darah pasien 150/95 mmHg. Mahasiswa menjelaskan bahwa tekanan darah sudah menurun tetapi masih belum terkontrol.
Evaluasi kepatuhan obat	Mahasiswa mengevaluasi apakah pasien minum obat secara rutin.	Mahasiswa bertanya, "Apakah Bapak rutin minum amlodipin setiap hari?" Pasien menjawab masih lupa 2 kali dalam seminggu.
Evaluasi pola makan	Mahasiswa menilai apakah pasien sudah mengurangi garam dan makanan tinggi natrium.	Mahasiswa menanyakan apakah pasien masih makan ikan asin dan mie instan. Pasien mengatakan sudah mengurangi menjadi 1 kali seminggu.
Evaluasi aktivitas fisik	Mahasiswa menilai perubahan aktivitas fisik pasien	Pasien mengatakan sudah mulai jalan pagi 20 menit, 3 kali seminggu
Evaluasi merokok	Mahasiswa mengevaluasi kebiasaan merokok pasien	Pasien sebelumnya merokok 1 bungkus/hari, sekarang berkurang menjadi 5 batang/hari.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga dengan Hipertensi
Evaluasi dukungan keluarga	Mahasiswa menilai peran keluarga dalam mendukung pasien.	Mahasiswa bertanya kepada istri pasien apakah ikut mengingatkan obat. Istri menjawab sudah menyiapkan obat setiap pagi.
Indentifikasi masalah	Mahasiswa menyimpulkan masalah yang masih ada.	Mahasiswa menyimpulkan bahwa masalah utama masih berupa kepatuhan obat yang belum optimal dan tekanan darah belum terkontrol.
Edukasi lanjutan	Mahasiswa memberikan edukasi berdasarkan hasil evaluasi.	Mahasiswa menyarankan pasien menggunakan alarm HP agar tidak lupa minum obat dan tetap mengurangi makanan asin.
Keselamatan dan tanda bahaya	Mahasiswa menjelaskan kapan pasien harus segera ke fasilitas kesehatan.	Mahasiswa menjelaskan bahwa bila muncul nyeri dada, sesak, kelemahan anggota tubuh, atau pandangan kabur, pasien harus segera ke rumah sakit.
Pelibatan keluarga	Mahasiswa melibatkan keluarga dalam perencanaan tindak lanjut.	Mahasiswa meminta istri dan anak membantu mengingatkan obat dan menemani pasien jalan pagi.
Penutup	Mahasiswa mengakhiri interaksi dengan baik.	Mahasiswa merangkum hasil evaluasi dan berkata, “Kita akan evaluasi lagi minggu depan untuk melihat apakah tekanan darah Bapak semakin membaik.”
Instrument penilaian	Format penilaian yang digunakan oleh observer.	Penguji menggunakan lembar DOPS dengan skor 0–2 untuk setiap komponen.
Kriteria penilaian	Dasar pemberian nilai pada setiap komponen.	0 = tidak dilakukan, 1 = dilakukan tetapi kurang

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Keluarga dengan Hipertensi
		lengkap, 2 = dilakukan lengkap dan benar.
Umpan Balik	Komentar yang diberikan penguji setelah observasi.	Penguji menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan evaluasi obat, tetapi perlu lebih rinci dalam menjelaskan tanda bahaya hipertensi.

J. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi

Komponen	Deskripsi	Kasus Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi
Identitas Mahasiswa	Berisi identitas mahasiswa yang melakukan asuhan keperawatan keluarga.	Nama: Siti Aisyah, NIM: 2210456, Semester: VI, Program Studi Keperawatan.
Identitas keluarga	Berisi data singkat keluarga yang menjadi sasaran asuhan.	Keluarga Bapak Ahmad, usia 55 tahun, tinggal dengan istri dan 2 anak, diagnosis hipertensi sejak 3 tahun.
Tujuan Portofolio	Menjelaskan tujuan penyusunan portofolio..	Portofolio ini dibuat untuk mendokumentasikan proses evaluasi asuhan keperawatan keluarga pada pasien

Komponen	Deskripsi	Kasus Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi
		hipertensi dan menilai perkembangan pasien sertaanak dengan diare di ruang rawat anak.
Pengkajian Awal	Berisi hasil pengkajian sebelum intervensi diberikan.	TD 160/100 mmHg, pasien sering pusing dan tengkuk berat, tidak rutin minum amlodipin, masih mengonsumsi makanan asin, merokok 1 bungkus/hari, jarang olahraga
Diagnosa Keperawatan	Berisi masalah keperawatan yang ditemukan.	1. Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. 2. Ketidakpatuhan minum obat. 3. Risiko komplikasi hipertensi.
Rencana asuhan keperawatan	Berisi intervensi yang direncanakan untuk mengatasi masalah	Edukasi minum obat rutin, diet rendah garam, anjuran olahraga jalan kaki 30 menit/hari, edukasi berhenti merokok, melibatkan istri untuk mengingatkan obat.
Implementasi	Berisi tindakan yang telah dilakukan mahasiswa..	Mahasiswa memberikan pendidikan kesehatan tentang hipertensi, mendemonstrasikan cara mencatat tekanan darah, dan berdiskusi dengan keluarga mengenai pengaturan menu rendah garam.
Evaluasi hasil	Berisi perubahan kondisi pasien dan keluarga setelah intervensi	Setelah 1 minggu, pasien mengatakan lebih rutin minum obat, mengurangi mie instan dan ikan asin, serta mulai berjalan pagi 3 kali seminggu. TD menjadi 145/90 mmHg
Bukti kegiatan	Dokumen atau bukti yang menunjukkan kegiatan telah dilakukan	Foto edukasi keluarga, lembar observasi tekanan darah, catatan kunjungan rumah, leaflet hipertensi yang diberikan kepada keluarga..
Refleksi Mahasiswa	Berisi pengalaman, kesulitan, dan pembelajaran mahasiswa.	Mahasiswa merasa awalnya sulit menggali alasan pasien tidak patuh minum obat. Setelah menggunakan komunikasi yang lebih empatik, pasien lebih terbuka. Mahasiswa belajar bahwa dukungan

Komponen	Deskripsi	Kasus Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi
		keluarga sangat penting dalam keberhasilan pengobatan hipertensi.
Refleksi keluarga	Berisi pendapat keluarga tentang asuhan yang diterima.	Istri pasien mengatakan bahwa sebelumnya keluarga tidak memahami bahwa obat hipertensi harus diminum terus walaupun pasien tidak pusing. Setelah diberikan edukasi, keluarga lebih siap membantu pasien.
Tindak lanjut	Berisi rencana kunjungan atau intervensi berikutnya	Kunjungan ulang dilakukan 2 minggu kemudian untuk memantau tekanan darah, kepatuhan minum obat, dan keberhasilan diet rendah garam.
Penilaian dosen	Berisi hasil evaluasi dosen terhadap portofolio mahasiswa	Mahasiswa mampu melakukan evaluasi secara sistematis, namun perlu meningkatkan kemampuan dalam memberikan edukasi tentang tanda bahaya hipertensi.
Lampiran	Berisi dokumen pendukung portofolio.	Lembar pengkajian kelurga, format SOAP, foto kunjungan, lembar tekanan darah, dan daftar hadir keluarga saat edukasi.

Tabel. Case Report pada Evaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga dengan hipertensi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi
Judul Kasus	Menjelaskan fokus utama laporan kasus.	Evaluasi Asuhan Keperawatan Keluarga pada Bapak Ahmad dengan Hipertensi Tidak Terkontrollemas.
Identitas Pasien dan Keluarga	Berisi identitas singkat pasien dan anggota keluarga yang terlibat.	Bapak Ahmad, 55 tahun, pedagang, tinggal bersama istri dan 2 anak. Istri berperan sebagai caregiver utama.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi
Latar Belakang Kasus	Menjelaskan kondisi awal pasien dan alasan dilakukan evaluasi..	Pasien menderita hipertensi sejak 3 tahun lalu. Pasien sering pusing, tengkuk terasa berat, dan tekanan darah belum terkontrol karena tidak rutin minum obat.
Riwayat Penyakit	Menjelaskan riwayat hipertensi dan faktor yang memengaruhi kondisi pasien.	Pasien pernah didiagnosis hipertensi 3 tahun lalu dan mendapat terapi amlodipin 5 mg/hari. Pasien sering lupa minum obat karena merasa sembuh saat tidak ada keluhan.
Riwayat Keluarga	Menjelaskan kondisi keluarga dan dukungan yang diberikan.	Istri mengetahui pasien memiliki hipertensi, tetapi sebelumnya belum aktif mengingatkan minum obat. Anak-anak belum terlibat dalam perawatan.
Hasil Pengkajian Awal	Menjelaskan data subjektif dan objektif sebelum intervensi.	Data subjektif: pasien mengeluh pusing di belakang kepala sejak 1 minggu. Data objektif: TD 160/100 mmHg, nadi 88 x/menit, pasien masih merokok 1 bungkus/hari dan sering makan ikan asin serta mie instan.
Diagnose keperawatan	Menjelaskan masalah keperawatan yang ditemukan.	1. Ketidakefektifan manajemen kesehatan keluarga. 2. Ketidakpatuhan pengobatan. 3. Risiko komplikasi hipertensi.
Tujuan asuhan	Menjelaskan target yang ingin dicapai setelah interven	Setelah 1 minggu, pasien diharapkan lebih patuh minum obat, mengurangi konsumsi garam, dan tekanan darah menurun.
Intervensi keperawatan	Menjelaskan tindakan yang diberikan kepada pasien dan keluarga	Memberikan edukasi tentang pentingnya minum obat secara rutin, diet rendah garam, olahraga, berhenti

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi
		merokok, dan melibatkan istri sebagai pengingat oba
Implementasi	Menjelaskan bagaimana intervensi dilakukan.	Mahasiswa memberikan penyuluhan menggunakan leaflet, berdiskusi dengan pasien dan istri, lalu membantu membuat jadwal minum obat dan aktivitas jalan pagi
Respon keluarga	Menjelaskan bagaimana keluarga merespons intervensi.	Istri pasien mengatakan sekarang ia menyiapkan obat setiap pagi dan mengingatkan pasien agar tidak lupa minum obat.
Analisis kasus	Menjelaskan interpretasi hasil dan faktor yang memengaruhi.	Tekanan darah menurun karena pasien lebih patuh minum obat dan keluarga mulai berperan aktif. Namun, tekanan darah belum normal karena pasien masih merokok dan belum konsisten olahraga.
Masalah yang masih ada	Menjelaskan masalah yang belum teratasi sepenuhnya.	Pasien masih lupa minum obat sesekali dan masih merokok 5 batang per hari.
Tindak lanjut	Menjelaskan rencana lanjutan setelah evaluasi.	Direncanakan kunjungan ulang 2 minggu kemudian untuk memantau tekanan darah, kepatuhan obat, dan keberhasilan berhenti merokok.
Kesimpulan	Menjelaskan inti hasil evaluasi asuhan.	Evaluasi menunjukkan bahwa asuhan keperawatan keluarga dan dukungan keluarga mampu meningkatkan kepatuhan pasien hipertensi dan menurunkan tekanan darah.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Evaluasi Asuhan Keperawatan keluarga dengan hipertensi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi
Identifikasi Risiko	Mengidentifikasi risiko yang dapat membahayakan pasien selama perawatan di rumah.	Pasien berisiko mengalami stroke atau krisis hipertensi karena tekanan darah 160/100 mmHg dan tidak rutin minum obat.
Faktor Penyebab Risiko	Menjelaskan penyebab utama munculnya risiko keselamatan pasien.	Pasien sering lupa minum amlodipin, masih mengonsumsi makanan tinggi garam, dan belum memahami bahwa hipertensi dapat berbahaya walaupun tanpa gejala.
Risiko Kesalahan Obat	Mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam penggunaan obat..	Pasien hanya minum obat saat pusing dan menghentikan obat sendiri ketika merasa sehat.bahaya.
Risiko Kurangnya Edukasi	Menjelaskan risiko bila pasien dan keluarga tidak memahami penyakit.	Pasien dan keluarga menganggap hipertensi hanya perlu diobati saat ada keluhan sehingga berisiko tidak patuh pada terapi.
Risiko Komunikasi	Mengidentifikasi masalah komunikasi antara pasien, keluarga, dan petugas kesehatan.	Istri pasien mengetahui suaminya memiliki hipertensi, tetapi belum pernah diberi penjelasan mengenai cara membantu mengingatkan obat.
Risiko Lingkungan Rumah	Menjelaskan faktor lingkungan rumah yang dapat	Di rumah tidak ada jadwal minum obat atau alat pengingat sehingga pasien sering lupa.
Tindakan Pencegahan	Menjelaskan faktor lingkungan rumah yang dapat meningkatkan risiko.	Di rumah tidak ada jadwal minum obat atau alat pengingat sehingga pasien sering lupa.
Pelibatan Keluarga	Menjelaskan peran keluarga dalam menjaga keselamatan pasien.	Istri pasien diminta menyiapkan obat setiap pagi dan anak diminta membantu mengingatkan jadwal kontrol.
Edukasi Tanda Bahaya	Menjelaskan tanda dan gejala yang harus segera dirujuk	Pasien dan keluarga diberi tahu bahwa bila muncul nyeri dada, sesak, kelemahan anggota gerak, bicara pelo, atau

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Evaluasi asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi
		pandangan kabur harus segera ke rumah sakit.
Refleksi Mahasiswa	Menjelaskan pembelajaran mahasiswa terkait patient safety.	Mahasiswa menyadari bahwa sebelumnya hanya fokus pada tekanan darah, tetapi kurang mengevaluasi risiko pasien lupa minum obat. Setelah refleksi, mahasiswa belajar bahwa patient safety dimulai dari pencegahan kesalahan kecil di rumah.
Refleksi Keluarga	Menjelaskan kesadaran keluarga setelah menerima edukasi.	Istri pasien mengatakan baru memahami bahwa menghentikan obat sendiri dapat berbahaya dan sekarang akan lebih aktif mengingatkan pasien.
Hambatan	Menjelaskan kendala dalam menjaga keselamatan pasien.	Pasien masih merasa bosan minum obat setiap hari dan sulit mengurangi rokok.
Rencana Perbaikan	Menjelaskan langkah yang akan dilakukan agar keselamatan pasien meningkat.	Pada kunjungan berikutnya akan dibuat kartu pemantauan tekanan darah, jadwal minum obat, dan evaluasi ulang kepatuhan pasien.
Hasil Refleksi	Menjelaskan perubahan yang terjadi setelah tindakan patient safety dilakukan.	Setelah edukasi, pasien lebih patuh minum obat, keluarga lebih terlibat, dan tekanan darah menurun dari 160/100 mmHg menjadi 145/90 mmHg.

K. Red Flags & Eskalasi

Evaluasi Asuhan Keluarga dengan hipertensi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Tekanan darah ≥ 180/120 mmHg	Mengarah pada krisis hipertensi, berisiko stroke, gagal jantung, atau kerusakan organ	Segera rujuk ke IGD atau rumah sakit terdekat, jangan menunda dengan edukasi saja
Tekanan darah tetap >160/100 mmHg meskipun sudah minum obat rutin	Hipertensi belum terkontrol, kemungkinan obat tidak efektif atau ada faktor lain	Konsultasikan ke dokter untuk evaluasi obat dan jadwalkan kontrol lebih cepat
Nyeri dada	Dapat menandakan gangguan jantung atau serangan jantung	Hentikan aktivitas, rujuk segera ke IGD
Sesak napas	Dapat menunjukkan gagal jantung, edema paru, atau komplikasi hipertensi	Segera rujuk ke fasilitas kesehatan darurat
Sakit kepala hebat mendadak	Dapat mengarah pada perdarahan otak atau stroke	Segera rujuk ke rumah sakit
Pandangan kabur atau tiba-tiba tidak bisa melihat	Dapat menunjukkan komplikasi hipertensi pada mata atau stroke	Rujuk segera ke dokter/IGD
Bicara pelo, wajah mencong, kelemahan salah satu sisi tubuh	Tanda stroke	Segera lakukan rujukan darurat, catat waktu mulai gejala

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Penurunan kesadaran, bingung, kejang	Menandakan gangguan neurologis berat akibat hipertensi	Hubungi layanan gawat darurat dan rujuk segera
Pasien berhenti minum obat sendiri	Risiko tekanan darah meningkat dan komplikasi	Segera lakukan edukasi ulang dan laporkan ke dokter/petugas kesehatan
Pasien tidak mau kontrol atau menolak pengobatan	Menandakan kepatuhan sangat rendah	Libatkan keluarga, lakukan konseling, dan eskalasi ke perawat penanggung jawab atau dokter
Pasien masih merokok berat dan konsumsi garam tinggi meskipun sudah diedukasi	Risiko hipertensi tetap tidak terkontrol	Jadwalkan kunjungan ulang lebih sering dan libatkan keluarga untuk pengawasan
Keluarga tidak mendukung atau tidak peduli terhadap kondisi pasien	Risiko pasien tidak patuh dan tidak terpantau	Lakukan family meeting, edukasi keluarga, atau konsultasi dengan tim kesehatan komunitas
Pasien sering lupa minum obat karena	Berisiko terjadi medication error di rumah	Buat sistem pengingat, gunakan kotak obat, dan minta keluarga membantu

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
gangguan memori atau usia lanjut		
Terdapat lebih dari 2 kali kunjungan tanpa perbaikan	Menunjukkan intervensi belum efektif	Evaluasi ulang seluruh rencana asuhan dan konsultasikan ke tim multidisiplin
Pasien memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, gagal ginjal, atau riwayat stroke	Risiko komplikasi lebih tinggi	Tingkatkan frekuensi pemantauan dan koordinasikan dengan dokter

Form Checklist "Saya sudah bisa..."
Bab Asuhan Keperawatan keluarga dengan hipertensi
Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik / Skill Lab : _____
Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa Menjelaskan pengertian evaluasi dalam asuhan keperawatan keluarga dengan hipertensi	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa Menjelaskan tujuan evaluasi pada pasien dan keluarga dengan hipertensi	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa Mengidentifikasi data subjektif yang perlu dievaluasi pada pasien hipertensi	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
4	Saya sudah bisa Mengidentifikasi data objektif yang perlu dievaluasi, seperti tekanan darah dan kepatuhan obat	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa Menanyakan perubahan keluhan pasien, seperti pusing, tengkuk berat, atau lema	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa Menilai apakah tekanan darah pasien sudah membaik atau belum	☐	☐	_____
7	Saya sudah Menilai kepatuhan pasien dalam minum obat antihipertensi	☐	☐	_____
8	Saya sudah Menjelaskan alasan mengapa obat hipertensi harus diminum secara rutin	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa Menilai apakah pasien sudah mengurangi konsumsi garam dan makanan asin	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa Menilai perubahan kebiasaan merokok pada pasien	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa Menilai apakah pasien sudah mulai melakukan aktivitas fisik atau olahraga ringan	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa Menilai dukungan keluarga dalam mengingatkan obat dan membantu pasien	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa Mengidentifikasi masalah yang masih belum teratasi pada pasien hipertensi	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa Menentukan apakah tujuan asuhan sudah tercapai atau belum	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa Menentukan tindakan lanjutan bila tekanan darah pasien masih tinggi	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa Memberikan edukasi ulang bila pasien belum patuh minum obat			
17	Saya sudah bisa Menjelaskan tanda bahaya hipertensi yang harus segera dirujuk			

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
18	Saya sudah bisa Mengidentifikasi red flags, seperti nyeri dada, sesak, atau kelemahan anggota gerak			
19	Saya sudah bisa Menentukan kapan pasien harus kontrol ulang atau dirujuk ke fasilitas kesehatan			
20	Saya sudah bisa Melibatkan keluarga dalam rencana tindak lanjut pasien hipertensi			
21	Saya sudah bisa Menyusun evaluasi menggunakan format SOAP atau catatan perkembangan			
22	Saya sudah bisa Menuliskan hasil evaluasi secara singkat, jelas, dan sistematis			
23	Saya sudah bisa Melakukan komunikasi terapeutik saat evaluasi pasien dan keluarga			
24	Saya sudah bisa Menutup evaluasi dengan memastikan pasien dan keluarga memahami penjelasan			
25	Saya sudah bisa Merefleksikan hal yang sudah baik dan yang masih perlu diperbaiki dalam evaluasi asuhan keluarga dengan hipertensi			

Refleksi singkat mahasiswa:

L. Rangkuman Materi

Evaluasi Asuhan Keluarga dengan hipertensi

Evaluasi asuhan keluarga pada pasien hipertensi merupakan tahap untuk menilai keberhasilan intervensi yang telah diberikan kepada pasien dan keluarga. Evaluasi dilakukan terhadap perubahan kondisi pasien, kepatuhan minum obat, perubahan pola makan, aktivitas fisik, serta keterlibatan keluarga dalam perawatan. Pada keluarga dengan hipertensi, aspek yang dinilai meliputi penurunan keluhan seperti pusing dan tengkuk berat, perubahan tekanan darah, kepatuhan mengonsumsi obat antihipertensi, pengurangan konsumsi garam, pengurangan kebiasaan merokok, serta peningkatan aktivitas fisik. Selain itu, dievaluasi pula apakah keluarga sudah berperan dalam mengingatkan obat, mendampingi kontrol, dan mendukung perubahan gaya hidup pasien.

Contoh hasil evaluasi pada pasien hipertensi menunjukkan bahwa setelah diberikan edukasi dan melibatkan keluarga, pasien menjadi lebih rutin minum obat, mulai mengurangi makanan asin, dan melakukan olahraga ringan. Tekanan darah yang semula 160/100 mmHg menurun menjadi 145/90 mmHg, keluhan pusing berkurang, dan keluarga lebih aktif membantu pasien.Jika hasil evaluasi belum sesuai target, maka asuhan perlu diperbaiki melalui edukasi ulang, penguatan dukungan keluarga, pemantauan tekanan darah, dan kunjungan lanjutan. Dengan demikian, evaluasi asuhan keluarga berperan penting untuk mencegah komplikasi hipertensi dan meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarganya.

M. Daftar Pustaka

Aditya, I., Bissonnette, K., Khushk, S., & Swadas, N. (2026). Design and Evaluation of a Standardized Opioid Toxicity Prevention Pathway for Ontario. In *From Silos to Synergy: Building Bridges* (pp. 52–56). IOS Press.

Ai, J.-H., Huang, C., & Luo, J.-J. (2025). A Case Study of Comprehensive Postoperative Management for Elderly Total Hip Arthroplasty Patients Based on Peplau's Interpersonal Relationship Theory. *Chinese Medical Sciences Journal*, *40*(4), 315–326.

Albertson, E. M., Chuang, E., O'Masta, B., Miake-Lye, I., Haley, L. A., & Pourat, N. (2022). Systematic review of care coordination interventions linking health and social services for high-utilizing patient populations. *Population Health Management*, *25*(1), 73–85.

Allen, D., Gillen, E., & Rixson, L. (2009). The effectiveness of integrated care pathways for adults and children in health care settings: a systematic review. *JBI Evidence Synthesis*, *7*(3), 80–129.

Allen, J., Annells, M., Nunn, R., Petrie, E., Clark, E., Lang, L., & Robins, A. (2011).

Evaluation of effectiveness and satisfaction outcomes of a mental health screening and referral clinical pathway for community nursing care. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, *18*(5), 375–385.

Annells, M., Allen, J., Nunn, R., Lang, L., Petrie, E., Clark, E., & Robins, A. (2011). An evaluation of a mental health screening and referral pathway for community nursing care: nurses' and general practitioners' perspectives. *Journal of Clinical Nursing*, *20*(1-2), 214–226.

Barker, I., Steventon, A., & Deeny, S. R. (2017). Association between continuity of care in general practice and hospital admissions for ambulatory care sensitive conditions: cross sectional study of routinely collected, person level data. *Bmj*, *356*.

Barrios, R. L., & Méndez, D. M. (2025). Impact of Digitalization on Continuity of Care: The Case of the Referral and Counter-Referral Process in the Chilean Public Health Network. *Revista Medica de Chile*, *153*(12), 857–870.

Bowers, B., & Cook, R. (2012). Using referral guidelines to support best care outcomes for patients. *British Journal of Community Nursing*, *17*(3), 134–138.

Broekema, S., Paans, W., Roodbol, P. F., & Luttik, M. L. A. (2020). Nurses' application of the components of family nursing conversations in home health care: a qualitative content analysis. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, *34*(2), 322–331.

Brooten, D., Youngblut, J. M., Brown, L., Finkler, S. A., Neff, D. F., & Madigan, E. (2001). A randomized trial of nurse specialist home care for women with high-risk pregnancies: outcomes and costs. *The American Journal of Managed Care*, *7*(8), 793.

Brown, C. L., & Menec, V. (2021). Measuring processes of integrated care for hospital to home transitions. *International Journal of Integrated Care*, *21*(2), 12.

Calaguas, N. P. (2022). Family Health Conversations in HIV Nursing Care: A Qualitative Case Study on Supporting a Closeted Gay Filipino Man in the Philippines. *Journal of the Association of Nurses in AIDS Care*, 10–1097.

Combs, P. A. (1976). A study of effectiveness of nursing referrals. *Public Health Reports*, *91*(2), 122.

Denham, S. A., Eggenberger, S., Young, P., & Krumwiede, N. (2015). *Family-focused nursing care*. FA Davis.

Eggenberger, S. K., & Sanders, M. (2016). A family nursing educational intervention supports nurses and families in an adult intensive care unit. *Australian Critical Care*, *29*(4), 217–223.

Espinel-Flores, V., Vargas, I., Eguiguren, P., Mogollón-Pérez, A.-S., Ferreira de Medeiros Mendes, M., López-Vázquez, J., Bertolotto, F., & Vázquez, M. L.

(2022). Assessing the impact of clinical coordination interventions on the continuity of care for patients with chronic conditions: participatory action research in five Latin American countries. *Health Policy and Planning*, *37*(1), 1–11.

Foster, R. L. R., Hunsberger, M., & Tackett-Anderson, J. J. (1989). Family-centered nursing care of children. *(No Title)*.

Freeman, G., Shepperd, S., Robinson, I., Ehrich, K., & Richards, S. (2001). Continuity of care: report of a scoping exercise for the National Co-ordinating Centre for NHS Service Delivery and Organisation R & D (NCCSDO). *London: NCCSDO*.

Gonçalves, J. P. A., da Costa Moura, S. M., & Rabiais, I. C. M. (2017). Integrative literature review-nursing interventions in the stress control of the family of the sick person in a critical condition. *International Journal of Nursing*, *4*(1), 27–37.

Goodwin, N., Dixon, A., Anderson, G., & Wodchis, W. (2014). *Providing integrated care for older people with complex needs: lessons from seven international case studies*.

Haggerty, J. L., Reid, R. J., Freeman, G. K., Starfield, B. H., Adair, C. E., & McKendry, R. (2003). Continuity of care: a multidisciplinary review. *Bmj*, *327*(7425), 1219–1221.

Hesselink, G., Schoonhoven, L., Barach, P., Spijker, A., Gademan, P., Kalkman, C., Liefers, J., Vernooij-Dassen, M., & Wollersheim, H. (2012). Improving patient handovers from hospital to primary care: a systematic review. *Annals of Internal Medicine*, *157*(6), 417–428.

Hirst, K., & Fixsen, A. A. M. (2024). An innovative referral system: Bridging healthcare providers and community supports for pregnant and parenting people. *Public Health Nursing*, *41*(5), 1206–1209.

Jack, B. W., Chetty, V. K., Anthony, D., Greenwald, J. L., Sanchez, G. M., Johnson, A. E., Forsythe, S. R., O'Donnell, J. K., Paasche-Orlow, M. K., & Manasseh, C. (2009). A reengineered hospital discharge program to decrease rehospitalization: a randomized trial. *Annals of Internal Medicine*, *150*(3), 178–187.

Khatri, R., Endalamaw, A., Erku, D., Wolka, E., Nigatu, F., Zewdie, A., & Assefa, Y. (2023). Continuity and care coordination of primary health care: a scoping review. *BMC Health Services Research*, *23*(1), 750.

King, T. (2020). Call handlers for community nursing referrals: importance of collaborative working. *British Journal of Community Nursing*, *25*(3), 126–130.

Leal, W. O., & Franco, P. (2024). *Family-centered nursing care in the neonatal intensive care unit*. Seven Editora. https://doi.org/10.56238/sevened2024.012-032

Leppin, A. L., Gionfriddo, M. R., Kessler, M., Brito, J. P., Mair, F. S., Gallacher, K., Wang, Z., Erwin, P. J., Sylvester, T., & Boehmer, K. (2014). Preventing 30-day hospital readmissions: a systematic review and meta-analysis of randomized trials. *JAMA Internal Medicine*, *174*(7), 1095–1107.

Lise, F., Schwartz, E., Dall'Agnol, J., de Moura Lima Spagnolo, L., & Lange, C. (2020). Strategies for evaluation and intervention in the family of children and adolescents: integrative review of the literature / Estratégias de avaliação e intervenção nas famílias de crianças e adolescentes: revisão integrativa da literatura. *Revista de Pesquisa : Cuidado é Fundamental Online*, *12*, 984–991. https://doi.org/10.9789/2175-5361.RPCFO.V12.7145

Lise, F., Schwartz, E., de Moura Spagnolo, L., Lange, C., & Dall'Agnol, J. (2020). STRATEGIES FOR EVALUATION AND INTERVENTION IN THE FAMILY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS: INTEGRATIVE REVIEW OF THE LITERATURE. *Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental*, *12*(1).

Luttik, M. L. (2020). Family Nursing: The family as the unit of research and care. In *European Journal of Cardiovascular Nursing* (Vol. 19, Issue 8, pp. 660–662). SAGE Publications Sage UK: London, England.

MacDonald, S. A., & Jakubec, S. L. (2021). *Community Health Nursing in Canada-E-Book: Community Health Nursing in Canada-E-Book*. Elsevier Health Sciences.

Murofushi, K., Yakes Jimenez, E., Sundar, C., Lamers-Johnson, E., Vergili, J., Ji, M., Steiber, A., & Papoutsakis, C. (2026). Essential connections: the impact of a hospital-to-community referral intervention on nutrition care and health outcomes in older adults with malnutrition: a hybrid type 2 implementation effectiveness study protocol. *Journal of Health, Population and Nutrition*.

Naylor, M. D. (2006). Transitional care: a critical dimension of the home healthcare quality agenda. *Journal for Healthcare Quality*, *28*(1), 48–54.

Neter, E., & Brainin, E. (2019). Association between health literacy, eHealth literacy, and health outcomes among patients with long-term conditions. *European Psychologist*.

Parkes, J., & Shepperd, S. (2000). Discharge planning from hospital to home. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, *4*, CD000313–CD000313.

Saultz, J. W., & Lochner, J. (2005). Interpersonal continuity of care and care outcomes: a critical review. *The Annals of Family Medicine*, *3*(2), 159–166.

Silveira, A. O., & Angelo, M. (2006). A experiência de interação da família que vivencia a doença e hospitalização da criança. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, *14*, 893–900.

Vaughan-Cole, B. (1997). Family nursing practice. *(No Title)*.

PROFIL PENULIS



Dr. Eka Mishbahatul M Has, S.Kep., Ns., M.Kep. Lahir di Samarinda, 11 September 1985. Pendidikan terakhir yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S3 pada Program Studi Doktor Keperawatan, Fakultas Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2007 sampai saat di Universitas Airlangga mengampu mata kuliah Keperawatan Keluarga, Keperawatan Komunitas, dan Keperawatan Gerontik baik pada program sarjana ataupun magister. Sejak 2023, penulis juga menjadi Adjunct Research Fellows pada School of Nursing and Midwifery, La Trobe University, Australia sebagai keberlanjutan dari Australia Awards Fellowship Program. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan fokus pada keperawatan keluarga dan komunitas, kesehatan ibu dan anak, gizi anak, serta pemberdayaan perempuan. Penulis telah terlibat dalam berbagai penelitian nasional dan kolaborasi riset internasional, memperoleh hibah penelitian kompetitif, serta publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi**.** Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: eka.m.has@fkp.unair.ac.id.

Motto: "Keep on moving! Man Jadda Wajada, Kun Fayakun!"



Niswa Salamung

Lahir di Bottopadang Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Oktober 1988. Status belum menikah. Pada tahun 1993 masuk sekolah di SD Inpres 6/86 Bottopadang dan tamat tahun 1999, kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama pada tahun 1999 di SMP Negeri 1 Mandai dan tamat tahun 2002, selanjutnya masuk pada sekolah menengah atas pada tahun 2002 di SMA Negeri 13 Makassar dan tamat tahun 2005. Kemudian melanjutkan sekolah keperguruan tinggi pada tahun 2006 di Universitas Megarezky jurusan keperawatan dan tamat SI pada tahun 2010. Tahun 2011 melanjutkan studi Profesi Ners di Universitas Megarezky dan tamat tahun 2013. Tahun 2017 melanjutkan studi S2 Keperawatan dengan Peminatan Keperawatan Komunitas di Fakultas Keperawatan Univeristas Airlangga dan tamat tahun 2019.

Awal tahun 2013 sampai sekarang bekerja di STIK Indonesia Jaya sebagai dosen tetap di Program Studi Ilmu keperawatan yang aktif melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan memiliki karya ilmiah berupa penelitian dan pengabdian masyarakat.

Email: niswasalamung@gmail.com

Hp : 082259284100

PROFIL PENULIS



Ns. Arnindya Kanti Prasasti, S.Kep, M.Kep, SpKep.K. Lahir di Purworejo, 15 Juli 1991. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners di Universitas Diponegoro pada 2014. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Keperawatan peminatan keperawatan Komunitas di Universitas Indonesia pada 2019, dan Ners Spesialis Komunitas pada 2024. Karir penulis di bidang keperawatan diawali sebagai perawat pelaksana di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita pada 2014 hingga 2019. Setelah menyelesaikan studi Magister, penulis menjadi dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Raflesia Depok. Saat ini penulis aktif mengajar di Program Studi S1 Keperawatan dan Profesi Ners Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Binawan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ns.sasti@gmail.com

PROFIL PENULIS



Oop Ropei, S.Pd., S.Kep., Ners., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Kom., CBCHN merupakan akademisi keperawatan yang telah mendedikasikan lebih dari tiga dekade kehidupannya dalam **pendidikan, pengembangan profesi, dan pengabdian kepada masyarakat**, khususnya di bidang **Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, dan Keperawatan Gerontik**. Ilmu bukan sekadar pengetahuan yang dimiliki, tetapi amanah yang akan semakin bermakna ketika dibagikan dan memberikan manfaat bagi sesama.

Perjalanan akademiknya dimulai dari **Akademi Keperawatan Jenderal Achmad Yani Cimahi** (1996), kemudian **S1 Pendidikan STKIP Siliwangi Cimahi** (2000), **S1 Keperawatan dan Profesi Ners Universitas Padjadjaran** (2003), **Magister Keperawatan Universitas Indonesia** dengan keilmuan Keperawatan Komunitas (2010), serta **Spesialis Keperawatan Komunitas Universitas Indonesia** (2012).

Kiprahnya sebagai pendidik keperawatan telah dimulai sejak **1996**, yaitu di Akademi Keperawatan Jenderal Achmad Yani Cimahi, dilanjutkan di STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi (2000–2021), dan sejak 2021 hingga kini mengabdikan diri sebagai dosen di **Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan (FITKes), Universitas Jenderal Achmad Yani Cimahi**. Selain mengajar, ia aktif sebagai dosen tidak tetap, pakar, dan narasumber pada berbagai institusi dan kegiatan ilmiah.

Dalam pengembangan profesi, aktif di **Ikatan Perawat Kesehatan Komunitas Indonesia (IPKKI)**, pernah menjabat sebagai **Ketua IPKKI DPW Jawa Barat periode 2013–2017**, dan sejak 2019 hingga sekarang berkontribusi di **PP IPKKI Ketua bidang Organisasi**. Kompetensi profesionalnya juga diperkuat melalui sertifikasi **Certified Basic Community Health Nurse (CBCHN)**.

Dengan pengalaman akademik, profesional, dan organisasi tersebut, terus berkomitmen mengembangkan keperawatan yang menempatkan **keluarga dan komunitas sebagai mitra utama dalam membangun kesehatan, kemandirian, dan keberdayaan masyarakat**. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: oopropei@ymail.com

"Kalau kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka bersiaplah untuk menahan perihnya kebodohan."

PROFIL PENULIS



Aulya Kartini Dg Karra, S. Kep., Ns., M. Kep Lahir di Bulukumba, 21 April 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Keperawatan pada Universitas Airlangga dan lulus tahun pada tahun 2021. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2022 sebagai seorang dosen S1 Keperawatan dan Profesi Ners. Saat ini penulis bekerja di STIKES Amanah Makassar mengampu mata kuliah Konsep Keperawatan Komunitas, *Home Care*, Keperawatan Paliatif, Keperawatan Jiwa, Keperawatan Keluarga, dan Komunikasi Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi artikel penelitian, dan aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: kartiniaulya0@gmail.com
Motto: "*To give life meaning, keep learning, growing, and being helpful.*"



Ns. Lisna Nuryanti, M.Kep.
Lisna Nuryanti lahir di Bandung pada 20 Juli 1981. Beliau merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Medistra Indonesia.
Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners di Universitas Padjadjaran (UNPAD) pada tahun 2005. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan Magister Keperawatan dengan peminatan Keperawatan Komunitas di Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan menyelesaikannya pada tahun 2012.
Dalam bidang pendidikan, beliau mengampu berbagai mata kuliah keperawatan, di antaranya Keperawatan Komunitas, Keperawatan Keluarga, Keperawatan Gerontik, dan Promosi Kesehatan. Bidang pengajaran dan pengembangan akademiknya juga berkaitan dengan keperawatan komunitas, keluarga, kesehatan lansia, serta upaya peningkatan kesehatan di masyarakat.
Dalam perjalanan karier akademiknya, beliau dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Program Studi Ilmu Keperawatan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Medistra Indonesia. Selain menjalankan tugas pendidikan dan pengelolaan program studi, beliau aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pengembangan keilmuan dan kontribusi dalam bidang keperawatan.
Beliau dapat dihubungi melalui:
Email:lisnanuryanti6@gmail.com
Telepon: 0811-9669-589
Motto: write youre story, live your life well

PROFIL PENULIS



Sherli Mariance Sari, S.Kep., Ners., M.Kes.

Lahir di Lahat (Sumatera Selatan) 22 Maret 1984 Riwayat Pendidikan SDN 22 Lubuklinggau Tamat 1996, SMP N 4 Lubuklinggau Tahun 1999, SPK Depkes Lubuklinggau 2002, Program Studi Ilmu Keperawatan Bina Husada Palembang 2006 Profesi Ners Tahun 2007, Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Biomedik Tahun 2014 Penulis aktif sebagai dosen di Universitas Muhammdyah Karang anyar solo sebagai tenaga pendidik, peneliti dan pengabdian kepada masyarakat. Buku ini sebagai implementasi keilmuan dalam bidang pendidikan khususnya keperawatan .Penulis dapat dihubungi melalui e-mail:sherlimariancesari1@gmail.com

Motto: “Living your life well”

Sinopsis

Buku Ajar Keperawatan Komunitas disusun sebagai sumber pembelajaran yang membantu mahasiswa memahami keluarga sebagai unit utama dalam pelayanan keperawatan komunitas. Buku ini membahas konsep dasar keperawatan keluarga, siklus kehidupan keluarga, teori sistem keluarga, struktur, peran, fungsi, komunikasi, serta dinamika keluarga. Pembahasan juga dilengkapi dengan pengkajian keluarga menggunakan genogram dan ecomap sehingga mahasiswa dapat memahami hubungan antara kondisi kesehatan individu, struktur keluarga, lingkungan, risiko, serta sumber daya yang memengaruhi kemampuan keluarga dalam mempertahankan kesehatannya.

Pembahasan selanjutnya mengarahkan mahasiswa pada penerapan proses keperawatan keluarga secara sistematis, mulai dari perumusan diagnosis keperawatan, penentuan prioritas masalah, penyusunan tujuan dan intervensi, hingga pelaksanaan *home visit*. Aspek komunikasi, edukasi, negosiasi melalui *shared decision making*, keselamatan kunjungan, evaluasi, dan dokumentasi dibahas untuk memperkuat kemampuan mahasiswa dalam memberikan pelayanan langsung di lingkungan keluarga. Buku ini juga mengulas manajemen kasus keluarga dengan anggota yang mengalami penyakit kronik, ketergantungan, dan kebutuhan perawatan jangka panjang, termasuk peran *caregiver*, *caregiver burden*, pemberdayaan keluarga, pengelolaan perawatan di rumah, serta koordinasi pelayanan dengan berbagai sumber daya kesehatan dan masyarakat.

Keunggulan buku ini terletak pada pendekatan pembelajaran yang menghubungkan pemahaman teori dengan kompetensi praktik melalui aktivitas *Knows How*, *Shows How*, DOPS (*Does*), portofolio, latihan soal, *red flags*, dan eskalasi. Bagian akhir membahas evaluasi asuhan keluarga, *continuity of care*, sistem rujukan, dan integrasi pelayanan untuk memastikan kesinambungan asuhan dari rumah, komunitas, hingga fasilitas kesehatan. Dengan cakupan materi yang komprehensif dan aplikatif, **Buku Ajar Keperawatan Komunitas** diharapkan dapat menjadi pendamping belajar bagi mahasiswa dan referensi bagi perawat dalam mengembangkan asuhan keluarga yang holistik, aman, berpusat pada keluarga, serta responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat.

Buku Ajar Keperawatan Komunitas hadir sebagai sumber pembelajaran yang membahas keluarga sebagai bagian penting dalam pelayanan keperawatan di masyarakat. Buku ini mengawali pembahasan dengan konsep dasar keperawatan keluarga, keluarga sebagai unit asuhan, tatanan keperawatan keluarga, serta siklus kehidupan keluarga berdasarkan Duvall's Eight-Stage Life Cycle, termasuk dinamika keluarga yang mengalami perceraian. Pembahasan kemudian dikembangkan melalui teori sistem keluarga, tahapan perkembangan keluarga, struktur dan peran keluarga, fungsi keluarga, komunikasi, serta dinamika yang terjadi di dalam keluarga. Materi tersebut menjadi fondasi bagi mahasiswa untuk memahami bahwa kondisi kesehatan seseorang tidak dapat dipisahkan dari hubungan, peran, lingkungan, dan tahap perkembangan keluarganya.

Selanjutnya, buku ini mengarahkan pembaca pada keterampilan penting dalam proses keperawatan keluarga, dimulai dari pengkajian keluarga menggunakan genogram dan ecomap untuk mengidentifikasi struktur, hubungan, risiko, sumber daya, serta kebutuhan keluarga. Pembahasan dilanjutkan dengan perumusan diagnosis keperawatan keluarga, jenis-jenis diagnosis, serta penyusunan perencanaan asuhan yang sesuai dengan masalah dan kemampuan keluarga. Aspek pelayanan langsung di rumah juga dikaji melalui pembahasan home visit, mencakup komunikasi, edukasi, negosiasi, indikasi dan kontraindikasi kunjungan, persiapan pasien dan perawat, keselamatan kunjungan, evaluasi, serta dokumentasi. Dengan pembahasan tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana pelayanan keperawatan diterapkan secara nyata dalam lingkungan kehidupan pasien dan keluarga.

Bagian berikutnya memberikan pembahasan yang lebih mendalam mengenai manajemen kasus keluarga dengan anggota yang mengalami penyakit kronik, ketergantungan, dan kebutuhan caregiver, termasuk caregiver burden, pengkajian manajemen kasus, intervensi keperawatan, pemberdayaan keluarga, koordinasi pelayanan, serta peran perawat komunitas. Buku ini ditutup dengan pembahasan evaluasi asuhan keluarga, continuity of care, sistem rujukan, serta integrasi antara evaluasi, kesinambungan pelayanan, dan rujukan dalam keperawatan komunitas. Dilengkapi dengan latihan soal, rangkuman materi, daftar pustaka, dan glosarium, Buku Ajar Keperawatan Komunitas diharapkan menjadi sumber belajar yang sistematis dan aplikatif bagi mahasiswa keperawatan dalam mengembangkan kemampuan memberikan asuhan kepada keluarga secara holistik, terencana, berkesinambungan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.



Penerbit:
PT OPTIMAL UNTUK NEGERI
Kencana Tower Lt. Mezzanine
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005
Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-74-3 (PDF)
9 786347 927743